

Buku Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN MATERNITAS KOMPREHENSIF PENDEKATAN BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP)

Hilmi Yumni • Mimi Rosiska • Rigoan Malawat

Rini Mustikasari Kurnia Pratama • Aida Kusnaningsih • Siti Rochimatul Lailiyah

Apri Nur Wulandari • Santi Wahyuni

Editor: Suryani Hartati



BUNGA RAMPAI
ASUHAN KEPERAWATAN MATERNITAS
KOMPREHENSIF: PENDEKATAN BERBASIS EVIDENCE-
BASED PRACTICE (EBP)

Penulis:

Dr. Hilmi Yumni, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Mat.
Ns. Mimi Rosiska, S.Kep., M.Kep.
Rigoan Malawat. S.Kep., M.Kes.
Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.SiT., M.Keb.
Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah, S.SiT., M.Kes.
Apri Nur Wulandari, S.Kep., Ns., M.Kep.
Santi Wahyuni, SKp., M.Kep., Sp.Mat.

Editor:

Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

BUNGA RAMPAI ASUHAN KEPERAWATAN MATERNITAS KOMPREHENSIF: PENDEKATAN BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP)

Penulis: Dr. Hilmi Yumni, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Mimi Rosiska, S.Kep., M.Kep.

Rigoan Malawat, S.Kep., M.Kes.

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.SiT., M.Keb.

Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah, S.SiT., M.Kes.

Apri Nur Wulandari, S.Kep., Ns., M.Kep.

Santi Wahyuni, SKp., M.Kep., Sp.Mat.

Editor: Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7294-82-1

Cetakan Pertama : Agustus, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku bunga rampai ini dengan judul "Asuhan Keperawatan Maternitas Komprehensif: Pendekatan Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan maternitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice).

Keperawatan maternitas merupakan bagian integral dalam pelayanan kesehatan yang membutuhkan pengetahuan yang luas, keterampilan klinis yang tinggi, serta sensitivitas terhadap kebutuhan emosional dan psikologis ibu dan keluarga. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang sangat pesat, pendekatan berbasis bukti menjadi kebutuhan mutlak agar setiap intervensi yang diberikan mampu menghasilkan luaran kesehatan yang optimal bagi ibu dan bayi.

Buku ini menghimpun berbagai konsep, hasil penelitian terbaru, serta praktik terbaik yang telah teruji secara ilmiah, dengan harapan mampu menjadi referensi berharga bagi para praktisi keperawatan, pendidik, mahasiswa, serta tenaga kesehatan lainnya. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek keperawatan maternitas mulai dari perencanaan kehamilan, masa antenatal, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir.

Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam penerapan Evidence-Based Practice sangat bergantung pada komitmen, keterampilan, serta pengetahuan yang terus diperbarui dari para praktisi keperawatan. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai bentuk komitmen kami untuk terus mendukung peningkatan kompetensi profesional tenaga kesehatan demi tercapainya pelayanan maternitas yang aman, efektif, dan berbasis bukti.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis dan kontributor yang telah berperan aktif dalam menyusun setiap bab dalam buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu keperawatan maternitas serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Akhir kata, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan konstruktif guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Selamat membaca, dan semoga bermanfaat.

Agustus, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN MATERNITAS.....	1
Dr. Hilmi Yumni, S.Kep., Ns., M.Kep.Sp.Mat.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Sejarah dan Perkembangan Keperawatan Maternitas	2
C. Peran dan Fungsi Perawat Maternitas	4
D. Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan.....	7
E. Model Konseptual dan Teori dalam Keperawatan Maternitas	9
F. Proses Keperawatan dalam Praktik Maternitas.....	11
G. Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Nursing) dalam Maternitas	13
H. Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Maternitas.....	14
I. Aspek Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan Maternitas	17
J. Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Maternitas	18
K. Tantangan dan Isu Terkini dalam Keperawatan Maternitas.....	21
L. Simpulan	22
M. Referensi	23
N. Glosarium	24
CHAPTER 2 ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASA PRAKONSEPSI DAN KEHAMILAN.....	27
Ns. Mimi Rosiska, S.Kep., M.Kep.....	27
A. Pendahuluan/Prolog	27
B. Pengkajian Prakonsepsi dan Skrining Kesehatan Reproduksi Calon Ibu	29
C. Penatalaksanaan Keperawatan pada Kehamilan Normal.....	30
D. Edukasi dan Promosi Kesehatan pada Ibu Hamil.....	33
E. Deteksi Dini Tanda Bahaya Selama Masa Kehamilan	35
F. Simpulan	36
G. Referensi	37
H. Glosarium	38

CHAPTER 3 KEPERAWATAN PADA KEHAMILAN RISIKO TINGGI41

Rigoan Malawat, S.Kep., M.Kes.41

A. Pendahuluan/Prolog	41
B. Patofisiologi dan Kondisi Penyerta pada Kehamilan Risiko Tinggi.....	42
C. Deteksi Dini dan Asesmen pada Kehamilan Risiko Tinggi	44
D. Manajemen Keperawatan pada Kehamilan Risiko Tinggi.....	46
E. Pendidikan Kesehatan untuk Ibu Hamil Risiko Tinggi dan Keluarga	47
F. Kolaborasi Interprofesional dalam Asuhan Kehamilan Risiko Tinggi.....	49
G. Pemantauan dan Evaluasi Keperawatan dalam Kehamilan Risiko Tinggi	51
H. Simpulan	52
I. Referensi	54
J. Glosarium	54

CHAPTER 4 KEPERAWATAN DALAM SITUASI KEGAWATDARURATAN

OBSTETRI57

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb.57

A. Pendahuluan/Prolog	57
B. Identifikasi dan Penilaian Cepat dalam Kegawatdaruratan Obstetri.....	59
C. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan selama Kehamilan	61
D. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan saat Persalinan.....	62
E. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan pada Masa Nifas	64
F. Stabilisasi dan Transportasi Pasien Obstetri dalam Kondisi Gawat Darurat.....	66
G. Pendekatan Komunikasi Efektif dalam Kegawatdaruratan Obstetri.....	68
H. Pencegahan dan Edukasi Kegawatdaruratan Obstetri	70
I. Aspek Etik dan Hukum dalam Kegawatdaruratan Obstetri.....	72
J. Simpulan	74
K. Referensi	75
L. Glosarium	75

CHAPTER 5 MANAJEMEN NYERI DALAM PERSALINAN79

Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep.Sp.Kep.Mat.79

A. Pendahuluan/Prolog	79
B. Fisiologi Nyeri dalam Persalinan	81
C. Penilaian Nyeri dalam Persalinan.....	82
D. Metode Nonfarmakologis dalam Manajemen Nyeri Persalinan.....	84
E. Metode Farmakologis dalam Manajemen Nyeri Persalinan	87
F. Peran Perawat dalam Manajemen Nyeri Persalinan	88
G. Kolaborasi Interprofesional dalam Manajemen Nyeri Persalinan	90
H. Pendekatan Holistik dalam Manajemen Nyeri Persalinan	92
I. Tantangan dan Hambatan dalam Manajemen Nyeri Persalinan	94

J. Aspek Etik dan Hukum dalam Manajemen Nyeri Persalinan	96
K. Simpulan	98
L. Referensi	100
M. Glosarium	100
CHAPTER 6 ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASA PERSALINAN	103
Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah, S.SiT., M.Kes.	103
A. Pendahuluan/Prolog	103
B. Konsep dasar asuhan keperawatan pada persalinan.....	104
C. Persalinan Kala I.....	105
D. Kala II persalinan.....	108
E. Kala III.....	110
F. Kala IV	113
G. Simpulan	114
H. Referensi	115
I. Glosarium	116
CHAPTER 7 ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASA NIFAS DAN	
LAKTASI.....	121
Apri Nur Wulandari, S.Kep., Ns., M.Kep.	121
A. Pendahuluan/Prolog	121
B. Perubahan Fisiologis pada Masa Nifas.....	122
C. Asuhan Keperawatan pada Masa Nifas.....	124
D. Konsep Dasar Laktasi	130
E. Asuhan Keperawatan pada Ibu Menyusui.....	132
F. Dukungan Psikologis pada Masa Nifas dan Laktasi.....	137
G. Nutrisi dan Aktivitas Fisik pada Masa Nifas dan Laktasi.....	139
H. Simpulan	142
I. Referensi	143
J. Glosarium	144
CHAPTER 8 KEPERAWATAN PADA IBU DENGAN GANGGUAN	
PSIKOLOGIS SELAMA KEHAMILAN DAN NIFAS.....	147
Santi Wahyuni, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.	147
A. Pendahuluan/Prolog	147
B. Gangguan Psikologis pada Masa Kehamilan dan Nifas	149
C. Dampak Gangguan Psikologis.....	151
D. Faktor Risiko Gangguan Psikologis pada Ibu Hamil dan Nifas.....	153
E. Deteksi Dini dan Edukasi Psikologis oleh Perawat	155
F. Intervensi Psikoedukatif Berbasis Evidence dalam Kesehatan Mental Perinatal	157
G. Implikasi terhadap Kebijakan dan Sistem Pelayanan Kesehatan	159

H. Simpulan	161
I. Referensi	162
J. Glosarium	166
PROFIL PENULIS	169

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN MATERNITAS

Dr. Hilmi Yumni, S.Kep., Ns., M.Kep.Sp.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Keperawatan maternitas merupakan bidang spesialisasi keperawatan yang berfokus secara khusus pada pemenuhan kebutuhan asuhan kesehatan bagi perempuan selama periode reproduksi mereka, mulai dari masa sebelum konsepsi, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan (nifas), hingga perawatan neonatus atau bayi baru lahir. Keperawatan maternitas berpusat pada pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik perempuan saja, melainkan juga mencakup aspek emosional, sosial, psikologis, spiritual, dan budaya. Melalui pendekatan ini, perawat maternitas berupaya memberikan asuhan yang komprehensif guna mencapai hasil terbaik dalam kesehatan ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Secara filosofis, keperawatan maternitas didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak reproduksi perempuan, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan keyakinan bahwa setiap perempuan berhak atas pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, serta berpusat pada keluarga (family-centered care). Prinsip dasar yang melandasi keperawatan maternitas mencakup pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan tentang kesehatan reproduksinya sendiri, perlindungan hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi, serta menerapkan pendekatan evidence-based practice dalam setiap tindakan keperawatan yang dilakukan. Filosofi ini meyakini bahwa setiap perempuan adalah individu yang unik dengan kebutuhan, nilai-nilai, serta keyakinan yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan personal yang penuh empati, mendalam, serta sensitif terhadap perbedaan budaya dan sosial.

Prinsip-prinsip dasar keperawatan maternitas berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan praktik sehari-hari. Prinsip ini meliputi pentingnya menjalin komunikasi terapeutik yang efektif dan penuh rasa hormat, memberikan edukasi yang jelas dan tepat waktu kepada pasien dan keluarga, serta menjunjung tinggi prinsip keselamatan pasien. Lebih jauh, prinsip dasar keperawatan maternitas menuntut perawat untuk mampu berpikir kritis, melakukan advokasi terhadap hak pasien, mengembangkan hubungan terapeutik yang berorientasi pada kebutuhan

pasien dan keluarga, serta berkolaborasi dengan tim interprofesional demi tercapainya pelayanan kesehatan optimal bagi perempuan selama periode reproduksinya.

Ruang lingkup praktik keperawatan maternitas mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan yang dimulai sejak masa prakonsepsi atau persiapan kehamilan, seperti edukasi dan konseling kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan yang sehat, dan skrining awal untuk mendeteksi faktor risiko pada calon ibu. Selanjutnya, lingkup praktik mencakup pelayanan selama masa kehamilan, di antaranya pemantauan kesehatan ibu dan janin secara rutin, edukasi kehamilan sehat, deteksi dini komplikasi kehamilan, serta intervensi keperawatan untuk mendukung kenyamanan fisik dan psikologis selama proses kehamilan. Lingkup praktik juga meluas pada tahap persalinan, di mana perawat maternitas berperan aktif dalam mendukung proses kelahiran yang aman, memonitor kondisi ibu dan janin selama persalinan, dan melakukan intervensi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi.

Setelah proses persalinan, lingkup praktik keperawatan maternitas terus berlanjut hingga periode nifas, yang meliputi perawatan ibu pascapersalinan dalam mengatasi berbagai perubahan fisiologis, pemulihan fisik, pemberian edukasi tentang perawatan diri ibu dan bayi baru lahir, dukungan emosional dalam menghadapi transisi peran menjadi orang tua, serta deteksi dini terhadap komplikasi pascapersalinan seperti infeksi, perdarahan, atau gangguan psikologis seperti depresi postpartum. Selain itu, lingkup praktik keperawatan maternitas mencakup perawatan neonatus, seperti pemberian perawatan dasar bayi baru lahir, pemantauan tanda-tanda vital, mendukung pemberian ASI eksklusif, serta edukasi kepada orang tua tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir.

Secara keseluruhan, keperawatan maternitas menempatkan perempuan dan keluarganya sebagai pusat perhatian utama dalam setiap asuhan yang diberikan. Dengan demikian, pendekatan keperawatan maternitas selalu berorientasi pada keluarga, melibatkan pasangan dan anggota keluarga lainnya secara aktif dalam proses pengambilan keputusan serta perawatan yang diberikan. Melalui pendekatan yang integratif, holistik, dan kolaboratif ini, keperawatan maternitas berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan pengalaman reproduksi yang positif, aman, dan berdaya bagi perempuan serta keluarganya.

B. Sejarah dan Perkembangan Keperawatan Maternitas

Sejarah keperawatan maternitas memiliki akar yang panjang dan kaya, yang telah berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, serta kemajuan teknologi dalam dunia kesehatan. Pada zaman

dahulu, proses persalinan dan perawatan kehamilan hampir sepenuhnya bergantung pada tradisi serta pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui pengalaman. Bidan tradisional atau dukun bayi menjadi tokoh sentral yang dipercaya dalam membantu persalinan, memberikan perawatan pasca melahirkan, dan memberikan edukasi informal kepada para ibu baru. Pada masa ini, praktik-praktik maternitas masih bersifat sederhana, cenderung empiris, dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya serta adat-istiadat setempat.

Memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20, keperawatan maternitas mengalami transformasi besar yang didorong oleh munculnya pengetahuan medis dan keperawatan yang terstruktur secara ilmiah. Masa ini ditandai oleh munculnya pendidikan formal untuk perawat dan bidan, yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh pionir seperti Florence Nightingale, Mary Breckinridge, dan tokoh-tokoh lain yang peduli pada kesehatan perempuan. Perkembangan ini membawa pergeseran paradigma dalam pemberian asuhan maternitas, dari yang sebelumnya dominan dengan pendekatan tradisional menjadi lebih berbasis bukti ilmiah, serta mulai adanya perhatian terhadap aspek keamanan dan kualitas pelayanan bagi ibu dan bayi.

Selama abad ke-20, perkembangan keperawatan maternitas semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat. Organisasi-organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, serta asosiasi keperawatan dan kebidanan mulai mengeluarkan pedoman serta standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas asuhan kesehatan maternal. Program-program kesehatan masyarakat global juga mulai digencarkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, terutama di negara-negara berkembang. Pada periode ini, perawat maternitas semakin diakui sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam pemberian asuhan holistik kepada perempuan dalam masa reproduksi, serta memainkan peran sentral dalam advokasi kesehatan reproduksi perempuan.

Dalam beberapa dekade terakhir, khususnya sejak awal abad ke-21 hingga saat ini, tren kontemporer dalam keperawatan maternitas terus berkembang secara signifikan. Tren ini mencerminkan perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maternal yang semakin kompleks. Salah satu tren utama adalah penerapan praktik keperawatan maternitas berbasis bukti atau Evidence-Based Nursing (EBN). Pendekatan berbasis bukti ini mengharuskan perawat untuk terus-menerus mengikuti dan menerapkan hasil penelitian terbaru, guna memberikan intervensi yang efektif dan berkualitas kepada pasien. Penekanan terhadap penggunaan bukti ilmiah dalam praktik sehari-hari telah meningkatkan standar kualitas asuhan maternitas secara keseluruhan.

Selain itu, tren kontemporer lainnya adalah pendekatan yang berpusat pada keluarga atau dikenal sebagai Family-Centered Care (FCC). Model FCC semakin luas diterapkan karena terbukti mampu meningkatkan kepuasan pasien dan keluarganya, mempercepat proses pemulihan ibu pascapersalinan, serta meningkatkan ikatan emosional antara ibu, bayi, dan keluarga. Model ini mendorong keterlibatan aktif anggota keluarga dalam perawatan maternal, baik sebelum, selama, maupun setelah persalinan, dan menempatkan kebutuhan serta preferensi keluarga sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan terkait perawatan.

Perkembangan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap tren kontemporer dalam keperawatan maternitas. Penggunaan teknologi canggih dalam pemantauan kondisi ibu dan janin selama kehamilan dan persalinan, seperti ultrasonografi (USG), monitor denyut jantung janin, telemedicine, serta aplikasi kesehatan digital, semakin lazim digunakan dalam praktik keperawatan maternitas modern. Teknologi ini tidak hanya membantu deteksi dini terhadap komplikasi potensial, namun juga mendukung komunikasi yang lebih efektif antara pasien dan tenaga kesehatan serta meningkatkan edukasi pasien.

Isu-isu kesehatan mental ibu selama periode reproduksi juga mendapat perhatian khusus dalam tren kontemporer keperawatan maternitas. Kesadaran akan pentingnya kesehatan psikologis perempuan selama kehamilan dan pascapersalinan mendorong pengembangan intervensi psikososial yang spesifik, termasuk skrining rutin untuk gangguan mental seperti depresi postpartum, kecemasan maternal, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) akibat pengalaman persalinan traumatik. Perawat maternitas kini dituntut untuk tidak hanya mampu merawat fisik pasien, namun juga memberikan dukungan emosional dan psikologis secara optimal.

C. Peran dan Fungsi Perawat Maternitas

Perawat maternitas memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan asuhan kepada perempuan selama masa reproduksi, mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan serta perawatan bayi baru lahir. Dalam melaksanakan perannya, perawat maternitas memiliki tiga fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu fungsi mandiri, kolaborasi, dan edukatif.

Fungsi mandiri merupakan peran yang secara khusus mencerminkan otonomi profesi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara independen. Fungsi ini mencakup pengkajian terhadap kondisi pasien, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan dan implementasi intervensi keperawatan, serta evaluasi terhadap efektivitas asuhan yang telah diberikan. Dalam praktik maternitas, perawat

secara mandiri mampu memberikan tindakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar ibu dan bayi, seperti memberikan perawatan kenyamanan pada ibu hamil, membantu ibu menjalani proses menyusui, memberikan edukasi tentang perawatan pascapersalinan, serta memberikan intervensi psikososial yang dibutuhkan selama masa reproduksi. Fungsi mandiri ini mencerminkan kompetensi klinis perawat yang profesional dalam menjalankan peranannya, yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan klinis yang telah dimiliki.

Selain fungsi mandiri, perawat maternitas juga menjalankan fungsi kolaborasi. Fungsi ini menempatkan perawat sebagai bagian integral dari tim interprofesional yang terdiri dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan, bidan, ahli gizi, psikolog, tenaga farmasi, serta profesi kesehatan lainnya. Kolaborasi ini sangat penting karena kondisi kesehatan maternal sering kali kompleks dan memerlukan pendekatan holistik serta multidisiplin. Dalam praktiknya, perawat maternitas bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya dalam menyusun rencana perawatan, menentukan prioritas intervensi, mendiskusikan kondisi pasien yang membutuhkan perhatian khusus, serta memastikan adanya koordinasi yang efektif agar setiap tindakan yang diberikan kepada pasien konsisten dan saling mendukung. Melalui kolaborasi ini, pelayanan keperawatan maternitas menjadi lebih komprehensif, aman, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan pasien secara optimal.

Fungsi edukatif merupakan bagian esensial dari peran perawat maternitas, yang berfokus pada pemberian informasi, edukasi, dan konseling kepada pasien dan keluarganya. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatan mereka serta mengembangkan keterampilan pasien dan keluarga dalam merawat dirinya sendiri maupun bayinya. Dalam konteks maternitas, fungsi edukatif meliputi berbagai aspek seperti edukasi kehamilan sehat, persiapan menghadapi persalinan, cara-cara merawat bayi baru lahir, teknik pemberian ASI eksklusif, pengenalan tanda-tanda bahaya selama kehamilan maupun pascapersalinan, hingga edukasi terkait pencegahan komplikasi yang mungkin timbul selama masa reproduksi. Perawat maternitas juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa edukasi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pemahaman pasien, menggunakan metode yang tepat, dan sensitif terhadap budaya serta nilai-nilai yang dianut oleh pasien dan keluarganya.

Dalam rangka menjalankan peran dan fungsi tersebut, perawat maternitas dituntut memiliki sejumlah kompetensi utama yang spesifik dalam bidangnya. Kompetensi tersebut mencakup pengetahuan mendalam tentang anatomi dan fisiologi reproduksi perempuan, pemahaman terhadap proses kehamilan, persalinan, dan nifas secara menyeluruh, serta kemampuan dalam melakukan pengkajian fisik maupun psikososial pada pasien maternal. Perawat maternitas juga

harus memiliki keterampilan klinis yang baik, seperti pemantauan kondisi janin melalui pemeriksaan fisik maupun alat bantu teknologi, teknik komunikasi terapeutik yang efektif, manajemen nyeri saat persalinan, dan kemampuan untuk mengelola kondisi emergensi maternal seperti perdarahan postpartum atau hipertensi dalam kehamilan. Kompetensi ini juga meluas pada aspek nonklinis, yakni kemampuan advokasi terhadap hak pasien, keterampilan memberikan konseling dan edukasi secara efektif, serta kompetensi bekerja secara kolaboratif dalam tim multidisiplin.

Seiring dengan kompetensi yang dimiliki, perawat maternitas juga memikul tanggung jawab etik dan legal yang sangat penting dalam praktik profesionalnya. Tanggung jawab etik mengacu pada kewajiban perawat untuk mematuhi kode etik keperawatan, menjaga martabat pasien, menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan terkait asuhan kesehatannya, serta menjaga kerahasiaan informasi pasien secara ketat. Etika dalam keperawatan maternitas menekankan pentingnya kejujuran, integritas, empati, dan sikap profesional yang tinggi dalam setiap interaksi dengan pasien dan keluarganya. Perawat maternitas juga wajib melakukan tindakan advokasi, yaitu memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang adil, setara, dan bermartabat dalam setiap kondisi.

Tanggung jawab legal yang dimiliki oleh perawat maternitas mengharuskan mereka untuk selalu bertindak sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, regulasi yang berlaku, serta undang-undang kesehatan yang telah ditetapkan. Perawat harus memahami dengan jelas batas-batas kewenangan profesinya serta mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, perawat juga wajib mendokumentasikan setiap asuhan yang diberikan secara akurat, lengkap, dan jelas, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang telah dilakukan. Dengan mematuhi tanggung jawab etik dan legal ini, perawat maternitas tidak hanya melindungi pasien dari risiko yang tidak diinginkan tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas profesi keperawatan maternitas itu sendiri.

Dengan demikian, melalui fungsi mandiri, kolaborasi, serta edukatif yang dilaksanakan secara optimal, disertai kompetensi profesional yang tinggi dan tanggung jawab etik serta legal yang ketat, perawat maternitas mampu memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi, aman, efektif, serta sensitif terhadap kebutuhan ibu dan keluarganya. Hal ini secara keseluruhan akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan selama masa reproduksinya, serta menciptakan pengalaman maternitas yang lebih aman, nyaman, dan penuh pemberdayaan bagi setiap

D. Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan

Kesehatan reproduksi perempuan merupakan aspek penting dalam kehidupan yang mencakup kondisi kesehatan fisik, mental, emosional, serta sosial yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi perempuan. Pemahaman yang tepat tentang kesehatan reproduksi menjadi dasar utama dalam pelaksanaan keperawatan maternitas, karena hal ini menentukan keberhasilan asuhan yang diberikan kepada perempuan di sepanjang siklus reproduksinya, mulai dari prakonsepsi hingga masa pascapersalinan.

Sistem reproduksi perempuan terdiri atas sejumlah organ penting yang secara anatomi dan fisiologis memiliki fungsi khusus dalam proses reproduksi. Organ-organ tersebut terdiri atas organ reproduksi internal maupun eksternal. Organ reproduksi internal meliputi ovarium, tuba falopi (saluran telur), uterus (rahim), dan vagina. Ovarium berfungsi sebagai tempat produksi hormon estrogen dan progesteron serta tempat pematangan ovum (sel telur). Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, berperan sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sperma dan ovum. Rahim merupakan organ penting yang berfungsi sebagai tempat implantasi atau menempelnya hasil pembuahan serta tempat pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Sementara vagina adalah saluran yang menghubungkan uterus dengan dunia luar, memiliki fungsi sebagai organ seksual dan jalan lahir bayi saat proses persalinan.

Selain organ internal, organ reproduksi eksternal perempuan disebut vulva yang mencakup mons pubis, labia mayor dan minor, klitoris, vestibulum, dan lubang vagina. Organ-organ ini memiliki fungsi perlindungan serta peran penting dalam proses seksual. Secara fisiologis, sistem reproduksi perempuan bekerja melalui mekanisme hormonal yang kompleks, terutama melibatkan hormon estrogen, progesteron, Follicle Stimulating Hormone (FSH), dan Luteinizing Hormone (LH), yang dihasilkan oleh ovarium dan kelenjar hipofisis di otak. Hormon-hormon tersebut bertanggung jawab terhadap siklus reproduksi perempuan serta memengaruhi berbagai aspek fisiologis dan psikologis selama siklus menstruasi maupun masa kehamilan.

Siklus reproduksi perempuan merupakan suatu proses periodik yang terjadi secara rutin setiap bulan yang melibatkan perubahan hormonal, anatomi, dan fisiologis dalam tubuh perempuan. Siklus ini umumnya berlangsung selama kurang lebih 28 hari, meskipun variasi panjang siklus antara 21 hingga 35 hari masih dianggap normal. Siklus menstruasi terbagi atas beberapa fase, yakni fase menstruasi, fase proliferasi, fase ovulasi, dan fase sekresi atau luteal. Fase menstruasi ditandai dengan peluruhan dinding rahim yang tidak dibuahi, menghasilkan perdarahan menstruasi yang berlangsung selama 3 hingga 7 hari. Setelah fase

menstruasi, fase proliferasi terjadi dengan peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan penebalan kembali dinding rahim sebagai persiapan terjadinya implantasi.

Selanjutnya, fase ovulasi merupakan pelepasan sel telur matang dari ovarium ke tuba falopi, biasanya terjadi di pertengahan siklus (hari ke-14 pada siklus 28 hari). Ovulasi dipicu oleh lonjakan hormon LH yang sangat signifikan. Setelah ovulasi, fase luteal berlangsung, di mana hormon progesteron diproduksi dalam jumlah besar untuk mempertahankan dinding rahim agar siap menerima hasil pembuahan. Jika pembuahan tidak terjadi, maka kadar estrogen dan progesteron menurun tajam sehingga dinding rahim meluruh kembali, menandai dimulainya siklus menstruasi berikutnya. Pemahaman terhadap siklus ini sangat penting bagi perawat maternitas, terutama dalam memberikan edukasi kepada perempuan terkait masa subur, perencanaan kehamilan, maupun pencegahan masalah kesehatan reproduksi.

Kesehatan reproduksi perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berinteraksi satu sama lain, meliputi aspek fisik, biologis, psikologis, sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi. Faktor fisik dan biologis mencakup usia perempuan, status gizi, kondisi medis tertentu seperti diabetes atau gangguan tiroid, serta adanya riwayat penyakit reproduksi seperti endometriosis atau infeksi organ reproduksi yang dapat memengaruhi kesuburan atau kesehatan selama kehamilan. Faktor psikologis, seperti tingkat stres, depresi, kecemasan, atau trauma masa lalu juga memengaruhi kesehatan reproduksi, baik dalam proses menstruasi maupun dalam kehamilan dan persalinan.

Faktor sosial dan budaya sangat berperan dalam menentukan pemahaman perempuan terhadap kesehatan reproduksinya. Adanya stigma sosial terhadap menstruasi atau kehamilannya yang tidak direncanakan dapat menyebabkan perempuan enggan mencari pelayanan kesehatan. Kepercayaan dan praktik tradisional yang kurang tepat, serta rendahnya tingkat pendidikan perempuan mengenai kesehatan reproduksi, juga menjadi tantangan utama dalam pemeliharaan kesehatan reproduksi yang baik. Selain itu, faktor lingkungan seperti akses terbatas ke fasilitas pelayanan kesehatan, sanitasi yang buruk, serta rendahnya akses terhadap informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi turut menjadi penghambat utama yang memengaruhi kesehatan perempuan.

Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan rendahnya pendapatan keluarga, juga berdampak besar terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, sulit mendapatkan nutrisi yang baik selama kehamilan, serta sering kali tidak mampu mengakses layanan antenatal secara memadai. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas.

Sebagai bagian integral dari pelayanan keperawatan maternitas, penting bagi perawat untuk memahami secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, sehingga dapat mengidentifikasi faktor risiko sejak dini, melakukan intervensi yang tepat sasaran, serta memberikan edukasi yang efektif kepada perempuan dan keluarganya. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua faktor ini memungkinkan perawat maternitas untuk memberikan asuhan yang optimal guna meningkatkan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan, serta memastikan kesehatan reproduksi yang baik di setiap tahap kehidupannya.

E. Model Konseptual dan Teori dalam Keperawatan Maternitas

Model konseptual dan teori dalam keperawatan maternitas merupakan landasan ilmiah yang menjadi acuan penting dalam melaksanakan praktik asuhan keperawatan secara sistematis, terstruktur, serta berbasis bukti ilmiah. Penggunaan model konseptual dan teori-teori ini membantu perawat maternitas untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana proses asuhan harus dilakukan, bagaimana cara pasien merespons berbagai situasi selama masa reproduksi, serta bagaimana pendekatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga secara efektif.

Teori Adaptasi Roy atau dikenal sebagai Roy Adaptation Model merupakan salah satu teori keperawatan yang sangat relevan dan banyak digunakan dalam konteks keperawatan maternitas. Teori ini dikembangkan oleh Callista Roy, dengan asumsi dasar bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk merespons perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupannya melalui proses adaptasi. Dalam konteks maternitas, perempuan mengalami berbagai perubahan signifikan baik secara fisik, emosional, maupun sosial yang memerlukan adaptasi yang tepat agar mereka dapat menjalani masa reproduksi dengan baik. Perubahan tersebut antara lain meliputi perubahan hormon selama kehamilan, perubahan fisik dalam tubuh, dan perubahan peran sebagai seorang ibu.

Menurut teori ini, perawat maternitas bertanggung jawab untuk membantu perempuan mencapai adaptasi positif dalam menghadapi perubahan tersebut. Proses adaptasi ini dilakukan melalui empat mode adaptasi yang diusung oleh Roy, yaitu mode fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi. Dalam mode fisiologis, perawat membantu pasien beradaptasi terhadap perubahan tubuh selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Pada mode konsep diri, perawat membantu perempuan untuk menjaga harga diri dan citra tubuh yang positif selama masa reproduksi. Mode fungsi peran melibatkan bantuan perawat dalam mendukung perempuan untuk menjalankan peran barunya sebagai ibu dengan

optimal. Sedangkan pada mode interdependensi, perawat mendorong hubungan yang harmonis antara pasien dan keluarga atau lingkungan sosialnya. Dengan pendekatan ini, perempuan diharapkan dapat melewati masa maternitas secara positif dengan hasil yang optimal bagi kesehatan dirinya dan bayinya.

Selanjutnya adalah teori Self-Care Orem, yang dikembangkan oleh Dorothea Orem. Teori ini menekankan pentingnya kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri secara mandiri, terutama ketika menghadapi situasi khusus seperti masa kehamilannya. Dalam konteks maternitas, teori ini menjadi sangat penting karena perempuan diharapkan mampu mengelola berbagai aspek perawatan dirinya selama masa reproduksi, seperti menjaga nutrisi yang seimbang, memperhatikan tanda-tanda bahaya selama kehamilan, serta melakukan praktik-praktik kesehatan mandiri untuk menjaga kondisi dirinya maupun janin.

Dalam praktik keperawatan maternitas, perawat menggunakan teori Self-Care Orem untuk menilai kemampuan pasien dalam merawat diri, mengidentifikasi kebutuhan edukasi pasien, dan mengembangkan intervensi yang tepat guna meningkatkan kemampuan self-care pasien. Perawat maternitas bertindak sebagai fasilitator sekaligus pendidik yang membantu perempuan untuk memahami pentingnya perawatan diri mandiri, memberikan edukasi mengenai tindakan self-care yang efektif, serta menyediakan bantuan atau dukungan tambahan saat pasien mengalami keterbatasan dalam melakukan perawatan mandiri. Dengan pendekatan ini, perempuan tidak hanya menjadi penerima pasif asuhan kesehatan, tetapi juga aktif terlibat dalam menjaga kesehatannya sendiri, sehingga meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan hasil kesehatan yang lebih baik selama masa reproduksi.

Selain kedua teori tersebut, model konseptual Family-Centered Care (FCC) juga memiliki posisi sentral dalam praktik keperawatan maternitas masa kini. Family-Centered Care adalah model perawatan yang menempatkan keluarga sebagai pusat utama dalam proses asuhan. Konsep ini meyakini bahwa keluarga merupakan bagian integral dalam kehidupan pasien, yang sangat mempengaruhi bagaimana pasien mengalami kesehatan dan penyakit, serta bagaimana pasien mengelola perubahan kehidupan seperti kehamilan, persalinan, atau perawatan bayi baru lahir. Model ini menegaskan bahwa keputusan dan asuhan harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai, kebutuhan, preferensi, dan partisipasi aktif keluarga.

Dalam praktik keperawatan maternitas, model Family-Centered Care diwujudkan dengan melibatkan anggota keluarga secara aktif dalam proses perawatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi asuhan. Perawat maternitas bertanggung jawab untuk memberikan edukasi yang jelas kepada keluarga mengenai kondisi pasien, mengajak keluarga untuk terlibat aktif dalam

mendukung pasien selama kehamilan, persalinan, serta perawatan bayi baru lahir, serta mempertimbangkan masukan keluarga dalam setiap pengambilan keputusan. Selain meningkatkan kualitas asuhan yang diberikan, model ini juga terbukti mampu memperlerat hubungan emosional antar anggota keluarga, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, serta mempercepat proses adaptasi keluarga dalam menjalankan peran baru setelah kelahiran bayi.

F. Proses Keperawatan dalam Praktik Maternitas

Proses keperawatan merupakan rangkaian sistematis yang menjadi dasar utama dalam memberikan asuhan keperawatan secara efektif, aman, serta berorientasi pada kebutuhan individu pasien. Dalam praktik keperawatan maternitas, proses ini menjadi pedoman penting yang memandu setiap langkah perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas tinggi. Proses keperawatan terdiri atas tahapan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan dan implementasi asuhan, serta evaluasi efektivitas asuhan keperawatan yang diberikan.

Pengkajian keperawatan merupakan langkah awal dalam proses keperawatan yang sangat penting dalam praktik maternitas. Pengkajian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang komprehensif mengenai kondisi fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dari pasien maternitas. Proses pengkajian dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, serta penelaahan catatan medis pasien. Pengkajian keperawatan maternitas mencakup riwayat kehamilan saat ini dan sebelumnya, kondisi medis masa lalu dan sekarang, riwayat keluarga, status gizi ibu, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik sistem reproduksi, serta pengkajian psikososial seperti tingkat stres, dukungan keluarga, dan kesiapan pasien dalam menghadapi masa reproduksi.

Selama proses pengkajian, perawat juga melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor risiko yang mungkin muncul selama masa kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Informasi yang didapat dari hasil pengkajian digunakan untuk menyusun gambaran utuh tentang kondisi pasien, sekaligus menjadi dasar penetapan diagnosa keperawatan serta perencanaan tindakan keperawatan berikutnya.

Setelah pengkajian selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan pernyataan yang mendeskripsikan masalah atau respon pasien terhadap kondisi kesehatan yang dialaminya, serta menjadi dasar untuk menentukan rencana tindakan keperawatan. Dalam keperawatan maternitas, diagnosa keperawatan bisa berupa masalah aktual maupun potensial yang dialami perempuan selama masa reproduksinya. Contoh diagnosa yang umum ditemui meliputi mual muntah berlebihan selama kehamilan

(hiperemesis gravidarum), kecemasan dalam menghadapi proses persalinan, risiko infeksi pascapersalinan, ketidaknyamanan akibat kontraksi uterus, nyeri akut terkait persalinan, serta gangguan pola tidur selama masa nifas.

Diagnosa keperawatan yang dibuat harus spesifik, jelas, akurat, serta didasarkan pada bukti yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan sebelumnya. Setiap diagnosa keperawatan harus memiliki rasionalisasi ilmiah yang jelas sehingga intervensi keperawatan yang nantinya dirancang dapat efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Langkah berikutnya dalam proses keperawatan maternitas adalah perencanaan dan implementasi asuhan keperawatan. Perencanaan merupakan tahap penting di mana perawat menentukan prioritas kebutuhan pasien, merancang tujuan asuhan yang akan dicapai, serta menyusun intervensi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menyusun perencanaan, perawat maternitas harus melibatkan pasien dan keluarganya agar tujuan dan intervensi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan serta preferensi pasien secara realistis.

Implementasi asuhan keperawatan adalah proses pelaksanaan dari rencana keperawatan yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, perawat maternitas melakukan tindakan keperawatan secara langsung kepada pasien, seperti memberikan edukasi mengenai nutrisi selama kehamilan, membantu pasien melakukan latihan relaksasi saat kontraksi persalinan, mengajarkan teknik perawatan diri pada masa nifas, serta memberikan tindakan klinis yang diperlukan seperti perawatan luka pascapersalinan atau pemantauan tanda vital ibu dan bayi. Setiap intervensi yang diberikan oleh perawat maternitas harus selalu berdasarkan prinsip evidence-based nursing sehingga efektif dan aman dalam menyelesaikan masalah yang dialami pasien.

Tahap akhir dalam proses keperawatan maternitas adalah evaluasi efektivitas asuhan keperawatan yang telah diberikan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah tujuan asuhan keperawatan yang dirancang telah tercapai secara optimal, serta untuk menentukan apakah pasien telah mengalami perubahan atau perbaikan kondisi kesehatan sebagaimana yang diharapkan. Evaluasi dilakukan dengan berbagai metode, seperti observasi langsung terhadap kondisi pasien, wawancara untuk mengetahui persepsi pasien mengenai perubahan yang dialami, serta analisis dokumentasi klinis seperti catatan keperawatan maupun hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium terbaru.

Dalam evaluasi, perawat juga menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi hambatan yang ditemui selama proses asuhan, serta menetapkan apakah ada kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap rencana asuhan yang sebelumnya dibuat. Jika evaluasi menunjukkan bahwa tujuan belum

tercapai atau muncul masalah baru, maka proses keperawatan kembali dilakukan mulai dari tahap pengkajian untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan asuhan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan terkini.

G. Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Nursing) dalam Maternitas

Asuhan keperawatan berbasis bukti atau dikenal sebagai Evidence-Based Nursing (EBN) merupakan pendekatan sistematis yang digunakan oleh perawat untuk memberikan pelayanan keperawatan dengan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis perawat, serta mempertimbangkan nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien secara individual. Dalam praktik keperawatan maternitas, pendekatan berbasis bukti memiliki peranan sangat penting karena proses asuhan dalam masa reproduksi perempuan, seperti kehamilan, persalinan, hingga masa nifas, sangat kompleks dan dinamis serta terus mengalami perkembangan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan pendekatan ini memastikan bahwa asuhan yang diberikan oleh perawat maternitas senantiasa mutakhir, efektif, aman, serta mampu menghasilkan outcome kesehatan yang optimal bagi ibu dan bayi.

Pentingnya penerapan Evidence-Based Nursing dalam praktik keperawatan maternitas terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal. Dengan menerapkan EBN, perawat maternitas mampu mengidentifikasi intervensi-intervensi keperawatan yang paling efektif dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi, mencegah komplikasi yang berpotensi membahayakan ibu dan bayi, serta mempercepat proses pemulihan ibu pascapersalinan. Selain itu, pendekatan berbasis bukti juga membantu perawat dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga yang didasarkan pada informasi ilmiah terbaru, sehingga meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatannya serta memperkuat kemandirian pasien dalam melakukan perawatan diri secara mandiri.

EBN dalam praktik maternitas juga mendukung perawat dalam mengambil keputusan klinis secara lebih rasional dan terukur. Dengan merujuk pada hasil penelitian terkini, perawat maternitas dapat menghindari praktik-praktik yang telah terbukti kurang efektif atau bahkan berbahaya, serta mendorong penerapan praktik-praktik yang lebih aman dan terbukti memberikan hasil terbaik bagi kesehatan ibu dan bayi. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada penurunan angka morbiditas dan mortalitas maternal, peningkatan keselamatan pasien, serta peningkatan kepuasan pasien dan keluarganya terhadap pelayanan yang diberikan.

Penerapan hasil penelitian terkini dalam asuhan keperawatan maternitas merupakan inti dari praktik EBN. Dalam konteks maternitas, perawat dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan penelitian terbaru yang relevan dengan bidangnya, baik melalui literatur ilmiah, jurnal penelitian terkini, pedoman klinis berbasis bukti (clinical practice guidelines), maupun rekomendasi dari organisasi profesional internasional seperti WHO, ACOG, ICM, dan AWHONN. Contoh penerapan hasil penelitian terkini dalam praktik keperawatan maternitas antara lain penggunaan metode manajemen nyeri nonfarmakologis selama persalinan seperti teknik relaksasi, aromaterapi, atau pijat terapeutik yang terbukti efektif dalam mengurangi nyeri dan kecemasan ibu; penerapan inisiasi menyusui dini (IMD) yang telah terbukti secara ilmiah meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif serta mempercepat ikatan emosional ibu dan bayi; serta penggunaan intervensi berbasis psikologis seperti cognitive behavioral therapy (CBT) dalam mengelola kecemasan dan depresi pada ibu selama masa reproduksi.

Selain itu, hasil penelitian terbaru juga mendorong perawat maternitas untuk melakukan berbagai inovasi dalam praktik klinisnya, seperti penggunaan teknologi digital dalam edukasi antenatal, penerapan telehealth dalam pemantauan kondisi ibu hamil secara jarak jauh, serta penerapan praktik delayed cord clamping yang terbukti dapat meningkatkan kadar hemoglobin bayi baru lahir secara signifikan. Hasil penelitian ini membantu perawat dalam menentukan prioritas tindakan, memilih metode intervensi yang tepat dan efektif, serta mengevaluasi secara kritis manfaat dan risiko dari setiap tindakan keperawatan yang dilakukan.

Penerapan hasil penelitian dalam praktik keperawatan maternitas tentu bukan tanpa tantangan. Perawat maternitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses hasil penelitian terkini, kesulitan dalam memahami atau menerjemahkan hasil penelitian ke dalam praktik klinis sehari-hari, serta resistensi dari rekan sejawat atau pasien yang masih mempertahankan tradisi praktik lama yang belum berbasis bukti. Oleh karena itu, perawat maternitas dituntut memiliki keterampilan khusus dalam mencari, memahami, menginterpretasikan, serta mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik klinisnya. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi perawat maternitas menjadi kebutuhan penting agar mereka mampu menerapkan hasil penelitian secara efektif di lapangan.

H. Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Maternitas

Komunikasi terapeutik merupakan salah satu komponen penting dalam praktik keperawatan maternitas, yang melibatkan proses interaksi secara sadar, terencana, serta bertujuan antara perawat dengan pasien dan keluarga. Komunikasi ini tidak sekadar pertukaran informasi, tetapi lebih dalam lagi merupakan suatu pendekatan

emosional, empatik, serta interpersonal yang bertujuan untuk membantu pasien mencapai pemahaman, meningkatkan penerimaan terhadap kondisi yang dialami, serta memfasilitasi perubahan perilaku yang positif terkait kesehatan reproduksinya. Dalam konteks keperawatan maternitas, komunikasi terapeutik sangat penting karena perempuan selama masa reproduksi sering menghadapi perubahan fisik, psikologis, dan emosional yang signifikan, sehingga memerlukan dukungan psikososial yang kuat dari tenaga kesehatan.

Salah satu aspek utama komunikasi terapeutik dalam keperawatan maternitas adalah strategi komunikasi efektif dengan ibu hamil dan keluarga. Strategi ini menitikberatkan pada pembentukan hubungan saling percaya (*trust relationship*) antara perawat dan pasien melalui berbagai cara. Langkah awal yang penting adalah menciptakan lingkungan komunikasi yang nyaman dan aman secara emosional, sehingga pasien merasa dihargai, diterima, dan dihormati. Perawat maternitas menggunakan komunikasi verbal maupun nonverbal yang sesuai, misalnya melalui penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana, mempertahankan kontak mata yang tepat, menunjukkan ekspresi wajah yang ramah dan penuh empati, serta menggunakan nada suara yang menenangkan.

Dalam berkomunikasi secara efektif dengan ibu hamil dan keluarganya, perawat maternitas juga perlu menerapkan keterampilan mendengarkan aktif (*active listening*). Mendengarkan aktif mencakup kemampuan perawat untuk mendengar dengan penuh perhatian, memahami perasaan yang tersirat dalam pesan yang disampaikan pasien, serta memberikan respons yang relevan dan bermakna. Perawat maternitas juga perlu menunjukkan sikap empati yang tulus terhadap kondisi pasien, yaitu dengan mencoba memahami perasaan atau pengalaman pasien dari sudut pandangnya sendiri. Selain itu, perawat juga perlu mengedepankan keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi medis, edukasi tentang kehamilan, persalinan, serta berbagai tindakan klinis yang akan dilakukan. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya pasien terhadap perawat serta meningkatkan keterlibatan pasien dalam keputusan yang berkaitan dengan asuhan kesehatannya.

Strategi komunikasi efektif juga mencakup pendekatan individual yang sensitif terhadap perbedaan budaya, latar belakang sosial, pendidikan, serta nilai-nilai keluarga pasien. Perawat maternitas harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi serta cara penyampaian informasi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik individu pasien, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Keterlibatan keluarga dalam komunikasi juga menjadi sangat penting, karena keluarga merupakan sistem pendukung utama pasien dalam menjalani masa kehamilan hingga pascapersalinan. Melalui komunikasi yang inklusif, perawat dapat

memperkuat pemahaman keluarga tentang kondisi pasien, meningkatkan partisipasi mereka dalam perawatan pasien, serta mendorong terciptanya dukungan sosial yang kuat.

Selain strategi komunikasi efektif, perawat maternitas juga harus menguasai teknik komunikasi dalam situasi krisis dan sensitif. Situasi ini sering kali ditemui dalam praktik keperawatan maternitas, seperti komplikasi serius selama kehamilan, kondisi darurat saat persalinan, kelahiran bayi prematur, kehilangan bayi, atau kondisi ibu yang kritis setelah melahirkan. Dalam situasi tersebut, perawat harus mampu berkomunikasi secara hati-hati, empatik, namun jelas, agar pasien dan keluarga mampu menghadapi situasi yang sulit tersebut dengan baik.

Teknik komunikasi dalam situasi krisis mencakup kemampuan perawat dalam memberikan informasi yang jelas, akurat, serta realistis mengenai kondisi yang dihadapi oleh pasien dan keluarganya. Informasi harus disampaikan dengan jujur namun tetap penuh empati, memperhatikan kondisi emosional pasien dan keluarganya. Perawat juga harus mampu mengontrol emosi pribadi sehingga tetap tenang, profesional, dan suportif selama berkomunikasi dalam situasi kritis tersebut. Teknik khusus seperti penggunaan kalimat pendek, sederhana, jelas, serta langsung pada poin inti permasalahan, sangat dianjurkan untuk mengurangi kebingungan dan kecemasan pasien serta keluarganya.

Selain itu, perawat maternitas juga dituntut memiliki keterampilan khusus dalam menyampaikan kabar buruk (breaking bad news), misalnya kematian janin, keguguran, atau diagnosis komplikasi serius. Dalam hal ini, teknik komunikasi seperti SPIKES Protocol (Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, Strategy/Summary) dapat digunakan oleh perawat untuk memastikan bahwa pesan disampaikan dengan baik, jelas, empatik, serta dengan mempertimbangkan kesiapan emosional pasien. Melalui teknik ini, perawat dapat memberikan ruang bagi pasien dan keluarganya untuk bereaksi secara emosional, serta memberikan dukungan emosional tambahan yang dibutuhkan.

Dalam situasi sensitif, teknik validasi perasaan juga sangat penting, di mana perawat secara verbal mengakui dan menghargai perasaan serta pengalaman emosional pasien. Hal ini bertujuan untuk membantu pasien merasa didengar, dipahami, serta dihargai dalam kondisi sulit yang sedang dialaminya. Komunikasi terapeutik dalam situasi sensitif ini bertujuan tidak hanya sekadar untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membantu pasien dan keluarga mengatasi krisis dengan pendekatan yang empatik dan penuh perhatian.

I. Aspek Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan Maternitas

Aspek psikososial dan budaya merupakan dimensi penting dalam praktik keperawatan maternitas yang harus diperhatikan secara serius oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat. Periode reproduksi perempuan yang mencakup masa kehamilan, persalinan, hingga nifas, tidak hanya melibatkan perubahan fisik semata, namun juga perubahan emosional, psikologis, sosial, dan budaya yang signifikan. Perawat maternitas harus mampu mengenali, memahami, serta merespons secara tepat berbagai aspek psikososial dan budaya yang dialami oleh pasien agar asuhan keperawatan yang diberikan bersifat holistik dan mampu memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif.

Pengaruh budaya dalam praktik keperawatan maternitas memiliki dampak signifikan terhadap sikap, perilaku, persepsi, serta keputusan yang diambil perempuan selama masa reproduksinya. Setiap budaya memiliki keyakinan, nilai-nilai, norma sosial, serta kebiasaan tertentu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, maupun perawatan bayi baru lahir. Misalnya, dalam budaya tertentu, terdapat keyakinan tentang pantangan makanan tertentu selama kehamilan, ritual khusus sebelum persalinan, atau kebiasaan merawat bayi baru lahir dengan cara-cara tradisional yang telah turun temurun. Hal-hal seperti ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana perempuan menjalani masa reproduksinya dan bagaimana mereka menerima atau menolak pelayanan kesehatan.

Perawat maternitas perlu memahami bahwa praktik-praktik budaya ini bisa menjadi penguat bagi pasien atau justru sebaliknya, menjadi hambatan bagi tercapainya kesehatan yang optimal. Pemahaman terhadap aspek budaya ini memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan yang sensitif budaya (*culturally sensitive care*). Dalam hal ini, perawat harus menunjukkan sikap terbuka, toleran, serta menghargai perbedaan budaya pasien, sekaligus mampu melakukan edukasi dan negosiasi secara hati-hati apabila ada praktik-praktik budaya tertentu yang secara ilmiah terbukti kurang tepat atau berisiko bagi kesehatan ibu dan bayi.

Perawat maternitas juga perlu memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan transkultural yang baik, yaitu pendekatan keperawatan yang mempertimbangkan perbedaan budaya pasien dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan. Perawat harus memahami secara mendalam keyakinan pasien, gaya komunikasi, bahasa tubuh, kebiasaan keluarga, serta sistem dukungan sosial yang dimiliki oleh pasien, agar pasien merasa dipahami, dihargai, serta bersedia bekerja sama secara optimal dalam proses perawatan.

Selain aspek budaya, dukungan psikososial merupakan elemen penting lainnya dalam keperawatan maternitas. Masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas adalah masa yang penuh tantangan secara emosional bagi perempuan. Selama

periode ini, perempuan sering mengalami kecemasan, ketakutan, stres, atau bahkan kondisi yang lebih serius seperti depresi dan gangguan psikologis lainnya. Dukungan psikososial yang baik dari perawat maternitas dapat membantu pasien menghadapi tantangan tersebut dengan lebih positif dan adaptif.

Dukungan psikososial ini mencakup berbagai aspek seperti dukungan emosional, dukungan informasi, dukungan instrumental atau praktis, serta dukungan sosial dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, pasangan, dan komunitas. Dukungan emosional dilakukan dengan cara memberikan perhatian penuh, empati, rasa nyaman, serta kehadiran fisik maupun psikologis perawat di samping pasien selama masa sulit yang dialaminya. Dukungan informasi mencakup pemberian edukasi yang jelas tentang kondisi kehamilan, proses persalinan, perawatan pascapersalinan, serta berbagai hal yang perlu diantisipasi oleh pasien agar mampu mengurangi kecemasan serta ketidakpastian yang dialaminya.

Dukungan instrumental atau praktis melibatkan bantuan konkret dari perawat, seperti membantu pasien dalam melakukan perawatan diri, memberikan bantuan praktis dalam mengatasi ketidaknyamanan fisik selama kehamilan, mendampingi pasien saat proses persalinan, serta memberikan bantuan yang dibutuhkan selama masa nifas. Dukungan sosial berfokus pada penguatan relasi pasien dengan keluarga, pasangan, serta komunitasnya, sehingga pasien merasa lebih terhubung, diterima, serta didukung secara sosial dalam menjalani peran barunya sebagai ibu.

Perawat maternitas juga perlu melakukan skrining psikologis secara rutin untuk mengidentifikasi secara dini masalah psikososial yang mungkin dialami pasien, seperti depresi postpartum atau gangguan kecemasan. Dalam situasi ini, perawat harus mampu memberikan intervensi awal berupa dukungan psikologis secara intensif serta mampu melakukan rujukan kepada profesional kesehatan mental jika dibutuhkan.

J. Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Maternitas

Kolaborasi interprofesional dalam keperawatan maternitas merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang melibatkan kerja sama erat antara perawat maternitas dengan berbagai profesi kesehatan lainnya. Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai pusat utama pelayanan, dengan tujuan memberikan asuhan yang terintegrasi, holistik, efektif, dan aman bagi perempuan selama periode reproduksinya, mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Pentingnya kolaborasi interprofesional dalam keperawatan maternitas didasari oleh kenyataan bahwa proses kesehatan reproduksi sering kali kompleks, dinamis, dan membutuhkan perspektif serta keahlian yang beragam dari berbagai profesi kesehatan.

Dalam praktik keperawatan maternitas, tim interprofesional biasanya terdiri dari perawat maternitas, bidan, dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter anak, dokter anestesi, psikolog, ahli gizi, tenaga farmasi, pekerja sosial, serta berbagai profesi lain sesuai kebutuhan spesifik pasien. Setiap anggota tim interprofesional memiliki peran dan tanggung jawab khusus yang saling melengkapi, guna mencapai tujuan bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal yang optimal. Sebagai contoh, perawat maternitas bertanggung jawab memberikan asuhan keperawatan holistik, melaksanakan intervensi klinis, serta memberikan edukasi kesehatan. Bidan bertanggung jawab terhadap proses persalinan normal serta pemantauan kehamilan risiko rendah, sedangkan dokter spesialis obstetri-ginekologi bertanggung jawab terhadap penanganan komplikasi kehamilan, persalinan berisiko tinggi, maupun intervensi medis yang kompleks.

Dokter anak bertanggung jawab terhadap kesehatan bayi baru lahir, termasuk resusitasi neonatal jika dibutuhkan. Dokter anestesi berperan dalam manajemen nyeri selama persalinan serta anestesi selama operasi Caesar jika diperlukan. Psikolog bertanggung jawab memberikan dukungan psikologis kepada pasien yang mengalami kecemasan atau depresi selama masa reproduksi, sedangkan ahli gizi memastikan bahwa kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi secara optimal selama kehamilan maupun masa menyusui. Tenaga farmasi berperan dalam memastikan penggunaan obat-obatan yang aman bagi ibu dan bayi, sementara pekerja sosial membantu pasien yang memiliki masalah sosial-ekonomi agar dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan baik.

Kolaborasi interprofesional tidak hanya terbatas pada peran masing-masing profesi, tetapi juga mencakup komunikasi, koordinasi, serta pengambilan keputusan bersama di antara semua anggota tim. Setiap anggota tim harus mampu bekerja dalam lingkungan kolaboratif, saling menghormati peran masing-masing, serta terbuka dalam memberikan masukan dan menerima kritik yang konstruktif. Perawat maternitas sebagai bagian integral dari tim harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, mampu bekerja secara tim, serta memiliki keterampilan advokasi yang tinggi untuk memastikan bahwa kebutuhan pasien terpenuhi dengan optimal.

Untuk mencapai kolaborasi interprofesional yang efektif dalam keperawatan maternitas, diperlukan strategi khusus yang dapat diterapkan di berbagai tingkat layanan kesehatan. Strategi pertama adalah peningkatan komunikasi antarprofesi yang jelas dan efektif. Komunikasi ini mencakup diskusi rutin atau briefing harian, penggunaan dokumentasi bersama yang jelas, serta komunikasi terbuka dalam forum atau diskusi klinis rutin. Penggunaan metode komunikasi standar seperti

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) juga sangat membantu dalam menciptakan komunikasi yang efektif, jelas, serta terarah.

Strategi kedua adalah pengembangan tim melalui pelatihan interprofesional secara reguler. Pelatihan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antarprofesi mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, meningkatkan rasa percaya diri antaranggota tim, serta menciptakan budaya kerja sama yang positif. Pelatihan interprofesional dapat mencakup simulasi situasi klinis yang kompleks, latihan keterampilan komunikasi antarprofesi, serta kegiatan team-building yang bertujuan memperkuat relasi interpersonal di antara anggota tim.

Strategi ketiga adalah penggunaan pedoman klinis berbasis bukti (clinical practice guidelines) yang disepakati oleh seluruh profesi dalam tim. Pedoman klinis yang jelas, konsisten, serta berbasis bukti ilmiah terbaru akan membantu mengurangi kesalahan komunikasi, menyamakan persepsi antaranggota tim, serta memastikan bahwa semua profesi kesehatan bekerja menuju tujuan yang sama. Dalam penyusunan pedoman ini, semua anggota tim interprofesional perlu dilibatkan sehingga keputusan klinis yang dihasilkan benar-benar merefleksikan konsensus bersama dari seluruh profesi yang terlibat.

Strategi keempat adalah evaluasi rutin terhadap proses kolaborasi antarprofesi dalam praktik klinis. Evaluasi ini mencakup penilaian efektivitas komunikasi, tingkat kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan, identifikasi hambatan yang muncul selama proses kolaborasi, serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Melalui evaluasi rutin ini, tim dapat secara cepat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memastikan bahwa pelayanan keperawatan maternitas terus berkembang secara positif.

Dengan menerapkan kolaborasi interprofesional secara optimal, tim kesehatan maternitas mampu memberikan pelayanan yang lebih komprehensif, aman, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan pasien dan keluarganya. Kolaborasi ini juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, menghargai peran setiap profesi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, kolaborasi interprofesional dalam keperawatan maternitas tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi secara signifikan, tetapi juga memberikan pengalaman reproduksi yang positif, bermakna, serta memberdayakan bagi perempuan dan keluarganya.

K. Tantangan dan Isu Terkini dalam Keperawatan Maternitas

Dalam era modern ini, bidang keperawatan maternitas menghadapi berbagai tantangan dan isu yang kompleks serta membutuhkan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, terutama perawat maternitas. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam lingkup global adalah meningkatnya angka kematian ibu dan bayi di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Berdasarkan laporan terbaru dari organisasi kesehatan internasional, meskipun telah ada berbagai intervensi kesehatan yang signifikan, namun angka kematian ibu dan bayi tetap tinggi akibat berbagai faktor seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, ketidaksetaraan ekonomi, dan masalah infrastruktur kesehatan yang kurang memadai. Selain itu, kekurangan tenaga keperawatan yang terlatih secara profesional juga menjadi isu serius yang memperlambat upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, penting bagi perawat maternitas untuk terus meningkatkan kompetensi, kemampuan klinis, dan keterampilan advokasi mereka dalam upaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi secara global.

Tantangan global lain yang perlu mendapat perhatian khusus adalah meningkatnya beban penyakit kronis pada ibu hamil, seperti diabetes melitus gestasional, hipertensi, preeklampsia, serta gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan selama kehamilan dan masa nifas. Fenomena ini menciptakan tantangan tersendiri dalam praktik keperawatan maternitas, karena kondisi-kondisi tersebut memerlukan pendekatan asuhan yang komprehensif, berbasis bukti, serta terintegrasi dengan tim interprofesional lainnya. Oleh karena itu, tenaga keperawatan maternitas harus mampu mengenali secara dini gejala-gejala penyakit kronis tersebut serta mengimplementasikan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing pasien. Selain itu, perubahan demografis berupa peningkatan usia ibu saat kehamilannya juga menghadirkan risiko tambahan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, yang menuntut kemampuan khusus dari perawat dalam melakukan asesmen risiko yang tepat dan menyusun rencana asuhan yang adaptif.

Selain tantangan global tersebut, isu etik dan legal juga menjadi perhatian utama dalam keperawatan maternitas saat ini. Isu etik yang sering muncul mencakup masalah pengambilan keputusan terkait perawatan ibu hamil dan janin, khususnya dalam situasi-situasi kritis yang membutuhkan keputusan cepat namun sarat dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai budaya. Contohnya adalah keputusan mengenai tindakan intervensi medis seperti sectio caesarea pada kondisi tertentu atau terminasi kehamilan dalam kondisi kesehatan yang mengancam nyawa ibu. Di sinilah peran penting perawat dalam memberikan edukasi yang jelas

kepada pasien dan keluarga, serta menjembatani komunikasi antara tim medis dengan pasien, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip otonomi pasien, keadilan, dan benefisiensi.

Di sisi lain, isu legal yang kerap muncul dalam praktik keperawatan maternitas adalah masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien maupun tenaga kesehatan. Banyak kasus yang dilaporkan mengenai pelanggaran hak pasien, seperti kurangnya persetujuan tindakan medis yang informatif (informed consent), kelalaian medis yang berpotensi menyebabkan litigasi, serta masalah privasi dan kerahasiaan informasi medis pasien. Isu ini tidak hanya berdampak buruk bagi pasien, tetapi juga mengancam kredibilitas profesi perawat secara umum. Untuk itu, tenaga keperawatan maternitas perlu memahami dengan baik tentang aspek hukum yang relevan dalam praktiknya, termasuk pentingnya dokumentasi medis yang teliti, akurat, dan lengkap sebagai upaya perlindungan hukum bagi diri mereka sendiri dan pasien.

Dengan mempertimbangkan tantangan global serta isu etik dan legal yang semakin kompleks, diperlukan perhatian yang serius dari institusi kesehatan, lembaganya pendidikan, serta organisasi profesi keperawatan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi perawat maternitas. Melalui pendekatan multidisiplin, kolaboratif, dan berbasis bukti, diharapkan perawat maternitas mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi, serta mampu menjawab berbagai tantangan dan isu terkini dalam bidang keperawatan maternitas.

L. Simpulan

Keperawatan maternitas merupakan cabang spesialisasi keperawatan yang berfokus pada asuhan kesehatan perempuan selama masa reproduksi, mulai dari prakonsepsi hingga pascapersalinan serta perawatan neonatus. Filosofi dasar keperawatan maternitas bertumpu pada penghormatan hak reproduksi perempuan, pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan pemberian asuhan berbasis keluarga dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, emosional, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Dalam menjalankan tugasnya, perawat maternitas memiliki tiga fungsi utama, yaitu mandiri, kolaborasi, dan edukatif, yang dijalankan dengan kompetensi klinis tinggi serta kesadaran terhadap tanggung jawab etik dan legal yang ketat.

Secara historis, praktik keperawatan maternitas mengalami perkembangan signifikan dari pendekatan tradisional menuju praktik berbasis ilmiah dan bukti (Evidence-Based Nursing). Tren kontemporer dalam keperawatan maternitas

meliputi penerapan model Family-Centered Care yang menekankan peran aktif keluarga, penggunaan teknologi digital, peningkatan perhatian pada aspek psikologis, serta pendekatan multidisiplin yang melibatkan kolaborasi interprofesional. Model konseptual seperti Roy Adaptation Model, Self-Care Orem, dan Family-Centered Care menjadi landasan penting dalam pelaksanaan praktik maternitas guna membantu perempuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang dialaminya selama masa reproduksi.

Proses keperawatan maternitas dilaksanakan secara sistematis, meliputi pengkajian komprehensif, penetapan diagnosa keperawatan yang akurat, perencanaan dan implementasi intervensi berbasis bukti, serta evaluasi efektif terhadap asuhan yang diberikan. Aspek psikososial dan budaya juga menjadi komponen penting dalam pemberian asuhan keperawatan maternitas, di mana perawat dituntut untuk memberikan dukungan emosional yang kuat, komunikasi terapeutik yang efektif, serta pelayanan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya pasien.

Tantangan global utama dalam bidang keperawatan maternitas meliputi tingginya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya prevalensi penyakit kronis selama kehamilan, serta berbagai isu etik dan legal terkait pengambilan keputusan kritis dalam pelayanan maternitas. Oleh karena itu, tenaga keperawatan maternitas perlu terus meningkatkan kompetensi profesional, keterampilan komunikasi dan advokasi, serta pemahaman terhadap aspek etik dan legal dalam praktiknya. Melalui pendekatan kolaboratif antarprofesi, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan penerapan Evidence-Based Nursing secara konsisten, diharapkan perawat maternitas mampu menjawab berbagai tantangan dan isu terkini secara efektif, sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu, bayi, serta keluarga secara keseluruhan.

M. Referensi

- Arulkumaran, S. (2020). *Maternal and Child Health Nursing*. Cambridge University Press.
- Black, R. E., Laxminarayan, R., Temmerman, M., & Walker, N. (Eds.). (2023). *Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health: Disease Control Priorities* (3rd ed.). The World Bank.
- Dewi, I. G. A. O., & Widjaja, I. (2022). *Keperawatan Maternitas & Neonatal: Konsep, Teori, dan Praktik*. Penerbit Salemba Medika.

- Henderson, A., & Norton, W. (2021). Family-centered maternity care: principles and practice. *Journal of Advanced Nursing*, 77(6), 2484–2495.
<https://doi.org/10.1111/jan.1482>
- Orem, D. E. (2001). *Nursing: Concepts of Practice* (6th ed.). Mosby.
- Reed, R. A., & Smith, J. (2019). Cultural competence in maternal child nursing. *Journal of Transcultural Nursing*, 30(2), 95–103.
<https://doi.org/10.1177/1043659618814565>
- Roy, C. (2009). *The Roy Adaptation Model* (3rd ed.). Pearson.
- World Health Organization. (2024). Trends in Maternal Mortality: 2000 to 2022. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. WHO.
- Yanti, D., & Prasetyo, B. (2022). Implementasi komunikasi terapeutik pada perawatan ibu postpartum. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(1), 12–21.

N. Glosarium

Asuhan Keperawatan Maternitas: Pelayanan keperawatan spesialisasi yang diberikan kepada perempuan selama periode reproduksinya, mencakup prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir.

Family-Centered Care (FCC): Pendekatan asuhan keperawatan yang menempatkan keluarga sebagai pusat perhatian utama, melibatkan secara aktif keluarga dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.

Evidence-Based Nursing (EBN): Pendekatan keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien dalam setiap tindakan keperawatan yang dilakukan.

Komunikasi Terapeutik: Proses interaksi yang dirancang secara sadar dan empatik antara perawat dengan pasien dan keluarganya, bertujuan meningkatkan pemahaman, penerimaan kondisi kesehatan, dan perubahan perilaku yang positif.

Periode Nifas: Masa setelah persalinan hingga sekitar enam minggu, di mana ibu mengalami pemulihan fisik dan emosional serta adaptasi terhadap peran barunya sebagai ibu.

Neonatus: Bayi baru lahir hingga usia 28 hari, yang memerlukan perhatian khusus terutama dalam pemantauan kondisi kesehatan dan pemberian nutrisi, seperti ASI eksklusif.

Adaptasi Roy (Roy Adaptation Model): Teori keperawatan yang dikembangkan oleh Callista Roy, yang berfokus pada kemampuan individu untuk beradaptasi secara positif terhadap perubahan fisik, emosional, sosial, maupun lingkungan.

Self-Care Orem: Teori yang dikembangkan oleh Dorothea Orem, menekankan pentingnya kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan perawatan dirinya sendiri secara mandiri, terutama selama periode khusus seperti kehamilan.

Diagnosa Keperawatan: Pernyataan yang menggambarkan masalah kesehatan aktual atau potensial pasien berdasarkan hasil pengkajian, digunakan untuk merancang intervensi keperawatan yang spesifik dan terarah.

Advokasi Keperawatan: Tindakan perawat dalam melindungi hak-hak pasien, memastikan pelayanan kesehatan yang adil, setara, serta mempertahankan martabat pasien dalam setiap situasi klinis.

Siklus Menstruasi: Proses periodik pada perempuan yang mencakup fase menstruasi, proliferasi, ovulasi, dan luteal, diatur oleh perubahan hormonal untuk mempersiapkan tubuh terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.

Depresi Postpartum: Kondisi gangguan psikologis yang dialami oleh sebagian perempuan setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kecemasan berlebihan, dan gangguan emosi lainnya.

Kolaborasi Interprofesional: Pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan kerjasama tim antar berbagai profesi kesehatan, seperti perawat, dokter, bidan, psikolog, dan ahli gizi, untuk mencapai pelayanan kesehatan maternal yang holistik dan optimal.

Teknologi Kesehatan Digital (Telehealth): Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan secara jarak jauh, seperti edukasi antenatal atau pemantauan kondisi kehamilan secara virtual.

Pendekatan Transkultural: Pendekatan keperawatan yang memperhatikan perbedaan budaya dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan, guna memastikan pelayanan yang sensitif budaya dan meningkatkan penerimaan pasien terhadap intervensi kesehatan.

Manajemen Nyeri Nonfarmakologis: Pendekatan penanganan nyeri yang tidak menggunakan obat-obatan, seperti teknik relaksasi, aromaterapi, dan pijat terapeutik, yang efektif dalam mengurangi nyeri selama persalinan.

Validasi Perasaan: Teknik komunikasi terapeutik di mana perawat secara verbal mengakui, menghargai, serta merespon perasaan pasien dalam situasi emosional atau sensitif.

Informed Consent: Persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien setelah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tindakan tersebut, termasuk risiko dan manfaatnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP): Panduan tertulis yang berisi prosedur kerja yang baku dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, untuk memastikan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan perlindungan hukum.

Delayed Cord Clamping: Praktik menunda penjepitan tali pusat setelah bayi lahir untuk meningkatkan jumlah darah yang diterima bayi baru lahir, yang terbukti meningkatkan kadar hemoglobin bayi secara signifikan.

CHAPTER 2

ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASA PRAKONSEPSI DAN KEHAMILAN

Ns. Mimi Rosiska, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Asuhan keperawatan pada masa prakonsepsi dan kehamilan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi, karena masa ini merupakan periode krusial yang menentukan kesejahteraan ibu dan janin, baik selama masa kehamilan maupun setelah kelahiran. Masa prakonsepsi didefinisikan sebagai periode sebelum terjadinya kehamilan, di mana calon ibu dipersiapkan secara fisik, psikologis, sosial, dan emosional agar dapat menjalani proses kehamilan yang sehat dan aman. Persiapan yang tepat selama masa prakonsepsi terbukti efektif dalam mengurangi risiko komplikasi kehamilan, menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Peran perawat dalam asuhan prakonsepsi melibatkan kegiatan pengkajian kesehatan yang komprehensif, termasuk identifikasi riwayat kesehatan calon ibu, gaya hidup, kebiasaan nutrisi, status imunisasi, serta faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kehamilan di masa mendatang. Proses ini melibatkan pemeriksaan kesehatan fisik secara mendalam, pemeriksaan laboratorium rutin, serta wawancara mendetail terkait riwayat medis dan reproduksi sebelumnya. Upaya pengkajian dan skrining yang teliti ini bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan atau risiko tertentu, seperti anemia, hipertensi, diabetes mellitus, serta infeksi menular seksual yang dapat mempengaruhi kehamilan jika tidak terdeteksi dan teratasi secara dini.

Selanjutnya, periode kehamilan merupakan masa penting di mana tubuh wanita mengalami berbagai perubahan yang kompleks dan dinamis, baik secara fisik maupun psikologis. Proses kehamilan terdiri dari tiga trimester yang masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Pada trimester pertama, perawat perlu memfokuskan perhatian pada pengkajian tanda-tanda awal kehamilan, edukasi terhadap keluhan umum seperti mual, muntah, dan kelelahan, serta memberikan dukungan psikologis terkait kecemasan yang umum dirasakan oleh ibu hamil, terutama mereka yang baru pertama kali mengalami kehamilan.

Memasuki trimester kedua, peran perawat semakin strategis karena periode ini ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan janin yang pesat. Perawat harus memastikan bahwa ibu menerima perawatan antenatal secara rutin untuk memantau perkembangan janin serta mendeteksi adanya kemungkinan kelainan atau gangguan kesehatan yang muncul. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya menjaga nutrisi yang baik, istirahat cukup, serta aktivitas fisik yang aman dan terkontrol menjadi prioritas utama dalam pelayanan keperawatan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin tetap terjaga secara optimal.

Pada trimester ketiga, tantangan yang dihadapi calon ibu akan meningkat seiring dengan semakin dekatnya waktu persalinan. Oleh karena itu, peran perawat dalam periode ini berpusat pada persiapan fisik, mental, dan emosional ibu menghadapi proses kelahiran. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan informasi mendalam mengenai tanda-tanda persalinan, persiapan untuk menyusui, manajemen nyeri persalinan, serta strategi efektif dalam mengelola stres dan kecemasan yang umumnya meningkat menjelang persalinan.

Selama masa kehamilan, edukasi dan promosi kesehatan oleh perawat memiliki peran yang tak kalah pentingnya dalam menciptakan kehamilan yang sehat dan aman. Perawat bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai nutrisi seimbang yang mencukupi kebutuhan gizi ibu dan janin, aktivitas fisik yang aman, serta teknik pengelolaan stres. Edukasi ini bertujuan agar calon ibu memiliki keterampilan serta pengetahuan yang cukup dalam menjaga kesehatannya, mengenali tanda-tanda bahaya, serta memahami tindakan tepat yang harus dilakukan apabila terjadi kondisi kegawatdaruratan selama masa kehamilan.

Terakhir, deteksi dini terhadap tanda bahaya selama kehamilan merupakan fokus penting dari perawatan kehamilan, yang melibatkan perawat sebagai garda terdepan dalam identifikasi awal kondisi berisiko tinggi. Kondisi seperti preeklamsia, perdarahan, kontraksi dini, serta gejala infeksi memerlukan perhatian segera dan respons yang cepat. Oleh karena itu, perawat harus terampil dalam mengenali gejala dini yang muncul, memberikan edukasi kepada ibu mengenai tanda-tanda bahaya, serta memastikan ibu mendapatkan akses cepat ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat waktu.

Keseluruhan proses asuhan keperawatan pada masa prakonsepsi dan kehamilan menuntut kompetensi, keterampilan komunikasi, pemahaman mendalam terhadap proses fisiologis dan psikologis selama kehamilan, serta kemampuan untuk memberikan pelayanan secara holistik dan komprehensif. Dengan demikian, pelayanan keperawatan ini diharapkan mampu secara nyata meningkatkan status

kesehatan ibu dan janin, mengurangi risiko komplikasi, serta memastikan proses kehamilan dan persalinan berjalan lancar dan aman bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Pengkajian Prakonsepsi dan Skrining Kesehatan Reproduksi Calon Ibu

Pengkajian prakonsepsi merupakan langkah awal dan fundamental dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang berorientasi pada persiapan calon ibu sebelum memasuki masa kehamilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi fisik, psikologis, dan sosial calon ibu berada dalam keadaan optimal, sehingga proses kehamilan nantinya dapat berjalan lancar dan aman. Secara konseptual, pengkajian prakonsepsi melibatkan identifikasi berbagai aspek yang mencakup kondisi kesehatan secara menyeluruh dari seorang perempuan sebelum ia merencanakan kehamilan. Melalui pendekatan yang proaktif ini, tenaga keperawatan dapat membantu calon ibu mempersiapkan diri secara matang, yang pada akhirnya mampu menekan angka kesakitan dan komplikasi selama masa kehamilan hingga persalinan.

Dalam melaksanakan pengkajian prakonsepsi, perawat memiliki peran penting dalam proses pengumpulan data terkait kondisi kesehatan reproduksi calon ibu secara sistematis dan menyeluruh. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis yang mendalam dan terstruktur, mencakup informasi riwayat kesehatan secara umum maupun riwayat kesehatan reproduksi secara khusus. Riwayat yang dikumpulkan meliputi informasi tentang riwayat menstruasi, siklus haid, riwayat penggunaan kontrasepsi, pengalaman kehamilan sebelumnya, serta berbagai masalah reproduksi yang mungkin pernah dialami calon ibu, seperti riwayat keguguran, kehamilan ektopik, kelainan hormonal, infeksi menular seksual, atau riwayat infertilitas.

Selain itu, pengkajian data juga mencakup aspek gaya hidup dan kebiasaan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, misalnya pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, hingga tingkat stres psikologis yang dialami calon ibu. Data-data ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap kehamilan yang direncanakan. Melalui wawancara yang dilakukan secara terbuka dan empati, perawat mampu menggali informasi secara akurat sambil membangun hubungan kepercayaan dengan calon ibu.

Setelah data terkumpul, perawat melakukan analisis dan interpretasi secara seksama untuk mengidentifikasi berbagai faktor risiko dan potensi komplikasi yang mungkin timbul pada masa kehamilan. Identifikasi faktor risiko ini mencakup pengenalan terhadap kondisi yang dapat memicu terjadinya komplikasi obstetrik seperti hipertensi kronis, diabetes mellitus, obesitas, gangguan tiroid, anemia

defisiensi zat besi, hingga infeksi menular seksual yang berpotensi menyebabkan dampak serius terhadap janin. Dengan pengenalan faktor risiko secara dini, tenaga kesehatan dapat merancang intervensi pencegahan yang tepat, termasuk memberikan edukasi khusus, rekomendasi perubahan gaya hidup, ataupun melakukan terapi medis yang diperlukan sebelum calon ibu benar-benar memasuki masa kehamilan.

Selain pendekatan wawancara mendalam dan analisis riwayat kesehatan, pengkajian prakonsepsi juga melibatkan pemeriksaan penunjang sebagai bagian integral dari skrining kesehatan reproduksi. Pemeriksaan penunjang yang umum dilakukan mencakup pemeriksaan fisik secara menyeluruh seperti pemeriksaan tekanan darah, indeks massa tubuh (IMT), serta pemeriksaan panggul untuk memastikan tidak adanya kelainan anatomi yang dapat mengganggu proses kehamilan nantinya. Pemeriksaan penunjang juga melibatkan berbagai pemeriksaan laboratorium rutin seperti pemeriksaan darah lengkap, gula darah, profil lipid, status imunisasi terutama rubella, hepatitis B, dan status HIV.

Selain itu, calon ibu dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan tambahan seperti skrining infeksi menular seksual (IMS), pemeriksaan fungsi tiroid, pemeriksaan HbA1c bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes atau faktor risiko tinggi, serta pemeriksaan genetik apabila terdapat indikasi seperti riwayat keluarga dengan kelainan genetik tertentu. Prosedur-prosedur pemeriksaan ini sangat penting dalam mendeteksi berbagai kondisi yang mungkin tidak menimbulkan gejala namun berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan janin.

Dengan dilaksanakannya pengkajian prakonsepsi secara komprehensif yang mencakup pengumpulan data secara sistematis, identifikasi faktor risiko secara dini, serta pelaksanaan pemeriksaan penunjang yang tepat, tenaga keperawatan dapat memastikan bahwa calon ibu berada pada kondisi kesehatan yang prima saat memasuki masa kehamilan. Keberhasilan dalam pengkajian prakonsepsi ini tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap proses kehamilan yang sehat, tetapi juga secara signifikan membantu mengurangi risiko komplikasi obstetrik, menekan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta janin, sekaligus meningkatkan kualitas hidup calon ibu selama masa kehamilan dan setelahnya.

C. Penatalaksanaan Keperawatan pada Kehamilan Normal

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang normal dialami oleh seorang perempuan. Namun demikian, dalam menjalani kehamilan yang sehat dan aman, peran asuhan keperawatan sangat penting dalam memantau, menjaga, dan meningkatkan kesehatan ibu dan janin hingga tiba saat persalinan. Penatalaksanaan keperawatan pada kehamilan normal mencakup berbagai aspek penting yang harus

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap trimester kehamilan, mulai dari trimester pertama hingga trimester ketiga. Dengan penatalaksanaan yang tepat, perawat mampu membantu ibu hamil menjalani proses kehamilan secara nyaman, aman, dan menyenangkan.

Pada trimester pertama kehamilannya, calon ibu akan mengalami berbagai perubahan fisik yang signifikan sebagai bentuk adaptasi tubuh terhadap kehadiran janin yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, pengkajian keperawatan pada tahap ini melibatkan pemantauan adaptasi fisiologis calon ibu secara intensif. Perawat melakukan pengumpulan data seperti riwayat kesehatan ibu, pemeriksaan fisik rutin, serta pemantauan kondisi umum ibu seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, berat badan, serta pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya. Adaptasi fisiologis yang penting diamati pada periode ini antara lain perubahan hormonal yang menyebabkan gejala seperti mual muntah (*morning sickness*), kelelahan, pusing, dan sensitivitas emosional.

Selain itu, penatalaksanaan keperawatan juga mencakup manajemen terhadap keluhan dan ketidaknyamanan yang umum dialami calon ibu di trimester pertama, seperti mual muntah, peningkatan sensitivitas bau, mudah lelah, serta perubahan pola tidur dan makan. Perawat harus mampu memberikan edukasi terkait cara-cara mengurangi mual, seperti makan dalam porsi kecil namun sering, konsumsi makanan ringan tinggi karbohidrat, menghindari bau menyengat, serta memastikan asupan cairan yang cukup. Selain pengelolaan fisik, dukungan psikososial sangat penting dilakukan perawat selama trimester pertama. Calon ibu, terutama yang baru pertama kali hamil, sering kali mengalami rasa cemas, takut, dan khawatir tentang kondisi kehamilan maupun janinnya. Dukungan emosional yang diberikan melalui konseling, edukasi, dan komunikasi terapeutik sangat membantu dalam menciptakan rasa nyaman serta meningkatkan kepercayaan diri ibu hamil dalam menghadapi proses kehamilannya.

Memasuki trimester kedua, peran perawat dalam penatalaksanaan keperawatan difokuskan pada monitoring pertumbuhan dan perkembangan janin secara lebih mendalam. Pada masa ini, pertumbuhan janin berlangsung sangat pesat, sehingga diperlukan pemantauan rutin melalui pemeriksaan fisik antenatal secara berkala. Pemeriksaan rutin seperti pengukuran tinggi fundus uteri, deteksi denyut jantung janin, serta evaluasi ultrasonografi (USG) dilakukan untuk memastikan bahwa janin tumbuh sesuai usia kehamilan. Perawat juga secara aktif memberikan edukasi kepada calon ibu tentang tanda-tanda perkembangan janin yang normal serta memberikan informasi mengenai tanda bahaya yang harus diwaspadai.

Pada periode ini pula, calon ibu mungkin mengalami beberapa keluhan fisik yang semakin nyata seiring pertumbuhan janin yang pesat, seperti nyeri punggung, nyeri ligamen, kram otot, varises, konstipasi, serta pembengkakan kaki (edema ringan). Oleh karena itu, perawat berperan memberikan edukasi tentang teknik pencegahan dan penanganan keluhan tersebut. Hal-hal sederhana seperti latihan relaksasi, posisi tidur yang nyaman, mengurangi aktivitas berat, serta penggunaan kompres hangat dapat membantu ibu mengurangi keluhan fisiknya. Lebih lanjut, konseling terkait persiapan psikologis calon ibu dalam menghadapi kehamilan yang semakin besar dan mulai terasa nyata sangat penting dilakukan. Konseling ini bertujuan membantu calon ibu menerima perubahan tubuhnya secara positif serta mengelola kecemasan yang mungkin muncul tentang persiapan kelahiran atau tanggung jawab sebagai orang tua baru.

Pada trimester ketiga, penatalaksanaan keperawatan memiliki peran yang semakin penting dalam membantu calon ibu melakukan persiapan secara fisik dan mental menghadapi persalinan yang semakin dekat. Pada tahap ini, perawat harus aktif dalam memberikan edukasi mengenai persiapan persalinan, baik secara fisik seperti latihan pernapasan, relaksasi, persiapan teknik mengejan, maupun persiapan mental seperti menghadapi rasa takut, cemas, atau kekhawatiran terhadap proses persalinan. Persiapan adaptasi fisik dan mental sangat diperlukan guna meningkatkan kepercayaan diri calon ibu sehingga mampu menjalani persalinan dengan lebih tenang.

Selain persiapan persalinan, manajemen nyeri dan ketidaknyamanan juga menjadi perhatian khusus dalam penatalaksanaan trimester ketiga. Calon ibu sering mengalami ketidaknyamanan akibat ukuran janin yang semakin besar, seperti sesak napas, sulit tidur, nyeri pinggang, dan kontraksi palsu (Braxton Hicks). Penatalaksanaan yang diberikan berupa edukasi posisi tidur yang nyaman, teknik relaksasi, latihan pernapasan, serta aktivitas fisik ringan seperti jalan santai atau senam hamil yang membantu mengurangi keluhan tersebut. Jika nyeri atau ketidaknyamanan tersebut terasa berlebihan atau di luar batas normal, perawat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan ibu segera mendapatkan perhatian medis lebih lanjut.

Terakhir, kesiapan mental dan emosional ibu menjelang proses persalinan menjadi perhatian utama perawat pada periode akhir kehamilan ini. Perawat membantu calon ibu untuk memahami proses persalinan, tanda-tanda awal kelahiran, pilihan metode melahirkan, serta pentingnya dukungan dari keluarga dan lingkungan terdekat. Dengan pendekatan edukatif dan suportif, perawat mampu menciptakan kondisi psikologis yang nyaman dan penuh rasa percaya diri bagi ibu,

sehingga ibu mampu menjalani proses persalinan dengan lebih positif, nyaman, dan percaya diri.

D. Edukasi dan Promosi Kesehatan pada Ibu Hamil

Edukasi dan promosi kesehatan selama masa kehamilan merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam membantu calon ibu menjalani proses kehamilannya secara sehat, aman, dan optimal. Dalam konteks ini, edukasi yang diberikan kepada ibu hamil tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kesehatan kehamilan, tetapi juga untuk membantu ibu dalam mengambil keputusan yang tepat guna mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun janin yang dikandungnya.

Salah satu aspek penting dalam edukasi kesehatan pada ibu hamil adalah terkait nutrisi optimal selama masa kehamilan. Nutrisi yang adekuat menjadi faktor krusial yang menentukan kualitas kehamilan serta kesehatan janin sejak awal masa pembentukan hingga proses persalinan. Oleh karena itu, tenaga keperawatan memiliki peran sentral dalam memberikan edukasi mendalam mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan zat gizi yang esensial bagi ibu hamil. Dalam hal ini, perawat memberikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang komposisi makanan seimbang yang meliputi sumber protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, mineral, serta kebutuhan cairan yang mencukupi.

Secara khusus, calon ibu juga diberikan pemahaman tentang pentingnya konsumsi mikronutrien tertentu yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, seperti asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf, zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk mendukung perkembangan tulang janin, serta omega-3 yang berperan penting dalam perkembangan sistem saraf janin. Edukasi juga mencakup informasi tentang pola makan yang aman, jenis makanan yang perlu dihindari seperti makanan mentah atau setengah matang, makanan tinggi gula atau tinggi garam secara berlebihan, serta pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan makanan yang dikonsumsi.

Selain aspek nutrisi, edukasi kesehatan pada ibu hamil juga mencakup rekomendasi terkait aktivitas fisik yang aman dan efektif. Meskipun kehamilan membawa berbagai perubahan fisiologis yang mungkin membatasi beberapa jenis aktivitas, namun ibu hamil tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang sesuai untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Perawat dalam hal ini bertugas memberikan edukasi mengenai jenis olahraga atau aktivitas fisik ringan yang aman dilakukan selama kehamilan, seperti berjalan santai, berenang, yoga prenatal, atau senam hamil. Aktivitas-aktivitas tersebut memiliki manfaat yang

signifikan dalam meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri punggung dan kram otot, mengurangi risiko diabetes gestasional, menjaga berat badan ideal, serta meningkatkan kualitas tidur dan suasana hati ibu hamil.

Dalam memberikan rekomendasi aktivitas fisik, perawat juga perlu menjelaskan kepada calon ibu tentang batasan yang harus diperhatikan selama aktivitas, seperti menghindari aktivitas yang terlalu berat, melompat, atau yang memiliki risiko jatuh tinggi. Edukasi terkait tanda-tanda bahwa aktivitas fisik perlu segera dihentikan, seperti nyeri perut hebat, perdarahan, sesak napas berlebihan, atau kontraksi uterus dini juga penting ditekankan agar ibu mampu mengenali tanda bahaya dan segera mencari pertolongan medis.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam edukasi dan promosi kesehatan pada ibu hamil adalah terkait strategi manajemen stres serta pemberian dukungan psikososial. Kehamilan tidak hanya membawa perubahan fisik, tetapi juga perubahan emosional dan psikologis yang cukup besar bagi seorang perempuan. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk membantu calon ibu memahami berbagai bentuk stres yang mungkin dialami selama kehamilan serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan ibu dan janin. Stres yang berlebihan dapat memicu gangguan tidur, gangguan makan, kecemasan berlebihan, hingga risiko komplikasi kehamilan seperti persalinan prematur atau preeklamsia.

Perawat, dalam hal ini, memberikan edukasi dan bimbingan mengenai berbagai strategi praktis dalam mengelola stres yang dialami ibu hamil, seperti teknik relaksasi berupa latihan pernapasan dalam, meditasi, serta aktivitas yang menenangkan seperti mendengarkan musik atau melakukan aktivitas yang disukai. Selain itu, perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan psikososial, yang dilakukan melalui komunikasi yang empati, konseling yang suportif, serta pemberdayaan keluarga sebagai support system utama bagi calon ibu selama masa kehamilan.

Dukungan psikososial juga mencakup keterlibatan pasangan atau keluarga secara aktif dalam proses kehamilan, termasuk persiapan menghadapi persalinan dan proses pengasuhan bayi kelak. Edukasi yang diberikan perawat melibatkan pemberian pemahaman kepada keluarga tentang peran penting mereka dalam memberikan dukungan emosional dan praktis, sehingga calon ibu dapat menjalani kehamilan secara nyaman dan penuh percaya diri. Dalam kasus-kasus tertentu, perawat juga dapat merujuk ibu hamil ke layanan psikologis khusus jika ditemukan adanya masalah emosional yang lebih serius, seperti kecemasan berlebih, depresi prenatal, atau gangguan psikologis lainnya yang membutuhkan intervensi spesifik.

E. Deteksi Dini Tanda Bahaya Selama Masa Kehamilan

Deteksi dini tanda bahaya selama masa kehamilan merupakan aspek penting dalam asuhan keperawatan antenatal yang bertujuan memastikan keselamatan dan kesejahteraan ibu serta janin. Upaya ini difokuskan pada pengenalan secara cepat terhadap berbagai kondisi yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan janin, sehingga dapat dilakukan tindakan intervensi dini untuk mencegah komplikasi serius. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan, khususnya perawat, memiliki peran vital untuk memberikan edukasi, membimbing calon ibu dalam mengenali tanda bahaya, serta mengelola kondisi yang muncul secara cepat dan tepat.

Salah satu langkah awal yang penting dilakukan dalam proses deteksi dini adalah identifikasi tanda dan gejala bahaya umum yang mungkin timbul selama masa kehamilan. Tanda-tanda bahaya tersebut dapat muncul kapan saja sepanjang periode kehamilan dan seringkali merupakan manifestasi awal dari komplikasi serius. Beberapa tanda bahaya utama yang perlu diketahui oleh ibu hamil meliputi perdarahan pervaginam baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, nyeri perut hebat atau kram yang persisten, pembengkakan tiba-tiba pada wajah, tangan, atau kaki disertai sakit kepala berat, gangguan penglihatan berupa pandangan kabur atau berkunang-kunang, mual dan muntah yang berlebihan hingga menyebabkan dehidrasi, serta penurunan gerakan janin yang signifikan.

Tanda-tanda bahaya lain yang juga penting untuk dikenali di antaranya adalah demam tinggi yang mengindikasikan adanya infeksi serius, nyeri saat buang air kecil yang bisa menjadi gejala infeksi saluran kemih, sesak napas berat yang tidak lazim terutama bila terjadi secara mendadak, serta kontraksi uterus yang sering dan teratur sebelum waktunya (persalinan prematur). Mengenali tanda bahaya ini secara dini memungkinkan calon ibu segera mengambil langkah antisipasi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi serius yang dapat mengancam nyawa ibu maupun janinnya.

Selanjutnya, dalam mendukung deteksi dini, strategi pemantauan mandiri oleh calon ibu juga sangat penting untuk diajarkan dan dikuasai. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan ibu dalam mengenali perubahan tubuh dan kesehatan dirinya sendiri selama kehamilan. Dalam pemantauan mandiri ini, ibu hamil diajarkan cara menghitung dan memantau gerakan janin secara rutin, khususnya pada trimester ketiga. Ibu juga diarahkan untuk rutin memeriksa tekanan darah secara mandiri bila memungkinkan, mengenali perubahan berat badan yang drastis, serta mengamati tanda-tanda bengkak abnormal pada ekstremitas.

Selain itu, perawat juga perlu memberikan panduan praktis tentang bagaimana ibu dapat mencatat dan memonitor gejala-gejala yang tidak biasa, seperti frekuensi nyeri kepala, intensitas nyeri perut, serta pola perdarahan atau keluarnya cairan

abnormal dari vagina. Ibu hamil yang telah teredukasi dengan baik mengenai pemantauan mandiri akan mampu secara cepat mengenali tanda-tanda bahaya dan segera melaporkan atau mendiskusikan temuannya dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan arahan serta intervensi lebih lanjut.

Ketika tanda bahaya telah dikenali dan dikonfirmasi, maka penatalaksanaan awal yang tepat waktu serta proses rujukan yang efektif menjadi tahap berikutnya yang amat menentukan keselamatan ibu dan janin. Perawat memiliki tanggung jawab penting dalam proses penatalaksanaan awal ini, termasuk memberikan pertolongan pertama yang cepat dan sesuai dengan kondisi kegawatdaruratan yang dialami ibu hamil. Misalnya, apabila terjadi perdarahan hebat, perawat harus mampu memberikan intervensi segera seperti membantu ibu berbaring dengan posisi aman, memberikan cairan infus jika tersedia, serta mempersiapkan ibu untuk proses rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Dalam kasus preeklamsia atau gejala hipertensi berat yang muncul mendadak, penatalaksanaan awal mencakup posisi ibu yang nyaman, mengurangi stimulasi yang dapat memperparah kondisi, serta pemberian oksigen jika tersedia sebelum merujuk ibu ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Begitu pula jika terjadi tanda-tanda persalinan prematur, perawat berperan dalam memastikan ibu dalam posisi istirahat total, memantau tanda vital ibu dan janin secara ketat, serta melakukan koordinasi cepat dengan tenaga kesehatan lainnya untuk merujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan fasilitas neonatal intensive care unit (NICU).

Rujukan tepat waktu juga sangat esensial dalam proses penatalaksanaan kondisi darurat selama kehamilan. Perawat bertugas memastikan bahwa rujukan dilakukan secara efektif, jelas, dan terkoordinasi dengan baik ke fasilitas kesehatan rujukan yang sesuai dengan tingkat keparahan kondisi ibu. Komunikasi yang efektif dengan tim rujukan, pengiriman data medis lengkap tentang kondisi ibu, serta persiapan transportasi dan tenaga pendamping yang memadai menjadi kunci keberhasilan proses rujukan darurat ini.

F. Simpulan

Asuhan keperawatan pada masa prakonsepsi dan kehamilan memiliki peran sentral dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan memastikan kesehatan optimal ibu dan janin. Proses ini dimulai sejak sebelum kehamilan (masa prakonsepsi) melalui pengkajian kesehatan secara komprehensif yang meliputi identifikasi riwayat kesehatan reproduksi, faktor risiko, gaya hidup, dan berbagai pemeriksaan penunjang. Langkah awal ini membantu mencegah munculnya

komplikasi selama kehamilan serta meningkatkan kesiapan calon ibu secara fisik, psikologis, sosial, dan emosional.

Selanjutnya, penatalaksanaan keperawatan selama kehamilan normal disusun berdasarkan kebutuhan dan perubahan fisiologis serta psikologis yang terjadi pada setiap trimester. Pada trimester pertama, fokus utamanya adalah adaptasi fisiologis, pengelolaan keluhan umum seperti mual dan kelelahan, serta pemberian dukungan psikososial untuk mengatasi kecemasan. Trimester kedua melibatkan monitoring ketat terhadap pertumbuhan janin, penanganan keluhan fisik yang meningkat seiring usia kehamilan, serta konseling untuk membantu calon ibu dalam persiapan mental menghadapi perubahan tubuhnya. Di trimester ketiga, perhatian keperawatan diarahkan pada persiapan persalinan secara fisik dan mental, manajemen nyeri, dan kesiapan emosional ibu untuk menghadapi kelahiran bayi.

Peran edukasi dan promosi kesehatan juga menjadi inti penting dari pelayanan keperawatan selama kehamilan. Edukasi meliputi pemberian informasi mengenai nutrisi optimal, aktivitas fisik yang aman, serta teknik manajemen stres dan pemberian dukungan psikososial yang efektif. Tujuannya adalah agar ibu mampu menjaga kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan janin secara mandiri serta mengambil keputusan yang tepat demi keselamatan keduanya.

Tidak kalah pentingnya adalah deteksi dini terhadap tanda bahaya yang mungkin muncul selama kehamilan. Dalam hal ini, perawat memberikan edukasi mengenai identifikasi tanda-tanda bahaya seperti perdarahan, preeklamsia, penurunan gerakan janin, hingga gejala infeksi. Ibu hamil juga diajarkan strategi pemantauan mandiri agar mampu mengenali kondisi abnormal secara cepat dan akurat. Jika tanda bahaya muncul, perawat bertanggung jawab dalam penatalaksanaan awal yang tepat serta memastikan rujukan darurat yang cepat dan efektif ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

G. Referensi

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2019). Guidelines for Perinatal Care (8th ed.). Washington, DC: American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricians and Gynecologists.

Blackburn, S. T. (2017). Maternal, Fetal, & Neonatal Physiology: A Clinical Perspective (5th ed.). Elsevier Health Sciences.

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). Williams Obstetrics (25th ed.). McGraw-Hill Education.

Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2019).

Maternity and Women's Health Care (12th ed.). Elsevier Mosby.

Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). Churchill Livingstone Elsevier.

Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2018). *Foundations of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing* (7th ed.). Elsevier.

Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., Wilson, D., Rodgers, C. C., & Alden, K. R. (2022). *Maternal Child Nursing Care* (7th ed.). Elsevier Mosby.

Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2020). *Maternity and Pediatric Nursing* (4th ed.). Wolters Kluwer Health.

World Health Organization (WHO). (2016). *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). (2020). *Improving Early Childhood Development: WHO Guideline*. Geneva: World Health Organization.

Yanti, Y., Claramita, M., Emilia, O., & Hakimi, M. (2015). Students' understanding of "Women-centred Care Philosophy" in midwifery care through Continuity of Care (CoC) learning model: A quasi-experimental study. *BMC Nursing*, 14(1), 1-7. <https://doi.org/10.1186/s12912-015-0094-z>

Zambrano, L. D., Ellington, S., Strid, P., Galang, R. R., Oduyebo, T., Tong, V. T., & Gilboa, S. M. (2020). Update: Characteristics of symptomatic women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status—United States, January 22–October 3, 2020. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 69(44), 1641-1647. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6944e3>

H. Glosarium

Asuhan Keperawatan Prakonsepsi

Asuhan keperawatan yang diberikan kepada calon ibu sebelum terjadinya kehamilan, bertujuan memastikan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan emosional calon ibu dalam keadaan optimal untuk kehamilan yang sehat dan aman.

Kesehatan Reproduksi

Kondisi kesehatan yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, yang berkaitan langsung dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi manusia di semua tahap kehidupan.

Trimester Kehamilan

Periode kehamilan yang dibagi menjadi tiga fase, yaitu trimester pertama (0–12 minggu), trimester kedua (13–28 minggu), dan trimester ketiga (29–40 minggu), masing-masing dengan karakteristik dan tantangan tersendiri.

Morning Sickness

Keluhan umum berupa mual dan muntah yang sering terjadi pada trimester pertama kehamilan, disebabkan oleh perubahan hormonal yang dialami ibu hamil.

Skrining Kesehatan Reproduksi

Proses pemeriksaan rutin yang dilakukan sebelum kehamilan untuk mendeteksi dini berbagai kondisi atau risiko kesehatan yang dapat mempengaruhi proses kehamilan dan perkembangan janin.

Edukasi Prenatal

Proses pemberian informasi dan pelatihan kepada calon ibu tentang berbagai aspek penting selama kehamilan, meliputi nutrisi, aktivitas fisik, manajemen stres, hingga tanda-tanda bahaya yang harus dikenali secara dini.

Promosi Kesehatan Kehamilan

Upaya yang dilakukan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta perilaku positif ibu hamil terhadap pentingnya menjaga kesehatan dirinya dan janin melalui pola hidup sehat.

Dukungan Psikososial

Bentuk dukungan emosional dan sosial yang diberikan kepada ibu hamil untuk membantu mengatasi stres, kecemasan, atau masalah emosional lain yang dapat muncul selama masa kehamilan hingga persalinan.

Preeklamsia

Kondisi komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, proteinuria (protein dalam urin), dan pembengkakan ekstremitas, yang berisiko serius bagi ibu maupun janin jika tidak dideteksi dan ditangani secara dini.

Rujukan Obstetri

Proses pengiriman pasien ibu hamil yang mengalami komplikasi atau kegawatdaruratan medis ke fasilitas kesehatan dengan kemampuan penanganan yang lebih lengkap, untuk mendapatkan pelayanan dan intervensi medis yang lebih lanjut.

CHAPTER 3

KEPERAWATAN PADA KEHAMILAN RISIKO TINGGI

Rigoan Malawat, S.Kep., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang umumnya berlangsung secara alamiah tanpa komplikasi berarti. Namun, dalam kondisi tertentu, kehamilan dapat mengalami berbagai masalah kesehatan yang berisiko bagi ibu maupun janin, yang dikenal dengan istilah kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi didefinisikan sebagai kondisi kehamilan di mana ibu, janin, atau keduanya menghadapi kemungkinan komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada umumnya, baik yang disebabkan oleh kondisi medis yang mendasari, faktor lingkungan, maupun komplikasi yang muncul selama proses kehamilan. Secara konsep, kehamilan risiko tinggi tidak hanya mencakup ancaman kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan emosional yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan ibu dan bayi, serta kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, kehamilan risiko tinggi menuntut perhatian khusus dari tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memastikan bahwa ibu dan janin tetap dalam kondisi terbaik selama periode kehamilan, persalinan, hingga masa nifas.

Kehamilan risiko tinggi bukanlah fenomena yang jarang ditemui dalam praktik klinis. Prevalensi atau angka kejadian kehamilan risiko tinggi terus meningkat secara global dan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang saling terkait. Beberapa faktor risiko yang sering dikaitkan dengan kehamilan risiko tinggi antara lain adalah usia ibu yang terlalu muda (remaja) atau usia yang terlalu tua (di atas 35 tahun), riwayat kehamilan sebelumnya yang bermasalah seperti keguguran berulang, persalinan prematur, atau kelahiran bayi dengan berat lahir rendah, serta adanya penyakit penyerta atau komorbiditas seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan penyakit autoimun. Selain faktor kesehatan fisik, kondisi sosial ekonomi yang rendah, kurangnya akses pelayanan kesehatan, pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, atau paparan zat-zat toksik, juga menjadi faktor risiko signifikan dalam meningkatkan kemungkinan komplikasi pada kehamilan. Kondisi ini menegaskan pentingnya identifikasi dini serta pemantauan

yang ketat selama masa kehamilan untuk mencegah atau meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.

Peran keperawatan dalam konteks kehamilan risiko tinggi sangat krusial dan strategis. Perawat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang holistik, komprehensif, serta terintegrasi kepada ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi. Pentingnya keperawatan dalam kehamilan risiko tinggi didasarkan pada prinsip pencegahan, deteksi dini, edukasi kesehatan, serta manajemen yang tepat guna mengurangi angka morbiditas maupun mortalitas ibu dan janin. Perawat memiliki peran vital dalam melakukan skrining awal, identifikasi risiko, dan penilaian klinis yang teliti, guna mendeteksi secara cepat adanya potensi komplikasi yang mungkin muncul selama kehamilan. Selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan dukungan emosional dan psikososial kepada ibu dan keluarga, yang bertujuan mengurangi tingkat kecemasan, stres, dan depresi yang sering kali menyertai kondisi kehamilan risiko tinggi. Dalam praktiknya, perawat juga menjadi fasilitator dalam koordinasi interprofesional, bekerja sama dengan dokter kandungan, bidan, ahli gizi, dan profesional kesehatan lain dalam menyediakan asuhan terbaik dan terintegrasi untuk ibu hamil berisiko tinggi.

Lebih lanjut, perawat memiliki tugas penting dalam memberikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil serta keluarganya terkait tanda bahaya kehamilan, pentingnya menjaga pola hidup sehat, kepatuhan terhadap rekomendasi medis, serta pentingnya pemantauan rutin dan kunjungan antenatal care yang teratur. Asuhan keperawatan pada kehamilan risiko tinggi tidak hanya berhenti pada upaya menjaga kesehatan fisik ibu dan janin semata, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan yang timbul selama masa kehamilan hingga proses persalinan berlangsung. Oleh karena itu, keterlibatan perawat dalam kehamilan risiko tinggi sangat menentukan dalam upaya mencapai hasil akhir yang positif bagi kesehatan ibu dan bayi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.

B. Patofisiologi dan Kondisi Penyerta pada Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi melibatkan berbagai gangguan dan kondisi penyerta yang secara signifikan memengaruhi proses fisiologis normal dalam tubuh ibu, serta meningkatkan risiko komplikasi pada ibu maupun janin. Salah satu kondisi yang paling sering terjadi adalah gangguan hipertensi dalam kehamilan, khususnya preeklampsia dan eklampsia. Preeklampsia merupakan suatu sindrom klinis yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu, yang ditandai oleh hipertensi, proteinuria, serta tanda-tanda gangguan fungsi organ lainnya. Kondisi ini terjadi akibat gangguan fungsi plasenta yang menyebabkan vasospasme arteriol sistemik,

disfungsi endotel pembuluh darah, serta aktivasi inflamasi yang luas di tubuh ibu. Apabila preeklampsia tidak teratasi atau terkontrol dengan baik, maka dapat berkembang menjadi eklampsia yang ditandai dengan timbulnya kejang-kejang tonik-klonik, yang meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas baik pada ibu maupun janin.

Selain hipertensi, diabetes mellitus gestasional (DMG) juga merupakan kondisi penting yang menyertai kehamilan risiko tinggi. DMG ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah yang pertama kali didiagnosis selama masa kehamilan, akibat adanya resistensi insulin yang meningkat secara fisiologis pada kehamilan. Secara patofisiologi, selama kehamilan, plasenta menghasilkan hormon seperti human placental lactogen (hPL), progesteron, kortisol, dan estrogen, yang secara alami menurunkan sensitivitas insulin, sehingga ibu perlu meningkatkan produksi insulin untuk mempertahankan kadar glukosa darah normal. Pada beberapa wanita hamil, kompensasi pankreas dalam menghasilkan insulin tidak mencukupi, sehingga terjadi kondisi hiperglikemia yang mengakibatkan janin mengalami hiperinsulinemia, pertumbuhan janin yang berlebihan (makrosomia), serta meningkatkan risiko komplikasi persalinan seperti distosia bahu, cedera persalinan, hingga gangguan metabolik bayi baru lahir.

Kondisi penyerta lain yang signifikan dalam kehamilan risiko tinggi adalah penyakit jantung. Pada kehamilan, sistem kardiovaskular ibu mengalami perubahan fisiologis berupa peningkatan volume darah, peningkatan denyut jantung, serta peningkatan beban kerja jantung secara keseluruhan. Pada ibu hamil yang memiliki penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung didapat sebelumnya, perubahan fisiologis ini dapat menyebabkan beban kerja jantung yang semakin meningkat hingga melampaui kapasitas adaptasi jantung ibu. Hal ini dapat menimbulkan manifestasi klinis berupa gagal jantung kongestif, edema paru, aritmia, bahkan risiko kematian maternal. Penyakit jantung pada kehamilan juga dapat mempengaruhi perfusi plasenta, sehingga berisiko menyebabkan komplikasi janin seperti pertumbuhan janin terhambat (PJT), persalinan prematur, hingga kematian intrauterin.

Anemia dalam kehamilan juga merupakan masalah serius yang sering menyertai kehamilan risiko tinggi. Anemia pada ibu hamil umumnya disebabkan oleh defisiensi zat besi, asam folat, atau vitamin B12, dan secara patofisiologi menyebabkan penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen ke jaringan tubuh ibu dan janin. Kondisi ini menyebabkan ibu hamil mengalami keluhan cepat lelah, lemas, sesak napas, serta berisiko tinggi mengalami persalinan prematur, perdarahan postpartum, dan gangguan pertumbuhan intrauterin. Secara lebih serius, anemia berat yang tidak tertangani dapat menyebabkan gagal jantung

kongestif akibat kompensasi tubuh meningkatkan kerja jantung demi mempertahankan oksigenasi jaringan tubuh ibu dan janin.

Infeksi selama kehamilan, seperti infeksi TORCH (Toksoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simpleks), hepatitis, serta HIV/AIDS, juga merupakan kondisi penting yang sangat mempengaruhi kehamilan risiko tinggi. Infeksi-infeksi tersebut dapat ditransmisikan dari ibu ke janin melalui plasenta, selama persalinan, ataupun melalui ASI setelah persalinan. Secara patofisiologi, infeksi ini mengakibatkan gangguan perkembangan janin, kelainan kongenital, serta meningkatkan risiko morbiditas neonatal seperti gangguan neurologis, gangguan pendengaran, retardasi mental, hingga kematian perinatal. Selain itu, infeksi HIV pada kehamilan memerlukan pendekatan khusus berupa terapi antiretroviral (ARV) secara rutin untuk menurunkan risiko transmisi vertikal dari ibu ke anak.

Kehamilan dengan riwayat komplikasi persalinan sebelumnya juga menjadi perhatian utama dalam konteks kehamilan risiko tinggi. Ibu yang pernah mengalami komplikasi pada kehamilan dan persalinan sebelumnya, seperti persalinan prematur, abortus habitualis, perdarahan postpartum, plasenta previa, atau solusio plasenta, memiliki kemungkinan yang lebih besar mengalami komplikasi serupa pada kehamilan berikutnya. Kondisi ini berhubungan erat dengan adanya faktor predisposisi atau patologis yang menetap seperti abnormalitas anatomi rahim, kelemahan serviks, gangguan pembekuan darah, atau gangguan vaskular yang belum tertangani secara optimal. Oleh sebab itu, perawat dan tenaga kesehatan harus secara intensif melakukan pemantauan, evaluasi, serta intervensi preventif terhadap ibu hamil dengan riwayat komplikasi persalinan sebelumnya untuk mencegah terjadinya komplikasi berulang yang dapat membahayakan ibu dan janin.

C. Deteksi Dini dan Asesmen pada Kehamilan Risiko Tinggi

Deteksi dini serta asesmen yang akurat merupakan elemen krusial dalam penanganan kehamilan risiko tinggi. Salah satu tahapan utama dalam proses ini adalah skrining kehamilan risiko tinggi. Skrining ini bertujuan untuk mengidentifikasi sedini mungkin berbagai kondisi atau faktor yang berpotensi menimbulkan komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Skrining dapat dilakukan melalui pengumpulan riwayat medis dan obstetri secara menyeluruh, meliputi riwayat kesehatan ibu sebelumnya, riwayat keluarga, pola hidup ibu, riwayat obstetri terdahulu seperti keguguran berulang, kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah, atau komplikasi-komplikasi lainnya. Selain itu, skrining juga melibatkan pemeriksaan fisik awal yang komprehensif untuk mengenali adanya gangguan yang sudah tampak, seperti tanda-tanda anemia, hipertensi, diabetes, atau penyakit lain yang dapat memperberat kondisi kehamilan. Skrining ini

sebaiknya dilakukan sejak awal trimester pertama dan terus dipantau secara rutin selama masa kehamilan berlangsung.

Setelah tahap skrining awal, tahap berikutnya yang sangat penting adalah pengkajian atau asesmen yang efektif. Teknik pengkajian yang efektif ini tidak hanya mencakup pemeriksaan fisik secara umum, tetapi juga menuntut kemampuan tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam menggunakan teknik wawancara, observasi langsung, serta analisis terhadap berbagai tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh ibu hamil. Dalam pengkajian kehamilan risiko tinggi, perawat perlu memperhatikan berbagai tanda bahaya seperti peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba, adanya edema yang signifikan terutama pada wajah dan tangan, proteinuria, gangguan penglihatan atau nyeri kepala berat yang dapat mengindikasikan preeklampsia. Selain itu, asesmen juga meliputi pemantauan kenaikan berat badan ibu yang abnormal, evaluasi terhadap pola makan dan aktivitas fisik ibu, serta evaluasi kondisi psikologis ibu seperti kecemasan, stres, atau depresi yang dapat memperburuk kondisi fisiknya. Teknik wawancara yang terstruktur namun tetap empati sangat penting agar ibu merasa nyaman dan terbuka dalam memberikan informasi mengenai kondisinya.

Di samping asesmen fisik dan psikososial, pemeriksaan penunjang memiliki peran vital dalam mengidentifikasi risiko pada kehamilan secara lebih spesifik. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan pencitraan yang mendukung diagnosis atau konfirmasi dari kondisi risiko tinggi tersebut. Pemeriksaan laboratorium yang umum dilakukan antara lain tes darah lengkap (Hb, hematokrit, leukosit, trombosit), pemeriksaan gula darah puasa atau tes toleransi glukosa oral (TTGO) untuk deteksi diabetes mellitus gestasional, pemeriksaan fungsi ginjal (ureum dan kreatinin) serta pemeriksaan fungsi hati pada kasus hipertensi dalam kehamilan atau preeklampsia. Pemeriksaan tambahan berupa tes serologi terhadap infeksi TORCH, hepatitis B, HIV/AIDS, sifilis, serta pemeriksaan urin rutin juga dianjurkan guna mendeteksi adanya proteinuria, glukosuria, atau infeksi saluran kemih yang dapat memperberat kehamilan.

Selanjutnya, pemeriksaan pencitraan seperti ultrasonografi (USG) obstetri memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam asesmen kehamilan risiko tinggi. USG digunakan untuk mengevaluasi kondisi janin secara langsung, meliputi pengukuran pertumbuhan janin, penilaian kesejahteraan janin melalui identifikasi denyut jantung janin, gerakan janin, jumlah cairan ketuban, serta kondisi plasenta yang mungkin abnormal seperti plasenta previa atau solusio plasenta. Selain USG dasar, pemeriksaan lanjutan seperti Doppler arteri umbilikalis dapat digunakan untuk menilai aliran darah antara ibu dan janin pada kasus-kasus dengan risiko gangguan pertumbuhan janin akibat insufisiensi plasenta, hipertensi, atau diabetes

mellitus gestasional. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan lebih lanjut seperti amniosentesis, non-stress test (NST), atau cardiotocography (CTG) juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi lebih lengkap tentang status kesehatan janin serta menentukan langkah intervensi selanjutnya.

D. Manajemen Keperawatan pada Kehamilan Risiko Tinggi

Manajemen keperawatan dalam kehamilan risiko tinggi merupakan serangkaian proses penting yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan intervensi, hingga pengelolaan kondisi krisis atau darurat yang mungkin muncul selama periode kehamilan. Dalam tahap awal manajemen keperawatan, perencanaan asuhan keperawatan memiliki peran sentral sebagai dasar pengelolaan efektif bagi ibu hamil yang mengalami kondisi risiko tinggi. Perencanaan asuhan keperawatan ini diawali dengan identifikasi berbagai masalah dan kebutuhan kesehatan ibu melalui proses asesmen yang sistematis dan komprehensif. Setelah dilakukan asesmen secara teliti, perawat kemudian merumuskan berbagai diagnosis keperawatan yang relevan dengan kondisi ibu, termasuk masalah fisik, psikososial, spiritual, dan edukasi kesehatan yang dibutuhkan. Setiap diagnosis keperawatan yang dibuat harus didasarkan pada data akurat hasil pengkajian awal, sehingga perencanaan asuhan yang dibuat dapat tepat sasaran serta memberikan dampak positif secara nyata dalam kondisi kesehatan ibu dan janin.

Setelah identifikasi diagnosis keperawatan dilakukan, maka perawat merancang berbagai rencana tindakan atau intervensi keperawatan yang spesifik, terukur, dan realistis. Perencanaan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi kesehatan, konseling emosional, pemantauan kondisi fisik, kolaborasi dengan tim multidisiplin, serta antisipasi terhadap potensi masalah yang mungkin timbul selama masa kehamilan maupun saat persalinan nanti. Pada tahap perencanaan ini, perawat juga menentukan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai, seperti stabilisasi tanda vital ibu, optimalisasi kesehatan janin, serta peningkatan pengetahuan ibu mengenai kondisi kesehatan yang dialami dan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah komplikasi.

Intervensi keperawatan dalam kehamilan risiko tinggi idealnya dilakukan berdasarkan prinsip evidence-based nursing (EBN). Pendekatan berbasis bukti dalam intervensi keperawatan ini berarti bahwa setiap tindakan keperawatan yang diberikan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang teraktual dan terpercaya, baik dari hasil penelitian maupun panduan klinis yang telah diakui secara global. Melalui pendekatan EBN, intervensi yang dilakukan akan lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul pada kehamilan risiko tinggi, serta mampu

meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan janin. Contoh intervensi berbasis bukti ini mencakup pengelolaan hipertensi dalam kehamilan dengan pemantauan tekanan darah yang ketat dan edukasi pola diet rendah garam, manajemen diabetes mellitus gestasional melalui edukasi nutrisi dan latihan fisik yang aman, pemberian suplemen zat besi dan asam folat dalam penanganan anemia, serta skrining rutin dan pemberian terapi antiretroviral pada ibu hamil dengan HIV/AIDS. Di samping itu, edukasi kesehatan tentang tanda bahaya dalam kehamilan juga merupakan intervensi EBN yang efektif guna meningkatkan kesiapsiagaan ibu dan keluarga dalam menghadapi situasi kritis.

Selain intervensi yang bersifat preventif dan promotif, perawat juga harus siap menghadapi situasi krisis dan kondisi darurat dalam kehamilan risiko tinggi. Pengelolaan krisis dan kondisi darurat pada kehamilan melibatkan kemampuan perawat dalam mengenali secara cepat berbagai tanda bahaya yang memerlukan intervensi medis segera, seperti hipertensi berat, kejang eklampsia, perdarahan masif akibat plasenta previa atau solusio plasenta, serta ancaman persalinan prematur. Dalam kondisi darurat, perawat memiliki tanggung jawab untuk segera melakukan intervensi awal seperti stabilisasi tanda vital, pemberian oksigen, pemasangan infus, pemberian obat-obatan sesuai protokol medis, serta segera berkoordinasi dengan dokter spesialis kandungan untuk penanganan lanjutan.

Dalam situasi krisis, perawat juga memainkan peran kunci dalam mengelola aspek psikologis dan emosional ibu serta keluarga yang umumnya mengalami kecemasan tinggi. Perawat harus mampu memberikan dukungan emosional, memberikan informasi secara jelas dan menenangkan, serta memastikan bahwa komunikasi antar anggota tim kesehatan berjalan efektif, agar ibu dan keluarga merasa aman dan terdukung dalam menghadapi situasi genting. Selain itu, perawat wajib memiliki kemampuan bekerja sama secara efektif dengan tim interprofesional, termasuk dokter spesialis kandungan, ahli anestesi, tenaga gizi, laboratorium, serta tenaga kesehatan lainnya dalam rangka memastikan keselamatan ibu dan janin.

E. Pendidikan Kesehatan untuk Ibu Hamil Risiko Tinggi dan Keluarga

Pendidikan kesehatan merupakan aspek penting dalam pengelolaan ibu hamil risiko tinggi karena dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kesiapan ibu dan keluarga dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan komplikasi selama kehamilan. Salah satu fokus utama dalam pendidikan kesehatan adalah pemberian edukasi mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan serta berbagai langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini. Tanda bahaya tersebut antara lain adalah perdarahan pervaginam, nyeri kepala hebat yang tidak membaik dengan istirahat, gangguan penglihatan, nyeri hebat pada perut bagian atas, edema wajah

atau tangan yang signifikan, penurunan gerakan janin, kontraksi dini atau nyeri perut yang berkelanjutan, serta demam tinggi yang tidak diketahui penyebabnya. Melalui edukasi yang efektif, ibu dan keluarga akan memiliki kemampuan mengenali secara dini tanda-tanda tersebut sehingga dapat segera mengambil tindakan yang tepat, seperti segera mencari pertolongan medis profesional guna mencegah komplikasi lebih lanjut.

Selain mengenali tanda bahaya, pendidikan kesehatan juga harus menitikberatkan pada pencegahan komplikasi selama kehamilan melalui perubahan gaya hidup yang sehat. Pencegahan tersebut mencakup edukasi mengenai pentingnya pola makan yang bergizi seimbang, aktivitas fisik ringan yang disesuaikan dengan kondisi ibu, kepatuhan terhadap jadwal pemeriksaan antenatal, serta menghindari kebiasaan berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, serta penggunaan obat-obatan tanpa pengawasan medis. Pendidikan kesehatan yang diberikan secara rutin dan konsisten ini memungkinkan ibu dan keluarganya memiliki peran aktif dalam menjaga kehamilan tetap sehat dan aman, serta mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan selama masa kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan.

Keberhasilan pendidikan kesehatan tidak terlepas dari strategi komunikasi yang tepat dan efektif. Strategi komunikasi dalam pendidikan kesehatan untuk ibu hamil risiko tinggi harus mempertimbangkan karakteristik psikologis, latar belakang sosial budaya, tingkat pendidikan, serta kondisi emosional ibu dan keluarga. Pendekatan yang digunakan harus bersifat empati, jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengaderti. Selain menggunakan bahasa verbal, strategi komunikasi ini juga harus memanfaatkan berbagai media yang relevan, seperti brosur edukasi, poster visual, buku panduan praktis, serta media digital seperti video edukasi atau aplikasi kesehatan yang interaktif. Perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh ibu hamil dan keluarganya melalui pendekatan yang personal dan interaktif, serta senantiasa memberikan ruang terbuka bagi ibu dan keluarga untuk berdiskusi, bertanya, atau menyampaikan kekhawatiran yang dialaminya. Dengan pendekatan komunikasi yang tepat, informasi yang diberikan tidak hanya sampai kepada ibu dan keluarganya, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan kehamilan.

Di samping aspek fisik dan komunikasi efektif, pendidikan kesehatan juga harus memperhatikan aspek dukungan psikososial. Kehamilan risiko tinggi seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi ibu hamil maupun keluarganya, seperti kecemasan, stres, rasa takut, hingga kondisi depresi. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan yang diberikan juga harus menyentuh aspek

dukungan emosional dan psikologis. Dukungan ini mencakup pemberian konseling secara rutin oleh perawat yang terlatih, pemberian informasi yang jujur namun tetap menenangkan, serta dorongan terhadap keluarga untuk turut serta memberikan dukungan emosional yang kuat kepada ibu selama kehamilan. Dalam pemberian dukungan psikososial, perawat tidak hanya berfungsi sebagai edukator, tetapi juga sebagai pendamping emosional yang dapat memahami serta berempati terhadap perasaan ibu. Selain itu, perawat juga bertugas menghubungkan ibu hamil dan keluarga dengan sumber dukungan tambahan jika dibutuhkan, seperti kelompok dukungan ibu hamil, layanan konseling psikologis profesional, serta layanan kesehatan mental yang tersedia.

Dengan pendekatan pendidikan kesehatan yang komprehensif, mencakup edukasi tanda bahaya, strategi komunikasi yang efektif, serta dukungan psikososial yang memadai, maka ibu hamil risiko tinggi dan keluarganya tidak hanya lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa kehamilan, tetapi juga memiliki kekuatan emosional dan psikologis yang optimal dalam menghadapi berbagai situasi kompleks yang mungkin terjadi. Hal ini pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup, menurunkan angka kejadian komplikasi, serta meningkatkan angka keselamatan dan kesejahteraan ibu maupun bayi hingga setelah persalinan.

F. Kolaborasi Interprofesional dalam Asuhan Kehamilan Risiko Tinggi

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan integral yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kehamilan risiko tinggi. Pendekatan ini menempatkan ibu dan janin sebagai pusat pelayanan kesehatan, yang membutuhkan keterlibatan berbagai tenaga profesional kesehatan secara sinergis dan terintegrasi. Tim multidisiplin yang terlibat dalam penanganan kehamilan risiko tinggi umumnya terdiri dari dokter spesialis kandungan (obstetri dan ginekologi), perawat spesialis maternitas, bidan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis jantung, ahli gizi, psikolog, tenaga laboratorium, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan klinis pasien. Setiap anggota tim memiliki peran spesifik namun saling melengkapi dalam proses asuhan, dengan tujuan akhir adalah memastikan keselamatan ibu serta janin secara optimal.

Secara khusus, dokter spesialis kandungan memiliki peran sentral dalam diagnosis dan penanganan medis kondisi kehamilan berisiko tinggi, seperti preeklampsia, diabetes gestasional, atau komplikasi medis lain yang memerlukan intervensi lanjutan. Perawat spesialis maternitas memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian holistik, perencanaan asuhan keperawatan, implementasi intervensi berbasis bukti, edukasi kesehatan, dan pemantauan kondisi ibu secara

berkelanjutan. Sementara itu, bidan memberikan pendampingan antenatal yang lebih intensif, khususnya dalam pemantauan rutin serta edukasi terkait tanda bahaya dan persiapan persalinan. Dokter spesialis lainnya, seperti dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis jantung, berperan dalam penanganan komplikasi medis yang menyertai kehamilan, seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau penyakit jantung, agar kondisi ibu tetap stabil dan terkontrol dengan baik selama kehamilan.

Ahli gizi juga memainkan peran penting dalam pengaturan diet yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi khusus pada kehamilan berisiko tinggi, seperti pemberian diet rendah gula untuk diabetes mellitus gestasional, diet rendah garam untuk hipertensi, dan diet tinggi zat besi untuk kondisi anemia. Psikolog atau konselor terlibat dalam memberikan dukungan psikologis, konseling kesehatan mental, serta pengelolaan stres atau kecemasan yang sering dialami ibu hamil risiko tinggi. Selanjutnya, tenaga laboratorium bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai pemeriksaan penunjang secara tepat waktu dan akurat, yang sangat diperlukan sebagai landasan diagnosis dan evaluasi kemajuan terapi, sedangkan apoteker berperan memastikan bahwa pemberian terapi obat-obatan kepada ibu hamil risiko tinggi aman dan sesuai dengan standar farmakologi yang berlaku.

Dalam implementasi kolaborasi interprofesional, berbagai strategi kolaborasi yang efektif harus diterapkan agar tujuan pengelolaan kehamilan risiko tinggi tercapai. Strategi yang utama dalam kolaborasi ini adalah membangun komunikasi yang terbuka, efektif, serta berkelanjutan antaranggota tim. Komunikasi ini mencakup pertukaran informasi yang lengkap, akurat, serta tepat waktu mengenai kondisi ibu dan janin, perkembangan kondisi klinis, serta rencana tindakan yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota tim. Pemanfaatan media komunikasi digital seperti rekam medis elektronik (electronic medical records/EMR), aplikasi pesan instan khusus kesehatan, serta telekonferensi tim secara rutin dapat menunjang efektivitas komunikasi tim interprofesional ini.

Strategi lainnya adalah mengadakan pertemuan berkala atau rapat koordinasi tim secara rutin untuk mengevaluasi kondisi pasien, menentukan prioritas tindakan, serta mendiskusikan tantangan atau hambatan yang mungkin muncul dalam pengelolaan kehamilan risiko tinggi. Pertemuan rutin ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menentukan keputusan secara bersama-sama, menetapkan tujuan terapi yang jelas, serta memastikan bahwa seluruh anggota tim memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mencapai target yang diharapkan.

Selain itu, strategi kolaborasi yang efektif juga mencakup penguatan peran masing-masing anggota tim dengan menghargai keahlian dan kontribusi unik mereka dalam proses asuhan. Setiap anggota tim didorong untuk aktif berpartisipasi, saling memberikan dukungan, serta mengutamakan pendekatan

saling menghormati dan menghargai dalam setiap interaksi. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kinerja tim, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, dan profesional, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh ibu hamil dan keluarganya.

G. Pemantauan dan Evaluasi Keperawatan dalam Kehamilan Risiko Tinggi

Pemantauan dan evaluasi keperawatan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengelolaan ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa intervensi yang diberikan telah sesuai dan efektif dalam mengurangi berbagai risiko serta mencegah terjadinya komplikasi serius selama masa kehamilan hingga masa nifas. Salah satu aspek penting dalam evaluasi ini adalah adanya indikator keberhasilan yang jelas dalam asuhan kehamilan risiko tinggi. Indikator keberhasilan tersebut mencakup beberapa aspek, seperti kondisi klinis ibu yang stabil, tanda vital ibu yang berada dalam rentang normal, tidak ditemukannya komplikasi lanjutan seperti hipertensi berat, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, atau anemia berat. Selain kondisi fisik ibu, indikator keberhasilan juga terlihat pada pertumbuhan janin yang optimal, gerakan janin yang aktif, berat janin yang sesuai usia kehamilan, serta hasil pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi dan pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan status kesehatan ibu dan janin berada pada batas yang aman.

Selain aspek klinis tersebut, indikator keberhasilan juga mencakup aspek psikososial, di mana ibu merasa tenang, percaya diri, dan memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali tanda-tanda bahaya serta mampu secara proaktif dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan medis segera jika diperlukan. Keluarga yang mendampingi ibu juga harus memiliki kesiapan dan pemahaman yang cukup mengenai kondisi ibu dan janin, serta mampu memberikan dukungan optimal selama proses kehamilan hingga persalinan. Indikator lain yang menunjukkan keberhasilan adalah tingginya kepatuhan ibu terhadap jadwal pemeriksaan rutin antenatal dan terapi yang diberikan, serta meningkatnya pengetahuan ibu dan keluarga setelah mendapatkan edukasi dari tim kesehatan.

Untuk memastikan bahwa berbagai indikator keberhasilan tersebut tercapai, diperlukan teknik pemantauan kesehatan ibu dan janin secara cermat, sistematis, dan konsisten. Teknik pemantauan ini mencakup berbagai aspek mulai dari pemeriksaan fisik rutin seperti pengukuran tekanan darah, berat badan, pemeriksaan edema, hingga pemeriksaan laboratorium berkala seperti kadar hemoglobin, kadar gula darah, fungsi hati dan ginjal, serta pemeriksaan urine untuk mendeteksi proteinuria atau infeksi. Selain pemantauan fisik ibu, kesehatan janin juga perlu diawasi dengan cermat melalui pemeriksaan ultrasonografi secara berkala

untuk menilai pertumbuhan janin, jumlah cairan ketuban, kondisi plasenta, serta pemantauan gerakan janin oleh ibu secara mandiri di rumah. Teknik pemantauan lanjutan seperti kardiotokografi (CTG) dan Doppler aliran darah plasenta juga digunakan dalam beberapa kondisi risiko tinggi tertentu untuk menilai kesejahteraan janin secara lebih rinci.

Selain pemantauan klinis rutin, teknik pemantauan kesehatan psikososial ibu juga penting dilakukan, yaitu melalui wawancara langsung, observasi perilaku, serta asesmen menggunakan kuesioner khusus guna mengevaluasi tingkat kecemasan, depresi, stres, atau dukungan sosial yang diterima ibu. Teknik ini membantu perawat mengidentifikasi dini adanya gangguan emosional yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan ibu secara keseluruhan, sehingga intervensi psikologis atau konseling dapat diberikan secara tepat waktu untuk menjaga keseimbangan emosional ibu.

Setelah dilakukan pemantauan secara menyeluruh, langkah penting berikutnya adalah dokumentasi dan pelaporan hasil pemantauan tersebut secara akurat dan terstruktur. Dokumentasi merupakan aspek penting dalam proses keperawatan yang membantu komunikasi efektif antaranggota tim kesehatan. Setiap data yang diperoleh, termasuk hasil pemeriksaan fisik, temuan laboratorium, hasil ultrasonografi, dan kondisi psikososial ibu harus didokumentasikan secara jelas, objektif, dan teratur. Dokumentasi yang baik mencakup pencatatan kronologis, tindakan atau intervensi yang telah dilakukan, respons ibu terhadap intervensi, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh tim kesehatan.

Pelaporan hasil dokumentasi ini dilakukan secara rutin dan sistematis kepada anggota tim multidisiplin yang terlibat dalam penanganan kehamilan risiko tinggi. Pelaporan dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan tim atau melalui sistem rekam medis elektronik (electronic medical records/EMR), yang memungkinkan akses informasi yang cepat dan akurat oleh semua pihak terkait. Pelaporan yang baik memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki informasi terbaru dan lengkap tentang kondisi ibu dan janin, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang tepat dan tepat waktu.

H. Simpulan

Kehamilan risiko tinggi merupakan kondisi khusus di mana ibu hamil, janin, atau keduanya mengalami ancaman komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan biasa. Berbagai faktor risiko seperti usia ekstrem, riwayat komplikasi sebelumnya, penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes gestasional, penyakit jantung, anemia, dan infeksi serius seperti TORCH atau HIV/AIDS, menjadi pemicu utama kondisi ini. Keadaan tersebut tidak hanya memengaruhi aspek fisik, namun

juga memberikan dampak psikologis, sosial, dan emosional bagi ibu serta keluarganya.

Dalam konteks ini, perawat memiliki peran penting dan strategis melalui pendekatan asuhan keperawatan yang holistik, komprehensif, dan berbasis bukti (evidence-based nursing). Deteksi dini melalui skrining dan asesmen menyeluruh sejak awal kehamilan, pemeriksaan penunjang yang akurat seperti ultrasonografi, tes laboratorium, serta pemantauan klinis yang rutin menjadi langkah krusial dalam upaya mencegah komplikasi yang lebih berat. Selain aspek klinis, perhatian terhadap aspek psikososial seperti kecemasan, stres, dan depresi juga harus diutamakan guna menjaga keseimbangan emosional ibu.

Manajemen keperawatan pada kehamilan risiko tinggi melibatkan perencanaan asuhan yang matang dan terukur, intervensi berbasis bukti, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan keluarga, termasuk edukasi tanda-tanda bahaya serta strategi komunikasi efektif, secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai kemungkinan komplikasi. Dukungan psikososial juga tidak kalah penting, yang membantu ibu dalam menghadapi tantangan emosional selama kehamilan.

Pendekatan kolaborasi interprofesional yang melibatkan dokter spesialis, bidan, ahli gizi, psikolog, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya sangat menentukan keberhasilan asuhan ini. Strategi komunikasi tim yang efektif, pertemuan rutin, serta penghargaan terhadap kontribusi masing-masing anggota tim meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara signifikan.

Evaluasi keberhasilan asuhan didasarkan pada indikator klinis seperti kestabilan tanda vital ibu, kondisi janin yang optimal, serta peningkatan pemahaman ibu dan keluarga terhadap kondisi kehamilan risiko tinggi. Pemantauan secara sistematis dan konsisten, disertai dokumentasi dan pelaporan yang akurat, memastikan kelangsungan serta efektivitas intervensi keperawatan yang telah diberikan.

Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif dalam manajemen kehamilan risiko tinggi yang melibatkan deteksi dini, intervensi berbasis bukti, pendidikan kesehatan, dukungan psikososial, kolaborasi interprofesional, serta evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam upaya menurunkan angka komplikasi, meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.

I. Referensi

- Cleveland Clinic. (2022). High-risk pregnancy: Age, complications & management. Diakses dari Cleveland Clinic.
- Gümüřdař, E., & Oskay, Ü. Y. (2024). Effect of high-risk pregnancy on prenatal stress level. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-05956-z>
- Lee, S. H., & Kim, I. J. (2020). Prevalence of high-risk pregnancy and its risk factors in pregnant women. *Asia Life Sciences*, 29(1), 315–326.
- National Center for Biotechnology Information. (2019). Well-being in high-risk pregnancy: An integrative review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20, Artikel 190. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03190-6>
- Verywell Health. (2023, Agustus 5). Preparing for a high-risk pregnancy. Verywell Health.
- Wikipedia. (2025, Juni). Gestational diabetes. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Gestational_diabetes
- Wikipedia. (2025, Juni). Pre-eclampsia. Diakses dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-eclampsia>
- Wikipedia. (2025, Juni). Pre-existing disease in pregnancy. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-existing_disease_in_pregnancy

J. Glosarium

Anemia dalam kehamilan: Kondisi penurunan jumlah hemoglobin dalam darah ibu hamil akibat kekurangan zat besi, asam folat, atau vitamin B12, menyebabkan turunnya kemampuan darah mengangkut oksigen ke jaringan ibu dan janin.

Asesmen kehamilan risiko tinggi: Proses pengkajian sistematis dan komprehensif oleh tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi tanda-tanda bahaya atau komplikasi yang berpotensi terjadi pada ibu hamil dan janin.

Diabetes Mellitus Gestasional (DMG): Kondisi tingginya kadar glukosa darah yang pertama kali terdeteksi saat kehamilannya, disebabkan resistensi insulin yang meningkat akibat hormon plasenta.

Edukasi kesehatan antenatal: Proses pemberian informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan ibu hamil dan keluarganya untuk mengenali tanda bahaya dan mengelola kondisi kehamilan secara optimal.

Eklampsia: Kondisi serius pada ibu hamil yang merupakan komplikasi dari preeklampsia, ditandai dengan munculnya kejang-kejang tonik-klonik.

Hipertensi dalam kehamilan: Kondisi peningkatan tekanan darah ibu selama kehamilan, yang secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi seperti preeklampsia, eklampsia, atau gangguan pertumbuhan janin.

Kehamilan risiko tinggi: Kondisi kehamilan dengan kemungkinan komplikasi lebih tinggi dibanding kehamilan normal, disebabkan oleh faktor medis, lingkungan, maupun riwayat obstetri sebelumnya.

Kolaborasi interprofesional: Kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan dari berbagai bidang spesialisasi dalam pengelolaan kehamilan risiko tinggi, untuk memastikan hasil terbaik bagi ibu dan janin.

Komplikasi persalinan: Gangguan atau masalah kesehatan yang muncul saat persalinan, seperti persalinan prematur, plasenta previa, solusio plasenta, atau perdarahan postpartum.

Makrosomia: Kondisi bayi yang lahir dengan berat badan jauh di atas rata-rata (>4000 gram), sering terjadi pada ibu dengan diabetes gestasional akibat hiperinsulinemia pada janin.

Manajemen keperawatan berbasis bukti (Evidence-Based Nursing - EBN): Pendekatan praktik keperawatan yang menggunakan hasil penelitian terbaru dan terbaik sebagai dasar intervensi yang diberikan kepada pasien.

Patofisiologi kehamilan risiko tinggi: Mekanisme gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan timbulnya komplikasi pada kehamilan, seperti gangguan vaskular, resistensi insulin, dan infeksi.

Pemantauan kesehatan psikososial: Proses evaluasi berkala terhadap kondisi mental dan emosional ibu hamil untuk mendeteksi kecemasan, depresi, atau stres selama masa kehamilan.

Pemeriksaan penunjang: Pemeriksaan tambahan berupa tes laboratorium atau pencitraan seperti USG, Doppler, CTG, yang bertujuan mendukung diagnosis atau konfirmasi kondisi risiko tinggi dalam kehamilan.

Preeklampsia: Gangguan hipertensi pada kehamilan yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu, ditandai dengan tekanan darah tinggi, proteinuria, dan gangguan fungsi organ tubuh lainnya.

Skrining kehamilan risiko tinggi: Proses deteksi awal melalui pemeriksaan klinis dan riwayat medis untuk mengidentifikasi faktor risiko yang berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan.

Tanda bahaya kehamilan: Tanda-tanda klinis seperti perdarahan, nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri perut hebat, dan penurunan gerakan janin, yang menunjukkan risiko komplikasi yang serius.

Transmisi vertikal: Penularan infeksi dari ibu ke janin selama masa kehamilan, persalinan, atau menyusui, misalnya pada infeksi HIV, hepatitis, atau TORCH.

Ultrasonografi (USG) obstetri: Pemeriksaan pencitraan menggunakan gelombang suara untuk memantau pertumbuhan dan kesejahteraan janin serta kondisi plasenta selama kehamilan.

Vasospasme arteriol sistemik: Kondisi penyempitan pembuluh darah kecil secara luas yang sering terjadi pada preeklampsia, menyebabkan berkurangnya aliran darah ke organ tubuh ibu dan plasenta.

CHAPTER 4

KEPERAWATAN DALAM SITUASI KEGAWATDARURATAN OBSTETRI

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kegawatdaruratan obstetri merupakan kondisi kritis yang dapat terjadi secara tiba-tiba selama masa kehamilan, persalinan, atau pada periode nifas, yang jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi berat, kecacatan permanen, bahkan kematian bagi ibu dan janin. Kegawatdaruratan obstetri dapat mencakup berbagai kondisi klinis serius seperti pre-eklamsia berat, eklamsia, perdarahan antepartum dan postpartum, ruptura uteri, emboli cairan ketuban, persalinan macet, serta kondisi lain yang berpotensi mengancam jiwa. Konsep dasar kegawatdaruratan obstetri didasarkan pada prinsip penanganan cepat, tepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar praktik klinis untuk memastikan keselamatan ibu dan janin. Dalam hal ini, tenaga kesehatan khususnya perawat perlu memahami konsep tersebut secara mendalam, mulai dari kemampuan mengenali gejala awal, melakukan penilaian klinis secara cermat, hingga pelaksanaan intervensi yang sesuai dengan panduan klinis terkini.

Definisi kegawatdaruratan obstetri secara umum adalah kondisi yang muncul mendadak pada wanita hamil, bersalin, atau pascapersalinan yang mengharuskan tindakan segera oleh tenaga medis profesional untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal. Hal ini menuntut tenaga kesehatan untuk memahami bahwa penanganan dalam situasi ini harus dilakukan tanpa penundaan karena setiap keterlambatan dapat secara signifikan meningkatkan risiko buruk terhadap kesehatan ibu maupun janin.

Perawat sebagai bagian integral dalam tim kesehatan memiliki peran sentral dalam manajemen kegawatdaruratan obstetri. Peran dan tanggung jawab perawat dalam kondisi kegawatdaruratan obstetri tidak hanya sebatas pemberian tindakan langsung kepada pasien, tetapi mencakup spektrum yang lebih luas. Dalam hal ini, perawat bertanggung jawab penuh dalam melakukan penilaian awal kondisi pasien, seperti melakukan pemeriksaan tanda vital secara cepat dan akurat, mengevaluasi status hemodinamik pasien, dan melakukan identifikasi dini tanda-tanda komplikasi yang mengancam jiwa. Selain itu, perawat juga harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam memberikan intervensi yang sesuai, seperti pemberian

terapi oksigen, pemasangan jalur intravena untuk terapi cairan, atau pemberian obat-obatan sesuai protokol klinis yang berlaku.

Di samping tindakan klinis langsung, perawat juga memiliki tanggung jawab dalam aspek koordinasi dan komunikasi tim interprofesional. Perawat dituntut mampu berkomunikasi secara efektif dengan tim multidisiplin seperti dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter anestesi, bidan, tenaga laboratorium, dan petugas lainnya guna memastikan tindakan medis berlangsung cepat, efisien, dan terintegrasi dengan baik. Keterampilan komunikasi ini sangat penting karena keberhasilan penanganan kegawatdaruratan obstetri bergantung pada kerja sama tim yang solid serta kemampuan bertindak dengan cepat berdasarkan panduan klinis yang jelas.

Selain itu, perawat juga memiliki peran penting dalam aspek edukasi kepada pasien dan keluarga. Dalam situasi kegawatdaruratan, keluarga sering mengalami kecemasan dan kebingungan. Oleh karena itu, perawat harus dapat memberikan informasi secara jelas, empati, dan profesional mengenai kondisi pasien, tindakan medis yang akan dilakukan, risiko yang mungkin timbul, serta hasil yang diharapkan. Peran edukasi ini bertujuan agar keluarga pasien tetap tenang, mendukung upaya penanganan yang dilakukan oleh tim medis, serta membantu mengurangi tingkat stres emosional pasien dan keluarga selama proses penanganan kegawatdaruratan berlangsung.

Secara holistik, tanggung jawab perawat dalam kegawatdaruratan obstetri juga mencakup pendokumentasian yang jelas dan akurat terhadap semua tindakan yang telah diberikan. Dokumentasi yang baik sangat penting dalam proses evaluasi klinis, kontinuitas perawatan, dan sebagai aspek legal dari pelayanan kesehatan. Dengan demikian, perawat harus memastikan setiap tindakan, hasil observasi, serta perubahan kondisi pasien dicatat secara sistematis dan dapat diakses oleh anggota tim kesehatan lainnya untuk mendukung pelayanan yang aman dan berkualitas.

Keseluruhan peran dan tanggung jawab ini menunjukkan bahwa perawat memegang peranan penting yang kompleks dan krusial dalam sistem kegawatdaruratan obstetri. Oleh karena itu, perawat perlu dibekali dengan kompetensi klinis yang memadai, pemahaman konsep kegawatdaruratan secara mendalam, serta kemampuan interpersonal yang kuat untuk memberikan pelayanan optimal yang mampu menyelamatkan nyawa ibu dan janin dalam situasi gawat darurat obstetri.

B. Identifikasi dan Penilaian Cepat dalam Kegawatdaruratan Obstetri

Identifikasi dan penilaian cepat merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam manajemen kegawatdaruratan obstetri. Ketepatan dan kecepatan dalam melakukan identifikasi serta evaluasi kondisi pasien secara dini menjadi penentu keberhasilan penanganan pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa. Pengetahuan mendalam mengenai tanda dan gejala awal kegawatdaruratan, penerapan prinsip triage obstetri, serta kemampuan melakukan penilaian menggunakan pendekatan ABCDE merupakan kompetensi utama yang harus dikuasai perawat dalam memberikan asuhan obstetri gawat darurat.

Tanda dan gejala awal kegawatdaruratan obstetri dapat muncul secara bervariasi, tergantung pada kondisi yang dialami ibu hamil, bersalin, maupun pada masa nifas. Gejala yang umumnya mengindikasikan kondisi kegawatdaruratan di antaranya meliputi perdarahan per vaginam yang hebat, nyeri kepala hebat disertai pandangan kabur, peningkatan tekanan darah yang signifikan (misalnya pada pre-eklamsia berat), nyeri perut yang sangat kuat dan tiba-tiba (kemungkinan ruptura uteri), kejang atau penurunan kesadaran yang merupakan tanda eklamsia, sesak napas akut yang menandakan emboli cairan ketuban atau edema paru, serta kondisi janin seperti penurunan denyut jantung janin (bradikardia janin) yang tiba-tiba. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengenali dengan cepat gejala-gejala tersebut serta segera mengidentifikasi kemungkinan komplikasi yang sedang terjadi.

Dalam situasi klinis yang dinamis dan penuh tekanan, triage obstetri memainkan peran penting dalam menentukan tingkat urgensi dan prioritas penanganan pasien. Triage obstetri adalah suatu proses cepat untuk mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi klinis dan risiko terhadap nyawa ibu dan janin. Sistem triage obstetri membantu perawat dan tim medis untuk menentukan urutan prioritas pelayanan secara objektif, terutama ketika menghadapi situasi di mana sumber daya terbatas atau banyaknya pasien yang datang bersamaan. Pada triage obstetri, pasien akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti kelompok merah (darurat tinggi), kuning (darurat sedang), hijau (darurat rendah), serta hitam (pasien meninggal atau kondisi sangat kritis dengan prognosis sangat buruk). Melalui sistem ini, perawat dapat memastikan bahwa pasien yang membutuhkan tindakan medis segera akan ditangani terlebih dahulu, sehingga meningkatkan peluang keselamatan ibu dan janin secara signifikan.

Setelah dilakukan triage awal, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian komprehensif menggunakan pendekatan ABCDE. Pendekatan ABCDE dalam kegawatdaruratan obstetri merupakan metode standar dan sistematis dalam menilai kondisi pasien yang bertujuan untuk memastikan kestabilan kondisi pasien secara

cepat. Pendekatan ini meliputi penilaian airway (jalan napas), breathing (pernapasan), circulation (sirkulasi), disability (status neurologis), dan exposure (paparan atau pemeriksaan menyeluruh).

Pada tahap airway (A), perawat harus segera memastikan bahwa jalan napas pasien terbuka, bebas hambatan, dan tidak ada risiko sumbatan. Kondisi seperti muntah hebat, kejang, atau penurunan kesadaran yang signifikan dapat mengganggu jalan napas dan harus segera diatasi agar pasien tetap mendapatkan suplai oksigen yang cukup.

Selanjutnya, pada tahap breathing (B), perawat mengevaluasi fungsi pernapasan pasien secara cepat, memastikan pernapasan pasien efektif, simetris, dan adekuat. Tanda-tanda distress napas seperti sesak napas berat, sianosis, peningkatan frekuensi napas (takipnea), atau bunyi napas abnormal harus segera dikenali agar dapat dilakukan intervensi seperti pemberian oksigen atau ventilasi bantuan dengan segera.

Pada tahap circulation (C), perawat harus segera melakukan penilaian status sirkulasi pasien dengan mengecek tanda vital, terutama tekanan darah, denyut nadi, serta melihat adanya tanda-tanda syok seperti pucat, berkeringat dingin, tekanan darah rendah, denyut nadi yang cepat dan lemah, serta ekstremitas yang dingin. Penanganan segera seperti pemasangan akses intravena untuk pemberian cairan atau transfusi darah harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah kerusakan organ vital akibat gangguan perfusi.

Pada tahap disability (D), penilaian fungsi neurologis pasien meliputi evaluasi tingkat kesadaran, respons terhadap rangsangan, serta tanda-tanda neurologis seperti kejang-kejang atau tanda eklamsia lainnya. Penilaian ini membantu perawat mengidentifikasi potensi gangguan neurologis secara dini dan melakukan tindakan pencegahan kerusakan neurologis lebih lanjut.

Akhirnya, pada tahap exposure (E), perawat perlu melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh secara cepat tetapi menyeluruh terhadap tubuh pasien. Tahap ini melibatkan pemeriksaan untuk menemukan tanda-tanda perdarahan tersembunyi, trauma, atau kondisi lain yang sebelumnya belum terlihat. Pemeriksaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan privasi pasien serta menjaga suhu tubuh pasien agar tetap stabil guna menghindari risiko hipotermia.

Melalui penerapan pendekatan ABCDE ini secara cepat dan tepat, perawat mampu mendapatkan gambaran klinis yang jelas tentang kondisi pasien. Hal ini memungkinkan perawat bersama tim medis lainnya untuk menentukan tindakan medis selanjutnya secara efektif dan terarah, sehingga mengurangi risiko komplikasi yang lebih parah dan memastikan pelayanan kegawatdaruratan obstetri yang aman serta optimal bagi ibu dan janin.

C. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan selama Kehamilan

Penatalaksanaan kegawatdaruratan selama kehamilan merupakan intervensi kritis dan sistematis yang bertujuan mengatasi kondisi serius pada ibu hamil yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Berbagai kondisi kegawatdaruratan selama kehamilan yang paling sering dijumpai antara lain hiperemesis gravidarum akut, preeklamsia berat dan eklamsia, perdarahan antepartum akibat placenta previa dan solusio plasenta, serta kegawatan pada kehamilan ektopik terganggu. Setiap kondisi ini memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam penanganannya, sehingga perawat dan tenaga medis perlu memahami secara detail serta mampu melaksanakan tindakan dengan tepat.

Hiperemesis gravidarum akut merupakan kondisi kegawatdaruratan pada trimester awal kehamilan yang ditandai oleh mual dan muntah berlebihan sehingga menyebabkan dehidrasi berat, gangguan elektrolit, dan penurunan status nutrisi secara signifikan. Kondisi ini dapat mengganggu kesehatan ibu secara serius apabila tidak segera ditangani dengan tepat. Penatalaksanaan awal hiperemesis gravidarum akut melibatkan pemberian cairan intravena untuk mengoreksi dehidrasi dan gangguan elektrolit, pemantauan tanda vital secara ketat, dan pemberian antiemetik secara intravena sesuai indikasi medis. Perawat bertanggung jawab dalam mengobservasi tanda-tanda vital, status hidrasi, keseimbangan elektrolit, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien agar kecemasan berkurang. Setelah kondisi pasien stabil, perlu edukasi mengenai pola makan yang baik, penyesuaian diet yang tepat, serta pemantauan lanjutan guna mencegah kekambuhan.

Preeklamsia berat dan eklamsia merupakan kondisi yang sangat serius pada kehamilan, ditandai oleh peningkatan tekanan darah yang signifikan ($>160/110$ mmHg), proteinuria berat, gangguan fungsi organ seperti hati, ginjal, serta gangguan neurologis yang dapat menyebabkan kejang. Eklamsia ditandai oleh terjadinya kejang yang merupakan komplikasi lanjutan dari preeklamsia berat. Penatalaksanaan preeklamsia berat dan eklamsia melibatkan pengontrolan tekanan darah menggunakan antihipertensi yang tepat seperti labetalol, hidralazin, atau nifedipin, pemberian magnesium sulfat sebagai pencegahan atau terapi kejang, serta memastikan stabilisasi kondisi hemodinamik ibu. Perawat wajib melakukan pemantauan ketat tanda vital, fungsi neurologis, refleks tendon dalam, keluaran urin, serta tanda-tanda toksisitas magnesium. Koordinasi dengan tim medis juga sangat penting guna menentukan waktu terbaik untuk persalinan segera yang merupakan penatalaksanaan definitif untuk kondisi ini. Pendekatan keluarga secara edukatif juga perlu dilakukan untuk mengurangi kecemasan keluarga dalam menghadapi situasi kritis ini.

Perdarahan antepartum yang disebabkan oleh placenta previa dan solusio plasenta merupakan kondisi kegawatdaruratan yang sering ditemukan pada trimester akhir kehamilan. Placenta previa ditandai dengan perdarahan vagina tanpa nyeri, di mana plasenta terletak abnormal menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Sebaliknya, solusio plasenta ditandai dengan perdarahan vagina yang disertai nyeri hebat akibat terlepasnya plasenta dari dinding rahim sebelum persalinan terjadi. Penatalaksanaan awal perdarahan antepartum adalah dengan memastikan kestabilan sirkulasi ibu melalui pemasangan akses intravena yang besar, pemberian cairan intravena atau transfusi darah, serta pemantauan ketat denyut jantung janin. Dalam kondisi placenta previa, perawat harus memastikan bahwa pemeriksaan vagina tidak dilakukan secara sembarangan karena risiko perdarahan hebat. Sebaliknya, pada solusio plasenta, identifikasi cepat gejala nyeri perut hebat disertai perdarahan sangat penting untuk penegakan diagnosis cepat. Kedua kondisi ini umumnya memerlukan persalinan segera melalui seksio sesarea untuk mencegah komplikasi lebih lanjut bagi ibu dan janin.

Kehamilan ektopik terganggu adalah suatu kondisi ketika kehamilannya berkembang di luar rahim, umumnya di tuba falopi, yang kemudian pecah sehingga menyebabkan perdarahan internal akut dan nyeri abdomen hebat. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan syok hemoragik dalam waktu singkat. Penatalaksanaan awal kegawatdaruratan ini adalah dengan stabilisasi hemodinamik pasien melalui pemasangan jalur intravena besar, pemberian cairan kristaloid atau transfusi darah, dan pengaturan oksigenasi. Perawat bertanggung jawab melakukan pemantauan vital sign secara ketat, memastikan adanya akses intravena yang adekuat, serta melakukan penilaian ABCDE secara cepat dan menyeluruh. Intervensi definitif pada kehamilan ektopik terganggu biasanya dilakukan dengan tindakan operatif, baik laparoskopi maupun laparotomi, guna menghentikan perdarahan aktif dan mengangkat jaringan yang mengalami ruptur.

D. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan saat Persalinan

Penatalaksanaan kegawatdaruratan saat persalinan merupakan serangkaian tindakan medis dan keperawatan yang harus segera dilakukan untuk mencegah komplikasi serius, termasuk kematian ibu dan janin. Beberapa kondisi gawat darurat yang paling sering muncul saat persalinan adalah distosia bahu (shoulder dystocia), prolaps tali pusat, ruptur uteri, dan emboli air ketuban (amniotic fluid embolism). Setiap kondisi ini memerlukan penanganan khusus, cepat, terstruktur, serta kerja tim yang efektif untuk mencapai hasil terbaik dalam menyelamatkan ibu dan janin.

Distosia bahu (shoulder dystocia) adalah situasi kritis di mana bahu anterior janin terjebak di belakang simfisis pubis ibu setelah kepala janin dilahirkan. Kondisi

ini ditandai dengan kesulitan melahirkan bahu janin secara spontan dalam waktu yang normal setelah kepala keluar. Distosia bahu merupakan situasi kegawatdaruratan obstetri yang membutuhkan intervensi segera karena dapat menyebabkan cedera neurologis pada janin, fraktur klavikula, atau asfiksia berat akibat tekanan berlebihan pada tali pusat. Penatalaksanaan awal mencakup tindakan sederhana seperti manuver McRoberts, yaitu fleksi ekstremitas bawah ibu ke arah abdomen, dan manuver tekanan suprapubik yang bertujuan membantu rotasi dan pelepasan bahu janin dari tulang pubis ibu. Perawat harus secara aktif berpartisipasi dalam melakukan posisi ini, membantu dokter dalam pelaksanaan manuver yang diperlukan, serta mencatat waktu secara akurat untuk memastikan tindakan tidak melebihi batas waktu aman (biasanya maksimal 5 menit). Jika tindakan sederhana gagal, langkah lebih lanjut seperti manuver Woods atau ekstraksi manual bahu oleh dokter mungkin diperlukan. Perawat juga wajib mempersiapkan tim neonatal untuk resusitasi bayi setelah kelahiran.

Prolaps tali pusat merupakan kondisi darurat ketika tali pusat keluar mendahului bagian terbawah janin atau bersamaan dengan bagian janin yang sedang lahir, menyebabkan tekanan terhadap tali pusat. Kondisi ini dapat menimbulkan hipoksia berat pada janin akibat gangguan suplai oksigen dari ibu ke janin. Penatalaksanaan prolaps tali pusat yang utama adalah segera mengurangi tekanan terhadap tali pusat untuk mempertahankan sirkulasi darah ke janin. Perawat harus segera memosisikan ibu dengan posisi knee-chest atau Trendelenburg yang ekstrem untuk mengurangi tekanan gravitasi terhadap tali pusat, sambil segera memberi tahu tim medis untuk persiapan tindakan segera berupa persalinan sesar darurat. Jika memungkinkan, perawat atau tenaga medis harus mempertahankan elevasi kepala janin secara manual melalui vagina untuk mengurangi tekanan terhadap tali pusat hingga tindakan operasi sesar dilakukan. Pemantauan denyut jantung janin harus dilakukan secara kontinu untuk memonitor kondisi janin selama persiapan tindakan darurat ini.

Ruptur uteri adalah robekan pada dinding rahim yang dapat terjadi spontan atau akibat intervensi medis tertentu selama persalinan. Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perdarahan internal hebat, syok hemoragik, hingga kematian ibu dan janin dalam waktu singkat. Tanda klinis ruptur uteri meliputi nyeri perut mendadak hebat, perubahan mendadak pada pola kontraksi, hilangnya denyut jantung janin secara tiba-tiba, serta tanda-tanda syok hipovolemik pada ibu. Penatalaksanaan awal ruptur uteri melibatkan stabilisasi kondisi ibu dengan pemasangan akses intravena besar untuk pemberian cairan dan darah, serta pemberian oksigen tambahan. Perawat berperan dalam memonitor ketat tanda vital, status hemodinamik pasien, dan menyiapkan

tindakan operasi darurat. Operasi sesar darurat segera harus dilakukan untuk mengendalikan perdarahan dan menyelamatkan janin. Kadang, tindakan histerektomi emergensi mungkin diperlukan untuk menghentikan perdarahan hebat apabila ruptur sangat luas dan tidak bisa diperbaiki secara konservatif.

Emboli air ketuban (amniotic fluid embolism) adalah kondisi langka namun sangat fatal, di mana cairan ketuban masuk ke dalam sirkulasi darah ibu, menyebabkan reaksi anafilaktoid akut yang berujung pada kegagalan respirasi akut, gagal jantung, koagulasi intravaskular diseminata (DIC), dan syok berat yang berisiko tinggi menyebabkan kematian. Tanda klinis yang khas adalah sesak napas mendadak, sianosis, hipotensi hebat, kolaps kardiovaskular, gangguan kesadaran, hingga perdarahan hebat akibat koagulopati. Penatalaksanaan emboli air ketuban merupakan tindakan kegawatdaruratan mutlak dengan prioritas utama stabilisasi jalan napas (airway), pernapasan (breathing), serta sirkulasi (circulation). Perawat harus segera memberikan oksigenasi maksimal, menyiapkan bantuan ventilasi mekanik, serta mengakses jalur intravena besar untuk pemberian cairan, vasopresor, dan transfusi produk darah. Penanganan lebih lanjut harus dilakukan di unit perawatan intensif dengan tim multidisiplin yang melibatkan dokter obstetri, anestesi, dan spesialis lainnya. Dukungan hemodinamik berupa pemberian vasopresor, koreksi gangguan koagulasi melalui transfusi komponen darah, serta resusitasi jantung paru (RJP) jika diperlukan, harus dilakukan sesegera mungkin untuk meningkatkan angka kelangsungan hidup ibu.

E. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan pada Masa Nifas

Penatalaksanaan kegawatdaruratan pada masa nifas merupakan serangkaian tindakan medis dan keperawatan kritis untuk menangani berbagai komplikasi serius yang terjadi setelah persalinan. Masa nifas adalah periode penting yang membutuhkan pemantauan ketat, mengingat ibu masih memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi yang berpotensi fatal, seperti perdarahan postpartum, infeksi berat (sepsis puerperalis), preeklampsia atau eklampsia yang berkembang pascapersalinan, hingga gangguan psikiatri akut yang dapat membahayakan keselamatan ibu maupun bayi. Oleh karena itu, tenaga keperawatan harus memahami secara mendalam mengenai tanda klinis, prinsip penilaian, serta tindakan darurat yang tepat untuk masing-masing kondisi.

Perdarahan pascapersalinan (postpartum hemorrhage, PPH) adalah komplikasi serius yang menjadi penyebab utama mortalitas ibu di seluruh dunia. Kondisi ini ditandai dengan kehilangan darah berlebihan yang mencapai lebih dari 500 ml setelah persalinan pervaginam atau lebih dari 1000 ml setelah persalinan sesar, disertai tanda-tanda klinis berupa pucat, hipotensi, takikardia, dan syok hipovolemik.

Penyebab umum PPH meliputi atonia uteri, retensio plasenta, trauma jalan lahir, dan gangguan koagulasi. Penatalaksanaan awal meliputi stabilisasi cepat sirkulasi ibu dengan memasang akses intravena ganda berdiameter besar untuk memberikan cairan kristaloid dan transfusi darah sesuai kebutuhan. Perawat bertanggung jawab dalam memantau tanda vital secara ketat, mengevaluasi tinggi fundus uteri untuk menentukan kemungkinan atonia, serta membantu pemberian uterotonika seperti oksitosin, metilergometrin, atau misoprostol. Jika perdarahan terus berlangsung, perawat harus berkoordinasi cepat dengan tim medis untuk intervensi lebih lanjut, seperti tamponade uterina, tindakan bedah seperti histerektomi emergensi, atau embolisasi pembuluh darah rahim.

Infeksi pascapersalinan atau sepsis puerperalis adalah kondisi infeksi serius yang dapat berkembang dalam beberapa hari hingga minggu pertama pascapersalinan. Infeksi ini ditandai oleh demam tinggi, nyeri abdomen, perdarahan vagina abnormal, keputihan purulen, serta tanda sistemik berupa takikardia, hipotensi, gangguan kesadaran hingga syok septik. Kondisi ini sering disebabkan oleh infeksi rahim (endometritis), infeksi luka episiotomi atau luka operasi sesar, serta mastitis berat. Penatalaksanaan awal melibatkan pemberian antibiotik spektrum luas intravena secara cepat setelah pengambilan kultur darah dan sampel jaringan yang relevan. Perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi tanda infeksi secara dini, pemantauan suhu tubuh dan tanda vital secara kontinu, menjaga hidrasi serta nutrisi yang adekuat, serta memberikan edukasi pada pasien mengenai kebersihan luka dan tanda-tanda infeksi. Pasien dengan sepsis puerperalis sering kali membutuhkan perawatan intensif dengan pendekatan multidisiplin guna mencegah komplikasi lebih lanjut seperti syok septik, gagal organ multipel, hingga kematian.

Preeklampsia dan eklampsia pascapersalinan merupakan kondisi kritis yang dapat muncul tiba-tiba setelah kelahiran bayi. Walaupun jarang, kondisi ini tetap berisiko tinggi karena sering tidak terdeteksi secara dini. Gejala khas preeklampsia pascanifas meliputi hipertensi berat, nyeri kepala hebat, pandangan kabur, edema ekstremitas berat, serta tanda neurologis yang bisa berkembang menjadi eklampsia berupa kejang-kejang. Penatalaksanaan awal meliputi pemberian antihipertensi intravena secara cepat, seperti labetalol atau hidralazin, serta pemberian magnesium sulfat untuk mencegah atau mengobati kejang. Perawat bertanggung jawab dalam pemantauan ketat tekanan darah, refleks tendon dalam, tanda-tanda kejang, serta mengidentifikasi efek samping terapi magnesium sulfat seperti gangguan pernapasan. Perawat juga harus memastikan keluarga pasien mendapat informasi jelas tentang kondisi ibu dan kebutuhan intervensi medis, sehingga mampu memberikan dukungan psikologis yang diperlukan selama proses penanganan.

Gangguan psikiatri akut pada masa nifas merupakan kondisi kegawatdaruratan psikiatri yang serius, mencakup postpartum depression berat, postpartum anxiety akut, hingga postpartum psychosis yang ditandai oleh gangguan emosi berat, perubahan perilaku drastis, halusinasi, delusi, serta adanya risiko mencederai diri sendiri maupun bayi. Kondisi ini memerlukan intervensi segera dan pendekatan multidisiplin melibatkan tim kesehatan mental. Perawat berperan penting dalam mengidentifikasi gejala-gejala gangguan psikiatri secara dini, memberikan dukungan emosional serta menjamin keamanan pasien dan bayinya. Penanganan kondisi ini meliputi pemberian obat psikotropika di bawah pengawasan ketat psikiater, terapi psikologis intensif, serta memastikan lingkungan pasien aman dan nyaman untuk mencegah cedera atau tindakan impulsif yang membahayakan. Perawat juga bertanggung jawab melakukan edukasi terhadap keluarga mengenai pentingnya pengawasan ketat, pemberian dukungan psikososial, serta mengenali tanda-tanda krisis psikiatri lebih lanjut.

F. Stabilisasi dan Transportasi Pasien Obstetri dalam Kondisi Gawat Darurat

Stabilisasi dan transportasi pasien obstetri yang mengalami kondisi kegawatdaruratan merupakan aspek penting dalam praktik pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Kondisi pasien obstetri yang mengalami kegawatdaruratan sering kali membutuhkan penanganan intensif yang segera, stabilisasi kondisi klinis yang optimal, serta proses transportasi yang cepat dan aman menuju fasilitas kesehatan dengan fasilitas lebih lengkap. Proses ini melibatkan berbagai prinsip penting, seperti stabilisasi awal pasien, penerapan teknik transportasi aman yang tepat, serta koordinasi efektif antara berbagai fasilitas kesehatan dalam sistem rujukan yang terpadu.

Prinsip dasar stabilisasi pasien obstetri dalam kondisi gawat darurat berfokus pada upaya mempertahankan dan mengembalikan fungsi vital pasien sebelum proses transportasi dilakukan. Stabilisasi meliputi penilaian cepat dan menyeluruh terhadap kondisi ibu dengan pendekatan ABCDE, yaitu memastikan jalan napas terbuka (Airway), evaluasi pernapasan (Breathing), menjaga sirkulasi darah yang efektif (Circulation), penilaian status neurologis (Disability), dan pemeriksaan menyeluruh (Exposure). Pada tahap stabilisasi ini, perawat bertanggung jawab memastikan bahwa pasien memiliki akses intravena yang memadai untuk pemberian cairan, obat-obatan darurat, atau transfusi darah. Tindakan stabilisasi juga mencakup pemberian oksigen tambahan, penanganan kondisi spesifik seperti perdarahan, kejang, atau syok, serta pengaturan posisi pasien yang aman dan nyaman sesuai dengan kondisi kegawatdaruratannya. Selain itu, perawat juga harus memastikan bahwa evaluasi ketat terhadap tanda vital dan pemantauan denyut

jantung janin terus dilakukan secara kontinu untuk mendeteksi dini perburukan kondisi ibu maupun janin selama proses transportasi.

Setelah kondisi pasien berhasil distabilisasi, proses selanjutnya adalah transportasi pasien obstetri ke fasilitas rujukan yang lebih lengkap dan mampu menangani kasus tersebut secara komprehensif. Teknik transportasi pasien obstetri dalam kondisi darurat memiliki prinsip khusus untuk memastikan keamanan ibu dan janin. Pemilihan alat transportasi, baik ambulans maupun alat transportasi udara (jika diperlukan), harus memperhatikan kondisi klinis ibu, kebutuhan medis yang spesifik, jarak tempuh, dan aksesibilitas fasilitas rujukan. Selama proses transportasi, posisi pasien harus disesuaikan dengan jenis kegawatdaruratan. Misalnya, pasien dengan perdarahan aktif harus dalam posisi terlentang dengan kaki sedikit lebih tinggi untuk mempertahankan aliran darah menuju organ vital; sedangkan pasien dengan prolaps tali pusat memerlukan posisi knee-chest atau Trendelenburg guna mengurangi tekanan tali pusat. Selama proses ini, perawat harus terus memantau tanda-tanda vital pasien, memberikan intervensi medis yang diperlukan seperti pemberian oksigen tambahan, menjaga akses cairan intravena, serta siap melakukan resusitasi jika terjadi perburukan kondisi mendadak di perjalanan.

Transportasi pasien dalam kondisi obstetri darurat memerlukan koordinasi yang baik antar fasilitas kesehatan dalam suatu sistem rujukan yang efektif. Koordinasi ini merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan proses rujukan pasien. Dalam hal ini, perawat memiliki peran sentral dalam komunikasi antarfasilitas, mencakup penyampaian informasi klinis pasien secara jelas dan akurat kepada fasilitas rujukan sebelum dan selama proses transportasi. Informasi penting yang harus disampaikan mencakup kondisi medis terkini pasien, tindakan stabilisasi yang telah dilakukan, kondisi janin, dan estimasi waktu kedatangan pasien. Koordinasi ini juga memastikan bahwa fasilitas penerima telah siap dengan personel, alat, obat-obatan, dan tindakan medis lanjutan yang diperlukan segera setelah pasien tiba. Melalui komunikasi ini, waktu tunggu dan keterlambatan tindakan medis di fasilitas rujukan dapat diminimalkan secara signifikan.

Selain itu, perawat juga harus memastikan bahwa dokumentasi medis terkait pasien dibuat secara lengkap dan jelas, mencakup catatan observasi selama perjalanan, tindakan yang diberikan, serta kondisi pasien saat diserahkan di fasilitas rujukan. Dokumentasi ini sangat penting untuk memastikan kontinuitas perawatan, evaluasi kualitas pelayanan, serta aspek legal dalam penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri.

Keseluruhan proses stabilisasi, transportasi aman, dan koordinasi antar fasilitas kesehatan dalam sistem rujukan pasien obstetri merupakan aspek penting yang secara langsung berdampak terhadap keselamatan dan hasil akhir yang optimal

bagi ibu maupun janin. Oleh karena itu, kompetensi klinis, keterampilan komunikasi, serta kemampuan koordinasi antarprofesi dalam tim kesehatan merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab perawat dalam memberikan pelayanan obstetri yang berkualitas tinggi pada kondisi kegawatdaruratan. Melalui pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip ini secara baik dan efektif, angka morbiditas serta mortalitas ibu dan janin dalam situasi gawat darurat obstetri dapat diminimalkan secara signifikan.

G. Pendekatan Komunikasi Efektif dalam Kegawatdaruratan Obstetri

Komunikasi efektif merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penanganan kegawatdaruratan obstetri. Dalam kondisi gawat darurat obstetri, suasana emosional yang intens, kecemasan tinggi pasien dan keluarga, serta kebutuhan akan koordinasi tim yang cepat dan akurat menuntut tenaga kesehatan, khususnya perawat, memiliki keterampilan komunikasi yang optimal. Komunikasi yang efektif dalam situasi ini mencakup komunikasi terapeutik yang empatik dan jelas kepada pasien dan keluarga, serta kolaborasi interprofesi yang terorganisasi dengan baik dalam tim obstetri emergensi.

Komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarganya merupakan bagian integral dari asuhan obstetri yang humanis dan profesional. Kondisi kegawatdaruratan obstetri sering kali menyebabkan pasien mengalami kecemasan, stres berat, hingga kebingungan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Oleh karena itu, perawat harus mampu memberikan informasi secara jelas, sederhana, dan akurat tentang kondisi medis pasien, tindakan medis yang akan diambil, tujuan tindakan tersebut, serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. Komunikasi terapeutik ini harus dilakukan dengan pendekatan empatik, penuh perhatian, menjaga kontak mata, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, serta memastikan bahwa pasien maupun keluarga benar-benar memahami informasi yang diberikan. Perawat juga perlu memberi kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya, mengungkapkan perasaan, atau menyampaikan kekhawatiran mereka, sambil secara aktif mendengarkan dan merespons secara empatik serta suportif.

Selain memberikan informasi medis, komunikasi terapeutik juga melibatkan pemberian dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya. Dukungan emosional yang tepat dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan, stres, hingga rasa takut pasien dan keluarga dalam menghadapi situasi kegawatdaruratan. Perawat harus secara terampil mampu menyampaikan pesan yang menenangkan, memberi dorongan, serta menunjukkan sikap percaya diri untuk meyakinkan pasien dan keluarga bahwa tim kesehatan bekerja secara optimal demi keselamatan ibu

dan janin. Dengan pendekatan komunikasi terapeutik ini, pasien dan keluarga dapat lebih tenang, merasa didukung secara psikologis, dan lebih kooperatif terhadap proses tindakan medis yang akan dilakukan.

Selanjutnya, dalam situasi kegawatdaruratan obstetri, kolaborasi interprofesi dalam tim obstetri emergensi merupakan elemen yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan penanganan kondisi darurat. Tim obstetri emergensi biasanya terdiri atas dokter spesialis obstetri-ginekologi, dokter anestesi, dokter umum, perawat, bidan, petugas laboratorium, dan petugas farmasi. Masing-masing anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan efisien. Peran perawat dalam kolaborasi ini sangat strategis, yaitu memastikan informasi klinis pasien disampaikan dengan jelas, koordinasi antaranggota tim berjalan lancar, dan tindakan medis dilakukan secara tepat waktu berdasarkan prioritas yang telah ditentukan bersama.

Kolaborasi interprofesional yang efektif dalam tim obstetri emergensi bergantung pada kemampuan komunikasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu antaranggota tim. Dalam situasi darurat, komunikasi harus singkat, jelas, terarah, dan berbasis data klinis yang objektif. Perawat perlu memiliki keterampilan untuk menyampaikan kondisi pasien secara ringkas dan jelas (SBAR: Situation, Background, Assessment, Recommendation) agar dokter atau anggota tim lainnya dapat segera memahami kondisi pasien dan mengambil keputusan cepat mengenai intervensi yang diperlukan. Selain itu, perawat harus mampu menerima dan mengonfirmasi instruksi dengan jelas, melakukan koordinasi tindakan secara simultan, serta memberikan laporan perkembangan kondisi pasien secara berkala selama proses penanganan kegawatdaruratan berlangsung.

Selain komunikasi yang jelas dan efektif, kolaborasi interprofesi juga memerlukan sikap profesional berupa penghormatan terhadap kompetensi masing-masing anggota tim, keterbukaan terhadap saran atau masukan dari anggota tim lain, serta kemampuan bekerja sama secara harmonis di tengah kondisi tekanan tinggi. Perawat berperan aktif dalam menjaga atmosfer tim tetap kondusif, profesional, serta memfasilitasi penyelesaian konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pendapat tentang penatalaksanaan kasus secara cepat dan bijaksana. Komunikasi terbuka, hormat terhadap kompetensi profesional masing-masing, serta sikap saling percaya antaranggota tim merupakan fondasi yang kuat dalam menciptakan kolaborasi interprofesional yang sukses di lingkungan obstetri emergensi.

Dengan menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif terhadap pasien dan keluarga serta menjaga komunikasi interprofesional yang optimal dalam tim

kegawatdaruratan obstetri, perawat tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi penanganan medis tetapi juga memperkuat dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh pasien dan keluarganya. Pendekatan komunikasi yang efektif ini, secara keseluruhan, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan obstetri emergensi serta menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal.

H. Pencegahan dan Edukasi Kegawatdaruratan Obstetri

Pencegahan dan edukasi dalam kegawatdaruratan obstetri merupakan elemen penting dalam upaya mengurangi angka kejadian komplikasi serius serta menurunkan tingkat morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal. Berbagai komplikasi obstetri seperti perdarahan hebat, preeklamsia dan eklamsia, infeksi, dan kondisi kegawatdaruratan lainnya sering kali dapat dicegah atau setidaknya dideteksi secara dini melalui berbagai strategi pencegahan yang terencana dan edukasi kesehatan yang efektif bagi ibu hamil serta keluarganya.

Strategi pencegahan komplikasi obstetri difokuskan pada identifikasi faktor risiko sejak awal kehamilan, perencanaan kehamilannya secara baik, pemantauan kondisi kesehatan ibu secara rutin selama kehamilan (antenatal care), serta persiapan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai. Salah satu langkah penting dalam strategi pencegahan komplikasi obstetri adalah melakukan pemeriksaan antenatal secara berkala dan teratur sesuai standar yang ditetapkan oleh layanan kesehatan. Selama kunjungan antenatal, tenaga kesehatan termasuk perawat berperan dalam melakukan skrining secara menyeluruh terhadap ibu hamil, seperti pengukuran tekanan darah rutin untuk mendeteksi dini hipertensi gestasional atau preeklamsia, pemeriksaan laboratorium rutin seperti kadar hemoglobin untuk mendeteksi anemia, pemantauan pertumbuhan janin, serta pemantauan tanda-tanda infeksi secara dini. Dengan deteksi dini dan intervensi segera, risiko berkembangnya kondisi gawat darurat obstetri dapat diminimalkan secara signifikan.

Selain pemantauan medis rutin, strategi pencegahan juga mencakup upaya promosi kesehatan melalui edukasi pola hidup sehat selama kehamilan, yang meliputi pemenuhan nutrisi yang adekuat, konsumsi suplemen kehamilan seperti zat besi dan asam folat, aktivitas fisik yang sesuai, serta menghindari perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, atau penggunaan obat-obatan yang tidak dianjurkan. Dalam hal ini, perawat memiliki peran kunci dalam menyampaikan edukasi dan motivasi kepada ibu hamil agar menerapkan gaya hidup sehat selama kehamilan, sehingga risiko komplikasi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang

dapat dicegah seperti anemia, hipertensi, diabetes gestasional, atau infeksi, dapat ditekan seminimal mungkin.

Selanjutnya, aspek penting lain dalam pencegahan kegawatdaruratan obstetri adalah memberikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil dan keluarga mengenai tanda-tanda bahaya selama kehamilan, persalinan, serta masa nifas. Pendidikan kesehatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga untuk mengenali gejala dini komplikasi obstetri, sehingga dapat segera mencari pertolongan medis sebelum kondisi menjadi lebih buruk. Dalam edukasi ini, perawat harus memberikan informasi jelas dan sederhana tentang tanda-tanda bahaya seperti perdarahan per vaginam yang berlebihan, nyeri kepala hebat, pandangan kabur, nyeri perut hebat, kejang-kejang, demam tinggi, pembengkakan ekstremitas yang tiba-tiba, penurunan gerakan janin yang signifikan, serta gejala psikiatri seperti rasa sedih atau cemas berlebihan. Perawat juga harus menjelaskan secara rinci kepada keluarga mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila tanda-tanda bahaya tersebut muncul, seperti segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat tanpa menunda waktu.

Dalam menyampaikan edukasi ini, perawat perlu menggunakan pendekatan yang empatik, memperhatikan tingkat pemahaman ibu dan keluarga, serta menggunakan media yang sesuai seperti poster, leaflet, video, atau demonstrasi langsung. Edukasi yang efektif juga melibatkan interaksi dua arah, di mana ibu dan keluarga dapat bertanya, berdiskusi, serta mengulang kembali informasi yang diberikan sehingga dapat memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar dipahami dengan baik. Perawat juga bertanggung jawab memberikan edukasi mengenai pentingnya merencanakan persalinan di fasilitas kesehatan yang dilengkapi tenaga kesehatan profesional, sehingga jika terjadi kondisi darurat, ibu segera mendapatkan penanganan medis yang memadai tanpa keterlambatan.

Lebih lanjut, edukasi tidak berhenti hanya sampai pada masa kehamilan dan persalinan, tetapi juga harus mencakup masa nifas, di mana risiko komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi, preeklamsia postpartum, atau gangguan psikiatri pascapersalinan masih tinggi. Oleh karena itu, perawat juga perlu memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga terkait pentingnya pemantauan ketat selama masa nifas, mengenali tanda bahaya selama periode tersebut, serta memberikan informasi terkait perawatan diri dan bayi yang baik, seperti perawatan luka jahitan, higiene personal, pola menyusui yang efektif, serta dukungan psikologis yang diperlukan agar ibu dapat pulih secara optimal baik secara fisik maupun emosional.

Dengan pendekatan edukasi yang komprehensif dan strategi pencegahan yang terencana dengan baik, risiko terjadinya kegawatdaruratan obstetri dapat diminimalkan secara signifikan. Perawat sebagai bagian integral dari tim kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa edukasi kesehatan ini

berjalan efektif, berkelanjutan, serta mampu memberdayakan ibu dan keluarganya agar memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi sepanjang periode kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Melalui pendekatan ini, angka kejadian komplikasi berat dalam bidang obstetri dapat diturunkan, kualitas pelayanan kesehatan maternal-perinatal dapat ditingkatkan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak secara keseluruhan.

I. Aspek Etik dan Hukum dalam Kegawatdaruratan Obstetri

Aspek etik dan hukum memiliki peranan penting dalam setiap situasi kegawatdaruratan obstetri, karena melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks serta tindakan medis yang bersifat segera dan kritis. Kondisi kegawatdaruratan obstetri tidak jarang menimbulkan dilema etik, terutama ketika melibatkan keputusan tentang intervensi medis yang berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu atau janin. Di sisi lain, setiap tindakan medis dalam situasi ini juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan khususnya perawat, harus memahami dengan baik prinsip-prinsip etik dalam pengambilan keputusan darurat serta implikasi hukum atas tindakan emergensi dalam praktik keperawatan obstetri.

Pertimbangan etik dalam keputusan gawat darurat obstetri didasarkan pada prinsip dasar bioetika, yang terdiri atas beneficence (melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan pasien), non-maleficence (tidak merugikan pasien), autonomy (menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan), serta justice (adil dalam memberikan pelayanan kesehatan). Dalam konteks obstetri gawat darurat, tenaga kesehatan termasuk perawat sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut, terutama ketika kondisi pasien sangat mendesak, situasi klinis cepat berubah, dan waktu pengambilan keputusan yang sangat terbatas.

Salah satu dilema etik yang sering muncul dalam kegawatdaruratan obstetri adalah terkait prinsip otonomi pasien. Idealnya, setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan pasien atau keluarganya. Namun, dalam kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa, prinsip beneficence (berbuat yang terbaik demi keselamatan ibu dan janin) sering kali lebih diutamakan. Dalam kondisi darurat, perawat dan tim kesehatan mungkin harus mengambil tindakan cepat tanpa sempat melakukan diskusi atau mendapatkan informed consent secara formal dari pasien atau keluarganya. Dalam hal ini, perawat harus dapat menjelaskan dengan jelas kepada keluarga bahwa tindakan yang dilakukan adalah demi kepentingan terbaik pasien. Setelah situasi stabil, perawat dan tim medis wajib memberikan penjelasan

rinci dan lengkap mengenai tindakan yang telah dilakukan untuk memastikan pasien maupun keluarga memahami alasan serta tujuan intervensi yang telah diberikan.

Perawat juga harus secara sensitif mempertimbangkan kondisi khusus seperti ketika terdapat perbedaan pendapat antara pasien dan keluarga tentang keputusan medis yang akan diambil. Dalam situasi seperti ini, pendekatan komunikasi yang empatik, penuh perhatian, dan bijaksana menjadi sangat penting guna mencapai keputusan yang paling sesuai dengan kondisi klinis pasien, dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya, keyakinan pribadi, dan preferensi pasien maupun keluarga. Konsultasi kepada komite etik rumah sakit atau pimpinan klinis dapat pula menjadi salah satu pendekatan yang efektif jika diperlukan dalam menghadapi dilema etik yang kompleks.

Di sisi lain, implikasi legal dalam tindakan emergensi keperawatan obstetri juga sangat penting untuk diperhatikan. Setiap tindakan medis atau keperawatan yang dilakukan dalam situasi gawat darurat harus sesuai dengan standar praktik klinis yang berlaku. Tindakan medis emergensi yang tidak sesuai prosedur, terlambat, atau tidak berdasarkan standar klinis yang jelas dapat berisiko menyebabkan tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perawat harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam kondisi darurat obstetri didasarkan pada pedoman klinis yang sudah disepakati secara profesional dan telah terbukti keamanannya.

Secara hukum, perawat harus memahami bahwa dalam situasi darurat yang bersifat kritis, tindakan medis yang segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dianggap sah secara hukum, bahkan jika persetujuan formal belum sempat diperoleh. Kondisi ini dikenal dengan prinsip *emergency consent*, yaitu persetujuan yang dianggap tersirat dalam situasi yang mengancam nyawa, di mana tindakan segera harus dilakukan untuk mencegah cedera serius atau kematian. Meski demikian, setelah tindakan selesai dilakukan, perawat dan tim medis wajib mendokumentasikan secara lengkap dan jelas setiap tindakan yang dilakukan, beserta alasan-alasan medis yang mendasari keputusan tersebut. Dokumentasi medis ini akan menjadi bukti hukum yang kuat jika kemudian muncul pertanyaan atau tuntutan terkait tindakan medis yang diambil dalam situasi darurat.

Perawat juga harus memperhatikan pentingnya komunikasi efektif dengan pasien dan keluarganya pascatindakan emergensi, guna memastikan mereka benar-benar memahami kondisi klinis, tindakan yang telah diberikan, serta kemungkinan risiko yang terjadi akibat tindakan tersebut. Hal ini penting dilakukan tidak hanya dari sisi etik tetapi juga sebagai bentuk perlindungan secara hukum bagi tenaga kesehatan. Transparansi dalam komunikasi, pendokumentasian yang teliti, serta

kepatuhan terhadap standar praktik klinis merupakan kunci utama untuk mengurangi risiko implikasi hukum dalam pelayanan kesehatan obstetri emergensi.

J. Simpulan

Kegawatdaruratan obstetri merupakan kondisi serius yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada masa kehamilan, persalinan, hingga periode nifas, yang berisiko tinggi menyebabkan morbiditas atau mortalitas maternal dan perinatal jika tidak segera ditangani dengan tepat. Penanganan yang efektif terhadap kondisi ini memerlukan kemampuan identifikasi dini, penilaian klinis cepat dan akurat, serta tindakan intervensi yang sesuai standar klinis terkini oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat.

Perawat memainkan peran sentral yang sangat krusial dalam manajemen kegawatdaruratan obstetri, mulai dari melakukan identifikasi awal tanda bahaya melalui pendekatan ABCDE, hingga menjalankan berbagai intervensi kritis seperti stabilisasi pasien, pemberian terapi cairan dan obat-obatan, serta memastikan transportasi pasien yang aman ke fasilitas rujukan. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab dalam aspek komunikasi terapeutik kepada pasien dan keluarga, serta kolaborasi interprofesional yang efektif dalam tim kegawatdaruratan obstetri.

Selama masa kehamilan, penatalaksanaan kegawatdaruratan difokuskan pada kondisi-kondisi seperti hiperemesis gravidarum akut, preeklamsia berat dan eklamsia, perdarahan antepartum akibat placenta previa atau solusio plasenta, serta kehamilan ektopik terganggu. Dalam persalinan, kondisi kritis seperti distosia bahu, prolaps tali pusat, ruptura uteri, dan emboli air ketuban menuntut tindakan medis dan keperawatan cepat serta terkoordinasi dengan baik. Sedangkan pada masa nifas, perawat harus mewaspadaikan perdarahan postpartum, infeksi berat, preeklamsia postpartum, hingga gangguan psikiatri akut, yang juga memerlukan penanganan segera guna mencegah komplikasi fatal.

Lebih lanjut, aspek pencegahan dan edukasi sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya komplikasi obstetri. Edukasi kesehatan kepada ibu hamil dan keluarga terkait tanda bahaya serta penerapan pola hidup sehat selama kehamilan secara nyata mampu menurunkan angka kejadian kegawatdaruratan. Perawat sebagai garda terdepan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi pencegahan dan edukasi kesehatan disampaikan secara efektif.

Di sisi lain, setiap tindakan medis dalam situasi kegawatdaruratan obstetri memiliki dimensi etik dan hukum yang signifikan. Perawat harus mampu mengambil keputusan yang mengacu pada prinsip bioetika yaitu beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. Implikasi hukum juga perlu diperhatikan dengan memastikan

semua tindakan medis dilakukan sesuai standar klinis, terdokumentasi dengan baik, serta dikomunikasikan secara transparan kepada pasien dan keluarga, untuk mengurangi risiko tuntutan hukum.

K. Referensi

- Ariyanti, N., & Wijaya, S. (2020). Manajemen kegawatdaruratan obstetri: Konsep dan penerapan klinis. Jakarta: Pustaka Medika.
- Budiarti, R., & Hasibuan, D. (2019). Triage dan penilaian cepat dalam obstetri akut. *Jurnal Keperawatan Maternal*, 13(2), 45–54.
- Cahyono, E., & Pranoto, A. (2021). Penatalaksanaan kondisi obstetri selama kehamilan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dewi, L. K. (2022). Kegawatdaruratan persalinan: Distosia bahu sampai emboli air ketuban. Surakarta: UNS Press.
- Fauziah, Y., & Setiawan, H. (2018). Komplikasi masa nifas dan penatalaksanaannya. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Gunawan, T. (2023). Stabilisasi dan transportasi pasien obstetri dalam kondisi darurat. *Jurnal Transportasi Kesehatan*, 8(1), 12–23.
- Heryanto, A., & Putri, I. (2020). Pencegahan dan edukasi kegawatdaruratan obstetri: Strategi praktis. Bandung: Refika Aditama.
- Iskandar, M., & Sari, P. (2021). Komunikasi efektif dalam situasi obstetri emergensi. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 9(3), 78–87.
- Juwita, R., & Kartini, S. (2019). Aspek etika dan hukum dalam praktek kegawatdaruratan obstetri. *Jurnal Etika Kedokteran*, 5(4), 102–110.

L. Glosarium

ABCDE: Pendekatan sistematis untuk mengevaluasi kondisi pasien dalam kegawatdaruratan, meliputi jalan napas (Airway), pernapasan (Breathing), sirkulasi (Circulation), status neurologis (Disability), dan pemeriksaan menyeluruh (Exposure).

Atonia Uteri: Kondisi lemahnya kontraksi otot rahim setelah persalinan yang menyebabkan perdarahan postpartum.

Distosia Bahu (Shoulder Dystocia): Kondisi darurat saat persalinan, di mana bahu janin terjebak di belakang tulang pubis ibu setelah kepala dilahirkan.

Edukasi Kesehatan: Proses penyampaian informasi kepada pasien dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kondisi kesehatan dan tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan.

Eklampsia: Komplikasi serius dari preeklampsia yang ditandai dengan terjadinya kejang pada wanita hamil, saat bersalin, atau masa nifas.

Emboli Air Ketuban (Amniotic Fluid Embolism): Kondisi langka dan fatal ketika cairan ketuban masuk ke pembuluh darah ibu, menyebabkan gangguan sirkulasi dan koagulasi berat.

Emergency Consent: Persetujuan tindakan medis yang dianggap tersirat dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ketika persetujuan formal tidak sempat diperoleh.

Endometritis: Infeksi rahim yang sering terjadi setelah persalinan, ditandai dengan demam, nyeri abdomen, serta keputihan abnormal.

Hipoksia Janin: Kekurangan oksigen pada janin akibat berbagai komplikasi, seperti prolaps tali pusat, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen atau kematian janin.

Hiperemesis Gravidarum: Mual dan muntah berlebihan selama kehamilan yang menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan penurunan nutrisi signifikan.

Informed Consent: Persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

Komunikasi Terapeutik: Metode komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga yang dilakukan secara empatik, jelas, dan efektif untuk mendukung proses pengobatan dan mengurangi kecemasan.

Koordinasi Antarfasilitas: Proses komunikasi dan kerja sama antar lembaga pelayanan kesehatan dalam menangani pasien yang memerlukan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Manuver McRoberts: Tindakan sederhana pada kasus distosia bahu dengan menekuk lutut ibu ke arah dada untuk mempermudah pelepasan bahu janin.

Penilaian Cepat (Triage Obstetri): Metode untuk mengklasifikasikan pasien berdasarkan tingkat urgensi kondisi medis yang dialami guna menentukan prioritas penanganan.

Perdarahan Antepartum: Perdarahan yang terjadi selama kehamilan sebelum proses persalinan, seperti pada placenta previa atau solusio plasenta.

Perdarahan Postpartum: Kehilangan darah berlebihan setelah persalinan, biasanya melebihi 500 ml pada persalinan normal atau 1000 ml pada operasi sesar.

Preeklampsia: Kondisi hipertensi serius pada kehamilan yang disertai proteinuria dan risiko komplikasi organ serta neurologis.

Prinsip Bioetika: Prinsip dasar etika dalam pelayanan medis yang terdiri atas beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), autonomy (menghormati hak pasien), dan justice (keadilan).

Prolaps Tali Pusat: Kondisi darurat saat tali pusat keluar mendahului atau bersamaan dengan janin sehingga mengalami tekanan dan gangguan aliran darah ke janin.

Ruptur Uteri: Robekan pada dinding rahim yang terjadi secara spontan atau akibat intervensi medis, menimbulkan risiko perdarahan dan komplikasi serius.

Sepsis Puerperalis: Infeksi sistemik berat yang terjadi pada masa nifas dengan gejala demam tinggi, takikardia, dan risiko gagal organ multipel.

Stabilisasi Pasien: Proses tindakan medis untuk menjaga atau mengembalikan kestabilan kondisi vital pasien sebelum tindakan lanjutan atau transportasi ke fasilitas rujukan.

Syok Hipovolemik: Kondisi darurat medis akibat kehilangan darah atau cairan tubuh yang signifikan sehingga menyebabkan gangguan sirkulasi dan risiko kerusakan organ vital.

Toksisitas Magnesium: Efek samping yang dapat terjadi akibat pemberian magnesium sulfat secara berlebihan, berupa gangguan pernapasan dan penurunan refleks tendon.

Transportasi Aman Pasien: Proses pemindahan pasien dari satu fasilitas ke fasilitas lain dengan memperhatikan aspek keselamatan pasien dan mempertahankan stabilitas kondisi klinisnya.

Uterotonika: Obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan kontraksi rahim guna menghentikan atau mencegah perdarahan postpartum.

CHAPTER 5

MANAJEMEN NYERI DALAM PERSALINAN

Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep.Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Nyeri dalam persalinan adalah sebuah pengalaman sensoris dan emosional yang kompleks serta sangat subjektif, yang dialami oleh ibu selama proses melahirkan. Konsep nyeri dalam persalinan sendiri mencakup berbagai dimensi, mulai dari aspek fisiologis, emosional, hingga psikologis. Secara fisiologis, nyeri persalinan muncul akibat rangsangan nyeri yang ditimbulkan oleh kontraksi rahim, pembukaan serviks, peregangan jaringan otot dan ligamen pelvis, serta tekanan yang disebabkan oleh pergerakan janin melalui jalan lahir. Intensitas nyeri tersebut dapat berbeda-beda antara satu ibu dengan ibu lainnya, tergantung dari berbagai faktor seperti persepsi individu terhadap nyeri, tingkat kesiapan mental, dukungan sosial, pengalaman persalinan sebelumnya, dan kondisi fisik ibu secara umum.

Konsep nyeri persalinan juga erat kaitannya dengan aspek psikologis dan emosional seorang ibu. Nyeri yang intens selama persalinan tidak hanya menyebabkan rasa tidak nyaman secara fisik, tetapi juga bisa menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan stres emosional yang signifikan. Hal ini karena nyeri persalinan tidak hanya sebatas sensasi fisik, namun juga melibatkan respon emosional ibu terhadap pengalaman yang sedang dialaminya. Banyak ibu yang menggambarkan nyeri persalinan sebagai nyeri yang sangat berat dan melelahkan, namun beberapa di antaranya juga menganggapnya sebagai bagian alami dari proses melahirkan yang harus diterima dan dilalui dengan sabar dan penuh kesadaran.

Mengelola nyeri selama persalinan adalah hal yang sangat penting karena nyeri yang tidak tertangani dengan baik dapat memberikan dampak negatif yang luas terhadap kondisi ibu maupun janin. Nyeri persalinan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ibu mengalami kelelahan ekstrem, hiperventilasi, dan bahkan gangguan sirkulasi darah, yang semuanya dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janin. Di samping itu, nyeri persalinan yang tidak ditangani secara efektif juga berpotensi menyebabkan gangguan psikologis jangka panjang seperti trauma persalinan, kecemasan pascapersalinan, hingga depresi postpartum. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memahami

dengan baik konsep dasar mengenai nyeri persalinan agar mampu memberikan penanganan yang optimal.

Manajemen nyeri persalinan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses persalinan secara keseluruhan. Pengelolaan nyeri persalinan yang tepat bertujuan untuk mengurangi sensasi nyeri hingga tingkat yang dapat ditoleransi oleh ibu, sambil tetap mempertahankan proses persalinan berlangsung secara alami dan aman. Dengan nyeri yang dapat dikontrol dengan baik, ibu akan merasa lebih nyaman, tenang, dan percaya diri selama proses melahirkan. Ini akan membantu meningkatkan kemampuan ibu dalam berpartisipasi aktif selama persalinan, misalnya dengan menerapkan teknik pernapasan yang benar, mengatur posisi tubuh, serta bekerja sama dengan tim medis.

Selain itu, manajemen nyeri yang efektif juga mendukung proses persalinan yang lebih lancar karena ibu cenderung lebih rileks, sehingga kontraksi uterus menjadi lebih efektif dan pembukaan serviks dapat berlangsung lebih optimal. Di sisi lain, dengan manajemen nyeri yang baik, stres fisik maupun emosional yang dialami ibu dapat diminimalisir sehingga membantu mengurangi risiko komplikasi seperti hipertensi selama persalinan, gangguan pola denyut jantung janin, hingga kemungkinan intervensi medis yang tidak perlu seperti tindakan operasi caesar darurat akibat distosia (persalinan macet).

Pentingnya manajemen nyeri persalinan juga terletak pada aspek emosional dan psikologis yang dirasakan oleh ibu. Ketika nyeri persalinan ditangani secara baik, ibu akan mengalami persalinan yang lebih positif, memuaskan, dan kurang traumatis. Ini secara signifikan meningkatkan pengalaman persalinan secara keseluruhan dan mendukung kondisi mental ibu setelah melahirkan. Ibu yang memiliki pengalaman positif selama persalinan juga cenderung memiliki hubungan emosional yang lebih baik dengan bayinya, serta mampu pulih lebih cepat baik secara fisik maupun mental pada masa nifas.

Oleh sebab itu, tenaga kesehatan khususnya perawat perlu memahami secara komprehensif konsep nyeri persalinan dan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang baik mengenai berbagai metode manajemen nyeri yang tersedia, baik metode nonfarmakologis maupun farmakologis. Dengan demikian, mereka dapat memberikan dukungan terbaik kepada ibu selama proses persalinan agar ibu merasa aman, nyaman, dan terkontrol, serta menghasilkan pengalaman persalinan yang positif dan aman bagi ibu maupun bayi.

B. Fisiologi Nyeri dalam Persalinan

Nyeri persalinan merupakan respons fisiologis tubuh terhadap proses kompleks yang terjadi selama persalinan. Pemahaman tentang fisiologi nyeri persalinan sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, agar dapat menentukan metode pengelolaan yang paling efektif dalam meredakan rasa nyeri yang dialami ibu selama persalinan. Dalam memahami fisiologi nyeri ini, terdapat dua aspek penting yang perlu dibahas secara mendalam, yakni mekanisme terjadinya nyeri persalinan dan berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri pada ibu bersalin.

Nyeri dalam persalinan terjadi melalui mekanisme kompleks yang melibatkan rangsangan fisik pada jaringan tubuh dan pengiriman impuls nyeri ke otak. Secara fisiologis, mekanisme terjadinya nyeri persalinan berhubungan erat dengan tahapan proses persalinan itu sendiri. Pada tahap pertama persalinan, nyeri utamanya disebabkan oleh adanya kontraksi uterus yang semakin kuat, serta dilatasi atau pembukaan serviks yang progresif. Kontraksi yang berulang dan intens menyebabkan iskemia otot rahim karena adanya penurunan aliran darah lokal, yang kemudian menimbulkan rasa nyeri hebat. Selain itu, pembukaan serviks menstimulasi reseptor nyeri yang terdapat pada jaringan serviks dan segmen bawah uterus. Impuls nyeri yang dihasilkan oleh stimulasi ini kemudian dihantarkan melalui serabut saraf viseral, khususnya serabut saraf aferen dari segmen torakal bawah hingga lumbal atas (T10–L1), menuju sumsum tulang belakang lalu dilanjutkan ke pusat nyeri di otak.

Pada tahap kedua persalinan, nyeri yang dirasakan berubah karakter menjadi lebih tajam dan terlokalisasi di area perineum, vagina, dan anus. Hal ini terjadi karena kepala janin turun memasuki jalan lahir, menekan jaringan pelvis, ligamen, otot, fascia, dan perineum yang kaya akan reseptor nyeri. Impuls nyeri pada tahap ini dihantarkan melalui saraf somatik, khususnya melalui saraf pudendus (S2–S4), yang menyalurkan informasi sensori secara cepat dan lebih terlokalisasi. Nyeri pada tahap ini sering digambarkan sebagai rasa panas, terbakar, atau robekan yang intens akibat peregangan jaringan-jaringan tersebut. Dengan demikian, nyeri persalinan merupakan gabungan dari nyeri viseral yang bersifat lebih dalam dan difus, serta nyeri somatik yang tajam, intens, dan spesifik.

Persepsi nyeri yang dialami oleh ibu bersalin tidak hanya dipengaruhi oleh proses fisiologis semata, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang sifatnya sangat individual. Persepsi nyeri merupakan pengalaman subjektif yang dapat sangat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, bahkan dalam kondisi yang relatif sama. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi persepsi nyeri adalah kesiapan psikologis ibu dalam menghadapi persalinan. Ibu yang memiliki persiapan

mental yang baik, misalnya dengan memahami proses persalinan serta teknik-teknik manajemen nyeri secara tepat, cenderung memiliki persepsi nyeri yang lebih terkendali dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki persiapan yang memadai. Sebaliknya, rasa takut, cemas, atau stres berlebihan dapat memperkuat persepsi nyeri karena kondisi psikologis tersebut meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri dan mengurangi ambang toleransi ibu terhadap rasa sakit.

Selain aspek psikologis, faktor fisiologis seperti tingkat kebugaran fisik ibu, kondisi kesehatan secara umum, usia ibu, serta ada atau tidaknya komplikasi kehamilan juga turut berpengaruh terhadap persepsi nyeri. Ibu yang memiliki kondisi fisik prima dengan otot-otot yang lebih kuat, fleksibel, dan memiliki daya tahan fisik yang baik umumnya mampu menghadapi nyeri persalinan dengan lebih baik dibandingkan ibu yang secara fisik kurang prima atau mengalami kondisi kehamilan yang kompleks.

Pengalaman sebelumnya dalam persalinan juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi persepsi nyeri seorang ibu. Ibu yang memiliki pengalaman positif dalam persalinan sebelumnya, umumnya memiliki persepsi nyeri yang lebih ringan atau terkontrol dibandingkan ibu yang pernah mengalami trauma atau pengalaman negatif dalam persalinan sebelumnya. Selain itu, dukungan sosial selama proses persalinan, seperti kehadiran suami, keluarga, atau petugas kesehatan yang memberikan dukungan emosional, dapat mengurangi intensitas persepsi nyeri dengan cara meningkatkan rasa aman, nyaman, dan percaya diri ibu.

Selanjutnya, budaya dan kepercayaan ibu terhadap nyeri persalinan turut mempengaruhi cara ibu mempersepsikan nyeri. Beberapa budaya melihat nyeri persalinan sebagai proses alami yang harus diterima tanpa intervensi, sementara budaya lain memandang nyeri sebagai sesuatu yang perlu segera dikontrol. Ibu yang berasal dari budaya yang menerima nyeri sebagai bagian alami cenderung memiliki persepsi yang lebih toleran terhadap nyeri dibandingkan dengan ibu yang menganggap nyeri sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari.

C. Penilaian Nyeri dalam Persalinan

Penilaian nyeri dalam proses persalinan adalah suatu langkah esensial yang wajib dilakukan secara rutin oleh tenaga kesehatan, terutama perawat. Penilaian ini merupakan fondasi penting dalam merencanakan intervensi pengelolaan nyeri yang efektif. Secara khusus, penilaian nyeri bertujuan untuk mengidentifikasi intensitas nyeri yang dirasakan oleh ibu bersalin, mengukur tingkat kenyamanan ibu, mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan, serta memberikan dasar untuk penyesuaian tindakan lebih lanjut. Dalam hal ini, pemahaman tentang metode dan alat penilaian nyeri, serta strategi penilaian yang tepat pada berbagai fase

persalinan, menjadi bagian integral dari manajemen nyeri persalinan yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan individu ibu bersalin.

Metode penilaian nyeri persalinan secara umum terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan subjektif dan objektif. Pendekatan subjektif mengacu pada penilaian berdasarkan pengungkapan pengalaman nyeri yang dialami langsung oleh ibu. Salah satu contoh yang paling banyak digunakan adalah metode skala nyeri, seperti skala numerik (Numerical Rating Scale/NRS), skala verbal (Verbal Rating Scale/VRS), dan skala wajah (Wong-Baker Faces Pain Rating Scale). Skala numerik biasanya meminta ibu untuk menilai intensitas nyeri yang dirasakan dalam rentang angka 0 sampai 10, dengan angka 0 menunjukkan tidak ada nyeri, dan angka 10 menunjukkan nyeri terburuk yang pernah dirasakan. Skala wajah menggunakan ekspresi wajah yang menggambarkan intensitas nyeri, mulai dari ekspresi bahagia tanpa nyeri hingga ekspresi wajah menangis yang menunjukkan nyeri hebat. Metode ini sangat berguna terutama jika ibu mengalami kesulitan dalam mengungkapkan tingkat nyeri melalui angka atau kata-kata, seperti ibu dengan tingkat pendidikan rendah, hambatan bahasa, atau ibu yang berada dalam kondisi emosional sangat tinggi.

Selain pendekatan subjektif, pendekatan objektif juga diperlukan terutama pada kondisi di mana ibu sulit atau tidak mampu menyampaikan persepsi nyerinya secara verbal. Pendekatan ini didasarkan pada observasi klinis terhadap tanda fisiologis dan perilaku nyeri. Tanda fisiologis meliputi peningkatan denyut nadi, tekanan darah, pernapasan cepat atau pendek, pucat, berkeringat, dan ekspresi wajah yang menunjukkan ketegangan atau distress. Sedangkan tanda perilaku dapat meliputi erangan, tangisan, menggenggam erat tangan pendamping, postur tubuh tertentu yang menunjukkan nyeri hebat, serta gerakan tubuh yang tidak terkontrol. Penggunaan alat penilaian objektif, seperti Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI) atau Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT), dapat membantu perawat mendapatkan gambaran nyeri secara komprehensif dalam situasi tersebut.

Setelah memilih metode dan alat penilaian yang tepat, strategi penilaian nyeri harus disesuaikan dengan fase persalinan yang sedang berlangsung. Proses persalinan terdiri dari beberapa fase yang memiliki karakteristik nyeri yang berbeda, yakni fase laten, fase aktif, dan fase transisi pada kala pertama, serta fase kala dua persalinan.

Pada fase laten (awal persalinan), nyeri biasanya masih relatif ringan hingga sedang, seringkali bersifat intermiten, tidak terlalu intens, serta mudah dikontrol oleh ibu melalui metode sederhana seperti relaksasi, pernapasan teratur, dan distraksi. Pada fase ini, strategi penilaian nyeri lebih berfokus pada pengukuran secara subjektif melalui wawancara ringan dengan ibu tentang persepsi nyeri,

intensitas, lokasi, dan bagaimana nyeri tersebut mempengaruhi aktivitas dan kenyamanan. Penilaian juga dilakukan secara berkala setiap 30 hingga 60 menit tergantung kebutuhan, agar dapat memantau perubahan intensitas nyeri secara tepat.

Memasuki fase aktif persalinan, intensitas nyeri meningkat secara signifikan akibat kontraksi uterus yang lebih kuat, lama, dan teratur, serta dilatasi serviks yang progresif. Pada tahap ini, strategi penilaian nyeri menjadi lebih intensif dan dilakukan secara lebih teratur, misalnya setiap 15 hingga 30 menit. Penilaian melibatkan kombinasi antara metode subjektif seperti penggunaan skala numerik atau wajah, dengan metode objektif melalui observasi tanda-tanda fisiologis seperti denyut jantung, tekanan darah, pola pernapasan, ekspresi wajah, dan perilaku ibu selama kontraksi. Perawat juga perlu melakukan observasi secara kontinu terhadap perubahan pola kontraksi uterus dan progres pembukaan serviks yang berkaitan erat dengan intensitas nyeri yang dirasakan.

Fase transisi merupakan periode yang paling intens dalam proses persalinan kala pertama, di mana ibu mengalami kontraksi yang sangat kuat, frekuensi tinggi, serta durasi yang panjang. Pada fase ini, nyeri seringkali mencapai puncaknya sehingga ibu menunjukkan respon fisiologis dan emosional yang sangat kuat seperti rasa takut, panik, dan gelisah. Strategi penilaian nyeri pada fase ini harus dilakukan secara ketat dan kontinu setiap 10 hingga 15 menit, dengan penekanan pada observasi objektif. Komunikasi verbal dengan ibu harus tetap dilakukan dengan cara sederhana dan suportif untuk mengukur tingkat persepsi subjektifnya tanpa meningkatkan stres tambahan.

Pada kala dua persalinan atau fase mengejan, nyeri menjadi sangat terfokus pada area perineum, vagina, dan rektum karena kepala bayi mulai meregangkan jaringan lunak di daerah tersebut. Strategi penilaian nyeri pada tahap ini berfokus pada kombinasi penilaian nyeri subjektif, observasi tanda objektif seperti ekspresi wajah, respon ibu terhadap bimbingan mengejan, serta komunikasi verbal singkat tentang intensitas nyeri yang dirasakan. Pada tahap ini, perawat juga harus mempertimbangkan kebutuhan tambahan seperti analgesik lokal, teknik relaksasi khusus, atau pendekatan lain untuk membantu ibu melewati fase ini dengan nyaman dan aman.

D. Metode Nonfarmakologis dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Metode nonfarmakologis dalam manajemen nyeri persalinan merupakan pendekatan alami yang bertujuan mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis, serta memberdayakan ibu agar mampu menjalani proses persalinan dengan lebih positif. Metode ini diminati karena minim efek

samping dan mampu memberikan manfaat holistik, termasuk penguatan dukungan emosional dan rasa percaya diri ibu dalam menghadapi proses melahirkan. Ada beberapa metode nonfarmakologis yang secara luas digunakan dalam praktik klinis, seperti teknik relaksasi dan pernapasan, aromaterapi dan terapi musik, hypnobirthing dan meditasi, terapi sentuhan dan pemijatan, hidroterapi, serta penggunaan posisi dan mobilisasi aktif. Setiap metode ini memiliki keunggulan serta pendekatan tersendiri dalam mengelola nyeri persalinan secara efektif.

Teknik relaksasi dan pernapasan merupakan metode nonfarmakologis dasar yang paling sering diterapkan dalam manajemen nyeri persalinan. Teknik ini berfokus pada penggunaan pola pernapasan khusus, seperti pernapasan lambat dan dalam, pernapasan ritmik, serta pernapasan berpola yang membantu ibu untuk lebih tenang dan rileks selama kontraksi berlangsung. Relaksasi ini berfungsi mengurangi ketegangan otot, menurunkan hormon stres, serta meningkatkan kadar hormon endorfin yang secara alami membantu meredakan rasa nyeri. Selain itu, teknik ini juga meningkatkan oksigenasi jaringan, membantu ibu lebih fokus, serta meningkatkan kontrol diri sehingga proses persalinan terasa lebih nyaman dan terkendali. Perawat atau bidan berperan penting dalam membimbing ibu menguasai teknik pernapasan sejak fase awal persalinan hingga fase mengejan agar ibu lebih siap secara fisik maupun mental.

Aromaterapi dan terapi musik adalah dua metode sensoris yang banyak digunakan untuk menciptakan lingkungan persalinan yang nyaman dan santai. Aromaterapi melibatkan penggunaan minyak esensial alami seperti lavender, peppermint, chamomile, atau lemon yang dihirup atau diaplikasikan secara topikal dalam bentuk pijatan. Aroma tertentu memiliki efek terapeutik yang mampu meredakan kecemasan, membantu relaksasi otot, serta mengurangi persepsi nyeri secara psikologis. Di sisi lain, terapi musik menggunakan suara atau musik yang disukai ibu untuk menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Musik dapat mengalihkan perhatian ibu dari rasa nyeri serta menurunkan stres dan kecemasan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi hormon endorfin sebagai analgesik alami tubuh.

Metode hypnobirthing dan meditasi merupakan pendekatan psikologis yang semakin populer dalam mengelola nyeri persalinan secara alami. Hypnobirthing adalah teknik khusus yang mengombinasikan relaksasi mendalam dengan sugesti positif melalui praktik hipnosis ringan yang dipandu oleh tenaga terlatih. Teknik ini bertujuan mengubah persepsi negatif ibu terhadap nyeri persalinan menjadi pengalaman positif yang tenang, nyaman, serta minim rasa takut. Sementara meditasi melibatkan praktik mindfulness atau kesadaran penuh di mana ibu belajar mengelola nyeri dengan menerima sensasi yang muncul tanpa penilaian negatif.

Melalui meditasi, ibu mampu meningkatkan kendali emosi, mengurangi kecemasan, serta menenangkan pikiran, yang secara signifikan dapat menurunkan intensitas nyeri selama proses persalinan.

Terapi sentuhan dan pijatan (massage) merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam mengurangi nyeri fisik selama persalinan. Sentuhan lembut yang konsisten, seperti pijatan ringan pada punggung bawah, bahu, kaki, atau tangan ibu, dapat membantu melepaskan ketegangan otot, memperlancar sirkulasi darah, dan mengurangi persepsi nyeri. Pijatan juga memiliki efek menenangkan secara emosional karena sentuhan manusiawi membantu ibu merasa didukung, dihargai, serta tidak merasa sendirian dalam menghadapi rasa nyeri yang dirasakan. Tenaga kesehatan, pendamping persalinan, atau keluarga ibu dapat melakukan pijatan ini secara bergantian, menyesuaikan dengan kebutuhan serta kenyamanan ibu selama berlangsungnya kontraksi.

Terapi air atau hidroterapi merupakan metode nonfarmakologis yang populer karena efek relaksasi yang kuat dalam mengatasi nyeri persalinan. Penggunaan air hangat selama persalinan, baik melalui mandi shower atau berendam dalam bak khusus (birthing pool), dapat memberikan efek analgesik yang signifikan karena air hangat membantu mengurangi tekanan gravitasi pada sendi dan otot, meningkatkan relaksasi otot, serta menstimulasi pelepasan hormon endorfin alami. Ibu yang menjalani hidroterapi seringkali merasakan pengurangan nyeri yang nyata, peningkatan mobilitas, serta kenyamanan fisik yang lebih tinggi selama kontraksi berlangsung. Namun, penting bagi perawat atau tenaga kesehatan untuk selalu memonitor kondisi ibu dan janin secara ketat selama ibu berada dalam air untuk memastikan keselamatan dan keamanan persalinan.

Penggunaan posisi dan mobilisasi aktif juga merupakan komponen penting dari metode nonfarmakologis dalam manajemen nyeri persalinan. Berbeda dengan posisi berbaring terlentang yang cenderung meningkatkan intensitas nyeri dan memperlambat proses persalinan, posisi vertikal seperti duduk, berdiri, berjongkok, atau menggunakan bola persalinan membantu mempercepat turunnya kepala bayi, meningkatkan efisiensi kontraksi, serta mengurangi tekanan nyeri di area punggung dan panggul. Mobilisasi aktif selama persalinan seperti berjalan-jalan singkat, gerakan menggoyangkan pinggul, atau melakukan gerakan lembut, mampu meredakan nyeri dengan merangsang pelepasan hormon endorfin serta membantu ibu merasa lebih nyaman dan terkendali dalam menjalani proses persalinan. Perawat dan bidan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi serta mendampingi ibu memilih posisi yang paling nyaman sesuai dengan fase persalinan yang sedang berlangsung.

E. Metode Farmakologis dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Metode farmakologis dalam manajemen nyeri persalinan merupakan pendekatan medis yang menggunakan obat-obatan tertentu untuk secara efektif mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri selama proses persalinan. Pendekatan ini biasanya dipilih ketika nyeri persalinan mencapai intensitas tinggi atau ketika ibu memerlukan metode tambahan selain teknik nonfarmakologis. Metode farmakologis secara umum dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu analgesia sistemik, analgesia regional, dan analgesia inhalasi. Pemilihan jenis analgesia ini bergantung pada kondisi klinis ibu dan janin, fase persalinan, ketersediaan fasilitas, preferensi ibu, serta penilaian tim medis yang menangani persalinan.

Analgesia sistemik adalah metode pengelolaan nyeri persalinan yang menggunakan obat analgesik yang masuk ke dalam aliran darah sehingga mempengaruhi seluruh tubuh. Analgesia ini umumnya terdiri dari dua jenis utama, yaitu analgesik opioid dan non-opioid. Analgesik opioid, seperti petidin, morfin, atau fentanyl, merupakan obat yang paling sering digunakan karena efektivitasnya dalam mengurangi intensitas nyeri yang signifikan. Opioid bekerja dengan cara mengikat reseptor nyeri di otak sehingga mengurangi persepsi nyeri dan memberikan efek relaksasi. Namun, penggunaan opioid memerlukan pengawasan ketat karena berpotensi menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, rasa kantuk berlebihan, penurunan kesadaran, serta depresi pernapasan pada ibu maupun bayi baru lahir jika diberikan dekat waktu kelahiran. Analgesik non-opioid, seperti parasetamol intravena atau obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) tertentu, juga dapat digunakan terutama pada tahap awal persalinan untuk mengurangi nyeri ringan hingga sedang dengan risiko efek samping yang lebih minimal dibandingkan opioid.

Metode berikutnya adalah analgesia regional, yang merupakan metode pengelolaan nyeri persalinan dengan pemberian anestesi lokal pada daerah spesifik di sekitar saraf yang mengirim sinyal nyeri ke otak. Teknik ini secara efektif mengurangi atau bahkan menghilangkan sensasi nyeri pada area tertentu tanpa menyebabkan penurunan kesadaran ibu. Analgesia regional yang paling umum digunakan adalah epidural, spinal, serta kombinasi epidural-spinal (combined spinal-epidural, CSE). Epidural merupakan metode paling populer dalam praktik klinis, dilakukan dengan menyuntikkan anestesi lokal seperti bupivakain atau ropivakain, biasanya dikombinasikan dengan opioid dosis rendah, ke dalam ruang epidural tulang belakang bagian bawah. Efek analgesia epidural muncul secara bertahap dalam waktu sekitar 10-20 menit setelah pemberian dan dapat bertahan selama proses persalinan hingga selesai. Keunggulan epidural adalah efektivitas analgesia tinggi, memungkinkan ibu tetap sadar, dan tidak mengganggu

kemampuan ibu dalam mengejan secara signifikan. Namun, epidural membutuhkan teknik yang akurat dan pengawasan ketat oleh tenaga medis terlatih untuk mencegah komplikasi seperti hipotensi, sakit kepala hebat pasca prosedur (post-dural puncture headache), atau efek samping yang jarang terjadi seperti cedera saraf.

Analgesia spinal berbeda dengan epidural, dilakukan dengan memasukkan anestesi lokal langsung ke dalam cairan serebrospinal melalui ruang subarachnoid di tulang belakang bagian bawah. Teknik ini memberikan efek analgesia yang lebih cepat (biasanya dalam 2-5 menit) dan lebih intens dibanding epidural, namun durasi analgesianya lebih singkat. Metode spinal sering digunakan pada situasi yang memerlukan efek analgesia yang cepat, seperti dalam kasus persalinan cepat atau prosedur bedah caesar. Kombinasi epidural-spinal (CSE) adalah metode gabungan yang memanfaatkan kecepatan analgesia spinal dan efektivitas analgesia jangka panjang epidural, sering dipilih untuk ibu yang mengalami nyeri hebat namun membutuhkan analgesia dalam waktu yang lama selama persalinan. Penggunaan teknik analgesia regional, baik epidural maupun spinal, harus dilakukan secara hati-hati dan dengan pemantauan intensif terhadap kondisi hemodinamik ibu serta denyut jantung janin selama proses persalinan.

Analgesia inhalasi merupakan pendekatan manajemen nyeri persalinan dengan penggunaan gas anestesi yang dihirup oleh ibu. Gas entonoks (campuran 50% nitrous oxide dan 50% oksigen) merupakan jenis analgesia inhalasi yang paling banyak digunakan. Penggunaan entonoks dalam persalinan dilakukan melalui masker khusus atau mouthpiece yang digunakan sendiri oleh ibu secara intermiten saat kontraksi datang. Efek analgesia dari entonoks muncul sangat cepat, umumnya dalam hitungan detik hingga menit setelah dihirup, memberikan efek analgesia sedang yang cukup efektif dalam mengurangi persepsi nyeri, kecemasan, serta membantu ibu lebih rileks dan tenang selama proses persalinan. Keuntungan dari analgesia inhalasi entonoks adalah sifatnya yang aman, mudah diberikan, serta efek analgesianya cepat hilang ketika ibu berhenti menghirup gas tersebut. Efek samping yang sering muncul dari entonoks biasanya ringan seperti pusing, mual ringan, atau perasaan seperti melayang, namun efek ini umumnya bersifat sementara dan cepat hilang setelah ibu menghentikan penggunaannya.

F. Peran Perawat dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Perawat memegang peran penting dalam manajemen nyeri persalinan, karena secara langsung bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, emosional, dan edukasi kepada ibu selama proses persalinan. Peran perawat dalam mengelola nyeri persalinan tidak

hanya sebatas pelaksana intervensi klinis, tetapi juga sebagai pengelola situasi, advokat bagi pasien, pendidik, serta pemberi dukungan emosional dan psikologis.

Dalam konteks tanggung jawab dan kompetensi perawat dalam mengelola nyeri persalinan, perawat harus memiliki pemahaman mendalam tentang fisiologi nyeri persalinan, mekanisme terjadinya nyeri, serta berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri pada ibu. Perawat juga dituntut memiliki keterampilan klinis yang baik dalam melakukan penilaian nyeri menggunakan berbagai alat dan metode pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien. Di samping itu, perawat bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan intervensi nonfarmakologis dan farmakologis sesuai protokol klinis dan rekomendasi berbasis bukti yang berlaku. Ini mencakup keterampilan dalam menerapkan teknik relaksasi, terapi sentuhan, hidroterapi, hingga pemahaman tentang pemberian analgesik sistemik, regional, maupun inhalasi. Selain pelaksanaan intervensi secara langsung, perawat harus mampu melakukan observasi ketat terhadap efek terapi yang diberikan, baik efek terapeutik maupun efek samping yang mungkin timbul, serta mampu merespons dengan cepat dan tepat jika terjadi perubahan kondisi klinis ibu.

Perawat juga berperan krusial dalam aspek edukasi dan pemberian dukungan emosional selama proses persalinan. Pendidikan kesehatan yang diberikan oleh perawat meliputi penjelasan mengenai apa yang akan dialami ibu selama persalinan, mengapa nyeri terjadi, apa saja opsi yang tersedia untuk mengatasi nyeri, serta manfaat dan risiko dari masing-masing metode manajemen nyeri yang dipilih. Perawat harus mampu menyampaikan informasi tersebut secara jelas, mudah dipahami, dan empatik sehingga ibu merasa nyaman, terinformasi, serta mampu membuat keputusan yang tepat mengenai manajemen nyeri yang diinginkannya. Selain edukasi kepada ibu, perawat juga perlu mengedukasi anggota keluarga atau pendamping persalinan mengenai cara-cara efektif mendukung ibu bersalin, misalnya melalui teknik relaksasi, memberikan afirmasi positif, serta membantu ibu tetap tenang dan fokus selama proses persalinan berlangsung.

Dukungan emosional merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam peran perawat. Perawat harus mampu menunjukkan empati, perhatian penuh, dan kehadiran yang mendukung secara psikologis terhadap ibu bersalin. Pengalaman persalinan sering kali diwarnai kecemasan, ketakutan, serta ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, kemampuan perawat dalam membangun hubungan terapeutik yang kuat, memberikan dukungan psikologis, serta menenangkan ibu sangat berkontribusi pada pengurangan persepsi nyeri secara signifikan. Komunikasi terapeutik yang efektif oleh perawat, seperti mendengarkan secara aktif, memberikan sentuhan yang menenangkan, menjaga kontak mata, serta memberikan pujian dan dorongan positif, dapat secara nyata meningkatkan

kepercayaan diri ibu, mengurangi stres, dan meningkatkan kenyamanan selama persalinan.

Selain aspek klinis dan emosional, perawat memiliki tanggung jawab penting dalam mendokumentasikan secara sistematis dan akurat segala tindakan, observasi, serta perubahan kondisi klinis yang berkaitan dengan nyeri selama proses persalinan. Dokumentasi nyeri yang baik mencakup pencatatan intensitas nyeri secara rutin menggunakan skala nyeri yang valid, deskripsi jenis nyeri yang dirasakan ibu, waktu pemberian intervensi (baik farmakologis maupun nonfarmakologis), respons ibu terhadap intervensi tersebut, serta efek samping atau komplikasi yang mungkin muncul. Dokumentasi yang komprehensif ini sangat penting untuk kontinuitas perawatan, evaluasi klinis yang tepat waktu, serta sebagai dasar pengambilan keputusan klinis lebih lanjut oleh tim kesehatan.

Evaluasi nyeri secara berkala oleh perawat juga menjadi elemen penting dalam peran mereka. Evaluasi rutin terhadap efektivitas intervensi yang diberikan membantu perawat dan tim medis untuk menilai apakah metode yang digunakan sudah memadai atau perlu dilakukan penyesuaian. Evaluasi ini harus dilakukan secara kontinu selama proses persalinan, mulai dari fase laten, aktif, hingga fase akhir persalinan, untuk memastikan bahwa nyeri ibu tetap terkendali secara optimal. Jika intervensi yang diberikan dirasakan kurang efektif, perawat harus segera melakukan koordinasi dengan tim medis untuk mempertimbangkan langkah alternatif atau intervensi tambahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan ibu.

G. Kolaborasi Interprofesional dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Kolaborasi interprofesional merupakan elemen kunci dalam keberhasilan manajemen nyeri persalinan. Dalam konteks ini, tim kesehatan yang terdiri dari perawat, dokter obstetri, dokter anestesi, bidan, dan profesi lain yang terlibat, harus bekerja secara terpadu dan harmonis untuk memastikan bahwa ibu yang sedang menjalani persalinan menerima asuhan yang efektif, komprehensif, dan terintegrasi. Kolaborasi ini sangat penting karena masing-masing anggota tim memiliki keahlian, tanggung jawab, serta peran spesifik yang saling melengkapi dalam upaya mengurangi nyeri, mencegah komplikasi, dan memberikan pengalaman persalinan yang positif bagi ibu.

Komunikasi tim merupakan salah satu fondasi utama dalam kolaborasi interprofesional di dalam manajemen nyeri persalinan. Komunikasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memungkinkan terciptanya pemahaman bersama mengenai kondisi ibu bersalin, tingkat nyeri yang dialami, preferensi pasien dalam metode pengelolaan nyeri, serta rencana intervensi yang akan diberikan. Untuk mewujudkan komunikasi tim yang efektif, diperlukan penggunaan pendekatan

komunikasi yang terstruktur, seperti teknik SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Melalui metode ini, anggota tim dapat dengan cepat dan jelas menyampaikan informasi mengenai kondisi klinis ibu, latar belakang medis yang relevan, hasil penilaian yang telah dilakukan, serta rekomendasi tindakan selanjutnya. Komunikasi yang baik juga mencakup pemberian informasi secara tepat waktu, konfirmasi ulang terhadap instruksi yang diberikan, serta kemampuan mendengarkan secara aktif. Hal ini sangat penting guna mencegah kesalahpahaman, memastikan bahwa setiap anggota tim memahami perannya secara jelas, serta menghindari keterlambatan atau kesalahan dalam pemberian terapi nyeri.

Di samping komunikasi tim yang efektif, koordinasi antar profesi seperti dokter anestesi, dokter obstetri, dan bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam manajemen nyeri persalinan. Dokter anestesi berperan vital terutama dalam pemberian metode analgesia regional seperti epidural atau spinal, serta analgesia sistemik dan inhalasi bila diperlukan. Peran dokter anestesi tidak hanya sebatas melakukan prosedur anestesi saja, tetapi juga bertanggung jawab dalam memantau kondisi ibu secara kontinu setelah pemberian anestesi, mengelola komplikasi yang mungkin timbul seperti hipotensi atau reaksi alergi, serta menyesuaikan dosis obat analgesik sesuai respons klinis ibu.

Dokter obstetri memiliki tanggung jawab utama dalam aspek klinis keseluruhan selama proses persalinan. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa proses persalinan berjalan dengan aman, baik bagi ibu maupun bayi, sambil memperhatikan aspek pengelolaan nyeri yang adekuat. Dokter obstetri harus selalu berkoordinasi erat dengan dokter anestesi dan perawat untuk menentukan metode pengelolaan nyeri yang paling sesuai dengan kondisi klinis dan preferensi pasien. Koordinasi ini meliputi keputusan kapan analgesia farmakologis diberikan, jenis analgesia yang dipilih, serta bagaimana pengelolaan nyeri dapat terintegrasi dengan rencana persalinan secara keseluruhan.

Sementara itu, bidan memiliki peran sentral dalam pengawasan langsung selama proses persalinan normal, terutama dalam penggunaan metode nonfarmakologis untuk mengelola nyeri seperti teknik pernapasan, relaksasi, massage, hidroterapi, atau penggunaan posisi yang mendukung kenyamanan ibu. Bidan juga merupakan pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan ibu, sehingga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi tingkat nyeri secara dini, memberikan dukungan emosional, serta melaporkan setiap perubahan kondisi pasien kepada perawat dan dokter secara cepat. Koordinasi bidan dengan perawat dan dokter anestesi penting dilakukan apabila pasien membutuhkan metode analgesia farmakologis lanjutan atau intervensi medis tambahan.

Dalam kolaborasi interprofesional ini, perawat memegang peran yang sangat strategis, yakni sebagai penghubung antara semua profesi terkait. Perawat bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan hasil observasi kondisi klinis ibu secara terus-menerus, melaporkan perkembangan tingkat nyeri secara teratur, dan memastikan bahwa seluruh anggota tim kesehatan selalu mendapat informasi terbaru tentang kondisi pasien. Selain itu, perawat juga bertugas mengoordinasikan waktu pelaksanaan intervensi analgesia, memastikan bahwa prosedur analgesia dilakukan tepat waktu, serta memastikan bahwa pasien dan keluarga mendapatkan informasi yang jelas dan konsisten mengenai setiap tindakan yang akan dilakukan oleh tim kesehatan.

Kolaborasi interprofesional yang efektif ini menuntut setiap anggota tim untuk memiliki sikap saling menghormati terhadap kompetensi masing-masing profesi, keterbukaan terhadap saran dan masukan dari anggota tim lain, serta kemampuan bekerja secara harmonis di bawah tekanan yang tinggi selama proses persalinan berlangsung. Kunci utama dari kolaborasi interprofesional yang sukses adalah adanya rasa saling percaya antarprofesi, kesadaran terhadap tanggung jawab bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien, serta komitmen kuat dari seluruh anggota tim untuk memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi kepada ibu bersalin.

H. Pendekatan Holistik dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Pendekatan holistik dalam manajemen nyeri persalinan merupakan sebuah konsep yang menempatkan ibu bersalin sebagai individu yang utuh, dengan mempertimbangkan aspek fisik, emosional, psikologis, sosial, dan spiritual dalam penanganan nyeri selama proses persalinan. Dalam pendekatan ini, manajemen nyeri tidak hanya berfokus pada penggunaan intervensi medis atau farmakologis semata, tetapi juga mengintegrasikan berbagai metode nonfarmakologis secara efektif guna mencapai kenyamanan maksimal ibu bersalin. Pendekatan holistik menekankan pentingnya menghormati pilihan dan preferensi individu, serta memastikan bahwa metode yang digunakan selaras dengan kebutuhan unik setiap pasien.

Integrasi metode farmakologis dan nonfarmakologis merupakan komponen utama dari pendekatan holistik ini. Dalam praktiknya, kedua metode tersebut tidak dianggap sebagai opsi yang saling mengecualikan, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Metode farmakologis seperti analgesia epidural, analgesia sistemik, maupun inhalasi gas entonoks, memiliki peran penting dalam mengendalikan nyeri akut yang hebat atau nyeri yang tidak responsif terhadap teknik nonfarmakologis. Sebaliknya, metode nonfarmakologis seperti teknik relaksasi, terapi pernapasan,

meditasi, hypnobirthing, terapi sentuhan, massage, aromaterapi, hidroterapi, serta penggunaan posisi atau mobilisasi aktif, memberikan kontribusi besar dalam mengurangi persepsi nyeri, kecemasan, dan stres ibu selama proses persalinan. Ketika kedua pendekatan ini digabungkan dengan tepat, pasien dapat merasakan pengurangan nyeri yang signifikan, peningkatan rasa nyaman, serta pengalaman persalinan yang lebih positif secara keseluruhan.

Keberhasilan integrasi antara metode farmakologis dan nonfarmakologis sangat bergantung pada kemampuan tim kesehatan, khususnya perawat, dalam menilai kondisi klinis ibu secara menyeluruh dan akurat. Perawat harus secara aktif melakukan penilaian berkelanjutan terhadap tingkat nyeri yang dialami ibu, respons pasien terhadap intervensi yang diberikan, serta perubahan kebutuhan ibu selama berlangsungnya persalinan. Melalui pemantauan yang intensif ini, tim kesehatan dapat dengan cepat menentukan kapan metode farmakologis perlu diterapkan dan kapan metode nonfarmakologis lebih efektif digunakan. Misalnya, seorang ibu yang awalnya berhasil mengendalikan nyerinya melalui teknik pernapasan dan relaksasi, namun kemudian merasa nyerinya semakin hebat seiring meningkatnya intensitas kontraksi, dapat segera diberikan tambahan analgesia epidural dengan mempertimbangkan kondisi klinisnya. Sebaliknya, pasien yang menggunakan analgesia epidural juga tetap mendapat manfaat dari penggunaan metode nonfarmakologis, seperti massage atau aromaterapi, untuk meningkatkan rasa nyaman, relaksasi, dan dukungan psikologis selama proses persalinan.

Selain integrasi metode farmakologis dan nonfarmakologis, pendekatan holistik juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis preferensi dan kebutuhan pasien. Setiap ibu memiliki persepsi, toleransi, dan harapan yang berbeda terhadap nyeri persalinan. Oleh karena itu, dalam menentukan strategi manajemen nyeri, tim kesehatan harus melibatkan ibu secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang berbagai opsi yang tersedia. Perawat harus memastikan bahwa ibu memahami secara menyeluruh mengenai keuntungan, risiko, serta dampak potensial dari setiap metode manajemen nyeri yang dipilih. Proses diskusi terbuka ini memungkinkan ibu untuk merasa didengarkan, dihargai, dan dihormati, serta mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai pribadi, kondisi klinis, dan keinginannya.

Dalam konteks ini, perawat berperan sangat penting sebagai advokat pasien, membantu pasien untuk mengartikulasikan preferensi dan kebutuhannya secara jelas, serta memastikan bahwa pilihan tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh anggota tim kesehatan yang terlibat. Perawat juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi kolaborasi yang erat antara dokter, bidan, dan tenaga

kesehatan lainnya agar setiap intervensi yang diberikan selaras dengan rencana manajemen nyeri yang disepakati bersama pasien. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis preferensi pasien ini, pasien cenderung merasa lebih puas, percaya diri, dan memiliki kontrol lebih besar terhadap pengalaman persalinannya.

Pendekatan holistik dalam manajemen nyeri persalinan juga menekankan pentingnya dukungan emosional, psikologis, dan sosial yang kuat selama proses persalinan. Perawat harus memberikan dukungan empati yang intens, menciptakan suasana yang hangat, tenang, dan nyaman di lingkungan persalinan, serta melibatkan keluarga atau orang terdekat ibu untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan emosional. Lingkungan persalinan yang positif, penuh penghormatan, dan suportif akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan rasa nyaman ibu, mengurangi stres dan kecemasan, serta memperkuat efek positif dari intervensi nyeri yang diterapkan.

I. Tantangan dan Hambatan dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Manajemen nyeri dalam persalinan merupakan proses yang kompleks dan multifaset yang melibatkan berbagai aspek, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga budaya, sosial, dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, seringkali ditemui berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan manajemen nyeri yang diberikan kepada ibu bersalin. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi, dipahami, dan diatasi agar setiap ibu memperoleh dukungan maksimal selama proses persalinan, serta untuk memastikan bahwa pengalaman melahirkan dapat berlangsung aman, nyaman, dan sesuai harapan ibu dan keluarga.

Salah satu tantangan utama dalam manajemen nyeri persalinan adalah isu budaya dan keyakinan yang berhubungan dengan persepsi terhadap nyeri. Dalam berbagai komunitas atau kelompok budaya tertentu, nyeri persalinan dianggap sebagai proses alamiah yang harus ditoleransi atau bahkan dijalani tanpa bantuan intervensi apa pun. Di beberapa budaya, seorang ibu yang mampu menahan nyeri persalinan tanpa bantuan medis dianggap kuat, terhormat, atau memiliki status tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memerlukan bantuan intervensi medis untuk mengatasi nyeri. Hal ini menyebabkan banyak ibu yang enggan atau menolak metode manajemen nyeri farmakologis atau bahkan nonfarmakologis karena takut dianggap lemah atau tidak mampu menjalani proses persalinan secara alami.

Persepsi budaya yang negatif terhadap penggunaan metode farmakologis seperti analgesia epidural atau penggunaan opioid dalam persalinan, misalnya, seringkali disebabkan oleh adanya keyakinan bahwa intervensi medis akan berdampak buruk pada bayi atau proses persalinan itu sendiri. Adanya informasi

yang tidak akurat, mitos, atau stigma yang kuat terkait efek samping dari intervensi medis semakin memperkuat keengganan ibu untuk menerima bantuan medis dalam manajemen nyeri. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi tim kesehatan, terutama perawat, yang bertugas memberikan edukasi yang benar, komprehensif, serta responsif terhadap nilai-nilai budaya pasien. Pendekatan yang sensitif secara budaya sangat diperlukan, di mana perawat harus memahami, menghormati, dan secara hati-hati memberikan edukasi yang membantu pasien memahami manfaat dan risiko dari setiap metode manajemen nyeri. Dengan melakukan pendekatan empati, mendengarkan kekhawatiran pasien secara aktif, serta melibatkan keluarga dalam diskusi, perawat dapat membangun rasa percaya, mengurangi ketakutan dan stigma yang terkait dengan manajemen nyeri persalinan, dan membantu ibu membuat keputusan yang terinformasi secara baik dan selaras dengan nilai-nilai budayanya.

Selain isu budaya, tantangan besar lainnya dalam manajemen nyeri persalinan adalah kendala sumber daya di fasilitas kesehatan. Sumber daya yang terbatas meliputi kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih secara khusus dalam manajemen nyeri persalinan, keterbatasan ketersediaan obat-obatan atau perangkat medis seperti alat epidural, serta minimnya fasilitas pendukung metode nonfarmakologis, seperti ruang bersalin yang nyaman, peralatan hidroterapi, atau tenaga terlatih yang mampu mempraktikkan teknik relaksasi, massage, atau terapi komplementer lainnya secara terampil dan aman. Kondisi ini sering terjadi di fasilitas kesehatan di daerah terpencil atau fasilitas kesehatan dengan keterbatasan dana dan sarana.

Dalam situasi di mana sumber daya terbatas, pilihan metode manajemen nyeri menjadi sangat terbatas. Misalnya, ketiadaan dokter anestesi atau tenaga medis yang mampu melakukan prosedur analgesia regional seperti epidural atau spinal membuat opsi metode farmakologis menjadi terbatas. Selain itu, ketersediaan gas entonoks yang terbatas atau tidak tersedia sama sekali di beberapa fasilitas juga membatasi pilihan analgesia inhalasi yang seharusnya mudah digunakan dan aman dalam situasi darurat. Di sisi lain, meskipun metode nonfarmakologis seperti teknik relaksasi, pernapasan, massage, dan hidroterapi relatif lebih murah, keberhasilan penerapan metode tersebut tetap membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan khusus, pelatihan yang rutin, serta lingkungan yang mendukung pelaksanaan metode tersebut secara optimal.

Keterbatasan sumber daya ini menuntut perawat dan tim kesehatan lainnya untuk lebih kreatif, adaptif, dan fleksibel dalam memberikan manajemen nyeri. Perawat perlu memiliki kompetensi dan keterampilan yang lebih luas untuk mengoptimalkan metode manajemen nyeri sederhana tetapi efektif seperti teknik pernapasan dalam, sentuhan terapeutik, atau penggunaan posisi dan mobilisasi aktif yang dapat dilakukan tanpa membutuhkan peralatan medis yang kompleks. Selain

itu, advokasi terhadap manajemen kesehatan atau pemerintah daerah juga perlu dilakukan secara aktif untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya investasi dalam fasilitas, pelatihan tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat-obatan serta alat-alat yang diperlukan guna mendukung manajemen nyeri persalinan yang optimal.

Kolaborasi interprofesional juga menjadi bagian penting dalam mengatasi tantangan ini, di mana koordinasi erat antara perawat, dokter, bidan, anestesi, manajemen rumah sakit, serta pihak pemangku kebijakan menjadi kunci dalam menyusun strategi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya ini. Kolaborasi tersebut dapat berupa pengembangan protokol manajemen nyeri yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya lokal, penyelenggaraan pelatihan berkala kepada tenaga kesehatan tentang teknik nonfarmakologis sederhana namun efektif, serta mendorong advokasi untuk pengadaan fasilitas atau sumber daya tambahan yang diperlukan.

J. Aspek Etik dan Hukum dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Aspek etik dan hukum merupakan elemen krusial yang harus diperhatikan secara cermat dalam setiap praktik manajemen nyeri persalinan. Ketika berbicara mengenai pengelolaan nyeri, khususnya pada proses persalinan, tenaga kesehatan terutama perawat menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan klinis. Hal ini mencakup pemberian analgesia atau intervensi medis lainnya yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan nyeri. Dalam konteks ini, memahami prinsip-prinsip etik secara mendalam dan menyadari implikasi hukum dari tindakan medis yang dilakukan menjadi kewajiban bagi seluruh tenaga kesehatan, termasuk perawat, dokter, dan bidan.

Prinsip etik yang mendasari pengelolaan nyeri dalam persalinan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu prinsip beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. Prinsip beneficence atau prinsip kebaikan mengharuskan tenaga kesehatan untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Dalam hal ini, upaya mengurangi rasa nyeri dan memberikan kenyamanan maksimal selama proses persalinan dianggap sebagai manifestasi langsung dari prinsip beneficence tersebut. Prinsip ini menuntut agar tenaga kesehatan tidak hanya memahami mekanisme fisiologis nyeri, tetapi juga mampu memberikan intervensi terbaik yang tersedia sesuai dengan kondisi klinis ibu serta preferensi pasien, dengan tujuan akhir yaitu memberikan manfaat maksimal berupa kenyamanan dan keamanan bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan.

Prinsip berikutnya adalah non-maleficence, yang menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk tidak menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pasien.

Dalam konteks manajemen nyeri persalinan, prinsip ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati efek samping atau risiko yang mungkin timbul akibat pemberian analgesia, baik secara farmakologis maupun nonfarmakologis. Setiap keputusan untuk memberikan analgesia harus didasarkan pada pertimbangan yang matang mengenai manfaat dan risiko. Sebagai contoh, pemberian analgesia epidural atau opioid harus dilakukan dengan pemahaman yang jelas mengenai potensi komplikasi seperti depresi pernapasan, penurunan tekanan darah, efek terhadap proses persalinan, maupun dampak terhadap kondisi janin. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk melakukan edukasi komprehensif kepada pasien dan keluarganya mengenai manfaat serta risiko dari setiap tindakan yang akan dilakukan.

Selanjutnya adalah prinsip autonomy atau otonomi pasien, yang menekankan pentingnya hak pasien untuk menentukan sendiri keputusan terkait tindakan medis yang diterima. Dalam konteks persalinan, ibu berhak menerima informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai setiap intervensi yang tersedia untuk manajemen nyeri, termasuk opsi farmakologis seperti epidural, analgesia inhalasi, atau opioid, serta metode nonfarmakologis seperti relaksasi, aromaterapi, maupun hidroterapi. Pemberian informasi ini bertujuan agar ibu dapat membuat keputusan yang terinformasi secara baik, yang sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, keyakinan budaya, dan preferensi pribadinya. Penghormatan terhadap otonomi pasien juga tercermin dalam kewajiban tenaga kesehatan untuk selalu meminta persetujuan pasien (informed consent) sebelum melaksanakan tindakan medis apapun, terutama tindakan yang memiliki risiko atau efek samping signifikan.

Prinsip terakhir adalah justice atau keadilan, yang menuntut bahwa setiap pasien harus mendapatkan akses yang setara terhadap manajemen nyeri persalinan, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, atau geografis. Dalam praktik nyata, prinsip ini menantang tenaga kesehatan untuk berupaya maksimal dalam mengatasi kendala sumber daya yang mungkin menghambat akses pasien terhadap analgesia atau metode nonfarmakologis yang efektif. Tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan advokasi demi meningkatkan fasilitas dan sumber daya kesehatan agar seluruh ibu bersalin memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh manajemen nyeri yang optimal dan aman.

Selain pertimbangan etik, implikasi hukum dalam pemberian analgesia selama persalinan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan serius. Implikasi hukum ini berhubungan erat dengan kewajiban tenaga kesehatan untuk bertindak sesuai dengan standar praktik klinis dan pedoman yang berlaku dalam manajemen nyeri. Setiap tindakan pemberian analgesia harus dilakukan berdasarkan prosedur yang

jelas dan standar, dengan kompetensi tenaga kesehatan yang memadai dan memiliki kualifikasi khusus jika diperlukan (misalnya dokter anestesi untuk epidural). Kelalaian dalam memberikan analgesia, pemberian analgesia yang tidak sesuai indikasi atau dosis yang tidak tepat, atau kegagalan dalam memberikan informasi yang memadai mengenai risiko tindakan kepada pasien, dapat menimbulkan risiko hukum yang serius seperti tuntutan malpraktik.

Dalam perspektif hukum, tenaga kesehatan khususnya perawat wajib memastikan bahwa setiap tindakan medis, termasuk pemberian analgesia, selalu didasarkan pada persetujuan yang jelas (informed consent). Dalam situasi gawat darurat, consent implisit atau emergency consent dapat berlaku, namun tetap harus didokumentasikan dengan rinci setelah kondisi pasien stabil. Dokumentasi medis yang teliti, akurat, dan rinci mengenai penilaian nyeri, tindakan yang diberikan, respons pasien terhadap analgesia, serta setiap edukasi dan informasi yang diberikan kepada pasien dan keluarganya, menjadi sangat penting sebagai bukti hukum yang kuat apabila terjadi sengketa atau masalah hukum di kemudian hari.

Lebih lanjut, implikasi hukum juga terkait erat dengan prinsip akuntabilitas, di mana setiap tenaga kesehatan harus bertanggung jawab secara profesional dan legal terhadap tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, penting bagi perawat dan seluruh tim kesehatan untuk secara rutin mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang manajemen nyeri persalinan, memahami secara jelas pedoman klinis yang berlaku, dan secara konsisten melaksanakan praktik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

K. Simpulan

Nyeri persalinan merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang sangat kompleks dan bersifat subjektif. Pengelolaan nyeri yang efektif selama proses persalinan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk kenyamanan fisik ibu tetapi juga untuk menjaga kondisi emosional dan psikologis, serta mencegah dampak negatif jangka panjang seperti trauma atau depresi postpartum. Manajemen nyeri persalinan harus mempertimbangkan mekanisme fisiologis terjadinya nyeri yang mencakup rangsangan viseral dari kontraksi uterus dan rangsangan somatik dari peregangan jaringan pelvis serta perineum.

Penilaian nyeri persalinan yang akurat menggunakan metode subjektif seperti skala nyeri numerik atau wajah, serta metode objektif melalui observasi klinis tanda fisiologis dan perilaku, menjadi dasar penting untuk menentukan intervensi yang tepat. Strategi penilaian nyeri harus disesuaikan dengan fase persalinan yang berbeda, mulai dari fase laten, aktif, hingga transisi dan mengejan, sehingga pengelolaan nyeri dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu.

Manajemen nyeri persalinan mencakup pendekatan nonfarmakologis dan farmakologis. Metode nonfarmakologis seperti teknik relaksasi, pernapasan, aromaterapi, musik, hypnobirthing, meditasi, massage, hidroterapi, dan mobilisasi aktif memberikan manfaat holistik, meningkatkan kenyamanan ibu, dan memperkuat rasa percaya diri dalam menghadapi persalinan. Metode farmakologis seperti analgesia sistemik (opioid dan non-opioid), analgesia regional (epidural dan spinal), serta analgesia inhalasi (entonoks) memberikan pengurangan nyeri yang signifikan, khususnya pada kondisi nyeri intens atau berat. Pemilihan metode farmakologis harus mempertimbangkan manfaat serta risiko yang mungkin terjadi.

Perawat memiliki peran yang sangat strategis dalam manajemen nyeri persalinan, tidak hanya melalui pelaksanaan intervensi klinis tetapi juga melalui edukasi, dukungan emosional, serta dokumentasi yang sistematis. Perawat bertanggung jawab memastikan bahwa ibu bersalin mendapatkan informasi yang jelas, merasa didukung, serta mampu mengambil keputusan yang tepat tentang pengelolaan nyeri yang diinginkan.

Kolaborasi interprofesional yang efektif antara perawat, dokter anestesi, dokter obstetri, dan bidan menjadi kunci utama dalam keberhasilan manajemen nyeri persalinan. Komunikasi yang terstruktur, koordinasi yang harmonis, serta rasa saling percaya antarprofesi memastikan bahwa asuhan yang diberikan kepada ibu bersalin bersifat terpadu dan berkualitas tinggi.

Pendekatan holistik yang mengintegrasikan metode farmakologis dan nonfarmakologis serta mempertimbangkan preferensi pasien secara individu sangat penting dalam mencapai manajemen nyeri yang optimal. Pendekatan ini memungkinkan ibu merasa dihargai, aman, dan mampu menjalani persalinan dengan nyaman.

Namun, implementasi manajemen nyeri persalinan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti isu budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap nyeri serta keterbatasan sumber daya di fasilitas kesehatan. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang sensitif secara budaya, edukasi yang intensif, serta advokasi aktif untuk memperbaiki ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan terlatih.

Aspek etik dan hukum dalam manajemen nyeri persalinan menekankan pentingnya prinsip beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip etik ini serta kesadaran terhadap implikasi hukum setiap tindakan medis, termasuk pemberian analgesia, menjadi kewajiban bagi tenaga kesehatan. Dokumentasi yang teliti, informed consent yang jelas, dan pelaksanaan intervensi sesuai standar praktik klinis merupakan cara efektif untuk mengurangi risiko hukum serta memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi ibu bersalin.

L. Referensi

- Chang, C.-Y., Gau, M.-L., Huang, C.-J., & Cheng, H.-m. (2022). Effects of non-pharmacological coping strategies for reducing labor pain: A systematic review and network meta-analysis. *PLoS ONE*, 17(1), e0261493. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261493>
- Hajnasiri, A. et al. (2023). Non-pharmacological pain management in labor: A systematic review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(23), 7203. <https://doi.org/10.3390/jcm12237203>
- Luoto, R. et al. (2024). Non-pharmacological approaches for managing labor pain: Systematic review. *IJMDC*, 8(12), 3808–3815. <https://doi.org/10.24911/IJMDC.51-1734622886>
- Parkies, L. E., Murray, D., & Okafor, U. B. (2024). The benefits and barriers of providing non-pharmacological pain relief to women in labour during COVID-19: A qualitative study of midwives in South Africa. *Women*, 4(1), 105–115. <https://doi.org/10.3390/women4010008>
- Simkin, P., & Bolding, A. (2004). Update on non-pharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 49(6), 489–504.
- White-Burns, N., et al. (2019). The nature of labour pain: An updated review of the literature. *Women and Birth*.

M. Glosarium

Analgesia:

Metode atau penggunaan obat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri selama proses persalinan.

Analgesia Epidural:

Teknik pemberian anestesi lokal melalui ruang epidural tulang belakang untuk meredakan nyeri persalinan secara efektif.

Analgesia Inhalasi:

Penggunaan gas anestesi (seperti entonoks) yang dihirup untuk mengurangi persepsi nyeri selama kontraksi persalinan.

Analgesia Regional:

Metode pengelolaan nyeri dengan menyuntikkan anestesi lokal di sekitar saraf tertentu sehingga memblokir impuls nyeri ke otak tanpa menurunkan kesadaran pasien.

Distosia:

Kondisi persalinan yang mengalami hambatan atau macet sehingga memerlukan intervensi medis, misalnya operasi caesar.

Endorfin:

Hormon alami dalam tubuh yang membantu mengurangi rasa nyeri serta menciptakan perasaan tenang dan nyaman.

Hiperventilasi:

Peningkatan frekuensi atau kedalaman pernapasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan komplikasi selama persalinan.

Hipnobirthing:

Metode manajemen nyeri nonfarmakologis yang menggunakan teknik relaksasi mendalam dan sugesti positif untuk mengurangi persepsi negatif terhadap nyeri persalinan.

Informed Consent:

Persetujuan dari pasien setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai manfaat, risiko, dan alternatif dari intervensi medis yang akan dilakukan.

Iskemia Uterus:

Kondisi kekurangan oksigen akibat penurunan aliran darah pada otot rahim selama kontraksi yang menyebabkan rasa nyeri intens.

Kolaborasi Interprofesional:

Kerja sama antar tenaga kesehatan dari berbagai profesi, seperti perawat, bidan, dokter obstetri, dan dokter anestesi, untuk memberikan asuhan nyeri persalinan yang komprehensif dan efektif.

Mobilisasi Aktif:

Penggunaan berbagai posisi dan gerakan tubuh oleh ibu selama persalinan untuk mengurangi nyeri dan mempercepat proses persalinan.

Nyeri Persalinan:

Pengalaman sensoris dan emosional kompleks yang dirasakan ibu akibat proses fisiologis persalinan, seperti kontraksi rahim, dilatasi serviks, dan tekanan janin pada jalan lahir.

Pendekatan Holistik:

Strategi manajemen nyeri yang memperhatikan semua aspek fisik, emosional, psikologis, sosial, dan spiritual ibu dalam proses persalinan.

Penilaian Nyeri Objektif:

Penilaian nyeri berdasarkan observasi tanda-tanda klinis dan perilaku pasien, seperti ekspresi wajah, tanda fisiologis (denyut jantung, tekanan darah), dan postur tubuh.

Penilaian Nyeri Subjektif:

Penilaian nyeri yang didasarkan pada laporan langsung dari ibu bersalin mengenai intensitas nyeri yang dialaminya menggunakan skala khusus seperti skala numerik atau skala wajah.

Prinsip Beneficence:

Prinsip etik yang mengharuskan tenaga kesehatan selalu bertindak demi kebaikan dan manfaat terbaik pasien dalam manajemen nyeri persalinan.

Prinsip Non-maleficence:

Prinsip etik yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk tidak menyebabkan bahaya atau risiko yang tidak perlu dalam pemberian terapi nyeri persalinan.

Prinsip Otonomi:

Hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai intervensi medis dan membuat keputusan mandiri terkait manajemen nyeri persalinan yang akan diterima.

Prinsip Keadilan (Justice):

Prinsip etik yang menegaskan bahwa setiap pasien harus mendapatkan akses yang setara terhadap metode manajemen nyeri persalinan tanpa diskriminasi.

CHAPTER 6

ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASA PERSALINAN

Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah, S.SiT., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Persalinan merupakan proses fisiologis yang kompleks dan menegangkan baik secara fisik maupun emosional bagi ibu. Masa persalinan menjadi momen kritis yang membutuhkan perhatian khusus karena merupakan fase transisi yang menentukan keselamatan ibu dan bayi. Keberhasilan proses persalinan sangat bergantung pada kesiapan ibu, dukungan lingkungan, serta kompetensi tenaga kesehatan, khususnya perawat dan bidan, dalam memberikan asuhan yang tepat, efektif, dan berpusat pada pasien.

Secara fisiologis, keperawatan maternitas adalah bentuk pelayanan asuhan keperawatan oleh perawat profesional kepada WUS dan keluarganya yang berkaitan dengan reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas dan BBL sampai umur 40 hari (Hartati et al., 2024).

Dalam konteks keperawatan maternitas, asuhan keperawatan pada masa persalinan berperan penting dalam memastikan pemantauan yang adekuat terhadap kondisi ibu dan janin, membantu proses adaptasi psikologis ibu terhadap nyeri dan stres persalinan, serta mencegah terjadinya komplikasi yang dapat membahayakan keduanya. Asuhan keperawatan yang berkualitas didasarkan pada prinsip *evidence-based practice*, pendekatan humanistik, serta kemampuan klinis yang terstandardisasi.

Tujuan persalinan normal adalah menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap, tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan (optimal). Melalui pendekatan ini maka setiap intervensi yang diaplikasikan dalam Asuhan Persalinan Normal (APN) harus mempunyai alasan dan bukti ilmiah yang kuat tentang manfaat intervensi tersebut bagi kemajuan dan keberhasilan proses persalinan (Oktarina, 2015).

Perawat dituntut untuk tidak hanya memahami aspek klinis dan fisiologis persalinan, tetapi juga aspek emosional, sosial, dan budaya yang melingkupi pengalaman melahirkan seorang ibu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tenaga

keperawatan dalam memberikan asuhan selama persalinan menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi(Collins et al., 2021).

Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai konsep dasar, prinsip, dan tahapan asuhan keperawatan pada masa persalinan, termasuk peran perawat dalam setiap kala persalinan, pengkajian, intervensi, dokumentasi, serta penanganan komplikasi. Dengan pemahaman ini, diharapkan pembaca, khususnya mahasiswa dan praktisi keperawatan, dapat memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan bermutu tinggi selama proses kelahiran.

B. Konsep dasar asuhan keperawatan pada persalinan

Asuhan keperawatan pada persalinan adalah serangkaian tindakan profesional yang diberikan oleh perawat kepada ibu yang sedang mengalami proses kelahiran, yang mencakup pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keperawatan. Asuhan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi, mengurangi ketidaknyamanan, serta mencegah dan menangani komplikasi secara dini.

Tujuan asuhan keperawatan pada persalinan adalah menjaga kestabilan kondisi fisiologis ibu dan janin, memberikan dukungan emosional selama proses persalinan, membantu ibu menjalani proses persalinan dengan nyaman dan aman, mendeteksi dini tanda-tanda komplikasi dan memfasilitasi pengalaman persalinan yang positif bagi ibu dan keluarga(Rosyati, 2017).

Prinsip-prinsip asuhan persalinan berpusat pada ibu (*woman-centered care*): Ibu adalah tokoh utama dalam proses persalinan, perawat harus menghargai pilihan dan kebutuhannya, aman dan sesuai standar: Berbasis pada standar praktik keperawatan dan pedoman klinis (misal: WHO, Kemenkes), holistik dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual ibu, *continuity of care* yaitu asuhan diberikan secara berkesinambungan sejak awal persalinan hingga masa nifas awal, dan adanya *Informed decision-making*. Perawat mendampingi ibu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas(Widiatmika, 2015).

Peran perawat dalam asuhan persalinan diantaranya melakukan pengkajian dengan Mengumpulkan data menyeluruh tentang kondisi ibu (fisik, emosional, obstetri), pemantauan klinis yaitu meliputi melakukan pemantauan tanda vital, kontraksi, DJJ, status ketuban, dan kemajuan persalinan (dengan partograf), manajemen nyeri dengan memberikan dukungan non-farmakologis dan farmakologis untuk mengatasi nyeri persalinan, memberikan dukungan psikologis dengan memberikan pendampingan, motivasi, dan menciptakan lingkungan yang menenangkan, kolaborasi dengan merujuk atau bekerja sama dengan dokter/bidan jika terjadi komplikasi atau kebutuhan intervensi lanjutan serta melakukan edukasi

dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait proses persalinan dan intervensi yang diberikan.

Tabel 6.1 tahapan persalinan dan asuhan keperawatannya (Atin karjatin, 2015)

Kala persalinan	Asuhan Keperawatan
Kala I (pembukaan serviks)	Pemantauan DJJ, kontraksi, pemeriksaan dalam, kenyamanan ibu, edukasi pernapasan
Kala II (pengeluaran bayi)	Mendampingi ibu mengejan, observasi tanda gawat janin, kesiapan resusitasi bayi
Kala III (pengeluaran plasenta)	Observasi perdarahan, kontraksi uterus, pemberian uterotonika
Kala IV (pengamatan awal pascapersalinan)	Observasi TTV, perdarahan, bonding ibu-bayi, inisiasi menyusui dini (IMD)

Dalam pertolongan persalinan perawat harus menjunjung etika dan profesionalisme meliputi menjaga privasi dan martabat ibu, melakukan komunikasi terapeutik, tidak melakukan tindakan tanpa persetujuan, dan mencatat dan mendokumentasikan semua tindakan secara akurat dan tepat waktu (Dewi Nopiska Lilis, Rif'atun Nisa, Rosmaria Manik, Mercy Joie Kaparang, Dina Indarsita, Dwi Suprapti, Herinawati, Ika Apriyanti. Sjenny Olga Tuju, Nita Tri Wahyuni, Rici Gusti Maulani, 2024).

C. Persalinan Kala I

Asuhan persalinan kala I adalah proses pemantauan dan pemberian pelayanan kebidanan kepada ibu bersalin selama tahap pertama persalinan, yaitu sejak awal kontraksi yang menyebabkan perubahan serviks hingga pembukaan lengkap (10 cm). Tujuannya adalah memastikan keselamatan ibu dan janin dengan deteksi dini terhadap penyimpangan serta pemberian intervensi tepat waktu (Putri & Handayani, 2025).

Asuhan pada kala ini ditujukan untuk menilai kemajuan persalinan, memastikan kondisi ibu dan janin dalam keadaan baik, memberikan kenyamanan dan dukungan psikologis, dan mendeteksi dini komplikasi.

Kala I di bagi menjadi 2 tahap yaitu fase laten (pembukaan serviks 0-4) dan fase aktif (pembukaan serviks 4-10)

Kala I fase laten

Kala I fase laten adalah tahap awal dari proses persalinan yang ditandai dengan dimulainya kontraksi uterus yang teratur dan menyebabkan perubahan serviks

berupa penipisan (efacement) dan pembukaan serviks secara perlahan hingga mencapai sekitar 3–4 cm(N. Jayne Klossner, n.d.).

Fase ini merupakan transisi dari kehamilan ke persalinan aktif dan bisa berlangsung selama 8–12 jam pada primigravida dan lebih singkat pada multigravida.

Ciri-ciri fase laten di antaranya:

1. Frekuensi kontraksi: tidak terlalu sering (setiap 5–10 menit)
2. Durasi kontraksi: 20–40 detik
3. Intensitas kontraksi: ringan hingga sedang
4. Pembukaan serviks: 0–3 atau 4 cm
5. Penurunan kepala janin: mulai masuk PAP
6. Ibu masih tampak tenang, mampu berjalan dan berbicara selama kontraksi
7. Status ketuban: masih utuh

Kala I fase aktif

Kala I fase aktif adalah tahap lanjutan dari proses pembukaan serviks dalam persalinan kala I, yang dimulai dari pembukaan ≥ 4 cm hingga mencapai **pembukaan lengkap 10 cm**. Pada fase ini, kontraksi menjadi lebih kuat, sering, dan teratur, yang menyebabkan dilatasi serviks berlangsung lebih cepat dibanding fase laten(Cunningham., Leveno., Bloom., Hoffman., Casey., 2015).

Fase aktif merupakan bagian kritis dalam persalinan karena merupakan periode kemajuan persalinan yang paling signifikan, baik dari segi pembukaan serviks maupun penurunan kepala janin ke jalan lahir.

Karakteristik fase aktif meliputi:

1. **Frekuensi kontraksi:** setiap 2–3 menit
2. **Durasi kontraksi:** 45–60 detik
3. **Intensitas kontraksi:** sedang hingga kuat
4. **Pembukaan serviks:** dari 4 cm sampai 10 cm
5. **Penurunan kepala janin:** semakin ke bawah, memasuki rongga panggul
6. **Ketuban:** bisa masih utuh atau sudah pecah

Asuhan yang di berikan meliputi:

1. pengkajian awal: melakukan anamnesis lengkap (riwayat ostetri, penyakit, status gizi dll), pemeriksaan fisik umum (tekanan darah, nadi, suhu, respirasi), pemeriksaan abdomen (tinggi fundus uteru, presentasi, denyut jantung janin), dan pemeriksaan dalam (pembukaan, penurunan kepala, effacement, ketuban)

2. monitoring berkala:

Parameter	Frekuensi
DJJ	Tiap 30 menit
Kontraksi uterus	Tiap 30 menit
TTV (TD, nadi, suhu)	Setiap 4 jam
Pembukaan serviks	Setiap 4 jam atau bila ada perubahan klinis

- dukungan psikologis dan fisik meliputi: melakukan pendampingan ibu selama proses persalinan, mengajarkan teknik pernafasan, memberikan cairan/ energy oral, dan memposisikan ibu senyaman mungkin (mobilisasi)
- pencegahan infeksi: dengan melakukan cuci tangan dengan benar, menggunakan APD, meminimalkan pemeriksaan dalam
- pendokumentasian menggunakan partograf untuk memantau kemajuan persalinan secara sistematis.

Komplikasi yang harus di waspadai meliputi, persalinan lama / *obstructed labor*, ketuban pecah dini, gawat janin (DJJ abnormal), dan infeksi intra uterin(Yulianti, 2006).

Kala I selesai jika pembukaan lengkap, ibu ingin mendedan secara alami, dan penurunan kepala janin di dasar panggul.

Berikut asuhan keperawatan pada persalinan kala I

1. Pengkajian

a. data subyektif

ibu mengeluh nyeri perut (kenceng-kenceng), rasa mulas, tegang di perut bagian bawah dan kecemasan, ketakutan, atau kelelahan.

b. data obyektif

frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi uterus, pembukaan serviks (hasil VT/pemeriksaan dalam), denyut jantung janin (DJJ) dengan Doppler/fetoscope, keadaan umum ibu (tanda vital:TD,N,RR,suhu tubuh), kondisi ketuban (ketuban utuh/pecah, warna dan bau cairan ketuban)

2. Diagnosis keperawatan yang mungkin

- nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus
- cemas berhubungan dengan proses persalinan yang sedang berlangsung
- risiko gangguan perfusi janin berhubungan hipoksia akibat kontraksi uterus
- risiko infeksi berhubungan dengan pecahnya ketuban

3. Perencanaan keperawatan

- menilai secara berkala kontraksi uterus dan DJJ
- mendorong teknik relaksasi dan pernafasan dalam

- c. memberikan dukungan emosional dan informasi selama proses persalinan
- d. menjaga kebersihan daerah genital untuk mencegah infeksi
- e. memberikan edukasi tentang proses persalinan kepada ibu dan keluarga
- f. mempersiapkan kemungkinan rujukan bila terdapat komplikasi
- g. mengajarkan keluarga untuk memberikan dukungan (Lubis et al., 2022)

4. Implementasi keperawatan

- a. monitor tanda-tanda vital dan DJJ setiap 30-60 menit
- b. catat hasil VT setiap 4 jam atau sesuai indikasi
- c. damping ibu secara terus menerus (*continous support*)
- d. anjurkan ibu untuk mobilisasi ringan sesuai kemampuan
- e. pastikan hidrasi cukup dan membantu penuhi kebutuhan nutrisi ringan
- f. jaga privasi dan kenyamanan ibu

5. Evaluasi

- a. ibu menunjukkan penurunan tingkat kecemasan dan mampu mengontrol nyeri dengan teknik relaksasi
- b. kontraksi uterus teratur dan efektif, pembukaan serviks progresif
- c. DJJ dalam batas normal
- d. Tidak terjadi infeksi atau komplikasi selama kala I

D. Kala II persalinan

Kala II persalinan adalah fase sejak pembukaan serviks telah lengkap (10 cm) hingga bayi dilahirkan secara utuh. Pada tahap ini, ibu mulai melakukan mengedan secara aktif, kontraksi uterus menjadi lebih kuat dan terkoordinasi, serta janin mengalami proses penurunan dan pengeluaran melalui jalan lahir. Kala II sering disebut sebagai fase pengeluaran bayi, dan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keberhasilan dan keamanan persalinan, baik bagi ibu maupun bayi.

Durasi kala II antara primigravida dan multi gravida terdapat perbedaan. Pada primigravida biasanya berlangsung selama 30 menit hingga 2 jam dan pada multigravida biasanya lebih singkat, yaitu 15 menit hingga 1 jam. Durasi bisa lebih panjang pada ibu dengan anestesi epidural, posisi janin yang tidak optimal, atau kelemahan kontraksi uterus (Leniwita, 2019).

Tanda kala II dimulai dapat dikenali dengan adanya pembukaan serviks lengkap (10 cm), ibu merasakan dorongan kuat untuk mengejan, terjadi tekanan pada rectum, sering disertai dengan refleks defekasi, penampakan bagian terendah janin di introitus (*crowning*), perineum mulai menonjol dan membuka, serta kontraksi uterus yang semakin kuat, sering dan lama.

Tujuan asuhan Kala II ini membantu proses pengeluaran janin dengan aman dan efektif, mencegah terjadinya trauma jalan lahir, menjaga kesejahteraan ibu dan bayi, dan memberikan dukungan fisik dan emosional selama proses mengejan.

Asuhan yang dilakukan pada fase ini meliputi:

1. Pemantauan kondisi ibu dan janin: pemantauan DJJ setiap 5 menit atau setiap kontraksi, kontraksi uterus (frekuensi, durasi, kekuatan), tanda vital ibu setiap 15-30 menit, observasi tanda-tanda kelelahan ibu, nyeri berlebihan, atau kesulitan mengejan
2. Pendampingan dan dukungan mendedan dengan membimbing ibu untuk mendedan hanya saat kontraksi berlangsung, menganjurkan posisi yang efektif dan nyaman (jongkok, miring, duduk), hindari mengejan sebelum pembukaan lengkap, beri istirahat di antara kontraksi.
3. Persiapan tindakan saat bayi lahir dengan mempersiapkan alat persalinan dan resusitasi neonates, melakukan teknik perineal protection untuk mencegah ruptur perineum, mendokumentasikan waktu lahir dan kondisi bayi.
4. Tatalaksana setelah bayi lahir dengan mengeringkan bayi dengan segera, memastikan jalan napas terbuka, tangis spontan, meletakkan bayi di dada ibu (IMD bila memungkinkan), dan mengklem dan memotong tali pusat secara aseptik.

Kala II berakhir jika bayi lahir seluruhnya, tangisan spontan bayi terdengar, ibu merasakan kelegaan setelah bayi lahir, dan siap masuk ke kala II (pengeluaran plasenta)

Komplikasi yang harus di waspadai meliputi gawat janin (DJJ abnormal), perlukaan jalan lahir berat (rupture perineum, vagina, serviks), retensi kepala janin (pada persalinan sungsang), distosia bahu, kelelahan ibu hingga tidak mampu mengejan.

Asuhan keperawatan kala II persalinan

1. Pengkajian

a. Data subyektif:

Ibu merasa ingin meneran. Perasaan tertekan di perineum atau rectum seperti ingin BAB, meningkatnya intensitas kontraksi.

b. Data obyektif:

Pembukaan lengkap (10cm), kepala janin sudah masuk panggul dan terlihat di introitus, DJJ di pantau setiap 5 menit atau setelah setiap kontraksi, status ketuban (pecah/tidak), dan tanda vital ibu

2. Diagnose keperawatan yang mungkin

- a. Nyeri akut berhubungan dengan distensi serviks dan peregangan perineum
- b. Risiko kelelahan berhubungan dengan upaya mengejan yang lama

- c. Risiko cedera pada ibu atau janin berhubungan dengan kemajuan persalinan yang tidak efektif
- d. Ansietas berhubungan dengan proses kelahiran bayi

3. Perencanaan keperawatan

- a. Menunjang proses persalinan spontan yang aman
- b. Menjaga keselamatan ibu dan bayi
- c. Memberikan dukungan emosional dan fisik pada ibu
- d. Menurangi risiko robekan jalan lahir

4. Implementasi keperawatan

- a. Pemantauan dan dukungan
Monitor DJJ setiap 5 menit, pantau kontraksi uterus dan kemajuan persalinan, anjurkan ibu mengejan saat kontraksi dan istirahat saat tidak berkontraksi, anjurkan posisi optimal untuk mengejan (setengah duduk, jongkok, lateral)
- b. Pencegahan trauma perineum
Kompres hangat pada perineum untuk mencegah robekan, siapkan episiotomy bila ada indikasi (misalnya: gawat janin, perineum kaku)
- c. Dukungan emosional
Dampingi ibu selama proses mengejan, berikan pujian, panduan dan motivasi
- d. Persiapan kelahiran
Siapkan alat dan bahan untuk kelahiran bayi (set partus), pastikan kebersihan dan sterilitas, lakukan maneuver kelahiran bayi secara hati-hati, keringkan bayi dan pastikan jalan napas terbuka (penilaian APGAR 1 menit)

5. Evaluasi

- a. Bayi lahir dengan selamat
- b. Ibu dalam keadaan stabil, tidak ada robekan berat atau perdarahan berlebihan
- c. DJJ stabil sebelum lahir
- d. Ibu menunjukkan pemahaman dan kepuasan atas proses persalinan

E. Kala III

Kala III persalinan adalah fase sejak bayi lahir hingga pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Tahapan ini disebut juga sebagai *tahap pengeluaran ari-ari* dan merupakan fase yang sangat penting karena berisiko terjadinya perdarahan postpartum, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di dunia.

Kala III secara normal berlangsung selama 5 -30 menit dan jika lebih dari 30 menit dan plasenta belum lahir yang disebut retensio plasenta.

Tanda kala III meliputi Rahim mengeras (kontraksi uterus), tali pusat memanjang ke luar, pancaran darah tiba-tiba, plasenta mulai tampak di introitus vagina, dan penonjolan fundus ke atas.

Asuhan kala III bertujuan untuk mengeluarkan plasenta dan selaput ketuban secara lengkap dan aman, mencegah dan menangani perdarahan postpartum dan menjaga kondisi ibu tetap stabil pasca persalinan.

Manajemen aktif kala III (AMTSL- *active management of third stage of labor*) yang merupakan standar WHO dan kemenkes RI)

1. Pemberian oksitosin diberikan segera setelah bayi lahir (dalam 1-2 menit) dengan dosis 10IU IM atau IV pelan
2. Penegangan terkendali pada tali pusat (controlled Cord traction-CCT) dengan salah satu tangan di atas symphysis
3. Pijatan fundus uteri, dilakukan untuk memastikan terjadinya kontraksi uterus dan mencegah terjadinya atonia uteri

Selain itu perlu melakukan pemeriksaan plasenta dan selaput untuk memastikan kelengkapan plasenta dan selaput, pemeriksaan jalan lahir untuk mendeteksi lacerasi, dokumentasi jumlah perdarahan, observasi tanda-tanda vital dan pemberian kenyamanan dan dukungan psikologis pada ibu.

Tanda bahaya pada kala III meliputi perdarahan berlebihan (>500ml), plasenta tidak lahir dalam 30 menit, plasenta lahir tidak lengkap, dan Rahim berkontraksi (atonia uteri).

Komplikasi yang dapat terjadi pada kala III meliputi retensio plasenta, atonia uteri, inversion uteri, dan lacerasi jalan lahir (Susilaningrum et al., 2013).

Jika terjadi retensi plasenta artinya terjadi kondisi di mana plasenta tidak lahir dalam waktu lebih dari 30 menit setelah bayi lahir, meskipun kontraksi uterus adekuat dan tidak ada perdarahan hebat. Kondisi ini berisiko tinggi menyebabkan perdarahan postpartum, infeksi, bahkan syok. Jenis Retensio plasenta meliputi adherens disebabkan karena implantasi terlalu dalam, plasenta insersus yaitu terlepas tetapi terperangkap karena uterus tidak berkontraksi dengan baik atau serviks menutup, dan plasenta tertinggal sebagian yaitu Sebagian jaringan plasenta tertinggal dalam uterus. Penanganan awal meliputi evaluasi kontraksi dan tanda vital ibu, cek pelepasan plasenta, lakukan manajemen aktif kala III, massase uterus, penegangan terkendali tali pusat, pemberian uterotonika berupa oksitosin, ergometrin, atau misoprostol, jika masih belum berhasil langkah sebelumnya maka dilakukan tindakan invasive berupa manual plasenta dengan cara tabgan dimasukkan ke dalam uterus secara perlahan, pisahkan plasenta dari dinding uterus dengan jari, angkat plasenta keluar seluruhnya dan periksa kelengkapan plasenta dan selaput. Dan jika plasenta manual tidak berhasil, lakukan rujukan segera.

Asuhan keperawatan persalinan kala III

1. Pengkajian

a. Data subyektif

Ibu merasa kontraksi uterus masih berlangsung meskipun bayi telah lahir, muncul kelegaan, rasa lelah, atau cemas terkait pengeluaran plasenta.

b. Data obyektif

1) Tanda pelepasan plasenta

Perubahan bentuk dan posisi uterus (menjadi bulat dan keras), tali pusat bertambah panjang, pancaran /semburan darah secara tiba-tiba.

2) Evaluasi kontraksi uterus

3) Tanda vital (TD, N,S,RR)

2. Diagnose keperawatan yang mungkin

a. Risiko perdarahan berhubungan dengan retensio palenta atau atonia uteri

b. Nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus dan penegeluaran plasenta

c. Cemas berhubungan dengan kekhawatiran terhadap kondisi pasca persalinan

3. Perencanaan keperawatan

a. Memastikan plasenta lahir lengkap dan utuh

b. Mencegah perdarahan

c. Kestabilan kondisi ibu

d. Memberikan dukungan emosional pada ibu

4. Implementasi keperawatan

a. Manajemen aktif kala III sesuai standar WHO:

Pemberian oksitosin 10 IU IM dalam 1 menit setelah bayi lahir (jika tidak ada kontraindikasi), penegangan tali pusat terkendali (controlled cord traction/brant-Andrews), dan pijatan uterus setelah plasenta keluar untuk merangsang kontraksi.

b. Tindakan lainnya

Observasi perdarahan pervaginam dan pemeriksaan kelengkapan plasenta dan selaput ketuban, dokumentasikan waktu lahirnya plasenta, menilai tanda-tanda vital ibu secara berkala, dan bersihkan dan jahit luka jalan lahir bila diperlukan dan berikan kenyamanan dan informasi yang menenangkan.

5. Evaluasi

a. Plasenta dan selaput lahir lengkap

b. Tidak terjadi perdarahan lebih dari 500 ml

c. Tanda vital ibu stabil

d. Ibu tampak tenang, nyeri berkurang, dan mendapat dukungan

e. Uterus berkontraksi baik dan keras.

F. Kala IV

Kala IV persalinan adalah periode 1-2 jam pertama setelah lahirnya plasenta, di mana ibu berada dalam masa observasi ketat untuk mendeteksi komplikasi dini seperti perdarahan postpartum syok dan gangguan vital lainnya. Dan ini merupakan tahap awal masa pemulihan pasca salin.

Tujuan kala IV adalah memastikan kontraksi uterus efektif (mencegah atonia), mengobservasi jumlah perdarahan postpartum, menilai stabilitas hemodinamik ibu (TD, nadi, pernafasan), menilai kondisi luka jalan lahir, dan membangun ikatan awal ibu dan bayi (IMD dan rawat gabung)

Pelayanan kala IV meliputi:

1. observasi dan monitoring
2. perawatan fisik
3. dukungan psikologis
4. pencegahan komplikasi

Akhir kala IV bila kondisi stabil dan tidak ada komplikasi, ibu bisa di pindahkan ke ruang pemulihan/postpartum dan lanjutkan pemantauan rutin persalinan.

Asuhan keperawatan persalinan kala III

1. Pengkajian

a. Data subyektif

Ibu merasa lelah setelah proses persalinan, ibu mengeluh nyeri pada perut bagian bawah akibat kontraksi uterus pasca persalinan, ibu merasa haus dan lapar, ibu ingin memeluk atau menyusui bayinya

b. Data obyektif

- 1) Tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan
- 2) Tinggi fundus uteri: seharusnya setinggi pusat dan keras (berkontraksi baik)
- 3) Jumlah perdarahan <500ml
- 4) Keadaan perineum/jika jahitan (bila ada)
- 5) Kandung kemih: penuh atau tidak
- 6) Keadaan emosional ibu: tenang, cemas, atau menangis
- 7) bayi telah melakukan IMD (bila memungkinkan)

2. Diagnose keperawatan yang mungkin

- a. Risiko perdarahan berhubungan dengan atonia uteri atau retensio jaringan
- b. Nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus pasca persalinan
- c. Risiko infeksi berhubungan dengan luka jalan lahir atau prosedur invasif
- d. Kelelahan berhubungan dengan proses persalinan yang lama
- e. Kurang pengetahuan tentang perawatan bayi baru lahir dan laktasi.

3. Perencanaan keperawatan

- a. Tujuan: ibu tidak mengalami perdarahan, ibu dalam kondisi stabil dan nyaman, meningkatkan ikatan ibu dan bayi, meningkatkan pengetahuan ibu tentang perawatan diri dan bayi
- b. Target waktu: dalam 2 jam postpartum, uterus berkontraksi baik dan tanda vital stabil, ibu mampu melakukan IMD, ibu memahami pentingnya menjaga kebersihan luka dan tanda bahaya pasca persalinan.

4. Implementasi keperawatan

a. Pemantauan

Tanda vital setiap 15 menit (1 jam pertama), lalu setiap 30 menit, jumlah perdarahan pervaginam (normal <500ml), kontraksi dan tinggi fundus uteri, dan observasi luka jalan lahir dan jahitan.

b. Tindakan

Pijatan uterus setiap 15 menit, Anjurkan ibu untuk berkemih agar uterus dapat berkontraksi optimal, Ganti pembalut/kain alas secara berkala, Bersihkan perineum dengan air hangat steril, Berikan kenyamanan: makanan/minuman ringan, posisi nyaman, Lakukan IMD dan dukung pemberian ASI, dan Edukasi tentang tanda bahaya postpartum, kebersihan, dan perawatan bayi

5. Evaluasi

- a. Uterus keras dan terletak di tengah, tidak ada perdarahan abnormal
- b. Tanda vital dalam batas normal
- c. Ibu merasa nyaman dan tidak nyeri berat
- d. IMD berhasil dilakuakn dan ibu mulai menyusui
- e. Ibu memahami cara merawat diri dan bayi

G. Simpulan

Asuhan keperawatan persalinan merupakan bagian integral dari proses pelayanan kebidanan dan keperawatan maternitas yang bertujuan untuk memastikan ibu dan bayi melalui proses persalinan dengan aman, nyaman, dan minim risiko. Asuhan ini mencakup pendekatan menyeluruh pada setiap tahapan persalinan (kala I sampai kala IV), dengan fokus pada pengajian yang komprehensif terhadap kondisi ibu dan janin secara fisik, psikologis, dan emosional, penetapan diagnosa keperawatan yang akurat sebagai dasar intervensi, perencanaan dan implementasi tindakan keperawatan yang bersifat suportif, preventif, kuratif, dan promotif, dan Evaluasi berkala untuk menilai respons ibu dan janin terhadap intervensi yang diberikan. Paran perawat sangat penting dalam memantau tanda-tanda bahaya persalinan, meningkatkan kenyamanan dan rasa aman ibu, mendorong proses fisiologis seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD), mencegah

komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi, dan trauma jalan lahir, dan Memberikan dukungan emosional dan edukasi kepada ibu dan keluarga. Asuhan keperawatan yang efektif dan empatik selama persalinan dapat meningkatkan keselamatan maternal dan neonatal, mempercepat pemulihan ibu, serta memperkuat ikatan awal ibu dan bayi.

H. Referensi

- Atin karjatin. (2015). keperawatan Maternitas. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>[Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt](https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt)<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Manajemen Kehamilan dan Persalinan*.
- Cunningham., Leveno., Bloom., Hoffman., Casey., S. (2015). *Williams Obstetrics*.
- Dewi Nopiska Lilis, Rif'atun Nisa, Rosmaria Manik, Mercy Joie Kaparang, Dina Indarsita, Dwi Suprpti, Herinawati, Ika Apriyanti. Sjenny Olga Tuju, Nita Tri Wahyuni, Rici Gusti Maulani, E. N. T. H. S. N. (2024). *Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir* (Yuniar Ekasaputri Burhanuddin (ed.); Issue Table 10).
- Hartati, S., Hinonaung, J. S. H., Winarti, R., Nurhayati, N., & Cahyani, S. L. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas Untuk Diii Keperawatan*.
- Leniwita, H. (2019). Petunjuk Praktikum Modul Keperawatan Maternitas. *Universitas Kristen Indonesia*, 1–225.
- Lubis, D. P. U., Samutri, E., Murniasih, E., Dewi, I. M., Haryanti, P., & Wahyuningsih. (2022). Buku Ajar Perawatan Mternitas. In <https://medium.com/> (Vol. 3). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- N. Jayne Klossner, N. T. H. (n.d.). *Introductory Maternity & Pediatric*.
- Oktarina, M. (2015). *Buku ajar asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir*.
- Putri, A. P., & Handayani, R. T. (2025). *Keperawatan Maternitas Berbasis Islami: Keterampilan dan Prosedur Klinis*. [http://repository.stikesmus.ac.id/80/1/Keperawatan Maternitas Berbasis Islami.pdf](http://repository.stikesmus.ac.id/80/1/Keperawatan%20Maternitas%20Berbasis%20Islami.pdf)

Rosyati, H. (2017). *Asuhan Kebidanan Persalinan*.

Susilaningrum, R., Nursalam, & Utami, S. (2013). *Asuhan Keperawatan Bayi Dan Anak Untuk Perawat Dan Bidan*.

Widiatmika, K. P. (2015). Maternity Nursing (An Introductory Text). In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).

Yulianti, D. (2006). *Buku Saku Manajemen KOMplikasi Kehamilan dan Persalinan*. EGC.

I. Glosarium

Adekuat	: cukup, memadai, atau memenuhi syarat
Anestesi epidural	: prosedur medis di mana obat bius (anestesi lokal) disuntikkan ke dalam ruang epidural di sekitar tulang belakang untuk memblokir rasa sakit di area tubuh tertentu
APD	: singkatan dari Alat Pelindung Diri. adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi diri dari potensi bahaya di lingkungan kerja atau saat melakukan aktivitas tertentu
<i>Ari-ari</i>	: plasenta
Aspek klinis	: segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamatan, diagnosis, dan penanganan kondisi kesehatan seseorang, baik dalam konteks medis maupun psikologis
Asuhan persalinan normal (APN)	: serangkaian tindakan yang diberikan pada ibu selama proses persalinan normal untuk memastikan persalinan yang aman dan bersih, serta mencegah terjadinya komplikasi
Atonia uteri	: kondisi ketika otot rahim (miometrium) gagal berkontraksi secara adekuat setelah melahirkan, baik setelah persalinan normal maupun operasi Caesar

BAB	: Buang air besar
Bonding ibu-bayi	: proses penting untuk membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak, yang sangat berpengaruh pada perkembangan bayi
<i>Crowning</i>	: saat kepala bayi terlihat jelas melalui lubang vagina dan tidak kembali masuk saat kontraksi berhenti
Diagnose	: penentuan jenis masalah keperawatan dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya dan tandanya dari data subyektif dan pemeriksaan fisik
DJJ	: Denyut jantung janin
Ergometrin	: obat yang digunakan untuk menyebabkan kontraksi rahim
<i>Evidence-based practice</i>	: pendekatan pengambilan keputusan yang memadukan bukti penelitian terbaik yang tersedia dengan keahlian klinis serta nilai dan preferensi pasien
Holistic	: pendekatan atau metode yang mempertimbangkan seluruh aspek suatu masalah atau situasi, bukan hanya bagian-bagiannya secara terpisah dalam konteks keperawatan adalah memperhatikan aspek sifik, erosional, spiritual, social dan lainnya
Implantasi	: proses tertanamnya sel telur yang telah dibuahi (embrio) pada dinding rahim
Infeksi	: kondisi ketika mikroorganisme (seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit) masuk ke dalam tubuh dan mulai berkembang biak, menyebabkan penyakit
<i>Informed decision-making</i>	: proses membuat pilihan berdasarkan pengumpulan dan analisis informasi yang relevan untuk memahami hasil potensial dan membuat pilihan terbaik
Inisiasi menyusui dini (IMD)	: proses meletakkan bayi segera setelah lahir di dada ibu, memungkinkan bayi mencari puting susu ibu dan mulai menyusui secara alami dalam waktu satu jam setelah lahir
Invasive	: Bersifat serbuan, mendadak
Kemampuan klinis	: kemampuan seorang tenaga kesehatan untuk melakukan serangkaian tindakan dan prosedur medis yang kompleks dalam praktik klinis sehari-hari, berdasarkan

		pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dimilikinya
Komprehensif	:	Luas dan lengkap
Kontraksi	:	pengerutan atau penegangan otot yang terjadi secara alami, baik pada otot tubuh secara umum maupun otot rahim pada ibu hamil dan bersalin
Manajemen kala iii	aktif :	serangkaian tindakan yang dilakukan secara proaktif oleh tenaga kesehatan untuk membantu pengeluaran plasenta setelah bayi lahir, dengan tujuan mengurangi risiko perdarahan pascapersalinan
Manuver	:	Gerakan tangan dalam menolong persalinan
Misoprostol	:	obat untuk mengatasi tukak lambung atau ulkus duodenum akibat penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS), tetapi obat ini dapat pula meningkatkan kontraksi rahim
Multigravida	:	istilah dalam kebidanan yang merujuk pada seorang wanita yang sedang hamil untuk kedua kalinya atau lebih
N	:	nadi
Obyektif	:	proses pengumpulan informasi yang dapat diamati, diukur, atau diverifikasi secara langsung oleh perawat, bukan berdasarkan persepsi atau perasaan pasien
Oksitosin	:	obat untuk memperkuat kontraksi rahim
Partus	:	istilah lain untuk persalinan atau melahirkan
Partograf	:	alat bantu untuk membuat keputusan klinik, memantau, mengevaluasi dan menatalaksan persalinan
Persalinan berpusat pada ibu (<i>woman-centered care</i>)	:	pendekatan dalam pelayanan kebidanan yang menempatkan kebutuhan, harapan, dan aspirasi ibu sebagai pusat perhatian utama
Postpartum	:	periode waktu setelah melahirkan yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika organ reproduksi wanita kembali ke kondisi sebelum hamil
Primigravida	:	istilah yang digunakan untuk seorang wanita yang sedang hamil untuk pertama kalinya

Prinsip	: aturan, ketentuan, dasar, atau asas yang menjadi pedoman untuk berpikir, bertindak, atau mengambil keputusan
Rahim	: organ reproduksi wanita berbentuk buah pir yang terletak di rongga panggul, di antara kandung kemih dan rektum
Retensio plasenta	: kondisi ketika plasenta atau ari-ari tidak keluar dari rahim setelah 30 menit pasca persalinan bayi
Riwayat obstetric	: catatan medis yang merinci semua pengalaman kehamilan dan persalinan seorang wanita
RR	: Respiratory Rate (Frekuensi Pernapasan) atau Risk Reward Ratio (Rasio Risiko/Imbalan) dalam konteks trading.
Status ketuban	: kondisi air ketuban yang meliputi volume dan warna
Sterilitas	: keadaan bebas dari mikroorganisme hidup, termasuk bakteri, virus, dan jamur
Subyektif	: proses mengumpulkan informasi dari pasien mengenai perasaan, persepsi, dan pengalaman mereka terkait kondisi kesehatan mereka
Syok	: kondisi serius di mana aliran darah ke organ-organ tubuh tidak mencukupi, menyebabkan kekurangan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan
TD	: Tekanan darah, kekuatan yang diberikan darah pada dinding arteri saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh
Terstandarisasi	: disesuaikan dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan
TTV	: Tanda-tanda vital yaitu pengukuran fungsi tubuh yang paling mendasar dan penting untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Tanda-tanda vital yang umum diukur meliputi suhu tubuh, denyut nadi (detak jantung), laju pernapasan, dan tekanan darah
Uterotonika	: obat atau zat yang digunakan untuk merangsang kontraksi otot rahim (uterus)
VT	: Vaginal toucher, prosedur medis untuk memeriksa kondisi jalan lahir, khususnya

CHAPTER 7

ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASA NIFAS DAN LAKTASI

Apri Nur Wulandari, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa nifas merupakan periode yang sangat penting dalam kehidupan seorang perempuan setelah melahirkan, yang biasanya berlangsung selama enam minggu atau sekitar 42 hari pascapersalinan. Pada masa ini, ibu mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan psikologis untuk kembali ke kondisi seperti sebelum kehamilan. Secara fisiologis, masa nifas ditandai dengan proses involusi uterus, yaitu kembalinya rahim dari ukuran yang besar saat kehamilannya menuju ke ukuran semula sebelum kehamilan. Selama periode ini, ibu akan mengalami lokia atau cairan nifas yang keluar dari vagina yang terdiri dari sisa jaringan plasenta, darah, dan sekret lainnya. Selain perubahan pada sistem reproduksi, perubahan juga terjadi pada sistem endokrin, kardiovaskuler, gastrointestinal, muskuloskeletal, serta psikologis. Perubahan psikologis yang sering dialami adalah fluktuasi emosi yang disebabkan oleh faktor hormonal, kelelahan fisik, serta adaptasi dengan peran baru sebagai ibu.

Laktasi adalah proses alami pembentukan dan sekresi Air Susu Ibu (ASI) yang terjadi segera setelah persalinan. Proses ini melibatkan hormon prolaktin yang berperan dalam produksi ASI dan hormon oksitosin yang berperan dalam pengeluaran ASI. Laktasi memiliki peran vital, baik bagi bayi maupun ibu. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi yang memberikan nutrisi optimal, meningkatkan imunitas bayi terhadap penyakit, serta mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Proses menyusui ini juga memberikan manfaat besar bagi ibu seperti mempercepat proses involusi rahim, mengurangi risiko perdarahan postpartum, serta mengurangi risiko berbagai penyakit jangka panjang seperti kanker payudara dan ovarium.

Asuhan keperawatan pada masa nifas dan laktasi memiliki arti penting yang tidak bisa diabaikan. Keperawatan yang baik selama periode ini sangat menentukan pemulihan kondisi ibu serta kesehatan bayi. Tenaga keperawatan yang terampil dan terlatih dapat membantu ibu mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama masa nifas, seperti nyeri pascapersalinan, kelelahan, gangguan emosi, serta masalah terkait laktasi seperti puting lecet, mastitis, dan produksi ASI yang tidak lancar. Lebih jauh lagi, asuhan keperawatan juga berperan dalam mendukung kondisi psikologis

ibu dengan memberikan edukasi, dukungan emosional, serta konseling yang tepat agar ibu merasa percaya diri dan siap menjalani peran barunya sebagai seorang ibu.

Tujuan utama dari asuhan keperawatan pada masa nifas dan laktasi adalah untuk memastikan bahwa kondisi fisik, emosional, dan psikologis ibu kembali pulih secara optimal serta mampu menjalankan fungsinya sebagai ibu dengan baik. Secara khusus, asuhan keperawatan bertujuan untuk membantu proses involusi uterus berlangsung secara efektif, mencegah komplikasi seperti perdarahan postpartum dan infeksi nifas, mendukung proses produksi dan pemberian ASI eksklusif yang sukses, serta memberikan dukungan psikologis yang komprehensif agar ibu dapat beradaptasi secara sehat dengan peran barunya. Selain itu, asuhan keperawatan juga bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam perawatan diri dan bayinya, sehingga ibu mampu mandiri dalam mengelola perawatan nifas dan laktasi dengan percaya diri dan nyaman.

B. Perubahan Fisiologis pada Masa Nifas

Masa nifas adalah periode kritis yang ditandai dengan berbagai perubahan fisiologis signifikan yang dialami oleh seorang perempuan setelah proses melahirkan. Perubahan-perubahan ini melibatkan berbagai sistem tubuh, seperti sistem reproduksi, kardiovaskuler, endokrin dan metabolisme, muskuloskeletal, serta pencernaan dan eliminasi. Pemahaman yang komprehensif tentang perubahan fisiologis ini sangat penting untuk menentukan intervensi keperawatan yang tepat agar ibu dapat pulih secara optimal.

Salah satu perubahan utama terjadi pada sistem reproduksi. Setelah persalinan, tubuh memulai proses involusi, yaitu proses kembalinya organ reproduksi ke keadaan sebelum hamil. Uterus, yang sebelumnya membesar selama kehamilannya, secara bertahap mengecil kembali ke ukuran semula dalam kurun waktu sekitar enam minggu pascapersalinan. Proses ini disertai dengan kontraksi uterus yang seringkali menimbulkan nyeri ringan hingga sedang. Selama involusi uterus, ibu juga mengalami keluarnya lochia, cairan nifas yang berasal dari sisa-sisa darah, lendir, serta jaringan dari rahim. Lochianya sendiri berubah dari lochia rubra (berwarna merah segar), menjadi lochia serosa (kecoklatan), lalu lochia alba (putih kekuningan). Serviks juga mengalami perubahan signifikan, kembali menutup secara bertahap, tetapi tidak lagi memiliki bentuk bulat sempurna seperti sebelum melahirkan. Perubahan lain terjadi pada vagina dan perineum yang mengalami edema serta memar akibat proses persalinan, terutama jika terdapat tindakan episiotomi atau ruptur spontan. Vagina secara perlahan kembali ke elastisitas dan ukuran normalnya dalam beberapa minggu pascapersalinan, sementara luka

episiotomi atau robekan perineum biasanya sembuh secara bertahap dalam waktu 2-4 minggu.

Perubahan selanjutnya adalah pada sistem kardiovaskuler. Selama masa kehamilan, volume darah ibu meningkat hingga sekitar 30-50%, namun setelah persalinan, tubuh secara alami mulai menyesuaikan volume darah kembali ke kondisi sebelum kehamilan. Proses ini menyebabkan perubahan seperti peningkatan sementara curah jantung dalam 24-48 jam pertama pascapersalinan akibat redistribusi volume darah. Selain itu, ibu juga mungkin mengalami bradikardia ringan sebagai respons fisiologis alami. Dalam periode nifas awal, kehilangan cairan secara signifikan melalui urinasi (diuresis postpartum) dan keringat berlebihan (diaforesis postpartum) sering terjadi sebagai mekanisme kompensasi tubuh untuk mengurangi kelebihan cairan. Tekanan darah ibu juga cenderung kembali ke tingkat sebelum kehamilan secara bertahap dalam waktu beberapa minggu, meskipun pada beberapa ibu, perubahan tekanan darah yang signifikan perlu diawasi dengan ketat karena dapat mengindikasikan komplikasi serius seperti preeklamsia postpartum.

Sistem endokrin dan metabolisme juga mengalami perubahan yang penting selama masa nifas. Penurunan dramatis kadar hormon estrogen, progesteron, human chorionic gonadotropin (hCG), dan hormon plasenta lainnya terjadi segera setelah plasenta dilahirkan. Penurunan ini memicu terjadinya perubahan emosional dan psikologis pada ibu, termasuk fluktuasi mood yang dapat menyebabkan baby blues pada sebagian besar perempuan. Penurunan hormon-hormon tersebut juga berpengaruh terhadap laktasi. Dengan menurunnya kadar estrogen dan progesteron, kadar prolaktin meningkat secara signifikan, yang bertanggung jawab atas produksi ASI. Hormon oksitosin juga berperan penting selama masa nifas karena membantu pengeluaran ASI sekaligus membantu kontraksi uterus untuk proses involusi. Metabolisme ibu pascapersalinan umumnya meningkat karena tubuh membutuhkan energi tambahan untuk proses laktasi dan pemulihan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan selama persalinan.

Perubahan signifikan berikutnya terjadi pada sistem muskuloskeletal. Selama kehamilan, tubuh mengalami perubahan struktur muskuloskeletal akibat peningkatan hormon relaksin yang membuat sendi dan ligamen lebih lentur guna mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, kadar relaksin mulai menurun dan menyebabkan sendi dan ligamen secara perlahan kembali ke kondisi semula. Namun, beberapa ibu tetap mengalami ketidaknyamanan pada sendi panggul dan tulang belakang hingga beberapa bulan setelah persalinan. Selain itu, otot-otot perut yang meregang selama kehamilan, khususnya otot rektus abdominis, akan mengalami pemulihan yang disebut proses diastasis rekti. Kondisi

ini biasanya membaik secara bertahap dalam beberapa minggu hingga bulan pascapersalinan, tergantung kondisi fisik dan aktivitas fisik ibu.

Terakhir adalah perubahan pada sistem pencernaan dan eliminasi. Setelah melahirkan, banyak ibu mengalami perlambatan fungsi saluran cerna untuk sementara waktu, terutama dalam beberapa hari pertama setelah persalinan. Ibu seringkali merasakan kembung, konstipasi, dan ketidaknyamanan abdomen. Hal ini terjadi karena penurunan motilitas usus yang disebabkan oleh efek residual hormon progesteron, pengaruh anestesi jika ada, atau rasa takut akibat adanya jahitan pada perineum atau episiotomi yang menyebabkan ibu enggan untuk mengejan saat buang air besar. Perubahan pola eliminasi urine juga sering terjadi akibat trauma kandung kemih selama persalinan, anestesi regional, atau adanya edema jaringan di sekitar kandung kemih. Beberapa ibu mungkin mengalami kesulitan untuk buang air kecil (retensi urine) dalam 24 jam pertama, namun sebagian besar kembali normal dalam beberapa hari.

C. Asuhan Keperawatan pada Masa Nifas

Asuhan keperawatan pada masa nifas adalah serangkaian intervensi profesional yang bertujuan memberikan dukungan fisik, psikologis, emosional, dan sosial kepada ibu yang baru saja melahirkan. Asuhan ini bertujuan memastikan bahwa ibu pulih secara optimal, mencegah komplikasi, serta mendukung ibu dalam menjalani perannya sebagai orang tua baru. Proses keperawatan pada masa nifas mencakup pengkajian yang sistematis, penegakan diagnosis keperawatan yang akurat, implementasi intervensi yang efektif, serta pencegahan dan manajemen komplikasi yang mungkin terjadi.

1. Pengkajian Keperawatan pada Ibu Nifas

Pengkajian merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan masa nifas. Melalui pengkajian yang komprehensif, perawat dapat menentukan kondisi fisik dan psikologis ibu, mengidentifikasi kebutuhan khusus yang dimilikinya, serta menemukan tanda-tanda awal adanya komplikasi.

Dalam melakukan pengkajian, perawat memperhatikan beberapa hal penting, di antaranya:

a. Identitas dan Riwayat Kesehatan Ibu

Perawat menggali data pribadi ibu, riwayat kehamilan, riwayat persalinan (jenis persalinan normal atau operasi Caesar), dan riwayat penyakit sebelumnya untuk mengidentifikasi risiko komplikasi nifas.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik secara rinci mencakup tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh), pemeriksaan tinggi fundus uteri untuk memastikan proses involusi berjalan baik, evaluasi lokia (volume, warna, bau, dan konsistensi), kondisi payudara (produksi ASI, puting, kondisi kulit payudara), luka episiotomi atau jahitan operasi Caesar, serta kondisi ekstremitas untuk deteksi dini trombosis vena dalam (deep vein thrombosis).

c. **Pengkajian Psikologis dan Emosional**

Perawat juga mengidentifikasi respons emosional ibu terhadap kelahiran bayinya, termasuk tanda-tanda stres emosional, kecemasan, kelelahan ekstrem, serta potensi terjadinya depresi postpartum.

d. **Evaluasi Pengetahuan dan Kesiapan Merawat Bayi**

Pengkajian meliputi pengetahuan ibu tentang perawatan bayi, teknik menyusui yang benar, serta dukungan sosial yang dimiliki ibu, terutama dari keluarga.

2. Diagnosa dan Intervensi Keperawatan Umum pada Masa Nifas

Diagnosa keperawatan yang umum terjadi pada masa nifas merupakan rumusan masalah aktual atau potensial yang dihadapi ibu berdasarkan data pengkajian yang didapatkan sebelumnya. Beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul pada ibu nifas antara lain:

a. **Nyeri akut terkait involusi uterus, luka episiotomi, atau jahitan Caesar**

Intervensinya mencakup edukasi tentang teknik relaksasi, pemberian kompres hangat atau dingin, pemberian analgesik sesuai instruksi medis, serta pengaturan posisi yang nyaman bagi ibu.

b. **Risiko infeksi terkait adanya luka perineum atau luka operasi**

Intervensinya adalah edukasi kebersihan personal, perawatan luka yang benar, pemantauan tanda-tanda infeksi seperti demam, bau lokia yang tidak sedap, atau kemerahan pada luka, serta pemberian antibiotik jika diperlukan berdasarkan resep dokter.

c. **Gangguan pola tidur terkait perubahan ritme aktivitas harian akibat perawatan bayi baru lahir**

Intervensinya berupa edukasi untuk memanfaatkan waktu istirahat secara optimal, melibatkan keluarga dalam perawatan bayi, menciptakan suasana nyaman untuk istirahat, serta memberikan teknik relaksasi sederhana yang dapat membantu ibu tertidur lebih cepat.

d. **Risiko konstipasi terkait penurunan motilitas usus pascapersalinan**

Intervensinya meliputi edukasi diet tinggi serat, konsumsi cairan yang cukup, mobilisasi dini pascapersalinan, serta penggunaan pencahar ringan apabila diperlukan atas rekomendasi tenaga medis.

- e. Gangguan menyusui terkait kurangnya pengetahuan atau teknik menyusui yang salah

Intervensinya mencakup edukasi teknik menyusui yang tepat, posisi menyusui yang nyaman, pengenalan tanda-tanda bayi mendapatkan ASI cukup, serta mendukung ibu secara emosional dalam proses menyusui.

- f. Risiko gangguan harga diri atau depresi postpartum terkait perubahan hormonal, fisik, dan peran sosial

Intervensi berupa dukungan emosional, pendampingan psikologis, edukasi tanda-tanda depresi postpartum, serta mengaktifkan dukungan sosial dari pasangan dan keluarga.

3. Pencegahan dan Manajemen Komplikasi Masa Nifas

- a. Perdarahan postpartum (PPH)

Pencegahan meliputi pemantauan ketat terhadap kontraksi uterus, memastikan pengosongan kandung kemih secara teratur, serta edukasi mengenai tanda-tanda perdarahan berlebih. Manajemen jika terjadi perdarahan adalah segera merangsang kontraksi uterus melalui pijat uterus, pemberian uterotonika, serta kolaborasi tim medis untuk intervensi lanjut.

- b. Infeksi nifas (endometritis, infeksi luka, infeksi saluran kemih)

Pencegahan berupa kebersihan diri ibu, perawatan luka steril, edukasi mengenai gejala infeksi, dan pemantauan suhu tubuh ibu secara berkala. Manajemen jika infeksi terjadi adalah pemberian antibiotik berdasarkan resep dokter, perawatan luka secara steril, serta dukungan nutrisi untuk mempercepat pemulihan.

- c. Trombosis vena dalam (DVT)

Pencegahan dilakukan dengan mobilisasi dini, menghindari posisi duduk atau berbaring terlalu lama, serta penggunaan stocking khusus bila diperlukan. Manajemen jika terjadi DVT meliputi pemberian antikoagulan sesuai resep dokter, istirahat ekstremitas yang terkena, dan pemantauan ketat komplikasi emboli paru.

- d. Mastitis

Pencegahan berupa edukasi teknik menyusui yang benar untuk mencegah sumbatan saluran susu, menjaga kebersihan payudara, dan memonitor tanda-tanda awal mastitis seperti nyeri payudara atau kemerahan. Manajemen mastitis dilakukan melalui kompres hangat, pemberian antibiotik sesuai anjuran dokter, serta edukasi ibu agar terus menyusui secara rutin untuk menjaga aliran ASI lancar.

e. Depresi postpartum

Pencegahan melalui edukasi terhadap ibu dan keluarga mengenai tanda-tanda depresi postpartum, mendukung interaksi positif antara ibu dan bayi, serta menyediakan lingkungan yang suportif. Manajemen jika ibu mengalami depresi postpartum adalah konseling psikologis, intervensi psikososial, serta rujukan kepada profesional kesehatan mental bila diperlukan.

4. Pendidikan Kesehatan Ibu dan Keluarga pada Masa Nifas

Pendidikan kesehatan pada masa nifas merupakan bagian integral dan sangat penting dalam asuhan keperawatan. Proses pendidikan ini tidak hanya ditujukan kepada ibu yang baru melahirkan, tetapi juga melibatkan keluarga atau pasangan yang berperan sebagai support system utama. Tujuan utama dari pendidikan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap positif ibu dan keluarganya dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi selama masa nifas. Dengan pemberian informasi yang tepat, ibu dan keluarga diharapkan mampu melakukan perawatan secara mandiri, memahami tanda-tanda komplikasi, serta mengambil keputusan yang bijak terkait perawatan ibu dan bayi selama masa transisi penting ini.

Pendidikan kesehatan masa nifas mencakup beberapa aspek penting yang perlu disampaikan secara komprehensif oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya:

a. Perawatan Diri Ibu pada Masa Nifas

Pendidikan mengenai perawatan diri bertujuan agar ibu mampu melakukan perawatan pribadi yang tepat sehingga dapat pulih secara fisik maupun emosional. Hal yang harus disampaikan kepada ibu dan keluarga meliputi:

1) Kebersihan Diri dan Perawatan Luka

Perawat memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan tubuh secara teratur, khususnya kebersihan daerah genital, luka episiotomi, atau luka bekas operasi Caesar. Ibu diajarkan cara membersihkan luka secara tepat dan mengenali tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, nyeri hebat, dan bau tidak sedap.

2) Pola Aktivitas dan Istirahat

Ibu dan keluarga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya istirahat yang cukup untuk mempercepat proses pemulihan tubuh. Perawat menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam mengatur jadwal aktivitas dan istirahat, serta berbagi tugas dalam merawat bayi agar ibu tidak mengalami kelelahan ekstrem.

3) Nutrisi Seimbang dan Hidrasi

Perawat mengedukasi ibu tentang pentingnya nutrisi seimbang, kaya protein, vitamin, mineral, serta cairan yang cukup. Informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ASI, mempercepat penyembuhan jaringan tubuh, serta menjaga energi ibu selama masa nifas.

b. Edukasi Tentang Menyusui (Laktasi)

Pendidikan tentang menyusui bertujuan mendukung keberhasilan ibu dalam memberikan ASI eksklusif, serta mengurangi berbagai masalah terkait proses menyusui, seperti mastitis, puting lecet, atau produksi ASI yang kurang optimal. Hal penting yang disampaikan antara lain:

1) Teknik Menyusui yang Benar

Ibu perlu diajarkan cara menyusui yang tepat agar bayi mendapatkan cukup ASI dan mencegah luka pada puting. Edukasi meliputi posisi menyusui yang nyaman, cara bayi melekat yang benar (latch-on), serta frekuensi dan durasi menyusui yang efektif.

2) Manajemen ASI Perah

Perawat mengajarkan teknik memerah ASI, menyimpan, serta menghangatkan ASI secara aman untuk mendukung ibu yang kembali bekerja atau ibu yang mengalami kesulitan menyusui langsung.

3) Pencegahan dan Penanganan Masalah Menyusui

Pendidikan juga mencakup informasi mengenai pencegahan komplikasi seperti mastitis, sumbatan saluran ASI, atau abses payudara. Ibu dan keluarga juga diajarkan tanda-tanda masalah yang harus segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan.

c. Pendidikan Kesehatan Mental dan Emosional

Perawat harus memberikan pemahaman mendalam mengenai perubahan psikologis yang umum terjadi pada masa nifas, seperti perubahan mood, baby blues syndrome, hingga depresi postpartum. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga agar mampu memberikan dukungan emosional yang optimal. Materi penting yang disampaikan antara lain:

1) Tanda-tanda Baby Blues dan Depresi Postpartum:

Ibu dan keluarga diajarkan untuk mengenali gejala seperti mudah menangis tanpa alasan jelas, perubahan suasana hati yang drastis, kurang minat terhadap bayi, insomnia atau gangguan tidur yang berat, serta rasa tidak berdaya atau putus asa.

2) Strategi Dukungan Psikologis:

Keluarga diberi edukasi tentang pentingnya komunikasi terbuka, menunjukkan empati, membantu ibu menjalani tugas sehari-hari, serta

kapan harus mencari bantuan profesional bila kondisi emosional ibu semakin berat.

d. Pendidikan tentang Perawatan Bayi Baru Lahir

Aspek penting lain yang perlu disampaikan adalah perawatan bayi baru lahir secara mandiri. Informasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri ibu dan keluarga dalam merawat bayi mereka di rumah, dengan mencakup hal-hal berikut:

1) Perawatan Tali Pusat dan Kulit Bayi:

Ibu diajarkan cara merawat tali pusat agar cepat kering dan mencegah infeksi, serta perawatan kulit bayi yang sensitif dengan menggunakan produk yang aman dan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.

2) Identifikasi Tanda Bahaya pada Bayi Baru Lahir:

Perawat memberikan edukasi tentang tanda-tanda bahaya pada bayi seperti demam tinggi, bayi sulit bernapas, bayi kuning, kejang, muntah terus-menerus, atau diare. Informasi ini sangat penting agar keluarga segera mencari bantuan medis jika gejala tersebut muncul.

3) Imunisasi Dasar:

Ibu dan keluarga dijelaskan tentang jadwal imunisasi dasar bayi, manfaat vaksinasi, serta tempat pelayanan imunisasi terdekat untuk memastikan bayi terlindungi secara optimal dari penyakit menular.

e. Pendidikan tentang Keluarga Berencana (KB) Pascanifas

Edukasi tentang KB penting diberikan sejak masa nifas untuk membantu pasangan dalam merencanakan keluarga secara sehat dan mencegah kehamilan terlalu cepat setelah melahirkan. Edukasi ini meliputi:

1) Jenis-jenis KB yang Aman pada Masa Nifas:

Informasi mencakup metode KB hormonal dan non-hormonal yang aman digunakan selama masa menyusui, seperti KB suntik, pil progestin-only, implan, IUD, atau kondom.

2) Waktu yang Tepat untuk Memulai KB:

Perawat mengedukasi kapan waktu yang tepat untuk mulai menggunakan kontrasepsi pascanifas agar ibu mendapatkan perlindungan maksimal tanpa mengganggu produksi ASI.

3) Konseling KB bagi Pasangan:

Perawat mengajak pasangan atau suami dalam konseling KB, agar keputusan penggunaan kontrasepsi adalah hasil kesepakatan bersama yang memperhatikan kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

D. Konsep Dasar Laktasi

Proses laktasi merupakan bagian alami yang dialami seorang ibu setelah melahirkan, yang melibatkan berbagai mekanisme fisiologis yang kompleks serta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Konsep dasar laktasi merupakan fondasi penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan edukasi dan dukungan yang tepat kepada ibu selama masa menyusui.

Proses laktasi sendiri secara umum diartikan sebagai proses pembentukan dan pengeluaran Air Susu Ibu (ASI) yang terjadi setelah kelahiran bayi, sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi selama bulan-bulan pertama kehidupannya. Proses ini tidak hanya sekedar memberikan makanan kepada bayi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis yang mendalam antara ibu dan bayi.

1. Fisiologi Produksi Air Susu Ibu (ASI)

Produksi ASI melibatkan berbagai sistem tubuh ibu yang bekerja secara harmonis, terutama sistem endokrin yang bertanggung jawab atas pelepasan hormon-hormon penting dalam proses ini. Secara fisiologis, produksi ASI dimulai sejak masa kehamilan, di mana terjadi perubahan signifikan pada jaringan payudara. Jaringan kelenjar susu atau alveoli dalam payudara mengalami proliferasi dan diferensiasi akibat stimulasi hormon estrogen, progesteron, prolaktin, serta Human Placental Lactogen (HPL).

Pada masa kehamilan, hormon estrogen dan progesteron dalam kadar tinggi merangsang pertumbuhan saluran susu dan alveoli sebagai persiapan produksi ASI. Namun, produksi ASI belum terjadi secara aktif karena hormon progesteron yang tinggi menghambat kerja hormon prolaktin. Setelah kelahiran bayi dan keluarnya plasenta, terjadi penurunan drastis hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh ibu. Penurunan hormon tersebut memberikan kesempatan kepada hormon prolaktin untuk berfungsi secara optimal dalam memulai produksi ASI secara aktif. Inilah yang dikenal dengan proses laktogenesis atau permulaan produksi ASI.

Selain prolaktin, proses produksi ASI juga dikontrol oleh hormon oksitosin. Hormon ini berperan dalam proses pengeluaran ASI atau refleksi let-down, di mana rangsangan yang diterima ibu dari hisapan bayi pada payudara akan mengirimkan sinyal melalui saraf ke otak, tepatnya ke hipotalamus dan hipofisis posterior. Hipofisis posterior kemudian merespons dengan melepaskan hormon oksitosin ke aliran darah, yang kemudian menyebabkan otot-otot di sekitar alveoli berkontraksi dan mengalirkan ASI ke saluran susu menuju puting susu untuk dihisap oleh bayi. Proses ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional ibu; rasa nyaman, tenang, dan santai sangat membantu pelepasan hormon oksitosin secara efektif sehingga ASI dapat mengalir lancar.

2. Faktor yang Mempengaruhi Produksi ASI

Proses produksi ASI dalam tubuh ibu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Secara internal, faktor-faktor fisiologis seperti keseimbangan hormon dalam tubuh ibu menjadi sangat penting. Hormon prolaktin dan oksitosin merupakan hormon utama dalam proses ini, namun keberhasilan pelepasan hormon tersebut sangat tergantung pada kondisi emosional ibu. Ibu yang mengalami stres atau kecemasan tinggi seringkali mengalami hambatan dalam produksi ASI karena hormon stres seperti kortisol dapat menekan pelepasan oksitosin.

Status gizi dan hidrasi ibu juga sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI yang dihasilkan. Ibu yang mendapatkan nutrisi seimbang, terutama yang kaya protein, vitamin, dan mineral, akan memiliki ASI dengan kualitas yang baik. Sebaliknya, kondisi malnutrisi, dehidrasi, atau kurangnya asupan makanan dan minuman ibu dapat menyebabkan penurunan volume dan kualitas ASI. Oleh sebab itu, perawat perlu memastikan ibu mendapatkan edukasi yang tepat mengenai pentingnya nutrisi seimbang serta hidrasi yang cukup selama menyusui.

Selain faktor internal, ada pula faktor eksternal yang berperan besar terhadap produksi ASI. Salah satu faktor yang sangat penting adalah pola menyusui bayi, seperti frekuensi menyusui, durasi menyusui, serta teknik hisapan bayi. Semakin sering bayi menyusu dan semakin efektif teknik menyusuinya, maka produksi ASI akan semakin meningkat karena proses ini menggunakan prinsip supply and demand, yaitu semakin tinggi permintaan bayi terhadap ASI, maka produksi ASI pun akan semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dukungan sosial dari keluarga, pasangan, dan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Ibu yang mendapatkan dukungan psikososial secara maksimal dari pasangan, keluarga, serta tenaga kesehatan cenderung lebih percaya diri, nyaman, dan bebas stres, sehingga produksi ASI bisa lebih optimal. Sebaliknya, ibu yang kurang mendapatkan dukungan atau mengalami tekanan sosial yang negatif, cenderung mengalami kesulitan emosional yang berdampak buruk terhadap produksi ASI.

3. Pentingnya ASI Eksklusif bagi Bayi dan Ibu

ASI eksklusif merupakan pemberian ASI kepada bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya selama enam bulan pertama kehidupannya. ASI eksklusif memiliki manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi bayi, tetapi juga bagi kesehatan fisik dan psikologis ibu.

Bagi bayi, ASI eksklusif merupakan nutrisi ideal yang mengandung komposisi zat gizi yang lengkap dan seimbang, seperti protein, lemak,

karbohidrat, vitamin, mineral, serta berbagai zat kekebalan tubuh (imunoglobulin) yang sangat penting dalam melindungi bayi dari berbagai infeksi. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif terbukti memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, risiko infeksi saluran pernapasan dan pencernaan yang lebih rendah, serta tumbuh kembang fisik dan kecerdasan yang optimal. ASI juga mengandung zat-zat penting yang tidak dapat ditemukan dalam susu formula, seperti asam lemak esensial DHA dan AA, yang berperan penting dalam perkembangan otak bayi.

Selain manfaat fisik, ASI eksklusif juga sangat berperan dalam meningkatkan ikatan emosional (bonding) antara ibu dan bayi. Kontak kulit-ke-kulit yang terjadi selama proses menyusui membantu bayi merasa aman, nyaman, dan terlindungi, yang menjadi dasar penting dalam perkembangan emosional dan psikologisnya.

Sementara bagi ibu, pemberian ASI eksklusif membantu mempercepat pemulihan tubuh setelah melahirkan. Proses menyusui secara rutin akan merangsang kontraksi uterus yang mempercepat proses involusi rahim, sehingga mengurangi risiko perdarahan postpartum. Selain itu, ibu yang menyusui secara eksklusif cenderung lebih cepat kembali ke berat badan semula karena proses menyusui membantu tubuh membakar kalori lebih banyak. Dalam jangka panjang, ibu yang menyusui secara eksklusif juga memiliki risiko lebih rendah terhadap kanker payudara dan kanker ovarium.

Secara psikologis, keberhasilan ibu dalam memberikan ASI eksklusif memberikan rasa pencapaian, kepuasan, serta meningkatkan rasa percaya diri dan keberhargaan diri ibu sebagai seorang wanita dan ibu. Dukungan penuh dari keluarga dan tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan ASI eksklusif ini.

E. Asuhan Keperawatan pada Ibu Menyusui

Asuhan keperawatan pada ibu menyusui adalah suatu bentuk pelayanan keperawatan yang holistik, yang bertujuan mendukung ibu dalam menjalani proses menyusui dengan baik, aman, nyaman, dan optimal. Perawat memegang peranan penting dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta intervensi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama masa menyusui. Asuhan ini meliputi tahapan pengkajian kondisi fisik dan psikologis ibu, penerapan teknik menyusui yang benar, serta identifikasi dini dan penanganan berbagai masalah atau komplikasi yang dapat menghambat kelancaran proses laktasi.

1. Pengkajian Keperawatan pada Ibu Menyusui

Pengkajian keperawatan merupakan langkah awal yang krusial dalam asuhan keperawatan pada ibu menyusui. Dalam tahap ini, perawat melakukan observasi dan wawancara yang komprehensif kepada ibu untuk mengetahui

kondisi kesehatan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, hingga spiritual. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memperoleh data yang akurat tentang kondisi ibu menyusui serta menentukan rencana asuhan yang sesuai dengan kebutuhan individu ibu.

Dalam pengkajian fisik, perawat perlu memperhatikan kondisi payudara ibu, termasuk ukuran, bentuk, simetri, adanya nyeri, kemerahan, bengkak, puting lecet, atau tanda-tanda infeksi seperti mastitis. Selain itu, pengkajian juga mencakup evaluasi produksi ASI dengan memperhatikan tanda-tanda kecukupan ASI seperti frekuensi bayi menyusui, kepuasan bayi setelah menyusui, jumlah popok basah, serta kenaikan berat badan bayi.

Selain aspek fisik, perawat juga perlu mengkaji aspek psikologis ibu. Kondisi emosional ibu seperti kecemasan, depresi, stres, atau kurang percaya diri dalam proses menyusui perlu diidentifikasi sejak dini. Hal ini penting karena kondisi emosional ibu sangat memengaruhi produksi ASI. Faktor sosial-budaya juga perlu dikaji, terutama keyakinan dan praktik budaya ibu mengenai menyusui. Identifikasi dukungan keluarga dan lingkungan sekitar yang diterima ibu juga merupakan hal penting dalam pengkajian ini karena dukungan sosial yang optimal akan meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menyusui bayinya.

2. Teknik Menyusui yang Tepat

Teknik menyusui yang tepat sangat menentukan keberhasilan proses menyusui. Oleh karena itu, perawat perlu memberikan edukasi mendalam kepada ibu mengenai teknik menyusui yang benar sejak dini. Teknik menyusui yang baik diawali dengan posisi tubuh ibu yang nyaman, baik itu posisi duduk, bersandar, maupun berbaring. Perawat perlu menjelaskan pentingnya posisi yang nyaman agar ibu tidak merasa lelah selama proses menyusui, sehingga membantu proses pelepasan hormon oksitosin yang memudahkan aliran ASI.

Setelah posisi ibu nyaman, posisi bayi juga perlu diperhatikan. Tubuh bayi harus menghadap ke arah tubuh ibu secara lurus dengan kepala bayi sedikit menengadahkan, sementara perut bayi menempel pada perut ibu. Perawat harus memastikan bahwa kepala, leher, dan tubuh bayi berada dalam satu garis lurus agar bayi tidak kesulitan saat menelan dan bernapas selama proses menyusui.

Tahapan penting selanjutnya adalah pelekatan bayi pada payudara ibu. Pelekatan yang tepat terjadi ketika bayi membuka mulutnya dengan lebar, sehingga sebagian besar areola (bagian gelap di sekitar puting susu) masuk ke dalam mulut bayi, bukan hanya bagian puting saja. Dengan pelekatan yang benar, bayi dapat menghisap ASI dengan efektif, sehingga tidak menyebabkan nyeri atau luka pada puting ibu, serta menjamin pengosongan payudara secara optimal. Perawat perlu memperhatikan apakah bibir bayi terbuka keluar, dagu

menempel pada payudara, serta gerakan rahang bayi terlihat aktif dalam menghisap ASI.

Selain itu, penting bagi perawat untuk mengajarkan ibu bagaimana mengetahui bayi telah menyusui dengan baik, seperti terlihatnya gerakan menelan bayi, bayi tampak rileks dan puas setelah menyusui, serta tidak adanya nyeri pada payudara ibu. Dengan menguasai teknik menyusui yang tepat, ibu akan merasa lebih percaya diri dalam menyusui bayinya, serta terhindar dari berbagai masalah menyusui seperti lecet puting, nyeri, maupun mastitis.

3. Identifikasi dan Penanganan Masalah Laktasi

Dalam proses menyusui, ibu tidak jarang menghadapi berbagai permasalahan laktasi yang dapat menghambat kelancaran pemberian ASI. Oleh sebab itu, perawat perlu secara proaktif melakukan identifikasi dini terhadap berbagai masalah yang umum terjadi pada ibu menyusui.

Beberapa permasalahan laktasi yang sering terjadi antara lain nyeri atau luka puting susu akibat pelekatan bayi yang kurang tepat, pembengkakan payudara atau engorgement akibat ASI yang tidak dikeluarkan secara optimal, mastitis atau infeksi pada payudara, serta produksi ASI yang kurang. Nyeri atau luka puting susu biasanya disebabkan oleh teknik pelekatan yang salah. Dalam hal ini, perawat harus segera memperbaiki teknik pelekatan bayi serta memberikan edukasi mengenai perawatan puting secara tepat.

Pembengkakan payudara (engorgement) terjadi akibat penumpukan ASI yang tidak dikosongkan secara efektif. Penanganan yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi tentang pentingnya menyusui secara rutin dan teratur, membantu ibu melakukan pemijatan lembut pada payudara, serta mengompres payudara dengan air hangat sebelum menyusui dan kompres dingin setelah menyusui. Mastitis yang ditandai dengan nyeri, kemerahan, bengkak, dan demam harus segera ditangani dengan tindakan medis yang tepat seperti antibiotik dan pengosongan payudara secara teratur.

Produksi ASI yang kurang menjadi permasalahan lain yang sering dihadapi ibu menyusui. Untuk mengatasinya, perawat perlu melakukan identifikasi penyebab rendahnya produksi ASI, seperti stres, nutrisi ibu yang tidak adekuat, atau kurangnya frekuensi menyusui. Setelah itu, perawat bisa memberikan edukasi dan dukungan yang tepat, termasuk mendorong ibu untuk meningkatkan frekuensi menyusui, memastikan asupan nutrisi dan cairan ibu mencukupi, serta memberikan dukungan emosional dan psikososial yang optimal.

4. Pendidikan Kesehatan tentang Menyusui

Pendidikan kesehatan tentang menyusui adalah bagian integral dari asuhan keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri ibu dalam menjalani proses menyusui. Pendidikan ini diberikan secara berkesinambungan, mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga periode nifas dan laktasi. Perawat berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh ibu dan keluarga, agar proses menyusui dapat berjalan dengan optimal serta memberikan manfaat maksimal baik bagi bayi maupun ibu.

Pemberian pendidikan kesehatan tentang menyusui diawali dengan menjelaskan pentingnya Air Susu Ibu (ASI) bagi bayi dan ibu. Perawat perlu menjelaskan kepada ibu bahwa ASI adalah nutrisi terbaik yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Selain memberikan nutrisi ideal, ASI juga mengandung zat imun yang membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi lainnya. Di sisi lain, menyusui juga sangat bermanfaat bagi ibu, karena membantu mempercepat pemulihan setelah persalinan, mengurangi risiko perdarahan postpartum, menurunkan risiko kanker payudara, serta mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

Selanjutnya, pendidikan kesehatan yang diberikan perawat mencakup persiapan ibu sebelum memulai proses menyusui. Dalam tahap ini, perawat akan menjelaskan tentang bagaimana merawat payudara sejak masa kehamilan, seperti menjaga kebersihan payudara, teknik pijat payudara untuk merangsang produksi ASI, serta cara mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk menghadapi proses menyusui. Perawat juga perlu menyampaikan tentang pentingnya dukungan dari suami, keluarga, dan lingkungan sekitar agar ibu merasa percaya diri dan nyaman dalam memberikan ASI kepada bayinya.

Perawat kemudian akan memberikan informasi mendalam mengenai teknik menyusui yang benar, termasuk posisi ibu saat menyusui, posisi bayi, serta pelekatan mulut bayi pada payudara. Teknik menyusui yang benar sangat penting agar bayi dapat mengisap ASI dengan optimal tanpa menyebabkan masalah seperti puting lecet, nyeri, atau mastitis. Selain itu, perawat juga menjelaskan tanda-tanda bayi mendapatkan cukup ASI, seperti bayi tampak puas setelah menyusu, popok bayi yang basah minimal 6–8 kali dalam sehari, serta kenaikan berat badan bayi yang sesuai dengan standar pertumbuhan.

Lebih lanjut, perawat juga akan membahas mengenai jadwal menyusui. Ibu perlu mengetahui bahwa menyusui sebaiknya dilakukan secara on demand atau sesuai keinginan bayi, tanpa harus dibatasi oleh jadwal yang ketat. Dengan

menyusui on demand, produksi ASI akan terangsang secara alami karena semakin sering bayi menyusu, semakin banyak pula produksi ASI yang dihasilkan. Perawat perlu menegaskan bahwa frekuensi menyusui yang sering adalah normal pada bayi baru lahir, karena kapasitas lambung bayi yang masih kecil dan kebutuhan energi bayi yang tinggi.

Selain informasi tentang teknik menyusui dan jadwal menyusui, pendidikan kesehatan tentang menyusui juga mencakup pemberian edukasi mengenai pola makan ibu selama masa menyusui. Perawat harus menyampaikan kepada ibu tentang pentingnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup. Perawat juga menekankan pentingnya konsumsi cairan yang cukup, minimal 2–3 liter per hari, untuk mendukung produksi ASI. Ibu juga dianjurkan menghindari konsumsi makanan atau minuman yang dapat mengganggu produksi ASI seperti minuman beralkohol, berkafein berlebihan, atau obat-obatan tertentu tanpa resep dokter.

Lebih lanjut, perawat juga memberikan edukasi mengenai bagaimana cara menyimpan ASI perah bagi ibu yang bekerja atau memiliki aktivitas di luar rumah. Perawat menjelaskan cara pemerahan ASI secara manual atau menggunakan pompa, prosedur penyimpanan ASI dalam wadah steril, cara penyimpanan yang benar dalam suhu ruangan, kulkas, atau freezer, serta bagaimana proses pencairan dan pemberian ASI perah kepada bayi. Edukasi ini bertujuan untuk memastikan bayi tetap mendapatkan ASI meskipun ibu harus bekerja atau bepergian jauh.

Perawat juga akan memberikan informasi tentang berbagai masalah laktasi yang mungkin timbul selama proses menyusui, seperti puting lecet, engorgement atau payudara bengkak, mastitis, produksi ASI yang kurang, atau kesulitan bayi dalam menyusu. Dalam pendidikan ini, perawat menjelaskan secara rinci penyebab dari masing-masing masalah tersebut, bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan, serta tindakan yang harus diambil jika masalah tersebut terjadi. Perawat perlu memastikan bahwa ibu mampu mengenali tanda-tanda dini masalah tersebut serta mampu mengambil tindakan yang tepat atau segera meminta bantuan tenaga kesehatan jika diperlukan.

Aspek penting lain yang diberikan dalam pendidikan kesehatan adalah pentingnya dukungan emosional dan sosial kepada ibu menyusui. Perawat perlu menginformasikan kepada keluarga, terutama suami dan orang-orang terdekat, tentang pentingnya dukungan psikologis yang dapat membantu ibu merasa nyaman, rileks, dan percaya diri selama menyusui. Dukungan emosional ini dapat berupa pendampingan, dorongan positif, apresiasi, atau membantu ibu dalam pekerjaan sehari-hari agar ibu dapat beristirahat secara optimal.

Melalui pemberian pendidikan kesehatan yang komprehensif ini, ibu diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menyusui bayinya. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi ibu dalam menjalani proses menyusui secara optimal, yang akhirnya berdampak positif pada tumbuh kembang bayi dan kesejahteraan ibu secara menyeluruh.

F. Dukungan Psikologis pada Masa Nifas dan Laktasi

Masa nifas dan laktasi merupakan periode yang sangat penting dan sensitif bagi seorang ibu, tidak hanya karena adanya perubahan fisik yang signifikan, tetapi juga karena perubahan psikologis dan emosional yang kompleks. Pada masa ini, ibu dapat mengalami beragam perasaan mulai dari kebahagiaan, kecemasan, hingga stres dan depresi akibat berbagai adaptasi yang harus dilakukan dalam peran barunya. Oleh karena itu, dukungan psikologis menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik.

Dukungan psikologis terhadap ibu nifas bertujuan untuk memastikan kondisi mental dan emosional ibu tetap stabil dan positif selama proses pemulihan serta dalam menjalankan peran barunya sebagai seorang ibu. Dukungan ini meliputi aspek emosional, sosial, dan spiritual yang harus diberikan secara konsisten dan penuh empati oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat dan keluarga terdekat. Perawat, sebagai pihak yang sering berinteraksi dengan ibu nifas, memiliki peran krusial dalam memberikan pendampingan psikologis yang kontinu sejak ibu menjalani proses persalinan hingga selesai masa nifas dan selama masa laktasi.

Pada masa nifas, ibu kerap mengalami berbagai tantangan psikologis seperti rasa cemas terkait dengan kemampuan merawat bayi, kurang percaya diri terhadap keterampilan menyusui, perubahan pola tidur, hingga perasaan kurang nyaman akibat perubahan fisik yang dialami. Perawat memiliki peran untuk membantu ibu mengidentifikasi serta mengatasi perasaan-perasaan ini melalui pendekatan komunikasi terapeutik yang efektif. Melalui komunikasi terapeutik, perawat mendengarkan keluhan, kekhawatiran, serta harapan ibu dengan penuh perhatian dan empati, sehingga ibu merasa dihargai, didengar, dan tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan selama masa nifas.

Selain itu, perawat juga perlu menerapkan berbagai strategi untuk membantu ibu mengatasi stres dan kecemasan selama masa nifas dan laktasi. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan memberikan edukasi mengenai teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dalam, meditasi ringan, atau aktivitas ringan yang menenangkan seperti mendengarkan musik favorit, membaca buku, maupun berjalan-jalan santai di sekitar rumah. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan fisik dan

mental yang dapat muncul karena perubahan hormonal atau kelelahan akibat aktivitas baru dalam merawat bayi. Dengan menguasai teknik relaksasi, ibu menjadi lebih siap secara psikologis dalam menghadapi tantangan sehari-hari selama masa nifas dan laktasi.

Perawat juga perlu memperkenalkan konsep mindfulness atau kesadaran penuh, yaitu sebuah pendekatan psikologis yang mengajarkan ibu untuk menerima setiap situasi dengan pikiran terbuka tanpa penilaian negatif yang berlebihan. Melalui mindfulness, ibu dilatih untuk tetap berada di masa kini dan fokus pada apa yang bisa dilakukan saat ini tanpa terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal di luar kendali. Praktik mindfulness terbukti mampu menurunkan tingkat kecemasan, meningkatkan ketenangan, dan membantu ibu untuk lebih menikmati momen bersama bayi.

Selain intervensi dari tenaga kesehatan, dukungan psikologis yang kuat juga berasal dari keluarga, terutama suami atau pasangan, serta orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara, atau sahabat. Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan psikologis ibu selama masa nifas dan laktasi. Dukungan keluarga ini dapat diwujudkan dalam bentuk perhatian, kasih sayang, penghargaan terhadap usaha ibu dalam merawat bayi, serta bantuan nyata dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau merawat bayi, sehingga ibu memiliki waktu untuk beristirahat, memulihkan diri, atau sekadar menikmati waktu pribadi yang menenangkan.

Peran suami atau pasangan menjadi kunci penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada ibu. Suami yang secara aktif terlibat dalam perawatan bayi, misalnya membantu mengganti popok, menggendong bayi, atau menemani ibu saat menyusui, akan sangat membantu ibu merasa didukung secara emosional. Keterlibatan aktif ini tidak hanya meringankan beban fisik ibu tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri serta mempercepat pemulihan psikologis ibu pascapersalinan.

Di samping itu, perawat perlu memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya mengenali tanda-tanda gangguan psikologis yang mungkin muncul pada masa nifas seperti baby blues syndrome, kecemasan berlebih, hingga depresi postpartum. Keluarga perlu memahami bahwa kondisi tersebut bukanlah bentuk kelemahan atau ketidakmampuan ibu dalam menjalankan perannya, melainkan kondisi medis yang memerlukan perhatian, dukungan, dan penanganan yang tepat. Oleh sebab itu, keluarga diajarkan untuk tidak memberikan penilaian negatif melainkan memberikan dukungan penuh kepada ibu, serta membantu ibu mendapatkan bantuan profesional jika kondisi psikologis ibu menunjukkan tanda-tanda yang semakin memburuk.

Lebih jauh lagi, keluarga juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif, tenang, nyaman, dan bebas stres bagi ibu. Lingkungan yang kondusif seperti rumah yang bersih, nyaman, serta minim gangguan akan sangat membantu ibu untuk merasa rileks, aman, dan lebih mudah beradaptasi dengan berbagai perubahan yang sedang dialaminya. Selain itu, keluarga juga dapat berperan aktif dengan menjaga pola komunikasi yang baik, membangun percakapan yang positif, dan secara aktif memberikan dukungan serta apresiasi atas usaha ibu dalam menjalankan peran barunya sebagai seorang ibu.

Dengan memberikan dukungan psikologis yang komprehensif seperti ini, ibu diharapkan dapat melewati masa nifas dan laktasi dengan lebih tenang, nyaman, serta mampu menjalani perannya sebagai seorang ibu secara lebih positif. Hasil akhirnya, dukungan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis ibu, meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan, serta menjamin tumbuh kembang bayi yang optimal dalam lingkungan yang penuh cinta dan perhatian.

G. Nutrisi dan Aktivitas Fisik pada Masa Nifas dan Laktasi

Masa nifas dan laktasi merupakan periode penting bagi ibu setelah menjalani persalinan. Selama masa ini, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis yang kompleks serta membutuhkan perhatian ekstra terhadap kebutuhan nutrisi dan aktivitas fisik. Nutrisi yang tepat dan aktivitas fisik yang teratur akan sangat mendukung proses pemulihan fisik, mempercepat penyembuhan jaringan, membantu produksi air susu ibu (ASI), serta meningkatkan kondisi emosional ibu secara keseluruhan.

Kebutuhan nutrisi ibu nifas dan menyusui mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan masa sebelum kehamilan atau selama kehamilan itu sendiri. Pada periode ini, nutrisi tidak hanya digunakan untuk pemulihan tubuh ibu, tetapi juga penting untuk memenuhi kebutuhan bayi yang disusui secara eksklusif. Oleh karena itu, penting bagi ibu nifas untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang, lengkap, dan bervariasi setiap harinya.

Nutrisi yang optimal untuk ibu nifas dan menyusui meliputi konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, mineral, serat, serta cairan yang cukup. Protein memiliki peran vital dalam memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat proses persalinan serta dalam produksi ASI yang berkualitas. Sumber protein terbaik meliputi telur, daging tanpa lemak, ikan, susu, produk susu seperti yogurt dan keju, serta kacang-kacangan.

Karbohidrat kompleks yang berasal dari gandum utuh, beras merah, ubi, dan oatmeal sangat dianjurkan karena tidak hanya menyediakan energi secara

berkelanjutan tetapi juga membantu ibu merasa kenyang lebih lama. Selain itu, karbohidrat kompleks kaya akan serat yang membantu mencegah konstipasi, sebuah keluhan yang umum dialami ibu nifas akibat perubahan hormonal dan kurangnya aktivitas fisik pada hari-hari pertama pascapersalinan.

Lemak sehat seperti asam lemak omega-3 dan omega-6 yang ditemukan pada ikan salmon, tuna, alpukat, kacang almond, serta minyak zaitun juga memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan sistem saraf bayi melalui ASI. Konsumsi lemak sehat juga membantu mempercepat pemulihan luka serta mendukung produksi hormon penting selama masa nifas.

Selain makronutrien, ibu nifas dan menyusui juga memerlukan mikronutrien khusus seperti zat besi, kalsium, vitamin D, vitamin B kompleks, dan asam folat. Kalsium dan vitamin D sangat diperlukan untuk kesehatan tulang ibu serta untuk mendukung pertumbuhan tulang bayi. Susu dan produk susu merupakan sumber utama kalsium dan vitamin D. Namun, jika ibu mengalami intoleransi laktosa, makanan alternatif seperti brokoli, tahu, bayam, dan suplemen kalsium mungkin diperlukan.

Zat besi penting untuk mencegah anemia pada ibu nifas, terutama yang mengalami perdarahan cukup banyak saat melahirkan. Makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, hati ayam, bayam, kacang-kacangan, dan biji-bijian sangat direkomendasikan. Konsumsi makanan kaya vitamin C seperti jeruk, jambu biji, dan stroberi juga akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh.

Cairan juga memiliki peran yang sangat krusial selama masa nifas dan menyusui. Ibu harus menjaga agar tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8–10 gelas per hari untuk menjaga volume dan kualitas ASI. Selain air putih, ibu juga dapat mengonsumsi jus buah segar, sup hangat, atau minuman elektrolit alami seperti air kelapa muda.

Di samping nutrisi, aktivitas fisik yang dianjurkan pada masa nifas dan laktasi juga penting untuk diperhatikan. Aktivitas fisik yang terencana dengan baik dan dilakukan secara bertahap akan membantu mempercepat pemulihan fisik, meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh, serta menjaga kesehatan mental ibu. Namun, ibu harus memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan bersifat ringan hingga sedang, terutama dalam 6–8 minggu pertama pascapersalinan.

Pada minggu-minggu awal masa nifas, aktivitas fisik dapat dimulai dengan latihan sederhana seperti latihan pernapasan dalam, senam kegel, serta peregangan ringan. Latihan pernapasan membantu ibu merasa rileks dan meningkatkan sirkulasi oksigen dalam tubuh yang penting untuk proses penyembuhan. Senam kegel bermanfaat untuk menguatkan otot dasar panggul yang melemah akibat proses

persalinan. Latihan ini sangat penting terutama bagi ibu yang melahirkan secara normal.

Setelah kondisi fisik mulai stabil, ibu dapat meningkatkan aktivitasnya secara bertahap dengan berjalan santai di sekitar rumah atau taman selama 15–30 menit per hari. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki akan membantu melancarkan sirkulasi darah, mempercepat pemulihan luka jahitan, mengurangi risiko pembekuan darah, serta meningkatkan mood ibu. Latihan yang lebih intens, seperti aerobik ringan, yoga khusus ibu pascapersalinan, atau berenang, biasanya dapat dimulai setelah mendapat persetujuan dari dokter atau tenaga kesehatan, biasanya setelah pemeriksaan rutin pada 6 minggu pertama setelah melahirkan.

Yoga pascapersalinan menjadi salah satu pilihan aktivitas yang populer karena mampu memberikan manfaat ganda, baik secara fisik maupun mental. Gerakan yoga khusus ibu nifas dirancang untuk menguatkan otot inti, memperbaiki postur tubuh, mengurangi nyeri punggung, serta membantu ibu lebih rileks secara emosional. Yoga juga membantu ibu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi stres serta kecemasan yang mungkin muncul selama masa nifas dan menyusui.

Selain yoga, latihan aerobik ringan yang berfokus pada penguatan otot perut, punggung, dan tungkai juga sangat dianjurkan. Aktivitas fisik yang teratur dan sesuai dengan kapasitas fisik ibu akan membantu proses penurunan berat badan secara alami tanpa mempengaruhi produksi ASI. Namun, ibu perlu memastikan asupan nutrisi tetap terpenuhi dengan baik agar aktivitas fisik tidak menyebabkan kelelahan berlebihan atau penurunan kualitas ASI.

Dalam melaksanakan aktivitas fisik pada masa nifas dan laktasi, ibu harus memperhatikan batas kemampuan tubuh dan tidak memaksakan diri. Ibu disarankan untuk segera menghentikan aktivitas jika merasakan kelelahan berlebih, nyeri hebat, atau gejala tidak nyaman lainnya. Istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, serta relaksasi juga merupakan bagian integral dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, pemulihan tubuh, serta produksi ASI.

Secara keseluruhan, nutrisi yang optimal dan aktivitas fisik yang tepat selama masa nifas dan laktasi akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan ibu maupun bayi. Dengan asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang, disertai aktivitas fisik yang rutin dan terukur, ibu dapat menjalani masa nifas dan laktasi dengan kondisi fisik yang sehat, suasana hati yang positif, serta mampu memberikan ASI berkualitas tinggi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal bayinya.

H. Simpulan

Masa nifas dan laktasi merupakan periode yang sangat penting dan kompleks dalam kehidupan seorang perempuan setelah persalinan. Dalam masa ini, ibu mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, emosional, serta perubahan dalam perannya sebagai seorang ibu. Perubahan fisiologis utama yang terjadi mencakup involusi uterus, penyesuaian sistem kardiovaskuler, endokrin dan metabolisme, muskuloskeletal, serta gastrointestinal dan eliminasi. Proses ini memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk memastikan pemulihan yang optimal dan pencegahan komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi nifas, mastitis, dan depresi postpartum.

Asuhan keperawatan memiliki peran krusial dalam membantu ibu melewati masa transisi ini dengan baik. Melalui pengkajian yang sistematis, diagnosa keperawatan yang tepat, intervensi efektif, serta edukasi kesehatan yang komprehensif, ibu dan keluarga diharapkan dapat menjalani masa nifas dengan percaya diri. Pendidikan kesehatan yang diberikan mencakup perawatan diri, teknik menyusui yang benar, manajemen ASI, kesehatan mental dan emosional, perawatan bayi baru lahir, serta informasi mengenai keluarga berencana.

Proses laktasi adalah aspek penting dalam masa ini, di mana ASI berperan vital dalam tumbuh kembang bayi serta kesehatan ibu. Pemahaman mengenai fisiologi produksi ASI, faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kondisi hormonal, nutrisi, hidrasi, serta dukungan sosial, menjadi dasar dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama. Manfaat ASI eksklusif sangat luas, baik untuk imunitas, nutrisi, dan perkembangan bayi, maupun untuk kesehatan fisik dan emosional ibu, termasuk pencegahan perdarahan postpartum serta risiko kanker payudara dan ovarium.

Dukungan psikologis menjadi elemen penting selama masa nifas dan laktasi, mengingat banyaknya tantangan emosional yang dihadapi ibu seperti kecemasan, stres, baby blues, hingga depresi postpartum. Perawat bersama keluarga memainkan peran penting dalam memberikan dukungan emosional, menerapkan strategi pengelolaan stres seperti teknik relaksasi dan mindfulness, serta menciptakan lingkungan yang mendukung secara emosional agar ibu merasa nyaman, aman, dan dihargai dalam menjalani peran barunya.

Aspek nutrisi dan aktivitas fisik juga sangat menentukan keberhasilan masa nifas dan laktasi. Nutrisi yang optimal, mencakup protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, mineral, dan cairan yang cukup, sangat penting untuk pemulihan fisik ibu, produksi ASI yang berkualitas, serta memenuhi kebutuhan gizi bayi. Aktivitas fisik yang dilakukan secara bertahap, mulai dari latihan ringan hingga aerobik ringan dan yoga, membantu mempercepat proses pemulihan, mengurangi

risiko komplikasi, meningkatkan kebugaran tubuh, serta meningkatkan kondisi psikologis ibu. Namun, aktivitas fisik ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi ibu, serta didukung dengan istirahat yang cukup.

I. Referensi

- Al-Chalabi, M., Bass, A. N., & Alsalman, I. (2021). Physiology, Prolactin. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Britannica. (n.d.). Lactation: Physiology, Pregnancy & Hormones. Encyclopedia Britannica.
- Cleveland Clinic. (2022). Uterus involution: process & how it feels. Cleveland Clinic.
- Frontiers in Global Women's Health. (2021). Dysphoric Milk Ejection Reflex: The psychoneurobiology. Frontiers in Global Women's Health.
- Kraus, V., Jr., Čižmarová, B., & Birková, A. (2025). When Your Body Tells You to Not Breastfeed—The Connivance of Oxytocin, Prolactin, and Dopamine. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(12), 5909. <https://doi.org/10.3390/ijms26125909>
- Lopez-Vicchi, F., De Winne, C., Brie, B., Sorianello, E., & Ladyman, S. R. (2020). Metabolic functions of prolactin: Physiological and pathological aspects. *Journal of Neuroendocrinology*.
- Mustafa Al-Chalabi, A. N. Bass, & I. Alsalman. (2021). Physiology, Breast Milk. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- NCBI Bookshelf. (2022). Physiology, Postpartum Changes. StatPearls.
- PMC. (2021). The Psychological Benefits of Breastfeeding: Fostering maternal bonding and mental health. *Frontiers in Psychology*.
- PubMed Central. (2023). Physiology of uterine involution in primiparous and multiparous women. *International Journal of Women's Health*.
- Uvnäs-Moberg, K., Ekström-Bergström, A., Buckley, S., Massarotti, C., & Pajalic, Z. (2020). Maternal plasma levels of oxytocin during breastfeeding – A systematic review. *PLOS ONE*.

J. Glosarium

Baby Blues Syndrome

Kondisi emosional yang sering dialami ibu baru, ditandai oleh perasaan sedih, mudah menangis, perubahan suasana hati, kecemasan ringan, dan perasaan lelah, biasanya muncul beberapa hari setelah melahirkan dan berlangsung singkat.

Bradikardia Postpartum

Penurunan denyut jantung secara ringan yang biasa terjadi dalam periode awal masa nifas sebagai respon fisiologis normal setelah melahirkan.

Diastasis Rekti

Kondisi di mana otot rektus abdominis yang meregang selama kehamilan mengalami pemisahan atau celah, yang umumnya membaik secara perlahan setelah persalinan.

Diaforesis Postpartum

Keringat berlebihan yang sering terjadi selama masa nifas sebagai mekanisme tubuh untuk mengurangi kelebihan cairan tubuh yang terakumulasi selama kehamilan.

Diuresis Postpartum

Peningkatan produksi dan frekuensi buang air kecil yang terjadi setelah melahirkan sebagai cara tubuh menyingkirkan kelebihan cairan.

Episiotomi

Prosedur bedah kecil berupa sayatan pada area perineum (daerah antara vagina dan anus) untuk memperlebar jalan lahir selama proses persalinan.

Involusi Uterus

Proses alami di mana rahim yang membesar selama kehamilan secara bertahap kembali ke ukuran semula sebelum kehamilan, biasanya berlangsung sekitar enam minggu pascapersalinan.

Laktasi

Proses alami pembentukan, produksi, dan sekresi Air Susu Ibu (ASI), dimulai setelah kelahiran bayi dan dikontrol oleh hormon prolaktin dan oksitosin.

Lokhia (Lokia)

Cairan yang keluar dari vagina pada masa nifas yang terdiri dari darah, sisa jaringan plasenta, dan sekret lainnya. Secara bertahap berubah dari lokia rubra (merah segar), menjadi lokia serosa (kecoklatan), hingga lokia alba (putih kekuningan).

Mastitis

Peradangan atau infeksi pada jaringan payudara yang sering terjadi pada ibu menyusui, ditandai oleh nyeri, kemerahan, pembengkakan, dan demam.

Mindfulness

Pendekatan psikologis berupa kesadaran penuh terhadap kondisi saat ini dengan penerimaan tanpa penilaian negatif yang berlebihan, membantu ibu mengatasi stres dan kecemasan selama masa nifas dan laktasi.

Oksitosin

Hormon yang berperan dalam pengeluaran ASI (refleks let-down) serta kontraksi uterus selama proses involusi rahim pascapersalinan.

Prolaktin

Hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior yang berperan dalam proses produksi Air Susu Ibu (ASI) selama masa menyusui.

Puting Lecet (Cracked Nipples)

Kondisi luka atau lecet pada puting payudara yang sering dialami oleh ibu menyusui, biasanya disebabkan oleh teknik menyusui atau pelekatan yang tidak tepat.

Refleks Let-down (Let-down Reflex)

Proses pelepasan ASI dari alveoli ke saluran susu yang dipicu oleh hormon oksitosin sebagai respon terhadap rangsangan hisapan bayi pada puting payudara.

Senam Kegel

Latihan khusus yang bertujuan memperkuat otot dasar panggul, penting bagi ibu pascapersalinan untuk mempercepat pemulihan fisik, mencegah inkontinensia urin, serta meningkatkan fungsi seksual.

Supply and Demand (dalam Laktasi)

Prinsip dasar laktasi di mana semakin sering bayi menyusu, semakin banyak pula produksi ASI yang dihasilkan oleh tubuh ibu untuk memenuhi kebutuhan bayi.

Trombosis Vena Dalam (Deep Vein Thrombosis/DVT)

Kondisi di mana terjadi pembentukan gumpalan darah (trombus) di dalam vena dalam, biasanya pada kaki, berisiko tinggi selama masa nifas, terutama jika ibu kurang aktif atau mengalami komplikasi tertentu.

Uterotonika

Obat-obatan yang digunakan untuk merangsang kontraksi rahim, membantu mempercepat proses involusi uterus, serta mencegah dan mengatasi perdarahan postpartum.

ASI Eksklusif

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama enam bulan pertama kehidupan bayi, penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal dan kesehatan bayi serta ibu.

CHAPTER 8

KEPERAWATAN PADA IBU DENGAN GANGGUAN PSIKOLOGIS SELAMA KEHAMILAN DAN NIFAS

Santi Wahyuni, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama masa kehamilan dan periode pascapersalinan merupakan isu penting yang menuntut perhatian serius dalam asuhan keperawatan maternitas. Periode ini ditandai oleh berbagai perubahan biologis, fisiologis, dan hormonal yang kompleks, yang secara signifikan dapat memengaruhi stabilitas emosional dan psikologis seorang ibu. Fluktuasi kadar hormon seperti estrogen dan progesteron, bersama dengan tuntutan fisik dan psikososial yang meningkat, dapat berkontribusi pada munculnya gangguan psikologis baru atau memperburuk gangguan yang telah ada sebelumnya. Kondisi ini meliputi berbagai spektrum gangguan, termasuk depresi perinatal, gangguan kecemasan, baby blues, hingga psikosis postpartum, yang masing-masing memiliki dampak potensial terhadap kesehatan ibu dan perkembangan anak (O'Hara & Wisner, 2014).

Periode perinatal, yang mencakup masa kehamilan hingga satu tahun setelah persalinan, merupakan fase kritis yang rentan terhadap gangguan emosional dan psikologis. Ibu menghadapi berbagai tekanan, termasuk ketidakseimbangan hormonal, perubahan peran sosial, ekspektasi budaya, serta tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan tanggung jawab keibuan. WHO (2022) melaporkan bahwa sekitar 10% wanita hamil dan 13% wanita pascapersalinan di negara-negara berkembang mengalami gangguan mental, terutama depresi dan kecemasan. Prevalensi ini meningkat hampir dua kali lipat di wilayah dengan keterbatasan layanan kesehatan jiwa dan rendahnya literasi kesehatan.

Di Indonesia, berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi gangguan mental emosional pada wanita usia subur mencapai 6,1%. Meski tidak spesifik pada ibu hamil dan nifas, angka ini diyakini lebih tinggi dalam kelompok tersebut karena adanya tekanan tambahan dari perubahan fisiologis, kondisi ekonomi, serta akses layanan kesehatan mental yang belum merata. Faktor-faktor seperti beban ganda, kekerasan dalam rumah tangga, dan norma budaya yang menuntut kesempurnaan peran keibuan memperparah kerentanan wanita terhadap gangguan psikologis dalam periode perinatal (Rokom, 2019).

Secara global, meta-analisis oleh Hahn-Holbrook et al. (2021) dan laporan dari StatPearls (2025) menunjukkan bahwa prevalensi depresi perinatal dapat mencapai 17,2%, dan hingga 24,7% di negara berpendapatan rendah. Insidensi tertinggi terjadi dalam tiga bulan pertama pascapersalinan. Selama pandemi COVID-19, prevalensinya meningkat menjadi 30–35%, menunjukkan tingginya kerentanan emosional ibu dalam situasi stres besar (Ceulemans et al., 2021).

Gangguan psikologis yang umum mencakup depresi perinatal, gangguan kecemasan, baby blues, psikosis postpartum, serta PTSD pascapersalinan. Masing-masing memiliki gejala dan risiko yang berbeda, mulai dari perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, hingga halusinasi dan delusi pada kasus psikosis. Baby blues, meskipun ringan, dapat berkembang menjadi depresi jika tidak ditangani. PTSD sering kali terkait pengalaman persalinan traumatis atau kehilangan janin, dan dapat berdampak jangka panjang (Howard et al., 2014).

Dampaknya tidak hanya pada ibu, tetapi juga terhadap bayi. Paparan stres maternal yang berlangsung kronis telah dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta gangguan dalam perkembangan neurokognitif dan kemampuan regulasi emosi maupun perilaku anak. Selain itu, ibu yang mengalami depresi atau gangguan kecemasan selama masa kehamilan dan pascapersalinan cenderung menghadapi hambatan dalam membangun hubungan emosional yang sehat dengan bayinya (*bonding*), yang pada akhirnya dapat memengaruhi pola pengasuhan, kualitas keterikatan ibu-anak, dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang (Field, 2017).

Perawat, sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan maternal, memegang peran strategis dalam melaksanakan fungsi promotif, preventif, serta dalam mendeteksi secara dini gangguan psikologis pada ibu hamil dan masa nifas. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, diperlukan penerapan intervensi yang berbasis pada praktik keperawatan berbasis bukti (*Evidence-Based Practice/EBP*), dengan pendekatan yang menyeluruh, berpusat pada manusia, serta peka terhadap nilai dan budaya masyarakat setempat. Penggunaan instrumen penilaian psikologis seperti *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS), *Patient Health Questionnaire-9* (PHQ-9), dan *Generalized Anxiety Disorder-7* (GAD-7) sangat dianjurkan sebagai alat skrining untuk mendeteksi dini gejala depresi maupun kecemasan. Selain itu, kompetensi perawat juga harus mencakup kemampuan melakukan komunikasi empatik, mengidentifikasi tanda-tanda psikologis yang tidak tampak secara eksplisit, serta merancang intervensi edukatif dan dukungan psikososial yang bersifat berkelanjutan, kolaboratif antarprofesi, dan inklusif terhadap kebutuhan ibu serta anggota keluarganya.

B. Gangguan Psikologis pada Masa Kehamilan dan Nifas

Masa kehamilan dan nifas merupakan periode yang sangat dinamis, tidak hanya secara fisiologis tetapi juga secara psikologis. Perubahan hormonal, tekanan sosial, peran baru sebagai ibu, serta pengalaman kehamilan dan persalinan itu sendiri dapat memicu berbagai bentuk gangguan psikologis, meliputi gangguan mood, kecemasan, hingga gangguan berat seperti psikosis dan PTSD. Pemahaman menyeluruh tentang jenis, gejala khas, dan prevalensinya sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, agar dapat melakukan deteksi dini dan intervensi yang sesuai.

Berikut ini adalah jenis gangguan psikologis yang terjadi pada masa kehamilan dan nifas :

1. Depresi Perinatal

Depresi perinatal adalah gangguan mood yang terjadi selama kehamilan (depresi antenatal) maupun setelah melahirkan (depresi postpartum). Gejalanya mencakup perasaan sedih yang terus-menerus, kelelahan ekstrem, penurunan energi, kehilangan minat terhadap aktivitas yang menyenangkan, gangguan tidur dan makan, serta pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi. Depresi ini juga dapat bermanifestasi sebagai iritabilitas ekstrem, gangguan kognitif ringan, dan menarik diri dari interaksi sosial. Penurunan harga diri serta konflik rumah tangga menjadi faktor pemicu tambahan. Studi longitudinal menunjukkan bahwa depresi antenatal meningkatkan risiko depresi postpartum hingga lima kali lipat (Slomian et al., 2019). Prevalensi global depresi postpartum menurut WHO (2022) dan Hahn-Holbrook et al. (2021) sekitar 17,2%, lebih tinggi di negara berkembang.

2. Gangguan Kecemasan

Gangguan kecemasan selama periode perinatal meliputi Generalized Anxiety Disorder (GAD), gangguan panik, fobia spesifik, tokophobia (ketakutan ekstrem terhadap persalinan), serta gangguan obsesif-kompulsif (OCD). Gejalanya termasuk pikiran intrusif tentang bahaya yang menimpa bayi, overchecking, dan kecenderungan perfeksionisme. Gangguan ini sering salah diartikan sebagai kekhawatiran normal, padahal dapat memicu gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan komplikasi persalinan (Leach et al., 2014). Prevalensi gangguan kecemasan mencapai 15–20%, lebih tinggi pada ibu dengan riwayat gangguan mental (Fairbrother et al., 2016).

3. Baby Blues

Baby blues merupakan kondisi emosional ringan namun umum, terjadi pada minggu pertama setelah persalinan, dialami oleh sekitar 50–80% ibu. Ditandai dengan perubahan suasana hati yang cepat, perasaan kewalahan, menangis tiba-tiba, dan gangguan tidur. Penyebab utamanya adalah penurunan hormon

estrogen-progesteron secara drastis pascapersalinan, ditambah kelelahan dan tekanan adaptasi. Ibu dengan keterbatasan dukungan sosial lebih rentan mengalami perburukan kondisi (Mughal et al., 2024). Bila berlangsung lebih dari dua minggu, perlu dicurigai depresi postpartum.

4. Psikosis Postpartum

Psikosis postpartum adalah kondisi akut yang membutuhkan perawatan psikiatri segera. Ditandai dengan halusinasi (misalnya mendengar suara), delusi (meyakini bayi dirasuki), perilaku kacau, dan pemikiran untuk menyakiti bayi. Kondisi ini dapat berkembang dalam 1–2 minggu pascapersalinan, sering dialami oleh ibu dengan riwayat bipolar atau skizofrenia. Perawatan mencakup antipsikotik, terapi elektrokonvulsif (ECT), dan rawat inap (Sit et al., 2006). Prevalensi psikosis postpartum sekitar 1–2 kasus per 1.000 kelahiran (Jones et al., 2020).

5. Postpartum PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

PTSD pascapersalinan timbul dari pengalaman persalinan traumatis, termasuk tindakan medis invasif tanpa penjelasan, rasa tidak dihargai selama proses melahirkan, atau kehilangan bayi. Gejala meliputi kilas balik, mimpi buruk, hipervigilans, mati rasa emosi, serta gangguan dalam merawat bayi. Dampaknya dapat memengaruhi menyusui, hubungan suami-istri, dan bonding ibu-anak. Prevalensinya 3–7%, meningkat pada kelompok dengan trauma masa lalu atau tanpa dukungan sosial (Yildiz et al., 2017; Ford et al., 2022).

6. Gangguan Komorbid dan Masalah Kesehatan Mental Terkait

Komorbiditas umum dalam gangguan perinatal meliputi penyalahgunaan zat (alkohol, benzodiazepin), gangguan makan (restriksi, binge eating), insomnia kronis, dan konflik relasional. Gangguan ini dapat memperburuk gejala utama, memperpanjang pemulihan, dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Micali et al. (2018) menemukan korelasi signifikan antara gangguan makan perinatal dengan komplikasi kehamilan. Howard et al. (2014) menekankan pentingnya pendekatan multidimensional karena satu diagnosis dapat menutupi gejala lainnya.

7. Gangguan Penyesuaian (Adjustment Disorders)

Gangguan penyesuaian timbul ketika ibu tidak mampu mengelola stres akibat perubahan besar pascamelahirkan. Gejalanya mencakup cemas, gangguan tidur, mudah tersinggung, penurunan performa sosial, dan konflik keluarga. Sering kali kondisi ini dianggap normal, padahal bila menetap >2 minggu dan mengganggu fungsi, perlu perhatian profesional. Berdasarkan DSM-5-TR (APA, 2022), diagnosis ditegakkan bila reaksi emosional terhadap stresor lebih intens

dibanding konteks budaya. Ibu dengan bayi berkebutuhan khusus atau tanpa dukungan pasangan sangat rentan mengalami gangguan ini.

Pemahaman mendalam tentang variasi jenis gangguan psikologis perinatal penting untuk membentuk pendekatan asuhan keperawatan yang sensitif, tepat sasaran, dan berbasis bukti. Perawat perlu dilatih untuk mengenali gejala awal, menghindari stigma, dan melibatkan keluarga dalam proses pemulihan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

C. Dampak Gangguan Psikologis

Gangguan psikologis selama masa kehamilan dan nifas bukan hanya masalah personal ibu, tetapi juga merupakan isu kesehatan masyarakat yang berdampak lintas generasi. Efek negatifnya mencakup dimensi fisik, emosional, dan sosial, baik bagi ibu, janin yang sedang berkembang, bayi yang lahir, bahkan kestabilan keluarga.

1. Dampak terhadap Ibu

Gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau PTSD dapat melemahkan kesehatan ibu secara signifikan:

- a. **Komplikasi Kehamilan dan Persalinan:** Ibu dengan depresi atau kecemasan mengalami peningkatan risiko preeklampsia, kelahiran prematur, dan komplikasi persalinan lainnya (Howard et al., 2014).
- b. **Penurunan Fungsi Perawatan Diri dan Bayi:** Gangguan mood menurunkan energi dan motivasi ibu untuk menyusui, menjaga pola makan sehat, atau menjalani perawatan postnatal (Field, 2017; Dagher et al., 2016).
- c. **Risiko Bunuh Diri dan Infanticide:** Psikosis postpartum yang tidak tertangani dapat memicu halusinasi dan delusi yang berbahaya, seperti dorongan menyakiti bayi (Jones et al., 2020).
- d. **Relaps dan Gangguan Mental Kronik:** Ibu dengan riwayat gangguan mental berisiko tinggi mengalami kekambuhan atau transisi ke gangguan kronik (Rae et al., 2025; Goodman et al., 2022).
- e. **Kepatuhan Rendah terhadap Pelayanan Kesehatan:** Depresi perinatal dikaitkan dengan rendahnya partisipasi dalam kontrol kehamilan, perawatan nifas, dan pemberian ASI eksklusif (Sipsma et al., 2013).
- f. **Masalah Relasional dan Sosial:** Konflik pasangan, perasaan isolasi, dan disfungsi peran dalam keluarga sering menyertai depresi pascapersalinan (Putriarsih et al., 2018; Slomian et al., 2019).

2. Dampak terhadap Janin

Kesehatan psikologis ibu memiliki pengaruh kuat pada kondisi janin:

- a. Keterlambatan Pertumbuhan Intrauterin (IUGR): Hormon stres seperti kortisol yang tinggi dalam tubuh ibu dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan janin dan berat badan lahir rendah (Grote et al., 2010).
- b. Kelahiran Prematur: Depresi dan kecemasan berkontribusi pada kelahiran sebelum waktunya, meningkatkan risiko morbiditas neonatal (Stein et al., 2014).
- c. Disregulasi Sistem Saraf Janin: Tingginya kadar kortisol dan disfungsi plasenta berdampak pada pematangan otak dan respons stres janin (O'Donnell et al., 2014).

3. Dampak terhadap Bayi

Bayi yang lahir dari ibu dengan gangguan psikologis menghadapi sejumlah tantangan:

- a. Gangguan Bonding dan Attachment: Ibu dengan depresi postpartum cenderung menunjukkan kurangnya responsivitas dan kehangatan, yang memengaruhi pembentukan ikatan emosional aman (Muzik et al., 2016; Field, 2017).
- b. Risiko Gangguan Perkembangan: Anak dari ibu dengan gangguan psikologis lebih rentan mengalami keterlambatan bicara, gangguan motorik, masalah perilaku, dan kecemasan masa anak (Kingston et al., 2018).
- c. Masalah Kognitif dan Sosial: Hubungan yang kurang optimal dengan ibu dapat mengganggu perkembangan empati, kontrol emosi, dan kemampuan sosial anak sejak usia dini (Stein et al., 2014).

4. Dampak terhadap Keluarga dan Lingkungan Sosial

Gangguan psikologis ibu berdampak sistemik:

- a. Stres Rumah Tangga: Ketegangan dalam relasi pasangan, kesenjangan komunikasi, hingga peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga sering muncul dalam konteks ibu yang mengalami depresi atau gangguan penyesuaian (Letourneau et al., 2020).
- b. Ketidakstabilan Peran Keluarga: Ibu mungkin kesulitan menjalankan peran sebagai pengasuh utama, yang memengaruhi struktur pengasuhan dan dinamika emosional dalam rumah tangga (Monalisa et al., 2024).
- c. Efek Lintas Generasi: Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan gangguan psikologis ibu memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap gangguan mental di kemudian hari (Goodman et al., 2022).

D. Faktor Risiko Gangguan Psikologis pada Ibu Hamil dan Nifas

Faktor risiko gangguan psikologis pada masa kehamilan dan nifas bersifat multifaktorial, yang berarti melibatkan interaksi antara kondisi biologis, psikososial, budaya, dan lingkungan. Pemahaman komprehensif terhadap faktor risiko ini sangat penting dalam praktik keperawatan, agar perawat dapat mengenali kerentanan individu sejak awal dan menyusun intervensi yang bersifat promotif dan preventif secara efektif.

1. Riwayat Gangguan Mental Sebelumnya

Wanita dengan riwayat gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan umum (GAD), gangguan bipolar, atau trauma masa lalu memiliki kerentanan tinggi terhadap kekambuhan selama kehamilan atau periode pascapersalinan. Yim et al. (2015) dalam tinjauan sistematisnya menegaskan bahwa riwayat depresi merupakan prediktor paling kuat terhadap timbulnya depresi perinatal. Sementara itu, Wesseloo et al. (2016) mengungkapkan bahwa ibu dengan gangguan bipolar memiliki risiko relaps hingga 66% dalam minggu-minggu awal setelah persalinan. Kepekaan perawat terhadap riwayat psikologis pasien menjadi fondasi penting dalam pengkajian awal.

2. Stresor Psikososial dan Lingkungan

Stres akibat konflik keluarga, ketidakpastian ekonomi, tuntutan pekerjaan, serta paparan kekerasan dalam rumah tangga berdampak besar pada stabilitas emosional ibu hamil. Tekanan berlapis ini dapat mengganggu regulasi stres dan menyebabkan disfungsi neuroendokrin. Biaggi et al. (2016) mencatat bahwa faktor stresor psikososial berkontribusi langsung terhadap insiden depresi antenatal. Di Indonesia, realitas beban ganda sebagai ibu dan pekerja sering kali tidak disertai dengan sistem dukungan sosial yang memadai, sehingga memperparah kondisi mental ibu.

3. Minimnya Dukungan Sosial

Rendahnya keterlibatan pasangan, keluarga, atau teman dalam proses kehamilan dan pengasuhan anak meningkatkan risiko isolasi sosial dan beban emosional. Slomian et al. (2019) dalam tinjauan sistematisnya menyimpulkan bahwa kurangnya dukungan emosional merupakan salah satu penyebab utama depresi postpartum. Bahkan, interaksi sosial yang negatif (misalnya kritik atau penolakan) memiliki dampak psikologis yang lebih besar daripada ketiadaan interaksi.

4. Komplikasi Obstetri atau Proses Persalinan Traumatis

Pengalaman medis seperti preeklamsia, perdarahan, kelahiran prematur, atau tindakan caesar darurat dapat menjadi pengalaman traumatis yang memicu gangguan stres pascatrauma (PTSD). Ayers et al. (2016) menemukan bahwa 3–6%

ibu mengalami PTSD pascapersalinan, dengan gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, dan hipervigilans. Kejadian yang melibatkan ancaman terhadap keselamatan ibu atau bayi sering kali meninggalkan bekas trauma psikologis yang mendalam.

5. Kehilangan Reproduksi atau Trauma Masa Lalu

Riwayat keguguran, kematian bayi, atau pengalaman kekerasan seksual masa kecil dapat membentuk luka psikologis yang kompleks. Wanita dengan riwayat kehilangan kehamilan memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih besar mengalami gangguan psikologis selama kehamilan berikutnya (Bayrampour et al., 2018). Kenangan traumatis dapat teraktivasi kembali selama proses kehamilan atau persalinan.

6. Norma Budaya, Peran Gender, dan Stigma Sosial

Tuntutan sosial agar ibu selalu tampil kuat dan bahagia, serta ekspektasi budaya untuk menjalankan peran keibuan secara sempurna tanpa keluhan, dapat menekan ekspresi emosional ibu. Stigma terhadap gangguan mental juga membuat ibu enggan mencari pertolongan. Di banyak budaya termasuk Indonesia, membicarakan perasaan tertekan sering dianggap tabu, sehingga kondisi psikologis memburuk dalam kesunyian. Kingston et al. (2021) menekankan bahwa norma budaya dan stigma sosial merupakan prediktor jangka panjang dari depresi maternal yang tidak tertangani.

7. Ketidakseimbangan Hormonal dan Faktor Biologis

Kehamilan dan nifas ditandai oleh fluktuasi tajam kadar estrogen, progesteron, kortisol, dan oksitosin yang berperan dalam regulasi mood. Beberapa ibu menunjukkan sensitivitas biologis terhadap perubahan hormonal ini yang memicu gejala psikologis. O'Hara & Wisner (2014) menjelaskan bahwa faktor biologis seperti kerentanan genetik terhadap disregulasi neurotransmitter turut berperan dalam timbulnya depresi perinatal, terutama pada ibu dengan riwayat keluarga gangguan mental.

8. Kehamilan Tidak Direncanakan atau Tidak Diinginkan

Kehamilan yang terjadi tanpa perencanaan atau persetujuan penuh dapat menyebabkan konflik batin, stres, dan ketidakstabilan emosional. Ibu mungkin merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, kehilangan kendali atas tubuh atau masa depannya, yang berkontribusi terhadap gejala depresi dan kecemasan. Faktor ini juga berhubungan dengan buruknya kepatuhan terhadap perawatan kehamilan dan rendahnya kualitas relasi ibu-bayi pasca persalinan.

9. Kondisi Anak yang Dilahirkan

Bayi yang lahir dengan kondisi prematur, berat lahir rendah, atau kebutuhan khusus sering kali menimbulkan kecemasan tinggi dan stres berlebih pada ibu.

Penelitian menunjukkan bahwa ibu dari bayi prematur memiliki risiko depresi dan PTSD yang lebih tinggi karena tekanan tambahan dalam proses perawatan (Vigod et al., 2010). Rasa cemas terhadap prognosis anak dan ketidakmampuan merawat bayi secara optimal menjadi beban psikologis tersendiri.

Pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor risiko ini memungkinkan perawat melakukan pengkajian secara lebih sensitif dan holistik. Skrining risiko harus menjadi bagian dari asuhan kehamilan rutin, termasuk wawancara psiko-sosial yang mendalam dan kolaboratif. Edukasi kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya mengenali faktor risiko ini juga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah dampak psikologis lebih lanjut.

E. Deteksi Dini dan Edukasi Psikologis oleh Perawat

Deteksi dini gangguan psikologis pada ibu hamil dan nifas merupakan langkah krusial dalam mencegah berkembangnya kondisi yang lebih berat dan dampak jangka panjang bagi ibu maupun bayinya. Perawat berperan strategis dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan psikologis serta melakukan edukasi yang tepat dan berkelanjutan.

1. Skrining Psikologis Terintegrasi dalam Asuhan Antenatal dan Postnatal

Proses deteksi dini sebaiknya dimulai sejak kunjungan pertama antenatal. Instrumen skrining yang valid dan reliabel, seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Cox et al., 1987), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), dan Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), telah direkomendasikan oleh berbagai organisasi profesi, seperti WHO dan ACOG, untuk digunakan dalam praktik klinis (ACOG, 2018). Penilaian dilakukan secara berkala, baik selama kehamilan maupun setelah persalinan, dengan pengulangan pada trimester akhir dan minggu-minggu pertama nifas. Skrining juga sebaiknya dilengkapi dengan asesmen latar belakang psikososial ibu dan riwayat kesehatan mental terdahulu agar dapat menilai risiko secara holistik.

2. Observasi Klinis dan Komunikasi Empatik

Selain skrining formal, observasi klinis oleh perawat memiliki peran sentral dalam mengenali perubahan emosi dan perilaku ibu. Gejala seperti lekas marah, menangis tanpa sebab, kurang minat terhadap aktivitas sehari-hari, atau ekspresi wajah yang datar bisa menjadi petunjuk adanya gangguan psikologis. Komunikasi empatik perlu dikembangkan agar ibu merasa aman untuk berbagi. Teknik komunikasi terapeutik seperti refleksi perasaan, validasi emosi, dan pertanyaan terbuka dapat membantu perawat menjangkau sisi emosional yang tidak langsung tampak. Dengan pendekatan ini, perawat tidak hanya mengumpulkan

data, tetapi juga membangun hubungan terapeutik yang mendukung pemulihan psikologis ibu.

3. Keterlibatan Keluarga dalam Deteksi Dini dan Dukungan Emosional

Deteksi dini akan lebih efektif jika dilakukan bersama dengan keluarga. Keluarga merupakan sistem dukungan utama bagi ibu dan sering kali menjadi pihak pertama yang menyadari perubahan suasana hati atau perilaku ibu. Perawat dapat memberikan konseling kepada pasangan atau anggota keluarga untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap gejala gangguan psikologis, serta melatih keterampilan dasar dalam memberikan dukungan emosional. Dalam budaya kolektif seperti Indonesia, keterlibatan keluarga juga membantu mengurangi stigma terhadap gangguan mental dan meningkatkan penerimaan terhadap intervensi psikologis (Howard et al., 2014).

4. Edukasi Psikologis yang Berkelanjutan dan Berbasis Kebutuhan

Edukasi tidak hanya diberikan dalam satu sesi, melainkan dirancang sebagai proses berkelanjutan sepanjang masa kehamilan dan setelah persalinan. Perawat dapat menyusun materi edukasi berbasis literasi kesehatan yang mencakup perbedaan antara gangguan ringan dan berat, kapan harus mencari pertolongan, serta teknik koping adaptif. Format edukasi bisa bervariasi mulai dari sesi tatap muka, media cetak, hingga teknologi digital seperti aplikasi kehamilan. Menyesuaikan pendekatan edukasi dengan latar belakang budaya, sosial, dan tingkat pendidikan ibu sangat penting untuk memastikan pesan dapat diterima dan diaplikasikan.

5. Kolaborasi Lintas Profesi dan Alur Rujukan yang Efisien

Ketika deteksi menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis yang membutuhkan penanganan lanjut, perawat harus segera melakukan rujukan ke tenaga profesional seperti psikolog klinis, konselor, atau psikiater. Kolaborasi ini memerlukan pemahaman lintas profesi yang kuat agar ibu tidak merasa dipingpong antar layanan. Perawat juga bertugas memastikan kontinuitas asuhan psikologis, memantau kepatuhan terhadap rencana intervensi, dan memfasilitasi komunikasi antara ibu dan tim kesehatan jiwa.

6. Penerapan Intervensi Psikososial Awal oleh Perawat

Perawat dengan pelatihan dasar psikososial dapat langsung memberikan intervensi awal yang bersifat preventif dan suportif, seperti pelatihan pernapasan dalam, teknik mindfulness, dukungan kelompok sebaya, atau penggunaan jurnal emosi. Intervensi berbasis perawat memiliki dampak positif dalam menurunkan gejala depresi ringan hingga sedang (Shorey et al., 2018). Selain itu, perawat juga dapat mengembangkan modul atau toolkit psikososial untuk diterapkan di

layanan primer, khususnya pada komunitas dengan akses terbatas terhadap layanan spesialis.

Deteksi dini dan edukasi psikologis oleh perawat merupakan jantung dari asuhan keperawatan maternal yang humanistik dan berbasis bukti. Ketika dilakukan secara sistematis, sensitif budaya, dan melibatkan keluarga serta komunitas, intervensi ini mampu mengubah trajektori gangguan mental ibu menuju pemulihan yang lebih cepat dan menyeluruh.

F. Intervensi Psikoedukatif Berbasis Evidence dalam Kesehatan Mental Perinatal

Dalam konteks gangguan psikologis perinatal, intervensi berbasis bukti difokuskan pada peningkatan kesehatan mental ibu melalui metode yang telah terbukti efektif dalam penelitian.

1. Terapi Perilaku Kognitif (CBT) dan Konseling dalam Keperawatan Maternitas

CBT merupakan pendekatan psikoterapi yang terbukti efektif dalam mengatasi gangguan mood, termasuk depresi dan kecemasan selama kehamilan dan masa nifas (Dennis & Dowswell, 2013). CBT membantu ibu mengidentifikasi pikiran negatif yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih adaptif. Efektivitas CBT telah dibuktikan dalam berbagai studi, baik dalam format individual maupun kelompok.

CBT juga dikenal sebagai pendekatan psikologis yang efektif untuk mengatasi depresi dan kecemasan selama masa kehamilan dan postpartum. Terapi ini membantu individu mengenali dan merekonstruksi pikiran negatif menjadi pola pikir yang lebih adaptif (Beck, 2011). Dalam praktik keperawatan, CBT telah terbukti menurunkan skor EPDS dan memperkuat keterampilan regulasi emosi serta penerimaan peran keibuan (Sockol, 2018; Green et al., 2022).

CBT dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Konseling individu menawarkan ruang personal, sedangkan CBT kelompok memperkuat dukungan sosial dan sense of belonging. Meta-analisis menunjukkan efektivitas serupa antara kedua bentuk intervensi (Cuijpers et al., 2020). Perawat berperan dalam deteksi dini dan rujukan ibu ke layanan kesehatan jiwa, serta dapat dilatih untuk memberikan elemen CBT dasar seperti penguatan kognitif, teknik napas dalam, pencatatan pikiran otomatis, dan edukasi psikoedukatif.

2. Relaksasi dan Mindfulness dalam Asuhan Keperawatan Perinatal

Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir secara sadar dalam saat ini tanpa menghakimi, yang efektif menurunkan gejala kecemasan dan stres pada ibu hamil dan nifas (Shorey et al., 2018). Latihan seperti mindfulness-based stress reduction (MBSR) dan mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan self-compassion dan

pengendalian emosi (Field, 2017). Perawat dapat mengintegrasikan latihan ini dalam kelas ibu hamil atau home visit.

Pendekatan mindfulness juga terbukti efektif dalam mengurangi stres, kecemasan, dan depresi perinatal. Latihan seperti body scan dan meditasi napas sadar mendorong penerimaan, meningkatkan regulasi emosi, dan memperkuat resiliensi (Ng et al., 2023; Shi & MacBeth, 2017). Penelitian juga menunjukkan manfaat mindfulness dalam adaptasi terhadap perubahan tubuh dan peran sosial selama kehamilan (Duncan & Bardacke, 2010).

Teknik relaksasi seperti Progressive Muscle Relaxation (PMR) dan latihan pernapasan dalam efektif menurunkan ketegangan otot, meningkatkan kualitas tidur, dan memberikan rasa kendali emosional. Studi menunjukkan bahwa PMR secara signifikan meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu hamil (Zhou et al., 2023).

3. Dukungan Sosial Terstruktur: Peer Support dan Kelas Ibu

Kelompok dukungan sebaya (peer support), kelas ibu sehat, dan edukasi berbasis komunitas memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri ibu, keterampilan pengasuhan, dan penurunan risiko depresi postpartum (Letourneau et al., 2020; Slomian et al., 2019). Dukungan sosial melalui peer support dan kelas ibu sehat juga mampu menurunkan isolasi sosial, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperkuat coping ibu hamil. Forum digital seperti WhatsApp group atau aplikasi peer support terbukti efektif dalam membangun koneksi emosional dan menurunkan gejala depresi (Tian et al., 2022).

Program edukatif seperti Kelas Ibu Sehat memberi pemahaman mendalam tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan neonatal, serta memfasilitasi interaksi antarsesama ibu. Penelitian oleh Li et al. (2022) menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan kesiapan psikologis dan menurunkan kecemasan. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran penting sebagai fasilitator komunitas dan penjemputan kebutuhan ibu dengan layanan sosial lainnya.

4. Media Digital dan Intervensi Inovatif

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan mental ibu hamil dan nifas semakin berkembang pesat. Internet-based CBT (iCBT), aplikasi relaksasi, mood tracker, serta layanan konseling daring terbukti efektif untuk mengatasi gangguan psikologis secara fleksibel dan terjangkau (Shorey et al., 2018). Perawat di era digital perlu memiliki literasi teknologi untuk menyarankan aplikasi yang aman dan berbasis bukti serta mendampingi ibu dalam penggunaannya.

Telehealth dan aplikasi self-care berbasis CBT dan mindfulness membuka akses baru bagi ibu hamil dan nifas untuk mendapatkan intervensi psikologis

tanpa batasan geografis. Program iCBT telah terbukti menurunkan depresi postpartum dengan tingkat kepatuhan pengguna yang tinggi (Loughnan et al., 2023). Perawat dapat memanfaatkan media ini dalam praktik dengan merekomendasikan aplikasi seperti Headspace atau MindMom, serta melakukan pemantauan melalui telekonsultasi atau sesi daring kelompok.

Bahkan WHO (2022) secara eksplisit mendukung penggunaan intervensi digital sebagai lini pertama dalam penanganan depresi perinatal ringan hingga sedang, menjadikan integrasi teknologi sebagai bagian penting dalam strategi asuhan keperawatan holistik.

5. Teknik Relaksasi Praktis dalam Asuhan Perinatal

Teknik relaksasi praktis merupakan pendekatan non-farmakologis yang mudah diajarkan dan diintegrasikan ke dalam praktik asuhan perinatal. Beberapa teknik yang sering digunakan adalah pernapasan dalam (deep breathing), relaksasi otot progresif (progressive muscle relaxation/PMR), guided imagery, dan stretching ringan. Teknik-teknik ini bertujuan untuk menurunkan aktivasi sistem saraf simpatik, menurunkan kadar kortisol, serta meningkatkan perasaan relaks dan rasa kendali atas tubuh.

Pernapasan dalam dilakukan dengan menarik napas perlahan melalui hidung, menahan sejenak, dan menghembuskan secara perlahan melalui mulut. Teknik ini dapat memicu respons relaksasi dan menstabilkan detak jantung. Sementara itu, PMR dilakukan dengan cara menegangkan lalu melemaskan kelompok otot tertentu secara sistematis dari kepala hingga kaki, yang telah terbukti menurunkan ketegangan otot, memperbaiki kualitas tidur, serta meningkatkan suasana hati dan rasa nyaman pada ibu hamil (Zhou et al., 2023).

Latihan ini dapat diberikan secara langsung oleh perawat saat kunjungan ANC/PNC, baik di fasilitas maupun saat home visit. Selain itu, ibu dapat diarahkan untuk mempraktikkannya mandiri sebagai rutinitas harian, terutama menjelang tidur atau saat merasa cemas. Penelitian juga menunjukkan bahwa intervensi relaksasi ini berdampak positif terhadap pengurangan gejala insomnia, kecemasan, serta nyeri punggung bawah yang umum terjadi selama kehamilan (Goodman et al., 2022).

G. Implikasi terhadap Kebijakan dan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penanganan gangguan psikologis pada ibu hamil dan masa nifas memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terpadu. Standar pelayanan keperawatan maternitas di Indonesia mengacu pada berbagai regulasi nasional, termasuk Standar Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Kemenkes Republik Indonesia, Standar

Kompetensi Perawat Indonesia (PPNI), serta Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Practice Guidelines (CPG) dari organisasi profesi dan lembaga akademik.

1. Standar Nasional Asuhan Keperawatan Maternal

Menurut Standar Kompetensi Perawat Indonesia (PPNI, 2022), perawat dituntut memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk deteksi dan penatalaksanaan awal gangguan psikologis. Dalam konteks pelayanan maternal, Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Kebidanan menyebutkan perlunya pendekatan holistik dalam pelayanan kehamilan dan nifas, termasuk aspek psikologis ibu.

Sementara itu, dalam Standar Pelayanan Antenatal Terpadu (Kemenkes RI, 2021), disebutkan bahwa tenaga kesehatan wajib melakukan skrining terhadap gangguan mental emosional selama kehamilan dan nifas, sebagai bagian dari pemeriksaan rutin. Pelaksanaan skrining ini mencakup penggunaan instrumen seperti SRQ-20 (Self Reporting Questionnaire), EPDS, dan PHQ-9 sesuai ketersediaan fasilitas layanan kesehatan.

2. Peran Perawat dalam Tim Kolaboratif Interprofesional

Pelayanan kesehatan jiwa perinatal yang optimal memerlukan kolaborasi interprofesional antara perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis obgyn, psikolog klinis, dan psikiater. Perawat berperan sebagai garda depan yang mengidentifikasi, memantau, dan menindaklanjuti kasus-kasus gangguan psikologis ringan hingga sedang. Kolaborasi ini mencakup proses rujukan, diskusi kasus, serta penyusunan rencana intervensi terintegrasi yang berfokus pada keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

Studi oleh Price et al. (2022) menegaskan bahwa model kolaborasi berbasis tim perinatal dapat meningkatkan deteksi dan penanganan gangguan psikologis secara dini, mengurangi beban rumah sakit, serta meningkatkan kepuasan ibu terhadap pelayanan. Perawat menjadi koordinator penting dalam menjaga kontinuitas layanan, menjembatani komunikasi antarprofesi, dan memfasilitasi akses ibu terhadap layanan yang dibutuhkan.

3. Penerapan Model Praktik Keperawatan Kolaboratif

Penerapan model praktik keperawatan kolaboratif (Collaborative Nursing Practice Model) didasarkan pada asas saling menghormati kompetensi lintas profesi, komunikasi terbuka, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks gangguan psikologis perinatal, model ini menempatkan perawat sebagai mitra aktif dalam pengelolaan kasus, bukan sekadar pelaksana instruksi medis. Hal ini sejalan dengan pendekatan woman-centered care yang menempatkan ibu sebagai subjek aktif dalam proses penyembuhan.

4. Penguatan Sistem Rujukan dan Ketersediaan Layanan Jiwa Perinatal

Pelaksanaan kolaborasi antarprofesi juga harus didukung oleh sistem rujukan yang efisien dan layanan jiwa perinatal yang mudah diakses. Namun, laporan dari WHO (2022) menunjukkan bahwa masih banyak negara, termasuk Indonesia, yang menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan jiwa perinatal, seperti kurangnya tenaga kesehatan terlatih dan stigma terhadap masalah kejiwaan. Oleh karena itu, diperlukan advokasi kebijakan, pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan, serta pengembangan unit pelayanan jiwa maternal di tingkat primer dan sekunder.

Dengan mengikuti standar nasional dan menerapkan kolaborasi interprofesional yang kuat, intervensi keperawatan terhadap gangguan psikologis selama kehamilan dan masa nifas dapat terlaksana secara efektif, aman, dan bermartabat, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

H. Simpulan

Gangguan psikologis selama kehamilan dan masa nifas merupakan kondisi yang kompleks, multifaktorial, dan berdampak luas terhadap kesejahteraan ibu, bayi, serta lingkungan keluarga secara keseluruhan. Jenis gangguan yang muncul meliputi depresi perinatal, gangguan kecemasan, baby blues, psikosis postpartum, PTSD, serta gangguan penyesuaian dan komorbid lainnya, dengan gejala dan manifestasi klinis yang kerap tumpang tindih namun tetap memiliki konsekuensi spesifik yang signifikan.

Tanpa deteksi dini dan penanganan tepat, gangguan ini dapat meningkatkan risiko komplikasi obstetri, gangguan relasi ibu-anak, hambatan dalam menyusui dan pengasuhan, serta gangguan tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Selain itu, kesehatan mental ibu yang terganggu turut memperburuk kualitas relasi dalam rumah tangga dan menurunkan kualitas hidup keluarga.

Oleh karena itu, peran perawat sangat vital dalam skrining, edukasi, pendampingan, dan rujukan pada kasus gangguan psikologis perinatal. Asuhan keperawatan harus bersifat holistik, berbasis empati, sensitif budaya, dan menjalin kolaborasi dengan tenaga kesehatan jiwa. Investasi pada peningkatan kapasitas perawat dalam bidang kesehatan mental perinatal akan menjadi langkah strategis dalam mencegah morbiditas ibu dan bayi, serta memastikan keberlangsungan generasi yang sehat secara fisik dan emosional.

I. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2018). Screening for perinatal depression. Committee Opinion No. 757. *Obstetrics and Gynecology*, 132(5), e208–e212.
- American Psychological Association. (2022). Guidelines for Psychological Practice with Women. <https://www.apa.org/about/policy/guidelines-women-practice.pdf>
- Ayers, S., Bond, R., Bertullies, S., & Wijma, K. (2016). The aetiology of post-traumatic stress following childbirth: A meta-analysis and theoretical framework. *Psychological Medicine*, 46(6), 1121–1134.
- Bayrampour, H., McDonald, S., & Tough, S. (2018). Risk factors of postpartum depression and depressive symptoms: A meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18(1), 1–9.
- Beck, J. S. (2011). *Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond* (2nd ed.). Guilford Press.
- Biaggi, A., Conroy, S., Pawlby, S., & Pariante, C. M. (2016). Identifying the women at risk of antenatal anxiety and depression: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 191, 62–77.
- Ceulemans, M., Hompes, T., & Van Den Bergh, B. R. H. (2021). Antenatal maternal anxiety and stress and the neurobehavioral development of the fetus and child: A review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 117, 306–322.
- Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *The British Journal of Psychiatry*, 150(6), 782–786.
- Cuijpers, P., Karyotaki, E., Reijnders, M., Purgato, M., & de Wit, L. (2020). Meta-analyses and mega-analyses of the effectiveness of CBT for perinatal depression and anxiety. *World Psychiatry*, 19(3), 336–345.
- Dagher, R. K., McGovern, P. M., Dowd, B. E., & Lundberg, U. (2016). Postpartum depression and health services expenditures among employed women. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 58(6), 588–594.

- Dennis, C. L., & Dowswell, T. (2013). Psychological and psychosocial interventions for preventing postpartum depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD001134.
- Duncan, L. G., & Bardacke, N. (2010). Mindfulness-Based Childbirth and Parenting Education. *Journal of Child and Family Studies*, 19(2), 190–202.
- Fairbrother, N., Young, A. H., Janssen, P., Antony, M. M., & Tucker, E. (2016). Depression and anxiety during the perinatal period: Prevalence, risk factors, and screening. *Current Psychiatry Reports*, 18(3), 1–9.
- Field, T. (2017). Mindfulness and self-compassion in perinatal women. *Infant Behavior and Development*, 49, 74–80.
- Ford, E., Ayers, S., & Bradley, R. (2022). Exploration of perinatal trauma and posttraumatic stress disorder in the perinatal period: A systematic review. *BMJ Open*, 12, e056162.
- Green, J. M., Wood, J., & Urquhart, L. (2022). Antenatal CBT for perinatal anxiety. *Clinical Psychology Review*, 97, 102203.
- Grote, N. K., Bridge, J. A., Gavin, A. R., Melville, J. L., Iyengar, S., & Katon, W. J. (2010). A meta-analysis of depression during pregnancy and the risk of preterm birth, low birth weight, and intrauterine growth restriction. *Archives of General Psychiatry*, 67(10), 1012–1024.
- Hahn-Holbrook, J., Cornwell-Hinrichs, T., & Anaya, I. (2021). Economic and health predictors of national postpartum depression prevalence: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression of 291 studies from 56 countries. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 776025. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.776025>
- Howard, L. M., Molyneaux, E., Dennis, C. L., Rochat, T., Stein, A., & Milgrom, J. (2014). Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. *The Lancet*, 384(9956), 1775–1788.
- Jones, I., Chandra, P. S., Dazzan, P., & Howard, L. M. (2020). Perinatal mental health. *The Lancet Psychiatry*, 7(2), 162–172.
- Kingston, D., Kehler, H., Austin, M.-P., et al. (2021). Trajectories of maternal depression and anxiety symptoms during pregnancy and postpartum: A latent class analysis. *International Journal of Epidemiology*, 50(5), 1605–1618.

- Leach, L. S., Poyser, C., Cooklin, A. R., & Giallo, R. (2014). Prevalence and course of anxiety disorders (and symptom levels) in men across the perinatal period: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 190, 675–686.
- Li, Y., Xu, Y., & Zhang, W. (2022). Family-centered prenatal education. *Midwifery*, 112, 103420.
- Loughnan, S. A., Sie, A., & Newby, J. M. (2023). Digital Interventions for Postnatal Depression. *Journal of Affective Disorders*.
- Monalisa, R., Fitria, L., & Rahmi, A. (2024). Hubungan dukungan keluarga dengan depresi postpartum. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 27(1), 56–62.
- Mughal, S., Azhar, Y., & Siddiqui, W. (2024). Postpartum Depression. In *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
- Muzik, M., & Borovska, S. (2016). Postpartum depression: Implications for mother–infant relationship and infant mental health. *Infant Mental Health Journal*, 31(6), 599–615.
- Ng, W. S., Chua, Y. X., Ng, S. F., & Shorey, S. (2023). Mindfulness-Based Psychoeducation Program. *JMIR Formative Research*, 6(9), e37216.
- O'Hara, M. W., & Wisner, K. L. (2014). Perinatal mental illness: Definition, description and aetiology. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 28(1), 3–12.
- O'Donnell, K. J., Glover, V., Barker, E. D., & O'Connor, T. G. (2014). The persisting effect of maternal mood in pregnancy on childhood psychopathology. *Development and Psychopathology*, 26(2), 393–403.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2022). Standar Kompetensi Perawat Indonesia.
- Price, S. K., Henneghan, A. M., & Monroe, L. (2022). Improving Perinatal Mental Health through Team-Based Care. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 51(1), 67–75.
- Putriarsih, D., Susanti, H., & Nurhidayah, I. (2018). Faktor risiko depresi postpartum pada ibu primipara. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 6(3), 206–214.

- Rae, K., Kendrick, D., & Leamy, M. (2025). Social support and maternal mental health: A qualitative meta-synthesis. *BMC Psychiatry*, 25(1), 10–19.
- Rokom. (2019). Kesehatan Jiwa Remaja Wanita Usia Subur. Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI. <https://www.kemkes.go.id>
- Shi, Z., & MacBeth, A. (2017). Mindfulness-based interventions on maternal perinatal mental health. *Mindfulness*, 8(4), 823–847.
- Shorey, S., Lau, Y., Dennis, C. L., Chan, Y. S., Tam, W. W. S., & Chan, Y. H. (2018). A randomized controlled trial of a postnatal psychoeducation program delivered via mobile application. *Journal of Medical Internet Research*, 20(4), e10778.
- Sipsma, H. L., Ofori-Atta, A., Canavan, M. E., et al. (2013). Empowerment and use of antenatal care among women in Ghana: A cross-sectional study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 13, 1–8.
- Sit, D., Rothschild, A. J., & Wisner, K. L. (2006). A review of postpartum psychosis. *Journal of Women's Health*, 15(4), 352–368.
- Slomian, J., Honvo, G., Emonts, P., Reginster, J. Y., & Bruyère, O. (2019). Consequences of maternal postpartum depression: A systematic review of maternal and infant outcomes. *Women's Health*, 15, 1745506519844044.
- Sockol, L. E. (2018). Interpersonal psychotherapy for perinatal women. *Journal of Affective Disorders*, 232, 316–328.
- Stein, A., Pearson, R. M., Goodman, S. H., et al. (2014). Effects of perinatal mental disorders on the fetus and child. *The Lancet*, 384(9956), 1800–1819.
- Stewart, D. E., & Vigod, S. N. (2019). Postpartum Depression: Treatment and Emerging Therapeutics. *Annual Review of Medicine*, 70, 183–196.
- Tian, Y., Wang, Y., & Chen, H. (2022). Peer Support in Online Perinatal Depression Communities. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2212.03452>
- Vigod, S. N., Villegas, L., Dennis, C. L., & Ross, L. E. (2010). Prevalence and risk factors for postpartum depression among women with preterm and low-birth-weight infants: A systematic review. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 117(5), 540–550.

- Wesseloo, R., Kamperman, A. M., Munk-Olsen, T., Pop, V. J., Kushner, S. A., & Bergink, V. (2016). Risk of postpartum relapse in bipolar disorder and postpartum psychosis: A systematic review and meta-analysis. *American Journal of Psychiatry*, 173(2), 117–127.
- WHO. (2022). Guideline for the integration of perinatal mental health into maternal and child health services. Geneva: WHO Press.
- Yildiz, P. D., Ayers, S., & Phillips, L. (2017). The prevalence of posttraumatic stress disorder in pregnancy and after birth: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 208, 634–645.
- Yim, I. S., Tanner Stapleton, L. R., Guardino, C. M., Hahn-Holbrook, J., & Dunkel Schetter, C. (2015). Biological and psychosocial predictors of postpartum depression: Systematic review and call for integration. *Annual Review of Clinical Psychology*, 11, 99–137.
- Zhou, Y., Zhang, Y., & Liang, Y. (2023). PMR and anxiety in pregnant women. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 10579678.

J. Glosarium

A

Antenatal: adalah periode selama kehamilan sebelum proses persalinan. Umumnya digunakan untuk merujuk pada kunjungan atau intervensi medis/prenatal.

Attachment: adalah ikatan emosional yang terbentuk antara ibu dan bayi, berperan penting dalam perkembangan psikologis dan sosial anak.

B

Baby Blues: adalah perubahan suasana hati ringan yang sering dialami ibu dalam minggu pertama setelah melahirkan, ditandai dengan mudah menangis, cemas, dan lelah secara emosional. Biasanya bersifat sementara.

Bonding: adalah proses awal pembentukan hubungan emosional antara orang tua dan bayi segera setelah kelahiran.

D

Depresi Antenatal: adalah depresi yang dialami ibu selama masa kehamilan, ditandai dengan gejala seperti kelelahan, kehilangan minat, dan rasa sedih yang mendalam.

Depresi Postpartum: adalah gangguan suasana hati serius yang terjadi setelah melahirkan. Gejala meliputi kesedihan mendalam, gangguan tidur, kelelahan, dan ketidakmampuan merawat bayi.

E

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): adalah alat skrining yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan depresi postpartum pada ibu.

Evidence-Based Practice (EBP): adalah Praktik klinis yang menggabungkan bukti ilmiah terbaik, pengalaman profesional, dan nilai serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan.

G

Generalized Anxiety Disorder (GAD): adalah gangguan kecemasan menyeluruh yang ditandai dengan kekhawatiran berlebihan, ketegangan otot, dan gangguan tidur.

I

Infanticide: adalah tindakan membunuh bayi, yang dalam konteks kesehatan mental perinatal dapat terjadi dalam kasus psikosis postpartum berat.

Interprofessional Collaboration: adalah kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan (perawat, bidan, dokter, psikolog, dll.) untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu.

K

Kesehatan Mental Perinatal: adalah kondisi kesehatan jiwa ibu selama masa kehamilan hingga satu tahun setelah melahirkan, mencakup berbagai gangguan psikologis yang mungkin timbul.

P

Postpartum Psychosis: adalah gangguan mental berat yang biasanya terjadi dalam beberapa minggu setelah persalinan, ditandai dengan delusi, halusinasi, perubahan perilaku ekstrem, dan risiko bunuh diri atau infanticide.

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Pascapersalinan: adalah gangguan stres pascatrauma yang muncul setelah pengalaman persalinan yang menakutkan atau traumatis. Gejala termasuk kilas balik, mimpi buruk, hipervigilans, dan penghindaran.

Prematur: adalah kelahiran bayi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Dapat dikaitkan dengan gangguan psikologis ibu selama kehamilan.

S

Skrining: adalah proses sistematis untuk mendeteksi kemungkinan gangguan atau kondisi tertentu sebelum gejala nyata muncul, seperti penggunaan EPDS untuk mendeteksi depresi postpartum.

T

Trauma Persalinan: adalah pengalaman persalinan yang menimbulkan dampak psikologis negatif yang signifikan, termasuk rasa takut yang ekstrem, kehilangan kendali, atau cedera.

PROFIL PENULIS



Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah.,S.SiT.,M.Kes. Penulis dilahirkan di Kota Sidoarjo, pada tanggal 23 November 1984. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Noor Huda Mustofa. Menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan Poltekkes Surabaya Kampus Bangkalan Madura, dan melanjutkan pendidikan D-IV Bidan Pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran Semarang. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi ilmu Kesehatan Masyarakat AKK (Administrasi Kebijakan Kesehatan) minat Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak. Mata kuliah yang diampu meliputi mata kuliah pelayanan KB, kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Sebelumnya penulis juga telah menerbitkan beberapa buku meliputi panduan praktikum Kegawatdaruratan Obstetri, Panduan pelaksanaan Stase Midwifery Critical Care, modul asuhan kebidanan persalinan dan Bayi baru Lahir, Modul asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pojok Tinggi dan berat Badan Balita (Pojok Timbang), ilmu Pendidikan, ilmu kebidanan, etika hukum dan perundang-undangan dalam pelayanan kebidanan, konsep kebidanan, buku ajar persalinan. Penulis juga telah menghasilkan beberapa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi antara lain Efektifitas teknik relaksasi nafas dalam dan pijatan Effleurage terhadap penurunan Skala Nyeri pada Post SC, pengaruh lama penggunaan DMPA (Depometdroxi Progesteron Asetat) terhadap penurunan libido pada WUS di PMB Lukluatun Mubrikoh, Evaluasi Input Kelas ibu Hamil di wilayah kerja PKM Sukoliloh, Deteksi Dini preeklampsia pada ibu hamil dengan penimbangan BB dan tekanan Darah, faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan Alat Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) pada wanita usia Subur (Studi di Wilayah UPT Puskesmas Kabupaten Bangkalan), Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelayanan KIA di Kab Bangkalan. Penulis mengawali karir sebagai pendidik sejak 2006, sekprodi Prodi DIV kebidanan STIKes Ngudia Husada Madura (sejak 2015-2018), Ka prodi DIII Kebidanan STIKes Ngudia Husada Madura (sejak 2018-2019), GKM STIKes Ngudia Husada Madura sejak 2019 sampai saat ini. Penulis dapat di hubungi melalui email sitirochimatullailiyah5@gmail.com nomor telepon 085735492133

Motto: "do the best every day"

PROFIL PENULIS



Apri Nur Wulandari, S.Kep.,Ns.,M.Kep. Lulus S1 Keperawatan dan Program Profesi Ners pada tahun 2014, dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan, Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017, dengan minat Keperawatan Maternitas. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015-2023 sebagai dosen tetap di STIKES Notokusumo Yogyakarta. Saat ini penulis bekerja di Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Diponegoro sebagai dosen tetap dengan mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas. Minat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada lingkup: nursing science, maternity nursing, reproductive health, dan social support. Penulis aktif menulis beberapa buku dengan tema kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, dan ibu hamil resiko tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wulandari.aprinur@gmail.com

PROFIL PENULIS



Santi Wahyuni, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat, Lahir di Bandung, 05 Januari 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2007 serta Program Spesialis-1 Keperawatan Maternitas, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 sebagai staf pengajar di Akademi Perawat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan melaksanakan program magang di RSUD Kabupaten Sumedang selama 1 tahun. Penulis sejak Mei 2002 hingga saat ini bekerja sebagai pengajar di Program Studi Keperawatan Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penulis mengampu mata Keperawatan Maternitas, Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, Metodologi Penelitian, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, reviewer soal uji kompetensi nasional, publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional, aktif mengikuti kegiatan ilmiah seperti pelatihan, workshop dan seminar. Penulis sebagai pendiri dan pembina Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKMA) SPIRIT, Asesor LAM-PT Kes, Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Pengurus DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Cirebon, Pengurus Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) Jawa Barat, Pengurus Yayasan Ahnaf Maulana Nafi, serta tergabung dalam tim vaksinator dan tim Health and Disaster (HADE) Center dari Center of Excellence (CoE) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: santiwahyuni@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id

Motto: "Kesuksesan sejati diraih dengan sabar, diwarnai dengan keikhlasan, dan diukir dengan ikhtiar."

Sinopsis

Buku Bunga Rampai "Asuhan Keperawatan Maternitas Komprehensif: Pendekatan Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang menyajikan secara mendalam dan sistematis mengenai praktik keperawatan maternitas dengan pendekatan berbasis bukti. Dalam buku ini, para pembaca akan menemukan berbagai konsep dasar, prinsip-prinsip terkini, serta hasil penelitian terbaru yang relevan dengan asuhan keperawatan maternitas.

Materi yang disajikan mencakup seluruh rentang siklus maternitas, mulai dari tahap perencanaan kehamilan, perawatan antenatal, manajemen persalinan, masa nifas, hingga perawatan bayi baru lahir. Buku ini secara khusus menekankan pentingnya penggunaan Evidence-Based Practice (EBP), yang bertujuan agar setiap intervensi yang dilakukan oleh perawat memiliki landasan ilmiah yang kuat, efektif, serta aman bagi ibu dan bayi.

Dilengkapi dengan tinjauan literatur yang komprehensif serta contoh penerapan EBP dalam situasi klinis nyata, buku ini sangat tepat digunakan sebagai referensi utama oleh para praktisi keperawatan, dosen, mahasiswa keperawatan, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan maternitas. Harapannya, buku ini dapat membantu meningkatkan kompetensi profesional dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas yang berkualitas tinggi, serta memberikan kontribusi positif terhadap hasil kesehatan ibu dan bayi.

Buku Bunga Rampai "Asuhan Keperawatan Maternitas Komprehensif: Pendekatan Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang menyajikan secara mendalam dan sistematis mengenai praktik keperawatan maternitas dengan pendekatan berbasis bukti. Dalam buku ini, para pembaca akan menemukan berbagai konsep dasar, prinsip-prinsip terkini, serta hasil penelitian terbaru yang relevan dengan asuhan keperawatan maternitas.

Materi yang disajikan mencakup seluruh rentang siklus maternitas, mulai dari tahap perencanaan kehamilan, perawatan antenatal, manajemen persalinan, masa nifas, hingga perawatan bayi baru lahir. Buku ini secara khusus menekankan pentingnya penggunaan Evidence-Based Practice (EBP), yang bertujuan agar setiap intervensi yang dilakukan oleh perawat memiliki landasan ilmiah yang kuat, efektif, serta aman bagi ibu dan bayi.

Dilengkapi dengan tinjauan literatur yang komprehensif serta contoh penerapan EBP dalam situasi klinis nyata, buku ini sangat tepat digunakan sebagai referensi utama oleh para praktisi keperawatan, dosen, mahasiswa keperawatan, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan maternitas. Harapannya, buku ini dapat membantu meningkatkan kompetensi profesional dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas yang berkualitas tinggi, serta memberikan kontribusi positif terhadap hasil kesehatan ibu dan bayi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-82-1



9

786347

294821